Caderno de revisão — sábado 07/11/2026

120 textos, ~511 min. Ordem do INDICE.md.
Medicamentos destacados em amarelo.

01 · G1 · RETIRADO da agenda em 04/11/2026 (era 2026-11-05 08:00 Bahia). Reagendar só após aprovação

Abandono de tratamento psiquiátrico: estratégias de resgate na UBS

Motivo: retirado da agenda até a revisão (aguarda-revisao-medica) + medicamento · ~6 min

Olá, colega da atenção primária. Vamos conversar sobre uma situação muito comum na nossa rotina: quando um paciente deixa de vir às consultas e para de tomar os seus remédios. Na nossa prática na comunidade, o cuidado não termina quando a pessoa sai da sala de atendimento. Cuidar de quem se afastou exige olhar sensível, paciência e estratégias ativas da equipe. Sabemos que o abandono do tratamento traz riscos sérios de recaída e sofrimento para a pessoa e para a família. Por isso, precisamos agir com acolhimento e firmeza técnica para reatar esse vínculo.

Guia Prático

Guia Prático para a Equipe

O resgate do paciente que abandonou o tratamento começa muito antes da consulta. Ele exige planejamento e sensibilidade de toda a equipe da unidade básica de saúde.

• Monitore os faltosos: A recepção e os agentes comunitários de saúde são fundamentais. Identifique quem não comparece há meses.

• Busca ativa humanizada: O agente comunitário de saúde é a ponte. A visita domiciliar deve ser feita sem tom

de cobrança ou julgamento, mas com genuína preocupação.

• Escuta sem culpa: Quando o paciente retornar, evite frases que gerem culpa. Pergunte o que aconteceu, quais foram as dificuldades e como a equipe pode ajudar.

• Investigue os motivos: Pergunte sobre efeitos colaterais incômodos, melhora percebida que gerou falsa segurança, custos, esquecimento ou estigma associado aos remédios.

• Reavalie o plano terapêutico: Ajuste horários, simplifique a rotina de uso e discuta alternativas viáveis com o paciente e seus familiares.

Fisiopatologia

Compreendendo o Processo de Recaída

Para planejar o resgate, precisamos entender o que acontece no cérebro e na vida de quem interrompe o tratamento psiquiátrico de forma brusca.

• Neuroadaptação e Descontinuação: O uso prolongado de psicofármacos altera circuitos neuroquímicos. A interrupção abrupta pode causar sintomas de abstinência física e emocional que o paciente confunde com o retorno da doença original.

• Déficit de Proteção Crônica: Transtornos mentais graves envolvem desequilíbrios em sistemas de neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina. A medicação atua mantendo a estabilidade desses sistemas.

• Vulnerabilidade Estressora: O cérebro em recuperação ainda responde de forma intensa aos estressores do cotidiano. Sem a proteção farmacológica e o suporte terapêutico, o limiar para novas crises diminui drasticamente.

• Cascata Comportamental: A descompensação subclínica afeta o sono, a cognição e o humor. Isso reduz a capacidade funcional do indivíduo, dificultando ainda mais a busca espontânea por ajuda médica.

Manejo Clínico

Manejo Clínico na Atenção Básica

O atendimento ao paciente resgatado exige avaliação clínica cuidadosa e condutas seguras baseadas em diretrizes da atenção primária.

• Avaliação de Risco: Investigue imediatamente ideação suicida, sintomas psicóticos agudos, agitação psicomotora ou incapacidade de autocuidado. Se houver risco iminente, acione o suporte adequado (SAMU 192).

• Reinício Medicamentoso: Na maioria das vezes, se o paciente estava bem com o esquema anterior e tolerava bem, podemos reiniciar a mesma classe terapêutica. Avalie a necessidade de reintrodução gradual para minimizar efeitos colaterais iniciais.

• Classes Terapêuticas Comuns:

• Antidepressivos (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina): reiniciar com dose individualizada, conforme a resposta e a tolerância já conhecidas, e reavaliar de forma precoce.

• Estabilizadores de Humor (como sais de lítio ou anticonvulsivantes): dosagem inicial individualizada e exames laboratoriais de base e de seguimento, segundo o protocolo local; no caso do lítio, a litemia (nível do medicamento no sangue) orienta a dose, com exames periódicos, porque a faixa terapêutica é estreita e há risco de toxicidade.

• Antipsicóticos (típicos ou atípicos): ajustar conforme o perfil de sintomas e a tolerabilidade, com dose individualizada.

• Manejo de Efeitos Colaterais: Uma das causas frequentes de abandono é o desconforto físico dos efeitos colaterais. Valide a queixa e oriente ajustes de horário ou troca de fármaco dentro da mesma classe se necessário.

• Critérios de Encaminhamento: Encaminhe para o especialista (Psiquiatria) quando houver refratariedade ao tratamento na atenção básica, incerteza diagnóstica complexa, risco elevado persistente ou gestantes com quadros graves.

Pontos-chave

• O abandono do tratamento psiquiátrico na atenção básica exige busca ativa humanizada e sem julgamentos por parte da equipe.

• A interrupção abrupta de psicofármacos pode causar sintomas de descontinuação e precipitar recaídas graves.

• Investigar efeitos colaterais incômodos é a chave para recuperar a adesão do paciente.

• O manejo clínico envolve avaliar riscos imediatos, reintroduzir medicações com cautela e simplificar o esquema terapêutico.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Semahegn A, Torpey K, Manu A et al.. Psychotropic medication non-adherence and its associated factors among patients with major psychiatric disorders: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2020;9(1):17. PMID 31948489. doi:10.1186/s13643-020-1274-3 — Revisão sistemática e metanálise

• Loots E, Goossens E, Vanwesemael T et al.. Interventions to Improve Medication Adherence in Patients with Schizophrenia or Bipolar Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(19):10213. PMID 34639510. doi:10.3390/ijerph181910213 — Revisão sistemática e metanálise (adesão ao tratamento)

• González de León B, Del Pino-Sedeño T, Serrano-Pérez P et al.. Effectiveness of interventions to improve medication adherence in adults with depressive disorders: a meta-analysis. BMC Psychiatry. 2022;22(1):487. PMID 35858887. doi:10.1186/s12888-022-04120-w — Metanálise

• Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV et al.. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018

guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord. 2018;20(2):97-170. PMID 29536616. doi:10.1111/bdi.12609 — Diretriz clínica (CANMAT/ISBD)

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

02 · G1 · RETIRADO da agenda em 04/11/2026 (era 2026-11-06 08:00 Bahia). Reagendar só após aprovação

Conviver com a oscilação de humor: limites e apoio familiar

Motivo: retirado da agenda até a revisão (aguarda-revisao-medica) + medicamento · ~6 min

Conviver com alguém que enfrenta oscilações intensas de humor traz desafios diários para a casa toda. Você pode se sentir pisando em ovos, sem saber o que esperar ao abrir a porta. É normal sentir cansaço, culpa e até frustração quando as tentativas de ajudar parecem não funcionar. Aqui na atenção primária, vejo muito isso nas famílias. Quero conversar com você sobre como encontrar um caminho de equilíbrio. Vamos olhar para formas de oferecer apoio real, sem que você precise carregar um peso que não é seu.

Guia Prático

Guia Prático para o Dia a Dia

Apoiar alguém com instabilidade emocional exige construir pontes de diálogo e, ao mesmo tempo, proteger o seu próprio espaço. Algumas atitudes simples ajudam a tornar o ambiente mais seguro para todos.

• Escolha o momento certo: Evite conversas difíceis ou cobranças no ápice da crise emocional. Espere o momento de calmaria para falar sobre o que aconteceu.

• Valide o que o outro sente: Você não precisa concordar com tudo, mas reconhecer a dor do outro ("eu vejo que isso está sendo muito difícil para você") desarma conflitos.

• Use frases na primeira pessoa: Diga "eu me sinto preocupado quando vejo você assim" em vez de "você está exagerando de novo". Isso reduz a defensividade.

• Estabeleça limites claros: Cuidar não significa aceitar ofensas ou agressões. Dizer "eu quero te ajudar, mas não posso conversar aos gritos" é um ato de amor e respeito mútuo.

• Mantenha a rotina possível: A previsibilidade ajuda a trazer segurança para quem oscila muito e organiza o dia da família.

Fisiopatologia

O que Acontece por Trás da Instabilidade

Quando falamos em oscilações intensas de humor, estamos lidando com circuitos cerebrais que regulam as emoções e a resposta ao estresse. Não é falta de vontade, frescura ou escolha.

• Regulação emocional: Áreas do cérebro responsáveis por processar impulsos e sentimentos, como o sistema límbico e o córtex pré-frontal, funcionam com uma sintonia mais delicada.

• Vulnerabilidade ao estresse: Pequenos gatilhos cotidianos podem ativar reações desproporcionais, gerando respostas rápidas de luta ou fuga.

• Ciclos naturais: O corpo e a mente passam por fases de maior energia e impulsividade, seguidas por momentos de exaustão e recolhimento profundo.

• Impacto relacional: O sistema nervoso de quem convive perto também entra em alerta. Compreender a base biológica ajuda a diminuir a culpa e a entender que o comportamento é parte de um processo de saúde.

Manejo Clínico

Manejo Clínico e o Papel da Família

O suporte familiar é uma base importante para o tratamento, mas a família não substitui a equipe de saúde. O acompanhamento profissional regular é indispensável.

• Adesão ao tratamento: Incentive com carinho o uso correto dos medicamentos prescritos e o comparecimento às consultas e psicoterapias.

• Fármacos de controle: Em muitas situações, o médico utiliza estabilizadores de humor ou moduladores da atividade cerebral (como lítio ou anticonvulsivantes em classes específicas, com dose e exames definidos pelo médico) para reduzir a frequência e a intensidade das crises.

• Sinais de gravidade: Fique atento a falas de desesperança extrema, ameaças de autoagressão, perda total do contato com a realidade ou recusa absoluta de autocuidado.

• Onde buscar ajuda: Em caso de crise grave, procure o pronto atendimento mais próximo, acione o SAMU (192) ou ligue para o CVV (188) para apoio imediato em sofrimento psíquico.

• Cuidado com quem cuida: Avalie também a sua própria saúde mental. Procure grupos de apoio para familiares e

reserve momentos para o seu descanso.

Pontos-chave

• Apoiar alguém com oscilação de humor exige empatia combinada com limites firmes e saudáveis.

• A instabilidade emocional tem base neurobiológica e não resulta de falta de esforço.

• A família é uma rede de apoio essencial, mas não deve assumir o papel de equipe terapêutica.

• O tratamento médico contínuo e a psicoterapia são pilares fundamentais para a estabilidade.

• Cuidar de si mesmo é uma necessidade para quem está na posição de cuidador.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Justo LP, Soares BG, Calil HM. Family interventions for bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2007;2007(4):CD005167. PMID 17943843. doi:10.1002/14651858.CD005167.pub2 — Revisão sistemática Cochrane e metanálise

• Soo SA, Zhang ZW, Khong SJ et al.. Randomized Controlled Trials of Psychoeducation Modalities in the Management of Bipolar Disorder: A Systematic Review. J Clin Psychiatry. 2018;79(3). PMID 29727072. doi:10.4088/JCP.17r11750 — Revisão sistemática

• Sampogna G, Brohan E, Luciano M et al.. Psychosocial interventions for carers of people with severe mental and substance use disorders: a systematic review and meta-analysis. Eur Psychiatry. 2023;66(1):e98. PMID 37997647. doi:10.1192/j.eurpsy.2023.2472 — Revisão sistemática e metanálise

• Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV et al.. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord. 2018;20(2):97-170. PMID 29536616. doi:10.1111/bdi.12609 — Diretriz clínica (CANMAT/ISBD)

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

03 · G1 · RETIRADO da agenda em 04/11/2026 (era 2026-11-07 08:00 Bahia). Reagendar só após aprovação

Manejo de Sintomas Dissociativos Associados ao Trauma e Estresse Crônico na APS: Guia de Acolhimento e Autorregulação

Motivo: retirado da agenda até a revisão (aguarda-revisao-medica) + medicamento · ~6 min

Olá. Aqui na Atenção Primária e no Pronto Atendimento, frequentemente encontramos pessoas que chegam carregando marcas profundas de estresse crônico e experiências difíceis. Às vezes, o sofrimento é tão intenso que a mente encontra uma forma de se distanciar da realidade para tentar proteger o corpo. É o que chamamos de sintomas dissociativos, como a sensação de estar fora do próprio corpo, ver o mundo como se fosse um sonho ou passar por breves apagões de memória. Vamos conversar sobre como reconhecer esses sinais com muito cuidado, oferecendo um espaço seguro de escuta, sem julgamentos e sem apressar diagnósticos. Lembre-se de que a nossa prioridade é construir um vínculo verdadeiro, ajudando você ou seu paciente a reencontrarem o próprio eixo de forma gradual e respeitosa.

Guia Prático

Guia Prático para o Acolhimento e Autorregulação

O que observar na consulta

• Queixas vagas de distanciamento, dormência emocional ou sensação de irrealidade.

• Relatos de que o tempo passou rápido demais ou falhas na memória recente.

• Postura de congelamento, olhar distante ou dificuldade para responder perguntas simples.

O que fazer no primeiro atendimento

• Garanta um ambiente fisicamente seguro e tranquilo, mantendo a porta acessível e a iluminação suave.

• Pergunte como a pessoa prefere ser chamada e valide o sofrimento dela sem minimizar a experiência.

• Evite insistir em detalhes de memórias traumáticas se a pessoa estiver se sentindo desconectada.

• Faça pausas frequentes e pergunte se ela está acompanhando a conversa.

Técnicas de Aterramento (Grounding)

• Toque e Textura: Peça para a pessoa tocar o próprio pé no chão, sentir a textura da roupa ou segurar um objeto firme.

• Orientação no Espaço: Convide-a a nomear três cores que ela vê na sala ou a descrever o som que escuta lá fora.

• Respiração Consciente: Oriente inspirações profundas e lentas, expirando o ar pela boca com calma, ajudando o corpo a perceber que o perigo imediato já passou.

Fisiopatologia

Fisiopatologia e Compreensão do Trauma

Quando o cérebro enfrenta uma situação de ameaça extrema ou estresse crônico e prolongado, os circuitos habituais de resposta de luta ou fuga podem não ser suficientes. Nesses momentos, entra em ação o mecanismo de congelamento e dissociação.

Do ponto de vista neurobiológico, ocorre uma hiperativação da amígdala cerebral ligada ao medo, associada a uma desconexão funcional com o córtex pré-frontal, área responsável pelo raciocínio lógico e pela sensação de controle. O sistema nervoso simpático e o parassimpático entram em colisão, gerando uma sobrecarga.

A dissociação funciona como um disjuntor que desarma para proteger o organismo contra um sofrimento insuportável. A pessoa se afasta das próprias sensações físicas, das emoções e das memórias daquele evento. Na prática clínica, isso explica por que a abordagem puramente verbal nem sempre funciona de imediato; é preciso primeiro regular o corpo para depois acessar a mente.

Manejo Clínico

Manejo Clínico na Atenção Primária

O manejo inicial na APS baseia-se na criação de segurança e na psicoeducação. Nunca force a narrativa do trauma. O foco é restaurar a sensação de controle sobre o próprio corpo.

Condutas de Primeira Linha

• Oferecer escuta qualificada e validadora.

• Ensinar técnicas diárias de aterramento para os momentos de gatilho.

• Avaliar com cuidado a presença de comorbidades como ansiedade grave, depressão ou transtornos do sono.

Abordagem Medicamentosa

• Não existe medicação específica aprovada exclusivamente para a dissociação.

• Medicamentos da classe dos antidepressivos (como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina) podem ser considerados, com dose definida pelo médico, se houver sintomas ansiosos ou depressivos marcantes.

• O uso de ansiolíticos benzodiazepínicos deve ser evitado ou cercado de extrema cautela, pois podem piorar a confusão mental e gerar dependência.

Sinais de Gravidade e Quando Encaminhar

• Presença de ideação suicida ou comportamentos de autolesão.

• Risco iminente à integridade física (oriente ligar para o SAMU 192 ou procurar o CVV 188).

• Desorganização psíquica grave, alucinações persistentes ou incapacidade total para o autocuidado.

• Nesses casos, o encaminhamento para a saúde mental especializada ou para o suporte de urgência psiquiátrica deve ser feito de forma articulada e humanizada.

Pontos-chave

• A dissociação é uma resposta de proteção do cérebro frente a traumas e estresses intensos.

• O acolhimento na APS exige segurança, validação e ausência de pressa para falar do trauma.

• Técnicas de aterramento ajudam a reconectar a pessoa com o presente e com o próprio corpo.

• Sinais de crise grave exigem suporte imediato da rede de urgência, priorizando a vida.

Os sintomas dissociativos variam com a cultura e muitas vezes aparecem disfarçados de outros quadros, como sintomas neurológicos funcionais ou crises de humor, o que exige uma avaliação atenta1.

Para a despersonalização e a desrealização, uma revisão sistemática encontrou estudos ainda pequenos, sugerindo combinar abordagens2. Num ensaio randomizado, um programa psicoeducativo on-line associado à psicoterapia melhorou a regulação emocional e os sintomas de estresse pós-traumático em pessoas com dissociação ligada ao trauma3. Quando há estresse pós-traumático, as terapias focadas no trauma têm a melhor evidência4.

Conteúdo educativo, de caráter geral. Condutas, doses e fluxos descritos são orientação geral: respeitam-se sempre os protocolos hospitalares, do Pronto Atendimento (PA) e da rede de saúde locais.

Referências

• Şar V. Dissociation Across Cultures: A Transdiagnostic Guide for Clinical Assessment and Management. Alpha

Psychiatry. 2022;23(3):95-103. doi:10.5152/alphapsychiatry.2022.21556

• Wang S, Zheng S, Zhang X, et al. The Treatment of Depersonalization-Derealization Disorder: A Systematic Review. J Trauma Dissociation. 2024;25(1):6-29. doi:10.1080/15299732.2023.2231920

• Brand BL, Schielke HJ, Putnam K, et al. A randomized controlled trial assists individuals with complex trauma and dissociation in Finding Solid Ground. Psychol Trauma. 2025;17(8):1717-1727. doi:10.1037/tra0001871

• Lewis C, Roberts NP, Andrew M, et al. Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. Eur J Psychotraumatol. 2020;11(1):1729633. doi:10.1080/20008198.2020.1729633

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

A planta que sobreviveu na janela do posto

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Narrativa composta por personagens e situações fictícios inspirados em vivências comuns na Atenção Primária, sem paciente real identificável. Na sala de espera do nosso posto de saúde, sobre o parapeito da janela que pega o sol da tarde, há um vaso pequeno. A terra ali dentro é seca, quase dura, e o vento de agosto costuma sacudir as folhas com força. Mesmo assim, sobrevive uma suculenta que ganhou o apelido carinhoso de Dona Maria. Foi deixada ali meses atrás por uma moradora que disse não saber cuidar de plantas. Dona Clara, nossa técnica de enfermagem mais antiga, adotou o vaso como quem adota um neto. Todo santo dia, depois de bater o ponto, ela despeja um gole d'água usando o copinho de café. Vi essa cena se repetir centenas de vezes enquanto atendi a comunidade. Na semana passada, atendi a dona Joana. Ela chegou com o passo arrastado, os ombros curvados pelo peso de cuidar do neto pequeno e de um filho com depressão severa. Sentou-se na minha cadeira, olhou para as mãos calejadas e soltou um suspiro que parecia carregar o cansaço do mundo. Falou que a vida tinha virado uma sequência de dias cinzentos, sem nenhuma perspectiva de melhora. Não há palavras mágicas que

desfaçam a dor de quem carrega fardos tão pesados. O que a gente faz na Atenção Primária é sentar perto, escutar sem pressa e validar o sofrimento. Conversamos sobre como a rotina consome a gente e como é difícil pedir ajuda. Olhando pela janela, apontei para o vasinho verde e disse à dona Joana que a suculenta resistia firme, mesmo recebendo apenas um pingo d'água por dia. Ela sorriu de leve, pela primeira vez na consulta. A saúde mental não brota de uma hora para a outra, nem de soluções imediatas. Ela cresce no solo fértil da escuta, do acolhimento diário e da certeza de que ninguém precisa carregar seus fardos sozinho. Quando a dor estiver muito forte e você sentir que faltam forças para seguir, procure um espaço de escuta na sua comunidade ou converse com nossa equipe na unidade básica. Estamos aqui para caminhar junto com você, um dia de cada vez.

A escuta que dona Joana encontrou não é detalhe: a qualidade do vínculo entre quem cuida e quem é cuidado está entre os fatores mais consistentes de melhora1. Cuidadores familiares, como ela, adoecem mais do que quem não cuida2, e ter com quem contar protege contra a depressão3. Atividades da comunidade também podem fazer parte do cuidado4.

Referências

• Flückiger C, Del Re AC, Wampold BE, et al. The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy (Chic). 2018;55(4):316-340. doi:10.1037/pst0000172

• Pinquart M, Sörensen S. Differences between caregivers and noncaregivers in psychological health and physical

health: a meta-analysis. Psychol Aging. 2003;18(2):250-67. doi:10.1037/0882-7974.18.2.250

• Santini ZI, Koyanagi A, Tyrovolas S, et al. The association between social relationships and depression: a systematic review. J Affect Disord. 2015;175:53-65. doi:10.1016/j.jad.2014.12.049

• Drinkwater C, Wildman J, Moffatt S. Social prescribing. BMJ. 2019;364:l1285. doi:10.1136/bmj.l1285

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

05 · G1 · agendado 2026-11-07 08:00 (Bahia)

O relógio na parede do pronto atendimento

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Esta é uma narrativa composta por personagens e situações fictícios inspirados em vivências comuns no Pronto Atendimento Psiquiátrico, sem paciente real identificável. O ponteiro grande do relógio branco na parede parece congelado. Para quem espera na sala de emergência sentindo o peito apertado e o pensamento acelerado, cada minuto se arrasta como uma hora inteira. A dor da crise aguda dobra o tempo, estica a angústia e faz o silêncio ao redor soar ensurdecedor. Mariana aperta as mãos geladas contra os joelhos e olha de relance para a porta de vidro fosco. No seu mundo interior, o sofrimento já dura uma eternidade. A respiração está curta e a sensação de que o socorro nunca chega é esmagadora. É exatamente essa urgência subjetiva que recebemos na porta da sala vermelha. Naquele instante, a prioridade número um não é apenas o registro no prontuário ou a burocracia da triagem. É a presença humana capaz de interromper o caos. O técnico de enfermagem se aproxima com passos firmes, mas tranquilos, oferecendo um copo d'água e um olhar que diz: estou aqui com você, você não está mais sozinho nessa tempestade. Acolher uma crise psiquiátrica é

emprestar o nosso ritmo interno para quem perdeu o compasso da própria vida. Quando a mente dispara em cenários catastróficos e o medo paralisa, o ambiente ao redor precisa ser o porto seguro que desacelera o relógio. Cada palavra dita com calma, cada gesto de escuta sem julgamento e cada silêncio respeitoso funcionam como um tônico para o sistema nervoso no limite. Nós sabemos que a dor psiquiátrica dói no corpo, aperta a garganta e tira o chão. Sabemos também que a espera, quando o mundo interno desaba, é um teste desumano de resistência. Por isso, a nossa equipe é treinada para agir rápido não apenas com medicações, mas principalmente com a escuta que valida o que o outro sente. Se você estiver passando por um momento em que a dor se torna insuportável e o tempo parece não ter mais saída, saiba que existe ajuda disponível agora mesmo. Você não precisa carregar esse peso sozinho e a tempestade vai passar. Procure um serviço de saúde, converse com alguém de sua confiança ou ligue para o Centro de Valorização da Vida no número 188. Em situações de risco imediato, o SAMU pode ser acionado pelo 192. Há sempre um caminho de volta para a segurança e para o cuidado.

A presença calma descrita aqui é recomendação técnica: a abordagem verbal e o cuidado com o ambiente são o primeiro passo no manejo da crise1,2, e a medicação, quando necessária, tem regras próprias3. Na crise de pânico, a terapia cognitivo-comportamental é o tratamento com melhor evidência para prevenir novos episódios4.

Referências

• Richmond JS, Berlin JS, Fishkind AB, et al. Verbal De-escalation of the Agitated Patient: Consensus Statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup. West J Emerg Med. 2012;13(1):17-25. doi:10.5811/westjem.2011.9.6864

• Baldaçara L, Ismael F, Leite V, et al. Brazilian guidelines for the management of psychomotor agitation. Part 1. Non-pharmacological approach. Braz J Psychiatry. 2018;41(2):153-167. doi:10.1590/1516-4446-2018-0163

• Baldaçara L, Diaz AP, Leite V, et al. Brazilian guidelines for the management of psychomotor agitation. Part 2. Pharmacological approach. Braz J Psychiatry. 2019;41(4):324-335. doi:10.1590/1516-4446-2018-0177

• Pompoli A, Furukawa TA, Imai H, et al. Psychological therapies for panic disorder with or without agoraphobia in adults: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4(4):CD011004. doi:10.1002/14651858.CD011004.pub2

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

06 · G1 · agendado 2026-11-08 08:00 (Bahia)

Primeiro atendimento em psiquiatria na UBS: guia prático para residentes

Motivo: medicamento · ~6 min

Olá, colega residente ou estudante. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de troca sobre a prática diária na Atenção Primária à Saúde. Sei bem o quanto o primeiro atendimento em saúde mental na UBS pode parecer desafiador. Afinal, a porta de entrada da comunidade nos traz uma mistura intensa de sintomas físicos, sofrimento emocional e histórias de vida complexas. Aqui, nosso objetivo é descomplicar esse momento. Vamos juntos organizar o raciocínio clínico, garantir um espaço seguro de escuta e definir condutas práticas que respeitam tanto o paciente quanto os limites do nosso nível de atenção.

Guia Prático

Acolhimento e Escuta Inicial

O primeiro passo é sempre a criação de um vínculo seguro. Receba seu paciente com calma, postura aberta e olhar atento.

• Permita que a pessoa fale sobre o que a aflige sem interrupções precipitadas nos primeiros minutos.

• Observe a comunicação não verbal: postura, tom de voz, contato visual e grau de agitação ou lentificação.

• Valide o sofrimento relatado. Nunca minimize a dor do outro, mesmo que os exames físicos estejam normais.

Raciocínio Clínico na APS

Na Atenção Primária, nosso foco não é buscar rótulos complexos, mas entender a funcionalidade e o impacto do sofrimento na vida da pessoa.

• Investigação de fatores orgânicos: lembre-se de que muitas condições clínicas simulam transtornos mentais. Avalie uso de substâncias, alterações tireoidianas e distúrbios metabólicos.

• Diferencie uma reação normal a um evento estressor agudo de um transtorno mental instalado.

• Avalie sempre o risco atual. Pergunte diretamente sobre pensamentos de morte ou desesperança, pois isso não induz o ato.

O Que Fazer na Rotina

• Organize os registros de forma clara, focando na história longitudinal e no impacto funcional.

• Estabeleça um plano terapêutico singular, construído junto com o paciente e, quando possível, com sua rede de apoio.

Fisiopatologia

Fisiopatologia Simplificada

Compreender os mecanismos biológicos e sociais por trás do sofrimento mental nos ajuda a explicar os sintomas aos pacientes com mais empatia e clareza.

Desregulação dos Circuitos Neurais

Os quadros mais comuns na APS, como transtornos ansiosos e episódios depressivos, envolvem alterações

na neurotransmissão em circuitos cerebrais ligados à regulação do humor, do medo e da resposta ao estresse. Sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos e gabaérgicos participam ativamente dessa modulação.

O Eixo Estresse e Resposta

A exposição crônica a adversidades e traumas ativa de forma persistente o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Esse desgaste biológico altera a resposta ao cortisol, gerando um estado de inflamação de baixo grau e exaustão física e mental.

O Modelo Biopsicossocial

Nenhum adoecimento mental ocorre no vácuo. A vulnerabilidade genética interage diretamente com determinantes sociais, eventos de vida recentes e estratégias individuais de enfrentamento. Olhar para esse conjunto é o que nos permite atuar de forma realmente eficaz na APS.

Manejo Clínico

Manejo Clínico na UBS

O manejo na APS deve ser resolutivo, seguro e pautado em intervenções de primeira linha.

Condutas de Primeira Linha

• Psicoeducação: explique o diagnóstico de forma simples, desmistificando o sofrimento mental e orientando sobre o tratamento.

• Intervenções psicossociais breves e ativação de redes de apoio comunitário.

• Quando indicado o uso de psicofármacos, utilize medicamentos de primeira linha, iniciando com doses baixas e aumentando de forma gradual.

• Classes comuns: Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) para ansiedade e depressão, com dose inicial baixa e titulação gradual segundo a bula e o protocolo local (CANMAT 2023, PMID 38711351; WFSBP 2012, PMID 22540422).

Sinais de Gravidade e Riscos

Fique atento aos seguintes sinais que exigem reavaliação imediata:

• Ideação suicida estruturada, plano elaborado ou tentativa recente.

• Sintomas psicóticos agudos com desorganização grave do pensamento ou comportamento.

• Agitação psicomotora intensa sem resposta a medidas verbais.

• Risco iminente de violência contra terceiros ou grave vulnerabilidade social.

Quando e Como Encaminhar

O encaminhamento para o ambulatório especializado ou CAPS deve ser criterioso e reservado para casos específicos.

• Indicações: refratariedade a duas tentativas com medicações de primeira linha em doses adequadas e tempo hábil, dúvida diagnóstica complexa ou risco grave.

• Como fazer: encaminhe com um resumo clínico detalhado, informando as medicações já utilizadas, os motivos da troca ou interrupção e o suporte social disponível.

Pontos-chave

• O acolhimento empático e a validação do sofrimento são fundamentais no primeiro atendimento na UBS.

• Investigue sempre causas orgânicas e o uso de substâncias antes de fechar qualquer hipótese.

• Pergunte abertamente sobre pensamentos de morte para avaliar o risco com segurança.

• Utilize intervenções de primeira linha e reserve os encaminhamentos para casos refratários ou graves.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Simon GE, Moise N, Mohr DC. Management of Depression in Adults: A Review. JAMA. 2024;332(2):141-152. PMID 38856993. doi:10.1001/jama.2024.5756 — Revisão

• Lam RW, Kennedy SH, Adams C, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2023 Update on Clinical Guidelines for Management of Major Depressive Disorder in Adults. Can J Psychiatry. 2024;69(9):641-687. PMID 38711351.

doi:10.1177/07067437241245384 — Diretriz clínica (CANMAT)

• Bandelow B, Sher L, Bunevicius R et al.. Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psychiatry Clin Pract. 2012;16(2):77-84. PMID 22540422. doi:10.3109/13651501.2012.667114 — Diretriz clínica (WFSBP, versão para atenção primária)

• Roppolo LP, Morris DW, Khan F et al.. Improving the management of acutely agitated patients in the emergency department through implementation of Project BETA (Best Practices in the Evaluation and Treatment of Agitation). J Am Coll Emerg Physicians Open. 2020;1(5):898-907. PMID 33145538. doi:10.1002/emp2.12138 — Diretriz (Project BETA) e revisão

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

A receita dobrada no bolso do casaco

Motivo: medicamento + dúvida da checagem · ~5 min

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Esta é uma narrativa composta por personagens e situações fictícios inspirados em vivências comuns na Atenção Primária, sem paciente real identificável. O casaco de frio estava pendurado na cadeira da sala há quase uma semana. No bolso esquerdo, dobrada em quatro, repousava a receita médica. Para Roberto, de quarenta e oito anos, aquele papel branco representava um peso muito maior do que os vincos deixados pelo tecido. Olhar para ele trazia uma mistura de alívio e vergonha. Na cabeça de Roberto, pedir ajuda sempre pareceu sinal de fraqueza. Durante anos, ele aprendeu que o homem da casa precisa dar conta de tudo sozinho, sem reclamar da dor ou do cansaço. O peito apertado, as noites mal dormidas e a irritação constante com os filhos foram tratados por muito tempo apenas como cansaço do trabalho. Ouvir de si mesmo que precisava de um médico não foi fácil. A consulta na Unidade Básica de Saúde aconteceu quase por acaso, após uma insistência carinhosa da esposa. Na sala de atendimento, a conversa foi tranquila. Não houve julgamentos, nem rótulos, nem pressa. O médico ouviu a história de Roberto com calma e acolheu aquele sofrimento que já durava meses. Quando o profissional sugeriu iniciar um

acompanhamento e receitou um medicamento para ajudar a regular o sono e a ansiedade, Roberto sentiu um frio na barriga. Pegou o papel, agradeceu e guardou no bolso. Nos dias seguintes, a resistência interna falou alto. Ele pensava que conseguiria resolver tudo sozinho se esforçasse mais um pouco. Pensava no que os amigos diriam se soubessem. Teve medo de fraquejar. Mas o corpo continuava dando sinais de que o limite havia sido alcançado. A falta de paciência com as pequenas coisas do dia a dia e o nó constante na garganta não desapareciam com força de vontade. Na quarta-feira seguinte, olhando para o reflexo no espelho do banheiro, Roberto percebeu que cuidar de si não era desistir. Era, na verdade, o único jeito de continuar inteiro para quem ele ama. Pegou o casaco, tirou o papel amassado do bolso e caminhou até a farmácia. Dar esse passo não tira de ninguém a força ou a dignidade. Pelo contrário. Reconhecer que precisamos de suporte é um ato de coragem profunda. Se você se reconhece nessa história, saiba que você não precisa carregar tudo sozinho. Procure a sua unidade de saúde e permita-se ser cuidado.

A hesitação de Roberto é comum: crenças sobre masculinidade dificultam que homens procurem ajuda para a depressão1,2, e as preocupações com o remédio pesam tanto quanto a percepção de que ele é necessário na hora de seguir o tratamento3. Os antidepressivos têm eficácia comprovada na depressão do adulto4.

Referências

• Seidler ZE, Dawes AJ, Rice SM, et al. The role of masculinity in men's help-seeking for depression: A

systematic review. Clin Psychol Rev. 2016;49:106-118. doi:10.1016/j.cpr.2016.09.002

• Addis ME, Mahalik JR. Men, masculinity, and the contexts of help seeking. Am Psychol. 2003;58(1):5-14. doi:10.1037/0003-066x.58.1.5

• Horne R, Chapman SCE, Parham R, et al. Understanding patients' adherence-related beliefs about medicines prescribed for long-term conditions: a meta-analytic review of the Necessity-Concerns Framework. PLoS One. 2013;8(12):e80633. doi:10.1371/journal.pone.0080633

• Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366. doi:10.1016/S0140-6736(17)32802-7

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Remédios demais no idoso: como a polifarmácia causa quedas e confusão e como revisar a lista com segurança

Motivo: medicamento · ~4 min

Um remédio para pressão, outro para diabetes, um para dormir, outro para dor, mais um para o estômago. Com o passar dos anos, a lista cresce, muitas vezes prescrita por diferentes médicos que não conversam entre si.

Por que isso é um problema

Com a idade, o corpo processa os medicamentos de outra forma. Remédios que eram seguros podem passar a causar efeitos indesejados, e a combinação de vários aumenta os riscos.

Os Critérios de Beers, atualizados pela Sociedade Americana de Geriatria, reúnem medicamentos que, em geral, devem ser evitados ou usados com cautela por pessoas com 65 anos ou mais. A própria publicação ressalta que essa lista apoia, e não substitui, a decisão clínica compartilhada.1

Os que mais exigem cuidado

• remédios para dormir e calmantes: em idosos, o pequeno ganho no sono vem acompanhado de mais quedas, sonolência de dia e prejuízo da memória;2

• medicamentos com efeito anticolinérgico, como alguns antialérgicos, antidepressivos mais antigos e remédios

para bexiga: o uso prolongado se associou a maior risco de demência.3

Efeitos que podem ser causados por remédios

• confusão mental, esquecimento e sonolência;

• tontura e quedas;

• constipação e retenção de urina;

• alterações de humor;

• perda de apetite.

Como revisar com segurança

• Junte todos os remédios em uso, inclusive os comprados sem receita, chás e suplementos.

• Leve tudo à consulta na UBS, com as receitas.

• Pergunte para que serve cada um e se ainda é necessário.

• Nunca suspenda por conta própria. Alguns, como os calmantes, precisam ser retirados aos poucos.

• Use um organizador de comprimidos e uma lista atualizada.

Informação faz diferença: num ensaio clínico, idosos que receberam um folheto explicando os riscos dos calmantes e como reduzi-los com o médico conseguiram parar o uso com muito mais frequência do que os que não receberam.4

Sinais de alerta

Confusão mental de início rápido, quedas novas, sonolência excessiva ou mudança brusca de comportamento devem ser avaliados logo. Em casos graves, procure atendimento de urgência.

Referências

• 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372

• Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005;331(7526):1169. doi:10.1136/bmj.38623.768588.47

• Coupland CAC, Hill T, Dening T, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1084-1093. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0677

• Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, et al. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014;174(6):890-8. doi:10.1001/jamainternmed.2014.949

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____

[ ] Não publicar

09 · G1 · agendado 2026-11-10 08:00 (Bahia)

A sala de espera que respirava em silêncio

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Esta é uma narrativa composta por personagens e situações fictícios inspirados em vivências comuns na Atenção Primária, sem paciente real identificável. A sala de espera da unidade básica de saúde guardava um silêncio peculiar naquela manhã de segunda-feira. Não era a quietude pacífica de uma biblioteca ou o silêncio confortável de quem aprecia o descanso. Tratava-se daquele silêncio denso, quase palpável, que costuma habitar os espaços onde pessoas aguardam para falar sobre o que pesa no peito. Nas cadeiras de plástico azul, enfileiradas rente à parede, os olhares evitavam o cruzamento direto. Cada um ali carregava seu próprio mundo invisível, feito de noites mal dormidas, pensamentos acelerados ou um aperto persistente no peito que não passava com chá nem com repouso. Dona Maria ajustava a alça da bolsa repetidas vezes, os nós dos dedos brancos de tanta força que fazia. Ao lado dela, um rapaz jovem olhava fixamente para a tela apagada do celular, as pernas balançando num ritmo acelerado que denunciava a urgência de escapar dali ou, pelo menos, de ver logo o seu nome chamado no alto-falante. Na prática da atenção primária e do pronto atendimento,

percebemos que o sofrimento mental tem essa capacidade de isolar a pessoa, mesmo quando ela está rodeada de gente. A sala de espera funciona como um microcosmo da nossa sociedade, onde muitos chegam esgotados por tentarem dar conta de tudo sozinhos. O peso do estigma, o medo de não serem compreendidos e a exaustão física criam uma barreira invisível entre as cadeiras. Quando a porta do consultório finalmente se abre e uma voz chama pelo próximo atendimento, o clima na sala muda sutilmente. Há um suspiro coletivo, um rearranjo de postura nos assentos e uma renovação silenciosa da esperança de que, logo ali atrás daquela porta, haverá alguém disposto a escutar sem julgamentos. Como médico de família, sei que o simples ato de chegar até a unidade de saúde já exige uma coragem imensa de quem sofre. Muitas vezes, o tratamento começa muito antes da prescrição ou da orientação médica; ele se inicia no momento em que a pessoa percebe que não está mais sozinha com a sua dor e que existe uma rede de cuidado pronta para acolher cada respiração contida naquele silêncio.

O silêncio daquela sala tem explicação: o estigma afasta as pessoas do cuidado em saúde mental1,2, e o isolamento, por si só, faz mal à saúde física e emocional3. Quando a pessoa encontra alguém disposto a escutar, o vínculo passa a fazer parte do tratamento4.

Referências

• Clement S, Schauman O, Graham T, et al. What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies.

Psychol Med. 2014;45(1):11-27. doi:10.1017/S0033291714000129

• Thornicroft G, Sunkel C, Alikhon Aliev A, et al. The Lancet Commission on ending stigma and discrimination in mental health. Lancet. 2022;400(10361):1438-1480. doi:10.1016/S0140-6736(22)01470-2

• Leigh-Hunt N, Bagguley D, Bash K, et al. An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation and loneliness. Public Health. 2017;152:157-171. doi:10.1016/j.puhe.2017.07.035

• Flückiger C, Del Re AC, Wampold BE, et al. The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy (Chic). 2018;55(4):316-340. doi:10.1037/pst0000172

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

10 · G1 · agendado 2026-11-10 14:00 (Bahia)

Transtorno bipolar na APS: rastreio e manejo intercrises

Motivo: medicamento · ~7 min

Seja muito bem-vindo, colega residente e futuro colega de profissão. Atender uma pessoa que chega ao posto de saúde com queixa de tristeza profunda é algo rotineiro na nossa prática da Atenção Primária. No entanto, muitas vezes essa aparente depressão unipolar esconde um transtorno bipolar. Como médico de família e comunidade, sei o quanto o primeiro atendimento é crucial. Diferenciar esses quadros evita condutas que podem agravar o sofrimento do paciente, como o uso isolado de antidepressivos. Vamos revisar juntos como fazer esse rastreio, entender o que acontece no cérebro e conduzir o manejo seguro no dia a dia da clínica.

Guia Prático

Guia Prático para o Atendimento na APS

Identificar o transtorno bipolar na atenção primária exige um olhar atento aos detalhes da história clínica. Muitas vezes, a pessoa busca ajuda apenas na fase depressiva, esquecendo-se de relatar os momentos de euforia ou irritabilidade intensa.

O que investigar na consulta

• História longitudinal: Nunca feche o diagnóstico apenas com o retrato do momento atual. Pergunte sobre períodos passados de energia excessiva.

• Sintomas de ativação: Questione se houve fases na vida em que a pessoa dormia muito pouco e acordava disposta, gastava dinheiro impulsivamente ou falava muito rápido.

• Idade de início: Quadros depressivos que começam na adolescência, com múltiplos episódios e história familiar de transtornos de humor, devem levantar suspeita.

• Uso prévio de medicações: Se a pessoa relata que ficou extremamente agitada, irritada ou teve insônia grave ao usar um antidepressivo no passado, acenda um alerta.

O que observar no consultório

• A forma como a pessoa narra sua história pode trazer pistas sobre flutuações de humor.

• Observe a presença de sintomas mistos, onde a tristeza profunda vem acompanhada de forte agitação interna e ansiedade extrema.

• Valide sempre o sofrimento relatado, construindo um vínculo de confiança que permita investigar episódios de mania ou hipomania sem julgamentos.

Fisiopatologia

Fisiopatologia e Mecanismos do Humor

Compreender a base biológica do transtorno bipolar nos ajuda a explicar ao paciente a importância de um tratamento contínuo, mesmo quando ele está bem.

Desregulação dos circuitos cerebrais

• O transtorno bipolar envolve uma instabilidade nos circuitos neurais que regulam as emoções, a energia e os impulsos.

• Há uma alteração na comunicação entre áreas corticais, responsáveis pelo controle racional, e estruturas límbicas, como a amígdala, ligadas à intensidade emocional.

Sistemas de neurotransmissores

• Os neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina apresentam flutuações e desregulação na sensibilidade dos seus receptores.

• O uso isolado de antidepressivos em pacientes com vulnerabilidade bipolar pode hiperestimular vias dopaminérgicas e noradrenérgicas, desencadeando episódios de mania ou estados mistos.

Neuroplasticidade e estresse

• Episódios repetidos de humor não tratado podem causar alterações neuroplásticas a longo prazo, tornando os episódios futuros mais frequentes e difíceis de controlar.

• Os estabilizadores do humor e antipsicóticos atuam justamente modulando esses sistemas, promovendo neuroproteção e estabilização dos circuitos afetivos.

Manejo Clínico

Manejo Clínico e Segurança na APS

O manejo do transtorno bipolar na atenção primária exige cautela, escuta ativa e trabalho em rede. O objetivo principal na fase intercrises é prevenir novas recaídas e manter a estabilidade.

Condutas de primeira linha

• Estabilizadores do humor: O tratamento de escolha envolve classes como os sais de lítio ou anticonvulsivantes moduladores do humor. Para o lítio, o nível no sangue (litemia) orienta a dose, e a faixa é individualizada pelo médico conforme resposta, efeitos e idade. Na manutenção em adultos, o consenso da força-tarefa ISBD/IGSLI indica como padrão 0,60 a 0,80 mmol/L, com a opção de reduzir para 0,40 a 0,60 se houver boa resposta e pouca tolerância, ou de subir para 0,80 a 1,00 se a resposta for insuficiente e a tolerância boa. Em idosos não houve consenso, mas a maioria apoiou uma abordagem mais conservadora, em geral 0,40 a 0,60 mmol/L, com máximo de 0,70 ou 0,80 entre 65 e 79 anos e de 0,70 acima dos 80 (Nolen et al., 2019, PMID 31112628). Como a faixa terapêutica é estreita e há risco de toxicidade, a litemia é repetida com exames periódicos, segundo o protocolo local. Para os anticonvulsivantes, a dose segue a bula e o monitoramento específico de cada fármaco.

• Antipsicóticos atípicos: Podem ser utilizados para controle de sintomas agudos ou manutenção, sempre avaliando o perfil metabólico do paciente.

• Evitar monoterapia com antidepressivos: Se o uso de um antidepressivo for estritamente necessário em episódios depressivos graves, ele deve vir sempre associado a um estabilizador do humor para evitar a virada maníaca.

Sinais de gravidade e alerta

• Mania induzida: Fique atento a insônia total, aceleração do pensamento, ideias de grandeza, comportamento de risco e irritabilidade extrema após iniciar um antidepressivo.

• Risco de automutilação ou suicídio: Avalie sempre a segurança do paciente. Em caso de crise grave, nunca descreva métodos e oriente buscar suporte imediato.

Quando e como encaminhar

• Encaminhe para a psiquiatria ou ambulatório de referência os casos de mania aguda grave, sintomas psicóticos, alto risco de suicídio, resistência ao tratamento na APS ou gestantes com transtorno bipolar.

• Mantenha o acompanhamento compartilhado na APS, garantindo a escuta longitudinal, o apoio às famílias e a continuidade do cuidado.

Pontos-chave

• Investigue sempre episódios prévios de hipomania ou mania em pacientes com quadros depressivos recorrentes.

• Evite o uso isolado de antidepressivos para não desencadear viradas maníacas ou estados mistos.

• O tratamento de manutenção baseia-se no uso seguro de estabilizadores do humor e acompanhamento longitudinal.

• Identifique sinais de gravidade e saiba o momento correto de acionar o suporte especializado.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Goodwin GM, Haddad PM, Ferrier IN et al.. Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: Revised third edition recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2016;30(6):495-553. PMID 26979387. doi:10.1177/0269881116636545 — Diretriz clínica (BAP)

• Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV et al.. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord. 2018;20(2):97-170. PMID 29536616. doi:10.1111/bdi.12609 — Diretriz clínica (CANMAT/ISBD)

• Malhi GS, Bell E, Boyce P et al.. The 2020 Royal Australian and New Zealand College of psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders: Bipolar disorder summary. Bipolar Disord. 2020;22(8):805-821. PMID 33296123. doi:10.1111/bdi.13036 — Diretriz clínica (RANZCP)

• Fountoulakis KN, Tohen M, Zarate CA. Lithium treatment of Bipolar disorder in adults: A systematic review of randomized trials and meta-analyses. Eur Neuropsychopharmacol. 2022;54:100-115. PMID 34980362. doi:10.1016/j.euroneuro.2021.10.003 — Revisão sistemática de ensaios e metanálises (lítio)

• Kishi T, Ikuta T, Matsuda Y et al.. Mood stabilizers and/or antipsychotics for bipolar disorder in the maintenance

phase: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Mol Psychiatry. 2020;26(8):4146-4157. PMID 33177610. doi:10.1038/s41380-020-00946-6 — Metanálise em rede (manutenção)

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

11 · G1 · agendado 2026-11-12 08:00 (Bahia)

O lenço esquecido na cadeira do consultório

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Esta é uma narrativa composta por personagens e situações fictícios inspirados em vivências comuns na Atenção Primária, sem paciente real identificável. A sala de atendimento da unidade de saúde guarda muitos segredos. Entre receitas de rotina, pedidos de exames e conversas sobre a pressão arterial, os minutos vão passando rápido. Mas há dias em que o tempo parece desacelerar. Foi o que aconteceu na tarde em que Mariana sentou na cadeira em frente à minha mesa. Mariana já havia vindo outras vezes. Sempre trazia queixas físicas vagas, dores no corpo que mudavam de lugar e exames laboratoriais perfeitamente normais. Naquele dia, ela vestia um casaco cinza, olhava fixamente para as próprias mãos e respondia às minhas perguntas com monossílabos. Havia uma muralha invisível entre nós, construída pelo medo de não ser compreendida ou de parecer fraca. Conversamos sobre o dia a dia, sobre o cansaço que parecia não passar com o sono. Eu a escutava com atenção, tentando mostrar que ali era um espaço seguro, sem julgamentos. Em consultórios de atenção primária e de pronto atendimento psiquiátrico, a gente aprende que a dor emocional muitas vezes veste

um pijama de sintomas físicos. O corpo grita o que a boca ainda não consegue dizer. Perguntei como estava sendo carregar tudo aquilo sozinha. Foi uma frase simples, dita sem pressa. Naquele instante, a muralha ruiu. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas e o choro contido por meses finalmente encontrou passagem. Ela falou sobre o luto que nunca havia tido tempo de viver, sobre a exaustão de tentar dar conta de tudo e sobre a sensação constante de solidão, mesmo estando rodeada de gente. Não havia fórmulas mágicas para apagar o sofrimento, nem promessas vazias de dias perfeitos. O meu papel ali não era consertar a vida dela com palavras rápidas, mas estar presente. Oferecer um ombro amigo, validar o que ela sentia e garantir que ela não precisava caminhar sozinha. Conversamos sobre caminhos possíveis para cuidar da saúde mental, incluindo o acompanhamento com profissionais de psicologia e psiquiatria, além de estratégias para o autocuidado no dia a dia. Quando a consulta terminou, Mariana respirou fundo, parecendo um pouco mais leve do que quando entrou. Agradeceu com um leve aceno de cabeça e saiu. Só fui perceber o objeto deixado para trás quando fui organizar a sala para o próximo atendimento. Sobre o assento da cadeira, repousava um pequeno lenço de tecido dobrado. Aquele lenço esquecido não era apenas um pedaço de pano. Era o símbolo tangível de uma dor que encontrou alívio ao ser compartilhada, a prova silenciosa de que a escuta atenta tem o poder de acolher e transformar. Se você também estiver enfrentando um momento difícil, saiba que não precisa passar por isso sozinho. Procure ajuda na sua unidade de saúde ou ligue para o Centro de Valorização da Vida através do número 188. Cuidar de si é um ato de coragem.

É comum que a depressão chegue ao consultório como dor no corpo: dor e depressão andam juntas com frequência e se agravam mutuamente1. Perguntas simples, como as do PHQ-9, ajudam a identificar o quadro2, e o cuidado colaborativo na atenção primária melhora a depressão e a ansiedade3. O vínculo construído na consulta também é parte da melhora4.

Referências

• Bair MJ, Robinson RL, Katon W, Kroenke K. Depression and pain comorbidity: a literature review. Arch Intern Med. 2003;163(20):2433-45. doi:10.1001/archinte.163.20.2433

• Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606-13. doi:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x

• Archer J, Bower P, Gilbody S, et al. Collaborative care for depression and anxiety problems. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10(10):CD006525. doi:10.1002/14651858.CD006525.pub2

• Flückiger C, Del Re AC, Wampold BE, et al. The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy (Chic). 2018;55(4):316-340. doi:10.1037/pst0000172

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

12 · G1 · agendado 2026-11-12 08:00 (Bahia)

Insônia refratária na atenção primária: investigação e conduta

Motivo: medicamento · ~6 min

Olá, colega da atenção primária. Quando atendemos alguém na unidade básica de saúde que já tentou de tudo para dormir e continua sem conseguir, sentimos o peso desse sofrimento. A insônia refratária esgota a energia, afeta o humor e desafia nossa prática diária. Vamos conversar sobre como investigar causas secundárias, aplicar a terapia cognitivo-comportamental para insônia adaptada à nossa realidade e conduzir a descontinuação segura de hipnóticos, sempre caminhando junto com a pessoa.

Guia Prático

O que investigar na APS

Quando a higiene do sono básica falha, precisamos olhar além. Pergunte sobre dor crônica, ronco alto com apneias testemunhadas, sintomas depressivos, ansiedade e o uso oculto de substâncias, incluindo café em excesso e álcool.

Passos iniciais

• Use um diário do sono por duas semanas. Ele revela o padrão real deitada na cama versus o tempo dormido.

• Revise medicações em uso que possam atrapalhar o descanso.

• Avalie se há crenças disfuncionais sobre o sono, como achar que o dia seguinte será totalmente perdido após

uma noite em claro.

Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia (TCC-I) na APS

Você não precisa ser terapeuta especializado para iniciar os conceitos básicos no posto:

• Controle de estímulos: Oriente a pessoa a ir para a cama apenas quando tiver sono. Se não dormir em vinte minutos, deve levantar e fazer uma atividade calma em outro ambiente.

• Restrição do sono: Reduza o tempo passado na cama para coincidir com o tempo real de sono, aumentando a eficiência e a pressão de sono.

• Higiene mental: Reserve um momento mais cedo no dia para anotar preocupações e listar pendências.

Fisiopatologia

O modelo dos três fatores

A insônia crônica costuma ser explicada pelo modelo de Spielman, que divide o processo em três fatores:

• Predisposição: Características individuais, como maior reatividade ao estresse ou histórico familiar.

• Precipitação: Acontecimentos de vida agudos, perdas, doenças clínicas ou estresse no trabalho.

• Perpetuação: Mudanças de comportamento que a pessoa adota para tentar resolver o problema, mas que acabam mantendo o quadro.

O ciclo da hiperativação

Com o tempo, o cérebro aprende a associar o quarto e a cama com frustração, ruminação e alerta. Há uma falha nos mecanismos de desligamento cortical. O sistema nervoso simpático permanece ativado quando deveria desacelerar, impedindo a transição natural para as fases mais profundas do sono.

Manejo Clínico

Condutas de primeira linha

A base do tratamento da insônia crônica é a TCC-I. Ela apresenta eficácia superior aos medicamentos a médio e longo prazo, sem os riscos de tolerância e dependência.

Retirada gradual de hipnóticos

Muitos pacientes chegam usando benzodiazepínicos ou agonistas de receptores de benzodiazepínicos por anos.

• Explique que a retirada será lenta e negociada.

• Reduza a dose de forma gradual, por exemplo, diminuindo 10% a 25% da dose a cada uma a duas semanas, com intervalos maiores se surgirem sintomas de retirada; não há consenso sobre o esquema ideal (Watson et al., 2023, PMID 37048577).

• Ofereça suporte frequente durante esse período para manejar a ansiedade de rebote.

Quando usar farmacoterapia de apoio

Se houver comorbidades associadas, medicações sedativas de menor risco podem ser consideradas por

tempo limitado, sempre associadas à TCC-I. Classes como antidepressivos sedativos em baixas doses podem ser avaliadas. A dose exata deve seguir a bula, os protocolos clínicos e a avaliação individual.

Sinais de gravidade e encaminhamento

Encaminhe para avaliação psiquiátrica especializada ou centros de referência se houver:

• Ideação suicida ou autolesão associada ao sofrimento intenso.

• Suspeita forte de apneia obstrutiva grave do sono refratária para avaliação com polissonografia.

• Parasomnias complexas ou quadros psicóticos associados à privação crônica de sono.

Pontos-chave

• A insônia refratária exige investigação ativa de causas secundárias como dor, apneia e transtornos de humor.

• A TCC-I é a conduta de primeira linha e pode ser adaptada para a rotina da atenção primária.

• O diário do sono é ferramenta essencial para entender o padrão real de repouso.

• A retirada de hipnóticos deve ser gradual, negociada e acompanhada de perto para evitar abandono.

Conteúdo educativo, de caráter geral. Condutas, doses e fluxos descritos são orientação geral: respeitam-se sempre os protocolos hospitalares, do Pronto Atendimento (PA) e da rede de saúde locais.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Cheung JMY, Jarrin DC, Ballot O et al.. A systematic review of cognitive behavioral therapy for insomnia implemented in primary care and community settings. Sleep Med Rev. 2018;44:23-36. PMID 30612061. doi:10.1016/j.smrv.2018.11.001 — Revisão sistemática

• Riemann D, Baglioni C, Bassetti C et al.. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6):675-700. PMID 28875581. doi:10.1111/jsr.12594 — Diretriz clínica (europeia)

• Qaseem A, Kansagara D, Forciea MA et al.. Management of Chronic Insomnia Disorder in Adults: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2016;165(2):125-33. PMID 27136449. doi:10.7326/M15-2175 — Diretriz clínica (ACP)

• Watson NF, Benca RM, Krystal AD et al.. Alliance for Sleep Clinical Practice Guideline on Switching or Deprescribing Hypnotic Medications for Insomnia. J Clin Med. 2023;12(7). PMID 37048577. doi:10.3390/jcm12072493 — Diretriz clínica (Alliance for Sleep; desprescrição de hipnóticos)

• Pottie K, Thompson W, Davies S et al.. Deprescribing benzodiazepine receptor agonists: Evidence-based clinical practice guideline. Can Fam Physician. 2018;64(5):339-351. PMID 29760253 — Diretriz clínica (desprescrição de BZRA)

• Espie CA, Emsley R, Kyle SD et al.. Effect of Digital Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia on Health, Psychological Well-being, and Sleep-Related Quality of Life: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2019;76(1):21-30. PMID 30264137. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.2745 — Ensaio clínico randomizado (TCC-I digital)

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

13 · G1 · agendado 2026-11-14 08:00 (Bahia)

O balcão da farmácia e as perguntas não feitas

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Esta é uma narrativa composta por personagens e situações fictícios inspirados em vivências comuns na Atenção Primária, sem paciente real identificável. O balcão da farmácia do posto de saúde costuma ser um ponto de encontro singular. Ali, entre caixas de remédios e carimbos de renovação de receita, muitas histórias silenciosas vêm à tona. Dona Maria esperava pacientemente na fila com sua bolsinha de plástico onde guardava as receitas antigas. Quando chegou sua vez, ela não pediu apenas a continuidade do seu medicamento para ansiedade. Ela segurou a caixinha por alguns segundos, olhou para o chão e perguntou se aquele remédio precisaria acompanhar a vida dela para sempre. Naquele momento, o balcão deixou de ser apenas um espaço de dispensação burocrática. Tornou-se o cenário de uma pergunta não feita que há meses pesava no peito dela. No meu dia a dia como médico de família, percebo que a renovação de uma receita raramente é um ato simples. Por trás do papel timbrado, existem receios sobre dependência, efeitos colaterais que nunca foram mencionados ou o medo de não conseguir lidar com a própria rotina sem o auxílio químico. Dona Maria tinha

medo de que o remédio fosse um sinal de fraqueza pessoal. Convidamos ela para entrar na sala de atendimento, saímos da correria do corredor e conversamos com calma. Expliquei que a medicação é uma ferramenta de suporte, um apoio temporário para que o organismo recupere o equilíbrio, mas que o cuidado nunca se resume ao comprimido. Falamos sobre as pequenas coisas do dia a dia, sobre o sono, sobre as caminhadas na praça que ela havia abandonado e sobre a solidão que apertava nos fins de semana. O tratamento medicamentoso tem seu valor e sua indicação precisa, mas ele ganha real eficácia quando vem acompanhado de escuta e validação do sofrimento. Dona Maria saiu da sala com a receita renovada, mas, principalmente, com a sensação de que não estava sozinha carregando aquele fardo. O balcão da farmácia nos lembra todos os dias que cuidar da saúde mental exige tempo para olhar nos olhos, validar angústias e construir caminhos junto com cada pessoa.

A pergunta de dona Maria merece resposta clara: preocupações com o remédio influenciam a forma como as pessoas seguem o tratamento1. Na ansiedade generalizada, existem medicamentos eficazes2, e a terapia cognitivo-comportamental também funciona3. Quando chega a hora de parar, a retirada deve ser gradual e combinada, para evitar sintomas de suspensão4.

Referências

• Horne R, Chapman SCE, Parham R, et al. Understanding patients' adherence-related beliefs about medicines prescribed for long-term conditions: a meta-

analytic review of the Necessity-Concerns Framework. PLoS One. 2013;8(12):e80633. doi:10.1371/journal.pone.0080633

• Slee A, Nazareth I, Bondaronek P, et al. Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2019;393(10173):768-777. doi:10.1016/S0140-6736(18)31793-8

• Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al. Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depress Anxiety. 2018;35(6):502-514. doi:10.1002/da.22728

• Davies J, Read J. A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based?. Addict Behav. 2018;97:111-121. doi:10.1016/j.addbeh.2018.08.027

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

14 · G2 · agendado 2026-11-04

Remédios numa caixa de sapato

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~5 min

A filha colocou a caixa de sapato sobre a mesa como quem entrega uma prova.

— Está tudo aqui, doutor. Ela toma tudo isso.

Eram quatorze caixas de remédio diferentes. Algumas pela metade, outras vencidas, umas repetidas com nomes comerciais distintos. Receitas de três médicos, de anos diferentes. Um frasco de gotas para dormir que uma vizinha tinha emprestado.

Chamemos a paciente de Dona Iolanda. Oitenta e três anos, viúva, professora primária aposentada. Nos últimos dois meses, tinha caído duas vezes em casa. Andava sonolenta durante o dia, confusa à tarde, às vezes trocava o nome dos netos. A família achava que era demência.

Uma caixa de cada vez

Fomos olhando cada caixa, uma por uma, com calma. Havia dois remédios para dormir, de tipos diferentes. Um antialérgico que ela tomava todas as noites "para relaxar". Um remédio para tontura que, por sua vez, dava mais sono. Dois remédios para pressão que faziam praticamente a mesma coisa. E outros que ela já não sabia para que serviam.

— Cada médico passava um — disse Dona Iolanda. — E eu tomava, para não desobedecer.

Expliquei à família que, com a idade, o corpo lida de outra forma com os remédios. Que alguns deles, especialmente os que dão sono, podem causar confusão, esquecimento e quedas. E que a soma de vários pode fazer parecer que a pessoa está perdendo a memória, quando, às vezes, é o próprio tratamento que precisa ser revisto.

A filha ficou em silêncio. Depois perguntou:

— Então pode não ser demência?

— Primeiro vamos arrumar a caixa — respondi. — Depois vemos.

Arrumar a caixa

Fizemos uma lista única. Retiramos o que era repetido, ajustamos o que precisava continuar e programamos a retirada gradual dos remédios para dormir, que não podiam ser suspensos de uma vez. A neta montou um organizador com os dias da semana. A caixa de sapato foi para a farmácia da unidade, para descarte.

As semanas seguintes foram de ajustes. Mas, aos poucos, Dona Iolanda foi ficando mais desperta. As quedas pararam. Voltou a fazer palavras cruzadas, como fazia antes.

Na consulta de retorno, ela me corrigiu quando errei a data de uma vacina.

— Fui professora quarenta anos, doutor — disse, rindo. — Ninguém me engana com conta.

O que esse encontro me ensinou

Nem toda confusão no idoso é demência. Os Critérios de Beers listam medicamentos que costumam ser inadequados depois dos 65 anos.1 Entre eles, os remédios para dormir, cujo pequeno benefício no sono vem acompanhado de mais quedas e confusão.2 O uso prolongado de medicamentos com efeito anticolinérgico, como alguns antialérgicos, se associa a maior risco de demência.3 E informar o próprio paciente sobre esses riscos ajuda a reduzir o uso com segurança.4 Pedir à família que traga tudo o que a pessoa toma, e olhar cada caixa com calma, é um dos gestos mais simples e mais poderosos da Atenção Primária.

Referências

• 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372

• Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005;331(7526):1169. doi:10.1136/bmj.38623.768588.47

• Coupland CAC, Hill T, Dening T, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1084-1093. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0677

• Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, et al. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER

cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014;174(6):890-8. doi:10.1001/jamainternmed.2014.949

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

15 · G2 · agendado 2026-11-04

Compulsão alimentar e obesidade: tratar a compulsão antes de prometer o peso

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~4 min

"Eu como escondido. À noite, quando todo mundo dorme, abro a geladeira e não consigo parar. Depois me sinto um lixo." Muitas pessoas com obesidade passam anos ouvindo que precisam "fechar a boca", sem que ninguém pergunte se existe compulsão alimentar. Tratar a compulsão pode ser o primeiro passo, antes de qualquer promessa sobre o peso.

O que é o transtorno de compulsão alimentar

É um transtorno alimentar caracterizado por episódios repetidos em que a pessoa:

• come uma quantidade grande de comida num período curto;

• sente que perdeu o controle e não consegue parar;

• come muito rápido, sem fome ou até passar mal;

• come sozinha por vergonha;

• sente culpa, nojo de si ou tristeza depois.

Diferente da bulimia, não há vômitos ou outras compensações regulares. É o transtorno alimentar mais comum entre adultos, segundo as pesquisas mundiais de saúde mental da OMS.1

A relação com a obesidade

Nem toda pessoa com obesidade tem compulsão, e nem toda pessoa com compulsão tem obesidade. Mas as duas condições aparecem juntas com frequência. Entre pessoas que buscam cirurgia bariátrica, a compulsão alimentar está entre os problemas de saúde mental mais comuns.2

Quando a compulsão não é reconhecida, a pessoa costuma receber apenas uma dieta restritiva. A restrição aumenta a fome e o desejo, o que pode alimentar novos episódios. O resultado é o ciclo conhecido: dieta, compulsão, culpa, nova dieta.

Não é falta de força de vontade

A compulsão alimentar é um transtorno, com fatores biológicos, emocionais e ambientais. A vergonha e o estigma do peso pioram o quadro: quem internaliza o preconceito tem mais comportamentos alimentares problemáticos e pior saúde mental.3

Tem tratamento

Uma metanálise de ensaios clínicos mostrou que tratamentos psicológicos, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, reduzem os episódios de compulsão de forma consistente. Alguns medicamentos também têm benefício.4 O tratamento costuma incluir:

• organizar as refeições, sem longos períodos de jejum;

• identificar gatilhos: emoções, horários, lugares, situações;

• trabalhar a vergonha e a autocrítica;

• desenvolver outras formas de lidar com as emoções;

• tratar a depressão ou a ansiedade, quando presentes;

• cuidar do peso depois, ou junto, sem dietas radicais.

O cuidado dos transtornos alimentares envolve equipe multiprofissional e a participação de quem convive com a pessoa.5

Para profissionais

Antes de prescrever uma dieta, pergunte: "Você tem episódios em que sente que perde o controle sobre a comida?" Uma pergunta simples, feita sem julgamento, pode mudar todo o plano de cuidado.

Quando procurar ajuda

Se você se reconheceu neste texto, procure a UBS e conte sobre os episódios. Não é preciso esperar emagrecer ou "ter força de vontade" para começar o tratamento. Se a vergonha vier acompanhada de pensamentos de morte, ligue para o CVV, 188.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Kessler RC, Berglund PA, Chiu WT, et al. The prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Biol Psychiatry. 2013;73(9):904-14. doi:10.1016/j.biopsych.2012.11.020

• Dawes AJ, Maggard-Gibbons M, Maher AR, et al. Mental Health Conditions Among Patients Seeking and Undergoing Bariatric Surgery: A Meta-analysis. JAMA. 2016;315(2):150-63. doi:10.1001/jama.2015.18118

• Romano KA, Heron KE, Sandoval CM, et al. Weight Bias Internalization and Psychosocial, Physical, and Behavioral Health: A Meta-Analysis of Cross-Sectional and Prospective Associations. Behav Ther. 2023;54(3):539-556. doi:10.1016/j.beth.2022.12.003

• Hilbert A, Petroff D, Herpertz S, et al. Meta-analysis of the efficacy of psychological and medical treatments for binge-eating disorder. J Consult Clin Psychol. 2019;87(1):91-105. doi:10.1037/ccp0000358

• Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911. doi:10.1016/S0140-6736(20)30059-3

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

16 · G2 · agendado 2026-11-05

Zolpidem e remédios para dormir: riscos do uso prolongado e o que mudou na receita

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~4 min

O zolpidem e outros remédios para dormir se tornaram muito usados no Brasil. Eles podem ajudar por um curto período, mas o uso prolongado, sem acompanhamento, traz riscos que muitas pessoas desconhecem. Por isso, as regras de prescrição ficaram mais rígidas.

O que mudou

Desde 1º de agosto de 2024, todo medicamento com zolpidem, em qualquer dose, só pode ser vendido com Notificação de Receita B, a "receita azul". A decisão da Anvisa veio depois do aumento das vendas e de relatos de uso abusivo.1

Riscos do uso inadequado

• tolerância: com o tempo, a mesma dose faz menos efeito;

• dependência e insônia de rebote ao parar de repente;

• comportamentos complexos durante o sono, como andar, comer, mandar mensagens ou até dirigir sem lembrar depois;

• sonolência no dia seguinte e risco de acidentes;

• em idosos, mais quedas, fraturas e confusão. Nessa faixa etária, os riscos dos sedativos costumam superar os

benefícios;2

• perigo maior quando misturado com álcool ou outros calmantes.

Qual é o tratamento de primeira escolha para a insônia?

Diretrizes recomendam a terapia cognitivo-comportamental para insônia como primeira opção para adultos com insônia crônica. Remédios podem ser considerados quando ela não é suficiente, por tempo limitado.3

Se você já usa há muito tempo

• não pare de uma vez: converse com o médico sobre uma redução gradual;

• combine a retirada com mudanças de hábitos de sono e, se possível, com TCC para insônia;

• nunca aumente a dose por conta própria nem use o remédio de outra pessoa;

• tome só na cama, quando puder dormir pelo menos 7 a 8 horas.

Em idosos, receber informação clara sobre os riscos levou cerca de um quarto dos participantes a suspender o calmante com orientação, num ensaio clínico.4

Referências

• Conselho Federal de Farmácia. Medicamento contendo zolpidem deverá ser prescrito por meio de Notificação de Receita B (decisão da Anvisa, vigente desde 1º de agosto de 2024). cff.org.br

• Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005;331(7526):1169. doi:10.1136/bmj.38623.768588.47

• Qaseem A, Kansagara D, Forciea MA, et al. Management of Chronic Insomnia Disorder in Adults: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2016;165(2):125-33. doi:10.7326/M15-2175

• Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, et al. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014;174(6):890-8. doi:10.1001/jamainternmed.2014.949

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

17 · G2 · agendado 2026-11-09

Pensamentos de morte: como pedir ajuda e montar seu plano de segurança

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Se você está pensando em morrer, ou em não acordar mais, saiba que esses pensamentos são mais comuns do que parece e que eles podem passar. Eles costumam surgir quando a dor parece maior do que a capacidade de suportá-la naquele momento. Com ajuda, a dor pode diminuir e outras saídas aparecem.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Você não precisa enfrentar isso sozinho

• conte para alguém de confiança o que está sentindo, mesmo que pareça difícil;

• se preferir, ligue para o CVV (188), gratuito, a qualquer hora, ou converse pelo chat;

• procure a UBS, o CAPS ou um pronto atendimento;

• se você corre perigo agora, ligue 192 ou vá a uma emergência.

Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Pesquisas mostram que perguntar e conversar sobre isso de forma acolhedora pode trazer alívio.1

Muitas pessoas em sofrimento procuram a Atenção Primária antes de qualquer outro serviço; contar ao médico de família o que está sentindo é um bom primeiro passo.2

Monte seu plano de segurança

O plano de segurança é uma lista pessoal, feita de preferência junto com um profissional, para usar nos momentos difíceis. Em um estudo em serviços de emergência, o plano de segurança com telefonemas de acompanhamento reduziu em cerca de 45% os comportamentos suicidas nos meses seguintes.3 Ele inclui:

• sinais de alerta pessoais: pensamentos, sentimentos e situações que indicam que a crise está chegando;

• coisas que você pode fazer sozinho para se acalmar ou se distrair;

• pessoas e lugares que ajudam a mudar o foco;

• pessoas a quem pedir ajuda, com os telefones;

• profissionais e serviços para contatar, incluindo o CVV (188) e o SAMU (192);

• como deixar o ambiente mais seguro, afastando meios que possam ser usados para se ferir, com a ajuda de alguém.

Um direito garantido

A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, criada pela Lei 13.819/2019, garante

atendimento e acompanhamento a quem passa por essa situação.4

Para quem está por perto: leve a sério, escute sem julgar, não deixe a pessoa sozinha em momentos de crise e ajude a buscar atendimento no mesmo dia.

Referências

• Dazzi T, Gribble R, Wessely S, et al. Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation? What is the evidence?. Psychol Med. 2014;44(16):3361-3. doi:10.1017/S0033291714001299

• Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-16. doi:10.1176/appi.ajp.159.6.909

• Stanley B, Brown GK, Brenner LA, et al. Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency Department. JAMA Psychiatry. 2018;75(9):894-900. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.1776

• Brasil. Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019 — institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. planalto.gov.br

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

18 · G2 · agendado 2026-11-10

Desemprego e saúde mental: o impacto da perda do trabalho, o risco de suicídio e o que protege

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Perder o emprego não é só perder o salário. É perder a rotina, os colegas, o papel que se tinha na família e, muitas vezes, a sensação de valor. Para muita gente, o desemprego é vivido com vergonha e em silêncio.

O que a ciência mostra

Uma metanálise de 104 estudos encontrou que pessoas desempregadas têm pior bem-estar psicológico e físico do que pessoas empregadas. Apoio social, organização do tempo, condições financeiras e a forma como a pessoa interpreta a situação tiveram forte relação com a saúde mental durante o desemprego.1

Um estudo com dados de 63 países encontrou que o desemprego esteve associado a um aumento de 20% a 30% no risco de suicídio em todas as regiões do mundo.2 A insegurança no emprego também adoece: tanto o medo de perder o trabalho quanto o desemprego se associam a pior saúde mental.3 E, quando o trabalho volta, a qualidade dele importa.4

Sinais de alerta

• tristeza, vergonha e sensação de fracasso que não passam;

• isolamento, evitar amigos e família;

• insônia ou dormir demais, perda da rotina;

• aumento do uso de álcool;

• desesperança sobre o futuro, pensamentos de morte.

O que protege

• Mantenha uma rotina: horários de acordar, procurar vagas, fazer atividade física.

• Não se isole. Conte a amigos e familiares; a rede ajuda na saúde e na busca por trabalho.

• Organize as finanças e conheça seus direitos: seguro-desemprego, FGTS, renegociação de dívidas.

• Cuide do corpo: sono, alimentação e movimento.

• Busque qualificação e serviços públicos de emprego.

• Separe quem você é do emprego que perdeu.

Para gestores e RH

Desligamentos feitos com respeito, comunicação clara e orientação sobre direitos reduzem o impacto para quem sai, e para quem fica.

Quando procurar ajuda

Se a tristeza persistir por semanas ou surgirem pensamentos de morte, procure a UBS ou o CAPS. Em risco imediato, ligue 192 ou 188.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em

emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• McKee-Ryan F, Song Z, Wanberg CR, Kinicki AJ. Psychological and physical well-being during unemployment: a meta-analytic study. J Appl Psychol. 2005;90(1):53-76. doi:10.1037/0021-9010.90.1.53

• Nordt C, Warnke I, Seifritz E, Kawohl W. Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000-11. Lancet Psychiatry. 2015;2(3):239-45. doi:10.1016/S2215-0366(14)00118-7

• Kim TJ, von dem Knesebeck O. Is an insecure job better for health than having no job at all? A systematic review of studies investigating the health-related risks of both job insecurity and unemployment. BMC Public Health. 2015;15:985. doi:10.1186/s12889-015-2313-1

• Harvey SB, Modini M, Joyce S, et al. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occup Environ Med. 2017;74(4):301-310. doi:10.1136/oemed-2016-104015

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

19 · G2 · agendado 2026-11-11

Pornografia e crianças: como falar sobre o assunto antes que a internet fale

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Muitas crianças têm o primeiro contato com pornografia antes dos 12 anos, frequentemente sem procurar: por um link, um vídeo enviado por colegas ou um anúncio. Para os pais, o tema é desconfortável. Mas o silêncio deixa a internet educar sobre sexualidade no lugar da família.

Por que preocupa

Uma revisão de 44 estudos que acompanharam adolescentes ao longo do tempo encontrou associações entre consumo de pornografia e comportamentos sexuais de risco, atitudes mais permissivas, crenças distorcidas sobre consentimento e, em alguns estudos, pior bem-estar, embora os resultados nem sempre sejam consistentes.1 Outra revisão encontrou associação entre exposição à pornografia online e assédio sexual virtual e pior saúde mental em meninas e jovens mulheres.2

• a pornografia mostra relações sem afeto, sem consentimento claro e muitas vezes com violência;

• cria expectativas irreais sobre o corpo e o sexo;

• pode gerar ansiedade, culpa, vergonha e uso compulsivo.

O compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento e a extorsão com essas imagens também atingem adolescentes, o que reforça a importância da conversa precoce.3

Como conversar

• Comece antes: com crianças pequenas, fale sobre o corpo, privacidade e o que fazer se virem algo que as deixe desconfortáveis;

• sem pânico nem vergonha: se descobrir que seu filho viu pornografia, mantenha a calma e converse;

• explique a diferença entre pornografia e relações reais, baseadas em respeito, afeto e consentimento;

• fale de consentimento e de imagens íntimas: pedir, enviar ou repassar nudes tem consequências;

• abra a porta: "Você pode me perguntar qualquer coisa sobre isso".

Proteção no ambiente digital

• use filtros e controles parentais, sabendo que não são infalíveis;

• mantenha os aparelhos fora do quarto à noite;

• o ECA Digital exige que sites de conteúdo adulto adotem mecanismos confiáveis de verificação de idade.4

Atenção: se a criança apresentar comportamento sexualizado inadequado para a idade ou contar que alguém mostrou esse tipo de conteúdo, investigue com cuidado a possibilidade de abuso e procure o Conselho Tutelar ou o Disque 100.

Referências

• Mestre-Bach G, Potenza MN. Adolescents, Pornography Use, and Problematic Pornography Use: A Rapid Systematic Review of Longitudinal Studies. J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry. 2025;36(3):122-134. doi:10.5765/jkacap.250015

• Thomas C, Tinner LE, Bennett J, et al. Is exposure to online misogyny associated with mental health outcomes in girls and young women? A systematic review of longitudinal studies. Womens Health (Lond). 2026;22:17455057261485065. doi:10.1177/17455057261485065

• Patchin JW, Hinduja S. When Sexting Goes Wrong: The Extent of Nonconsensual Sharing and Sextortion Among U.S. Teens. J Adolesc Health. 2026;78(4):572-579. doi:10.1016/j.jadohealth.2025.12.253

• Brasil. Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025 — Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), em vigor desde 17 de março de 2026. planalto.gov.br

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Nudes e sextorsão: como proteger seu filho e o que fazer se acontecer

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

"Se você não mandar mais fotos, vou mostrar para todo mundo." A sextorsão, chantagem com imagens íntimas, é uma forma grave de violência contra adolescentes. Muitos sofrem em silêncio por vergonha e medo da reação dos pais. Saber como agir pode salvar vidas.

O tamanho do problema

• em um estudo nacional nos Estados Unidos, cerca de um terço dos adolescentes já tinha enviado ou recebido imagens íntimas. Entre os que enviaram, cerca de metade teve a imagem repassada sem permissão ou sofreu sextorsão;1

• em outro estudo, cerca de 15% dos adolescentes tinham sido alvo de sextorsão, e a experiência se associou a pensamentos e comportamentos suicidas.2

Como acontece

• perfis falsos se passam por adolescentes e conquistam confiança;

• depois de receber uma imagem, passam a exigir dinheiro, mais fotos ou encontros;

• também pode partir de ex-namorados ou colegas;

• montagens feitas com inteligência artificial também são usadas para chantagem.

Se acontecer com seu filho

• Acolha sem culpar: "Você não está sozinho. A culpa é de quem está chantageando";

• não pague nem envie mais nada: a chantagem costuma continuar;

• não apague as conversas: faça capturas de tela e guarde as provas;

• bloqueie e denuncie o perfil na plataforma;

• registre ocorrência na delegacia, de preferência especializada em crimes cibernéticos. Produzir, armazenar ou divulgar imagens íntimas de menores de 18 anos é crime grave;

• peça a remoção do conteúdo às plataformas e procure a SaferNet Brasil;

• fique atento ao sofrimento e busque apoio psicológico.

O Estatuto da Criança e do Adolescente tipifica como crime produzir, armazenar, divulgar ou usar imagens de cunho sexual envolvendo menores de 18 anos.3

Perguntar diretamente sobre pensamentos de morte não aumenta o risco em jovens; diante de uma situação de exposição, essa conversa é essencial.4

Prevenção

• conversar sobre os riscos de enviar imagens íntimas, sem moralismo;

• explicar que qualquer pedido de foto íntima de um adulto é abuso;

• garantir que ele pode contar qualquer coisa sem perder a confiança dos pais.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Patchin JW, Hinduja S. When Sexting Goes Wrong: The Extent of Nonconsensual Sharing and Sextortion Among U.S. Teens. J Adolesc Health. 2026;78(4):572-579. doi:10.1016/j.jadohealth.2025.12.253

• Patchin JW, Hinduja S. Sextortion and suicide: Implications for adolescent image-based abuse. Child Abuse Negl. 2026;175:107981. doi:10.1016/j.chiabu.2026.107981

• Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente. www.planalto.gov.br

• Gould MS, Marrocco FA, Kleinman M, et al. Evaluating iatrogenic risk of youth suicide screening programs: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;293(13):1635-43. doi:10.1001/jama.293.13.1635

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____

[ ] Não publicar

21 · G2 · agendado 2026-11-16

Delirium no fim da vida: reconhecer, tratar a causa e apoiar a família

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~4 min

De repente, a pessoa fica confusa, não reconhece o quarto, vê coisas que não estão ali ou fica sonolenta e desligada. Para a família, é assustador. Para a equipe, é um sinal de que algo precisa ser investigado.

O que é delirium

Delirium é uma alteração aguda e flutuante da atenção e da consciência, causada por uma condição médica, medicamento ou intoxicação. Pode ser hiperativo (agitação, inquietação, alucinações), hipoativo (sonolência, apatia, pouca fala) ou misto. O hipoativo é o mais comum e o mais subdiagnosticado.1

Com que frequência acontece

Em uma unidade de cuidados paliativos, 42% dos pacientes com câncer avançado tinham delirium na admissão, e 88% apresentaram delirium nos dias antes da morte. Quase metade dos episódios foi revertida.2

Causas que vale procurar

• medicamentos: opioides, benzodiazepínicos, anticolinérgicos, corticoides;

• desidratação, alterações de sódio ou cálcio, insuficiência renal ou hepática;

• infecções;

• retenção urinária, constipação, dor não controlada;

• hipóxia, metástases cerebrais;

• abstinência de álcool, nicotina ou sedativos.

A decisão de investigar depende dos objetivos de cuidado. Nos últimos dias de vida, nem sempre faz sentido coletar exames; nas fases anteriores, tratar a causa pode devolver à pessoa dias lúcidos e preciosos.

Como rastrear

O 4AT é uma ferramenta breve, que leva menos de dois minutos e não exige treinamento especializado. Ela avalia alerta, orientação, atenção e mudança aguda, e mostrou boa precisão em idosos.3

Medicamentos: menos é mais

Um ensaio clínico em cuidados paliativos comparou risperidona, haloperidol e placebo para delirium leve a moderado. Os antipsicóticos pioraram os sintomas de delirium em comparação com placebo e causaram mais efeitos extrapiramidais.4 Por isso, a base do tratamento é não farmacológica e etiológica. Antipsicóticos ficam reservados para agitação intensa com sofrimento ou risco, em doses baixas e reavaliadas.

Medidas que ajudam

• presença de familiares, vozes conhecidas e objetos de casa;

• óculos e aparelho auditivo;

• luz de dia, escuro e silêncio à noite;

• reorientação gentil, sem confrontar alucinações;

• hidratação e mobilidade quando possível.

Para a família: a confusão não é "loucura" nem falta de vontade. É um sintoma da doença ou do tratamento. Falar com calma, tocar, contar quem você é e o que está acontecendo ajuda. E vale dizer à equipe se ela está "diferente do normal": você conhece essa pessoa melhor do que ninguém.

Referências

• Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet. 2013;383(9920):911-22. doi:10.1016/S0140-6736(13)60688-1

• Lawlor PG, Gagnon B, Mancini IL, et al. Occurrence, causes, and outcome of delirium in patients with advanced cancer: a prospective study. Arch Intern Med. 2000;160(6):786-94. doi:10.1001/archinte.160.6.786

• Tieges Z, Maclullich AMJ, Anand A, et al. Diagnostic accuracy of the 4AT for delirium detection in older adults: systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2021;50(3):733-743. doi:10.1093/ageing/afaa224

• Agar MR, Lawlor PG, Quinn S, et al. Efficacy of Oral Risperidone, Haloperidol, or Placebo for Symptoms of Delirium Among Patients in Palliative Care: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2017;177(1):34-42. doi:10.1001/jamainternmed.2016.7491

Conteúdo educativo sobre cuidados paliativos e saúde mental. Não substitui a avaliação individual nem a

orientação da equipe que acompanha o paciente e a família. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

22 · G2 · agendado 2026-11-19

Luto por suicídio: o que sentem os que ficam, os riscos para a saúde mental e como apoiar

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Depois de uma morte por suicídio, a família e os amigos costumam ficar com perguntas que não têm resposta: "Por quê?", "O que eu não vi?", "O que eu poderia ter feito?". Somam-se a isso o choque, a culpa e, muitas vezes, o silêncio das pessoas ao redor.

O que mostram os estudos

Uma revisão de 57 estudos mostrou que perder alguém próximo por suicídio se associa a vários impactos na saúde mental, que variam conforme a relação com quem morreu: maior risco de suicídio em parceiros e em mães que perderam um filho adulto, mais internações psiquiátricas em pais e mais depressão em filhos. Também apareceram mais sentimentos de rejeição e vergonha do que após outras mortes.1

Depois de mortes não naturais, como suicídio, homicídio e acidentes, o luto prolongado é bem mais frequente: uma metanálise estimou que pode atingir quase metade das pessoas enlutadas.2

O que é comum sentir

• culpa intensa e repetição de "e se…";

• raiva, inclusive de quem morreu, seguida de culpa por sentir raiva;

• vergonha e medo do julgamento dos outros;

• sensação de abandono;

• tristeza profunda, que pode durar muito tempo.

O que ajuda quem ficou

• Saber que a culpa não é sua. O suicídio tem muitas causas, e ninguém consegue controlar tudo.

• Falar sobre a pessoa e sobre a morte com quem você confia.

• Grupos de apoio para pessoas enlutadas por suicídio. As evidências ainda são limitadas, mas abordagens de apoio, terapêuticas e educativas, com facilitadores treinados, mostram-se promissoras.3

• Cuidado profissional, especialmente se o luto não diminuir com o tempo. O luto complicado tem tratamento específico.4

• Atenção a datas difíceis.

Como apoiar alguém enlutado por suicídio

• diga o nome de quem morreu e esteja presente;

• evite perguntas sobre detalhes da morte;

• não julgue nem procure culpados;

• continue por perto depois das primeiras semanas.

Quando buscar ajuda imediata

Quem perdeu alguém por suicídio também pode ter pensamentos de morte. Se isso acontecer, procure ajuda no mesmo dia: CVV (188), SAMU (192), UBS ou CAPS.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Pitman A, Osborn D, King M, et al. Effects of suicide bereavement on mental health and suicide risk. Lancet Psychiatry. 2014;1(1):86-94. doi:10.1016/S2215-0366(14)70224-X

• Djelantik AAAMJ, Smid GE, Mroz A, et al. The prevalence of prolonged grief disorder in bereaved individuals following unnatural losses: Systematic review and meta regression analysis. J Affect Disord. 2020;265:146-156. doi:10.1016/j.jad.2020.01.034

• Andriessen K, Krysinska K, Hill NTM, et al. Effectiveness of interventions for people bereaved through suicide: a systematic review of controlled studies of grief, psychosocial and suicide-related outcomes. BMC Psychiatry. 2019;19(1):49. doi:10.1186/s12888-019-2020-z

• Shear MK. Clinical practice. Complicated grief. N Engl J Med. 2015;372(2):153-60. doi:10.1056/NEJMcp1315618

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

23 · G2 · agendado 2026-11-23

Autolesão na adolescência: um guia para pais e professores reconhecerem, conversarem e buscarem ajuda

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Descobrir que um filho ou aluno se machuca de propósito assusta. A reação mais comum é o desespero, a bronca ou a vontade de esconder. Mas, para ajudar, é preciso entender o que está por trás.

Mais comum do que se imagina

Uma metanálise com quase 600 mil adolescentes de 41 países encontrou que cerca de 17% já se machucaram de propósito ao menos uma vez. O início costuma ser por volta dos 13 anos, e as meninas são mais afetadas. O motivo mais relatado foi o alívio de pensamentos ou sentimentos difíceis. Pouco mais da metade buscou ajuda, na maioria das vezes de um amigo.1

Não é "para chamar atenção"

A autolesão é uma tentativa de lidar com uma dor emocional que parece insuportável. Ela alivia por um momento, mas não resolve o sofrimento, e tende a se repetir. Adolescentes que se machucam têm risco muito maior de ideação e tentativa de suicídio, especialmente quando a autolesão é frequente.1 Por isso, nunca deve ser minimizada.

Sinais de alerta

• roupas compridas mesmo no calor;

• ferimentos sem explicação ou com explicações repetidas;

• isolamento, irritação, tristeza persistente;

• muito tempo trancado no quarto ou no banheiro;

• mudanças no sono, no apetite e nas amizades.

Como conversar

• Mantenha a calma. Raiva, choro ou ameaças fazem o adolescente se fechar.

• Fale do que você percebeu, com carinho: "Eu notei que você tem se machucado. Estou aqui para ajudar."

• Ouça sem julgar e pergunte o que ele está sentindo.

• Pergunte diretamente se ele já pensou em se matar. Perguntar não aumenta o risco.

• Não prometa segredo. Explique que vai buscar ajuda para protegê-lo.

Ajuda profissional é necessária

Uma metanálise com 19 estudos e mais de 2 mil adolescentes mostrou que intervenções psicológicas e sociais reduzem a autolesão, com melhores resultados para a terapia comportamental dialética, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia baseada em mentalização.2 Também é importante restringir o acesso a meios perigosos em casa.3

O papel da escola

A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio prevê que escolas e serviços de saúde notifiquem os casos suspeitos ou confirmados de autolesão, para que o adolescente e a família sejam acompanhados.4

Onde buscar ajuda

UBS, CAPSi ou serviço de saúde mental. Se houver ferimento grave ou risco imediato, procure a emergência ou ligue 192.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Gillies D, Christou MA, Dixon AC, et al. Prevalence and Characteristics of Self-Harm in Adolescents: Meta-Analyses of Community-Based Studies 1990-2015. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018;57(10):733-741. doi:10.1016/j.jaac.2018.06.018

• Ougrin D, Tranah T, Stahl D, et al. Therapeutic interventions for suicide attempts and self-harm in adolescents: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015;54(2):97-107. doi:10.1016/j.jaac.2014.10.009

• Hawton K, Saunders KE, O'Connor RC. Self-harm and suicide in adolescents. Lancet. 2012;379(9834):2373-82. doi:10.1016/S0140-6736(12)60322-5

• Brasil. Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019 — institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. planalto.gov.br

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

O último comprimido da noite

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~5 min

"Doutor, eu tomo esse remedinho para dormir há vinte e dois anos. Quem me deu foi um médico que já morreu." Dona Aurora disse isso rindo, como quem conta uma história de família.

Chamemos essa senhora assim. Setenta e oito anos, viúva, morava com uma neta. Tinha vindo à unidade por causa de uma queda no banheiro, de madrugada, que deixou um hematoma no braço e um susto enorme na família. Na lista de remédios, entre a pressão e o colesterol, estava o calmante que ela usava todas as noites desde os cinquenta e poucos anos.

A neta contou outras coisas: a avó andava esquecida, repetia perguntas, às vezes acordava confusa e não lembrava como tinha chegado à sala. "A gente achou que era a idade."

Um velho companheiro

Expliquei, com calma, que o remédio que tinha ajudado tanto lá atrás podia, agora, estar contribuindo para as quedas, para os esquecimentos e para aquela confusão da madrugada. Que, com a idade, o corpo passa a lidar de outro jeito com esse tipo de medicação.

Ela ficou séria. "Sem ele eu não durmo, doutor. Já tentei uma vez e passei a noite inteira olhando para o teto."

Eu não tinha pressa, e disse isso a ela. Não íamos tirar nada de uma vez. Combinamos uma redução muito lenta,

ao longo de meses, com retornos frequentes. Falamos sobre o sono: o cochilo longo depois do almoço, a televisão ligada até tarde, o café da tarde que ela adorava. Ela escolheu por onde começar. A neta ficou responsável por organizar os comprimidos e anotar como tinham sido as noites.

Houve semanas difíceis. Noites mais curtas, um pouco de ansiedade, um telefonema dela dizendo que ia desistir. Seguramos a redução no mesmo ponto por mais tempo, sem voltar atrás, e conversamos de novo sobre o porquê de tudo aquilo.

Quase um ano depois, ela tomou o último comprimido. Não houve festa. Houve uma frase, dita na consulta seguinte, enquanto mostrava o braço sem nenhuma marca: "Estou dormindo menos horas, mas acordo sabendo onde estou. Tinha esquecido como era isso."

O que esse encontro me ensinou

Muitos tratamentos começam com uma boa razão e continuam por inércia. Rever medicamentos antigos, principalmente em pessoas idosas, é uma forma de cuidado tão importante quanto prescrever algo novo. E a retirada só funciona quando é feita no ritmo da pessoa, com paciência, presença e a garantia de que ela não vai ficar sozinha nas noites mais difíceis.

Em idosos, os ganhos de sono com calmantes são pequenos diante do risco de quedas, confusão e acidentes.1 Os Critérios de Beers recomendam evitar benzodiazep ínicos em pessoas idosas.2 Informação clara sobre os riscos levou cerca de um quarto dos idosos a suspender o calmante com orientação, num ensaio

clínico.3 A terapia cognitivo-comportamental para insônia é o tratamento de primeira escolha e ajuda na retirada.4

Referências

• Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005;331(7526):1169. doi:10.1136/bmj.38623.768588.47

• 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372

• Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, et al. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014;174(6):890-8. doi:10.1001/jamainternmed.2014.949

• Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6):675-700. doi:10.1111/jsr.12594

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

25 · G2 · agendado 2026-11-23

Sedação paliativa: o que é, quando é indicada e por que não é eutanásia

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~4 min

Poucas decisões em cuidados paliativos geram tanta dúvida quanto a sedação paliativa. Bem indicada e bem explicada, ela é um ato de cuidado. Mal compreendida, pode deixar culpa e desconfiança na família.

O que é

Sedação paliativa é o uso monitorado de medicamentos para reduzir o nível de consciência de uma pessoa com doença avançada, com o objetivo de aliviar um sofrimento insuportável causado por sintomas refratários, isto é, que não responderam a todos os tratamentos adequados em tempo aceitável.

Quando é considerada

• delirium agitado refratário nos últimos dias de vida;

• falta de ar intensa sem resposta a outras medidas;

• dor refratária;

• situações agudas como hemorragia maciça;

• sofrimento existencial refratário, situação mais controversa, que exige avaliação cuidadosa por equipe experiente, incluindo saúde mental.

Princípios éticos

• Intenção: aliviar o sofrimento, e não causar a morte.

• Proporcionalidade: a menor profundidade de sedação capaz de aliviar o sintoma, ajustada conforme a resposta.

• Consentimento: decisão compartilhada com o paciente, quando possível, ou com o representante.

• Registro: indicação, sintomas refratários, conversa com família e plano documentados.

Uma revisão das diretrizes de sedação paliativa no mundo mostrou grande variação de termos e definições entre os documentos, e recomendou que cada serviço deixe claro qual tipo de sedação está tratando e em que situações.1

Por que não é eutanásia

Na eutanásia, a intenção e o resultado esperado são a morte. Na sedação paliativa, a intenção é aliviar o sintoma, a dose é proporcional e a morte decorre da doença. No Brasil, a eutanásia é vedada pelo Código de Ética Médica, que ao mesmo tempo determina oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis.2 A Resolução CFM nº 1.805/2006 garante os cuidados necessários para aliviar o sofrimento na fase terminal.3

Antes de sedar: o delirium

Muitas vezes o sintoma que leva a pensar em sedação é o delirium agitado. Antes, é preciso considerar causas reversíveis e medidas não farmacológicas. Antipsicóticos não mostraram benefício no delirium leve a moderado em cuidados paliativos.4,5

Para a família: é comum sentir culpa ("fomos nós que decidimos que ele dormisse"). A decisão foi tomada para aliviar o sofrimento dele, e a doença é o que está levando

à morte. Vocês podem continuar falando com ele, tocando e estando perto. A audição pode permanecer até o fim.

Referências

• Tomczyk M, Jaques C, Jox RJ. Clinical Practice Guidelines on Palliative Sedation Around the World: A Systematic Review. J Palliat Care. 2022;40(1):58-71. doi:10.1177/08258597221138674

• Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.217/2018 — Código de Ética Médica (art. 41 e parágrafo único; princípios fundamentais XXII). sistemas.cfm.org.br

• Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.805/2006. Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida, garantindo os cuidados necessários para aliviar os sintomas. sistemas.cfm.org.br

• Lawlor PG, Gagnon B, Mancini IL, et al. Occurrence, causes, and outcome of delirium in patients with advanced cancer: a prospective study. Arch Intern Med. 2000;160(6):786-94. doi:10.1001/archinte.160.6.786

• Agar MR, Lawlor PG, Quinn S, et al. Efficacy of Oral Risperidone, Haloperidol, or Placebo for Symptoms of Delirium Among Patients in Palliative Care: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2017;177(1):34-42. doi:10.1001/jamainternmed.2016.7491

Conteúdo educativo sobre cuidados paliativos e saúde mental. Não substitui a avaliação individual nem a orientação da equipe que acompanha o paciente e a família. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

26 · G2 · agendado 2026-11-26

Anorexia, bulimia e transtorno alimentar restritivo/evitativo (TARE): sinais que não podem passar

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~4 min

Os transtornos alimentares não são escolhas, fases ou vaidade. São doenças sérias, com complicações físicas e psicológicas, e estão entre os transtornos mentais com maior risco de morte. Reconhecer os sinais cedo faz toda a diferença no tratamento.

São mais comuns do que se imagina

Uma revisão de estudos publicados entre 2000 e 2018 mostrou que os transtornos alimentares são frequentes no mundo todo, especialmente entre mulheres, e que a prevalência média aumentou ao longo do período, passando de 3,5% para 7,8%.1 Eles atingem também homens, embora sejam menos reconhecidos neles.2

Anorexia nervosa

• restrição alimentar intensa e baixo peso;

• medo intenso de engordar, mesmo estando muito magro;

• percepção distorcida do próprio corpo;

• exercício excessivo, contagem obsessiva de calorias;

• perda da menstruação, tontura, frio, queda de cabelo, pelos finos no corpo.

Bulimia nervosa

• episódios de compulsão alimentar, com sensação de perda de controle;

• comportamentos para compensar: vômitos, laxantes, diuréticos, jejum ou exercício excessivo;

• peso que pode ser normal, o que dificulta o reconhecimento;

• idas ao banheiro logo após as refeições, feridas nos dedos, inchaço nas bochechas, problemas nos dentes.

Transtorno de compulsão alimentar

Episódios repetidos de comer grandes quantidades com perda de controle, seguidos de culpa, sem compensações regulares. É o transtorno alimentar mais comum entre adultos.3

Transtorno alimentar restritivo/evitativo (TARE)

Também chamado de ARFID, sigla em inglês. A pessoa restringe a alimentação não por medo de engordar, mas por desinteresse pela comida, aversão a texturas, cheiros ou cores, ou medo de engasgar, vomitar ou passar mal. Pode levar a perda de peso, deficiências nutricionais e prejuízo na vida social. É frequentemente confundido com "frescura" ou "criança enjoada para comer".

Sinais gerais de alerta

• mudanças importantes de peso;

• evitar refeições em família ou comer escondido;

• regras rígidas sobre comida, rituais à mesa;

• preocupação constante com peso, calorias e forma do corpo;

• isolamento, irritabilidade, tristeza;

• uso de roupas largas para esconder o corpo.

Um questionário simples, o SCOFF, com cinco perguntas, ajuda a rastrear transtornos alimentares na consulta.4

Tratamento

O tratamento envolve equipe multiprofissional, com acompanhamento médico, nutricional e psicológico, e a participação da família, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes.5 Quanto mais cedo começar, melhor tende a ser a evolução. Em situações de risco físico, pode ser necessária internação.

Como abordar alguém

• escolha um momento tranquilo e privado;

• fale do que você observou e da sua preocupação, sem acusar;

• evite comentários sobre peso e aparência;

• espere negação; ela é comum;

• ofereça ajuda concreta para buscar atendimento.

Quando procurar ajuda

Procure a UBS diante de qualquer sinal de alerta. Desmaios, palpitações, fraqueza intensa, vômitos

frequentes ou pensamentos de morte são motivo de atendimento imediato. Em caso de pensamentos de morte, ligue também para o CVV, 188.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Galmiche M, Déchelotte P, Lambert G, et al. Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period: a systematic literature review. Am J Clin Nutr. 2019;109(5):1402-1413. doi:10.1093/ajcn/nqy342

• Murray SB, Nagata JM, Griffiths S, et al. The enigma of male eating disorders: A critical review and synthesis. Clin Psychol Rev. 2017;57:1-11. doi:10.1016/j.cpr.2017.08.001

• Kessler RC, Berglund PA, Chiu WT, et al. The prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Biol Psychiatry. 2013;73(9):904-14. doi:10.1016/j.biopsych.2012.11.020

• Morgan JF, Reid F, Lacey JH. The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. BMJ. 1999;319(7223):1467-8. doi:10.1136/bmj.319.7223.1467

• Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911. doi:10.1016/S0140-6736(20)30059-3

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

27 · G2 · agendado 2026-11-30

Violência sexual: o atendimento nas primeiras 72 horas e o cuidado da saúde mental depois

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Depois de uma violência sexual, a pessoa pode estar em choque, com vergonha, medo de não acreditarem nela e sem saber para onde ir. Saber o caminho, antes, ajuda.

O que a lei garante

A Lei nº 12.845/2013 determina que hospitais do SUS ofereçam atendimento emergencial, integral e multidisciplinar a pessoas em situação de violência sexual, independentemente de boletim de ocorrência. O atendimento inclui diagnóstico e tratamento de lesões, profilaxia da gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis, coleta de material para exames, amparo psicológico e informação sobre direitos.1

Por que as primeiras 72 horas importam

• a profilaxia do HIV deve começar o quanto antes, idealmente nas primeiras horas, e no máximo em 72 horas;

• a contracepção de emergência é mais eficaz quanto mais cedo;

• coleta de provas é mais eficaz logo após a violência.

Mesmo depois de 72 horas, vale procurar atendimento: há cuidados, exames e acompanhamento importantes.

Impacto na saúde mental

Violência sexual está entre os eventos com maior peso no estresse pós-traumático nos inquéritos da OMS.2 Uma metanálise mostrou risco aumentado para praticamente todas as formas de sofrimento mental, com associações mais fortes para estresse pós-traumático e suicidalidade.3

A forma do atendimento faz diferença

Pesquisas mostram que, para muitas vítimas, o contato com serviços de saúde, polícia e justiça pode virar uma "segunda violência", quando há descrédito, julgamento ou demora.4 Acolhimento respeitoso, privacidade e informação clara reduzem esse dano.

Nas semanas seguintes

• acompanhar os exames e as profilaxias até o fim;

• buscar acompanhamento psicológico, mesmo que pareça estar tudo bem;

• contar com pessoas de confiança;

• observar sinais de estresse pós-traumático, depressão e uso de álcool;

• procurar ajuda imediata se surgirem pensamentos de morte.

Onde buscar: hospitais de referência para violência sexual, UPA ou UBS (que orientam o encaminhamento), Ligue 180, Delegacia da Mulher. Crianças e adolescentes: Conselho Tutelar e Disque 100.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Brasil. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013 — dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. www.planalto.gov.br

• Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. Eur J Psychotraumatol. 2017;8(sup5):1353383. doi:10.1080/20008198.2017.1353383

• Dworkin ER, Menon SV, Bystrynski J, et al. Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2017;56:65-81. doi:10.1016/j.cpr.2017.06.002

• Campbell R. The psychological impact of rape victims. Am Psychol. 2008;63(8):702-17. doi:10.1037/0003-066X.63.8.702

Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

28 · G2 · agendado 2026-12-02

Remédio para a saúde mental do meu filho? Dúvidas comuns dos pais

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~4 min

"Remédio para criança? Ela vai ficar dopada? Vai viciar? Vai ter que tomar a vida toda?" Quando o médico sugere um medicamento para a saúde mental do filho, é natural que os pais tenham medo e muitas dúvidas. Informação de qualidade ajuda a decidir com segurança.

Quando o remédio pode ser indicado

• TDAH com prejuízo importante na escola, nas relações ou na segurança;

• depressão ou ansiedade moderada a grave que não melhorou só com psicoterapia;

• TOC, tiques graves e algumas situações no autismo, como irritabilidade intensa;

• sempre como parte de um plano maior, com psicoterapia, orientação aos pais e apoio da escola.

Para problemas de comportamento, programas de orientação para pais costumam ser o primeiro passo, com eficácia demonstrada.1

O que a ciência mostra

• no TDAH, o metilfenidato é a primeira escolha em crianças e adolescentes, com eficácia comprovada a curto prazo;2

• na depressão de crianças e adolescentes, os antidepressivos têm benefício menor do que em adultos. Quando o medicamento é necessário, a fluoxetina teve o melhor perfil nos estudos.3

Em crianças e adolescentes com ansiedade, a sertralina e a terapia cognitivo-comportamental foram eficazes, e a combinação das duas teve o melhor resultado num grande ensaio clínico.4

Perguntas para fazer ao médico

• Qual é o objetivo do medicamento e como vamos medir a melhora?

• Quais efeitos colaterais são esperados e quais são sinal de alerta?

• Por quanto tempo, em princípio, ele vai usar?

• Como será o acompanhamento, com consultas e exames?

• O que acontece se esquecer uma dose?

• Que outras abordagens devem acompanhar o remédio?

Cuidados importantes

• no início do uso de antidepressivos, observe agitação, piora do humor ou falas sobre morte e avise o médico imediatamente;

• guarde os medicamentos fora do alcance de crianças e adolescentes;

• não aumente, diminua ou suspenda por conta própria;

• informe a escola, se for útil para o acompanhamento;

• converse com seu filho sobre o tratamento, de forma adequada à idade.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Furlong M, McGilloway S, Bywater T, et al. Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2012(2):CD008225. doi:10.1002/14651858.CD008225.pub2

• Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2018;5(9):727-738. doi:10.1016/S2215-0366(18)30269-4

• Cipriani A, Zhou X, Del Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Lancet. 2016;388(10047):881-90. doi:10.1016/S0140-6736(16)30385-3

• Walkup JT, Albano AM, Piacentini J, et al. Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med. 2008;359(26):2753-66. doi:10.1056/NEJMoa0804633

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

29 · G2 · agendado 2026-12-03

Anabolizantes na adolescência: dismorfia muscular, riscos e como conversar

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Academias, influenciadores e vídeos prometendo "shape" rápido. Cada vez mais adolescentes e jovens usam anabolizantes, hormônios e "peptídeos" comprados sem receita para ganhar músculos. Por trás dessa busca, muitas vezes há insatisfação intensa com o corpo, e os riscos para a saúde física e mental são sérios.

Dismorfia muscular

Alguns jovens, principalmente meninos, se veem sempre "pequenos" ou "fracos", mesmo com corpo musculoso. Eles podem treinar em excesso, seguir dietas rígidas e usar substâncias para ganhar massa. Essa forma de preocupação com o corpo, ligada à musculatura, é reconhecida entre os transtornos alimentares e de imagem corporal masculinos e muitas vezes passa despercebida.1

A dismorfia muscular se aproxima dos transtornos alimentares, que exigem avaliação e tratamento multiprofissional.2

Riscos dos anabolizantes

• Saúde mental: irritabilidade, agressividade, oscilações de humor, ansiedade e depressão, especialmente ao parar;

• dependência: estima-se que cerca de uma em cada três pessoas que usam esteroides anabolizantes desenvolve dependência;3

• corpo: aumento da pressão arterial e do colesterol, danos ao fígado, acne, queda de cabelo, alterações hormonais e da fertilidade;

• na adolescência: pode comprometer o crescimento e o desenvolvimento;

• produtos falsificados e de origem desconhecida.

A regra no Brasil

O Conselho Federal de Medicina proíbe que médicos prescrevam esteroides anabolizantes com finalidade estética, para ganho de massa muscular ou melhora de desempenho esportivo.4 Quem oferece essas substâncias a adolescentes coloca a saúde deles em risco.

Sinais de alerta para os pais

• ganho muito rápido de massa muscular;

• acne intensa, mudanças de humor, agressividade;

• frascos, seringas ou comprimidos escondidos;

• treino excessivo, mesmo machucado, e sofrimento intenso quando perde um treino;

• preocupação constante com o tamanho dos músculos.

Como conversar

• valorize o interesse por atividade física e alimentação saudável;

• converse sobre padrões irreais nas redes e sobre substâncias "milagrosas";

• procure atendimento de saúde sem julgamento se houver uso: parar exige acompanhamento médico e psicológico.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Murray SB, Nagata JM, Griffiths S, et al. The enigma of male eating disorders: A critical review and synthesis. Clin Psychol Rev. 2017;57:1-11. doi:10.1016/j.cpr.2017.08.001

• Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911. doi:10.1016/S0140-6736(20)30059-3

• Scarth M, Havnes IA, Bjørnebekk A. Anabolic-androgenic steroid use disorder: case for recognition as a substance use disorder with specific diagnostic criteria. Br J Psychiatry. 2025;228(1):68-72. doi:10.1192/bjp.2025.73

• Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.333/2023 — veda a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. portal.cfm.org.br

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

30 · G2 · agendado 2026-12-07

Negligência infantil: a violência silenciosa que mais acontece e menos se vê

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Ela chega à escola sempre com a mesma roupa, com fome, com piolho, com dor de dente. Ninguém vai às reuniões. Ninguém percebe quando ela falta. A negligência não faz barulho, mas machuca.

O que é negligência

Negligência é a omissão dos responsáveis em garantir as necessidades básicas da criança, quando têm condições de fazê-lo: alimentação, higiene, saúde, educação, supervisão, segurança e afeto.

• física: falta de alimentação, higiene, roupas, cuidados de saúde;

• supervisão: crianças pequenas sozinhas ou expostas a perigos;

• educacional: faltas sem motivo, falta de matrícula;

• emocional: indiferença, ausência de afeto e de atenção.

Muito frequente

Uma metanálise estimou que cerca de 16% das pessoas relatam negligência física e 18% negligência emocional na infância, sem diferença entre meninos e meninas. Os autores chamaram atenção para a "negligência da negligência": é a forma de maus-tratos menos estudada.1

Consequências

Outra metanálise mostrou que a negligência na infância está associada a mais depressão, uso de drogas e tentativas de suicídio na vida adulta.2 Em crianças, pode aparecer como atraso no desenvolvimento, dificuldades escolares, apatia ou busca excessiva de atenção de qualquer adulto.

Negligência não é pobreza

Famílias pobres podem não conseguir garantir tudo de que a criança precisa por falta de recursos, e não por omissão. Nesses casos, a resposta é apoio social, e não punição. A avaliação deve considerar se os responsáveis têm condições e não o fazem, ou se precisam de ajuda.

O que fazer

• escola e UBS: conversar com a família, entender o contexto, oferecer apoio;

• CRAS: inclusão em programas sociais e de acompanhamento familiar;

• Conselho Tutelar: quando há risco ou a situação persiste;

• notificação: profissionais de saúde e educação devem comunicar suspeita de maus-tratos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.3

A Lei Henry Borel reforçou os mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes, inclusive com medidas protetivas.4

Denuncie: Disque 100 (gratuito, 24h, pode ser anônimo) ou Conselho Tutelar da sua cidade. Em perigo imediato, 190.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Stoltenborgh M, Bakermans-Kranenburg MJ, van Ijzendoorn MH. The neglect of child neglect: a meta-analytic review of the prevalence of neglect. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012;48(3):345-55. doi:10.1007/s00127-012-0549-y

• Norman RE, Byambaa M, De R, et al. The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2012;9(11):e1001349. doi:10.1371/journal.pmed.1001349

• Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente. www.planalto.gov.br

• Brasil. Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022 (Lei Henry Borel) — cria mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. www.planalto.gov.br

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui

avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

31 · G2 · agendado 2026-12-07

Migração e psicose: por que o risco é maior e o que isso diz sobre exclusão social

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Um dos achados mais consistentes da psiquiatria social é que migrantes, e também seus filhos nascidos no novo país, têm maior risco de desenvolver psicose. A explicação mais provável não está na biologia, e sim na sociedade.

O que os estudos mostram

Uma metanálise com dezenas de estudos encontrou risco de esquizofrenia e transtornos relacionados cerca de 2,3 vezes maior em imigrantes de primeira geração e 2,1 vezes maior na segunda geração. O fato de o risco persistir nos filhos sugere que fatores após a migração pesam mais do que a migração em si.1

Uma metanálise mais recente estimou risco cerca de duas vezes maior de psicoses não afetivas entre migrantes e seus filhos, com os maiores riscos entre migrantes de países em desenvolvimento na Europa. Os autores sugerem que a exclusão social pode ter papel causal.2

Na Suécia, um estudo com 1,3 milhão de pessoas mostrou que refugiados tinham risco maior de psicose do que a população nascida no país e também do que migrantes não refugiados das mesmas regiões.3

Hipóteses para o risco aumentado

• discriminação e derrota social repetidas;

• isolamento e falta de pertencimento;

• traumas antes e durante a migração;

• adversidades socioeconômicas;

• uso de substâncias em alguns contextos.

Cuidado com o diagnóstico

Ao mesmo tempo em que o risco é real, há perigo de diagnóstico errado. Crenças religiosas ou culturais, desconfiança justificada por experiências de perseguição e sintomas de estresse pós-traumático podem ser confundidos com psicose, sobretudo sem intérprete e sem conhecimento cultural.

• usar intérprete profissional;

• perguntar à família e à comunidade se aquilo é comum na cultura de origem;

• avaliar se há traumas e estresse pós-traumático;

• investigar causas clínicas e uso de substâncias.

Prevalência em refugiados

Uma metanálise estimou psicose em cerca de 1,5% das pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio.4 É menos frequente que depressão ou estresse pós-traumático, mas exige cuidado especializado, contínuo e articulado com a rede.

Para famílias: mudanças bruscas de comportamento, falas sem sentido, desconfiança extrema ou isolamento

intenso pedem avaliação rápida no CAPS, na UBS ou no pronto atendimento. Primeiro episódio tratado cedo tem melhor evolução.

Referências

• Bourque F, van der Ven E, Malla A. A meta-analysis of the risk for psychotic disorders among first- and second-generation immigrants. Psychol Med. 2010;41(5):897-910. doi:10.1017/S0033291710001406

• Selten JP, van der Ven E, Termorshuizen F. Migration and psychosis: a meta-analysis of incidence studies. Psychol Med. 2019;50(2):303-313. doi:10.1017/S0033291719000035

• Hollander AC, Dal H, Lewis G, et al. Refugee migration and risk of schizophrenia and other non-affective psychoses: cohort study of 1.3 million people in Sweden. BMJ. 2016;352:i1030. doi:10.1136/bmj.i1030

• Blackmore R, Boyle JA, Fazel M, et al. The prevalence of mental illness in refugees and asylum seekers: A systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2020;17(9):e1003337. doi:10.1371/journal.pmed.1003337

Conteúdo educativo sobre migração e saúde mental. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Prevenção do suicídio em migrantes e refugiados: riscos, sinais e o que fazer

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Falar de suicídio salva vidas. Para migrantes, que muitas vezes estão longe da família, com barreiras de língua e medo de procurar serviços, perguntar e oferecer ajuda é ainda mais importante.

Um risco que varia

O risco de suicídio entre migrantes não é igual para todos. Uma revisão com adolescentes imigrantes de primeira geração encontrou ideação suicida menor na maior parte dos grupos, com exceções em alguns grupos de meninas, e mostrou que a coesão familiar protegeu contra a violência.1 Em crianças e adolescentes refugiados, depressão e suicidalidade aparecem com frequência e precisam ser avaliadas juntas.2 Entre crianças que ficaram no país de origem enquanto os pais migraram, a ideação suicida foi mais frequente.3

Fatores que aumentam o risco

• depressão, estresse pós-traumático e uso de álcool;

• isolamento e perda de vínculos;

• situação migratória insegura, medo de deportação, detenção;

• desemprego, dívidas, sensação de fracasso;

• violência, discriminação e humilhação;

• perdas recentes, inclusive de familiares no país de origem.

Sinais de alerta

• falar em morrer, desaparecer ou ser um peso;

• despedidas, doação de objetos, mensagens de "adeus";

• isolamento súbito, mudanças bruscas de humor;

• aumento do uso de álcool ou drogas;

• desesperança: "não tem saída".

Como perguntar

Perguntar diretamente sobre suicídio não aumenta o risco.4 Use palavras simples e, se precisar, intérprete profissional: "Você tem pensado em morrer ou em tirar a própria vida?" Escute sem julgar. Agradeça a confiança.

O que fazer

• não deixar a pessoa sozinha se houver risco imediato;

• construir um plano de segurança: sinais de alerta, formas de se acalmar, pessoas e serviços para contatar, redução do acesso a meios perigosos;5

• acionar o SAMU 192 ou levar ao pronto atendimento em situação de crise;

• garantir acompanhamento na UBS ou no CAPS nos dias seguintes.

Barreira da língua: o CVV atende em português. Para quem não fala bem português, procure a UBS, o CAPS ou

organizações de apoio a migrantes, que podem ajudar com mediação. Em emergência, o SAMU 192 atende todas as pessoas.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Pottie K, Dahal G, Georgiades K, et al. Do First Generation Immigrant Adolescents Face Higher Rates of Bullying, Violence and Suicidal Behaviours Than Do Third Generation and Native Born?. J Immigr Minor Health. 2015;17(5):1557-66. doi:10.1007/s10903-014-0108-6

• Jin SS, Dolan TM, Cloutier AA, et al. Systematic review of depression and suicidality in child and adolescent (CAP) refugees. Psychiatry Res. 2021;302:114025. doi:10.1016/j.psychres.2021.114025

• Fellmeth G, Rose-Clarke K, Zhao C, et al. Health impacts of parental migration on left-behind children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018;392(10164):2567-2582. doi:10.1016/S0140-6736(18)32558-3

• Dazzi T, Gribble R, Wessely S, et al. Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation? What is the evidence?. Psychol Med. 2014;44(16):3361-3. doi:10.1017/S0033291714001299

• Stanley B, Brown GK, Brenner LA, et al. Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency

Department. JAMA Psychiatry. 2018;75(9):894-900. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.1776

Conteúdo educativo sobre migração e saúde mental. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

33 · G2 · agendado 2026-12-09

Violência psicológica contra crianças: quando as palavras machucam tanto quanto as mãos

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

"Você não presta para nada." "Eu devia ter te deixado no hospital." "Se continuar assim, vou embora e te deixo sozinho." Frases ditas no calor da raiva podem ficar gravadas por décadas.

O que é violência psicológica

A Lei nº 13.431/2017 define a violência psicológica contra crianças e adolescentes como qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática que possa comprometer seu desenvolvimento. Inclui também expor a criança a crimes violentos contra membros da família e a alienação parental.1

Exemplos

• xingar, apelidar de forma humilhante, comparar com irmãos;

• ameaçar de abandono, de castigo extremo ou de violência;

• rejeitar, ignorar, retirar afeto como punição;

• colocar a criança no meio das brigas dos adultos;

• expor a criança a humilhações públicas ou nas redes sociais.

Efeitos

Uma metanálise mostrou que o abuso emocional na infância se associa a risco cerca de três vezes maior de depressão e a mais tentativas de suicídio na vida adulta, com efeitos comparáveis ou maiores que os do abuso físico.2 Crianças expostas a humilhações frequentes podem desenvolver baixa autoestima, ansiedade, dificuldade de confiar e de regular emoções.

Educar sem violência

A Lei Menino Bernardo garante à criança o direito de ser educada sem castigos físicos e sem tratamento cruel ou degradante, incluindo humilhar, ameaçar gravemente ou ridicularizar.3

• nomear o comportamento, e não atacar a pessoa: "isso não pode", em vez de "você é ruim";

• sair de cena quando a raiva estiver alta e voltar depois;

• reparar: pedir desculpas quando passar do ponto também ensina;

• buscar apoio quando o estresse da família estiver alto.

Apoio a pais e cuidadores é uma das estratégias com mais evidência para prevenir violência contra crianças.4

Para quem educa: ninguém acerta sempre. O que importa é o padrão: se as palavras duras viraram rotina, é hora de pedir ajuda. A UBS, o CRAS e grupos de pais podem apoiar.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Brasil. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 — estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência (escuta especializada e depoimento especial). planalto.gov.br

• Norman RE, Byambaa M, De R, et al. The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2012;9(11):e1001349. doi:10.1371/journal.pmed.1001349

• Brasil. Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014 (Lei Menino Bernardo) — estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados sem castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. planalto.gov.br

• World Health Organization et al. INSPIRE: seven strategies for ending violence against children. Genebra: WHO; 2016. www.who.int

Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

34 · G2 · agendado 2026-12-10

Quando a criança conta: como acolher a revelação de violência sexual e o que é escuta protegida

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Muitas crianças e adolescentes demoram anos para contar. Quando finalmente falam, muitas vezes testam o adulto com uma parte pequena da história. A reação desse adulto pode decidir se elas continuam ou se calam de novo.

Por que é tão difícil contar

• medo de não acreditarem;

• vergonha e culpa, muitas vezes estimuladas por quem praticou a violência;

• ameaças ou medo de "destruir a família";

• afeto pela pessoa que praticou a violência, quando é alguém próximo;

• crianças pequenas podem não ter palavras para descrever o que aconteceu.

Consequências de longo prazo

Uma revisão guarda-chuva publicada no Lancet Psychiatry mostrou que a violência sexual na infância se associa a vários transtornos mentais na vida adulta, como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e uso de substâncias, além de problemas psicossociais e de saúde

física.1 A forma como a revelação é acolhida pode reduzir ou agravar esse impacto.

O que fazer quando a criança conta

• manter a calma, mesmo sentindo raiva ou choque;

• acreditar e dizer isso: "Eu acredito em você";

• agradecer a coragem: "Você fez certo em me contar";

• dizer que não é culpa dela;

• não fazer muitas perguntas nem pedir detalhes: isso cabe a profissionais preparados;

• não prometer segredo; explicar que vai buscar ajuda para protegê-la;

• proteger a criança de novo contato com a pessoa suspeita.

Escuta protegida

A Lei nº 13.431/2017 criou a escuta especializada e o depoimento especial, para evitar que a criança tenha de repetir a história muitas vezes a pessoas diferentes, o que causa revitimização.2 O depoimento é feito em ambiente acolhedor, por profissional capacitado.

Estudos com vítimas adultas mostram que, para muitas pessoas, o contato com sistemas de saúde, justiça e polícia pode virar uma "segunda violência", quando há descrédito ou culpabilização.3 O mesmo risco existe para crianças, e por isso a escuta protegida é tão importante.

A quem recorrer

Conselho Tutelar, Disque 100, delegacias especializadas, serviços de saúde (que devem notificar e oferecer cuidados) e CREAS. O Estatuto da Criança e do Adolescente obriga profissionais de saúde e educação a comunicar suspeitas.4

Atendimento de saúde: em violência sexual recente, procure um serviço de saúde o quanto antes, idealmente nas primeiras 72 horas, para cuidados e profilaxias. Depois, acompanhamento psicológico ajuda criança e família.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Hailes HP, Yu R, Danese A, et al. Long-term outcomes of childhood sexual abuse: an umbrella review. Lancet Psychiatry. 2019;6(10):830-839. doi:10.1016/S2215-0366(19)30286-X

• Brasil. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 — estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência (escuta especializada e depoimento especial). planalto.gov.br

• Campbell R. The psychological impact of rape victims. Am Psychol. 2008;63(8):702-17. doi:10.1037/0003-066X.63.8.702

• Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente. www.planalto.gov.br

Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Adultos que sofreram violência sexual na infância: as marcas que aparecem depois e o caminho do cuidado

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

Ela tinha 35 anos quando, numa consulta sobre insônia, disse pela primeira vez em voz alta o que aconteceu quando tinha nove. Nunca tinha contado a ninguém. Disse que não sabia por que estava contando agora.

Por que tantas pessoas demoram a falar

Medo, vergonha, culpa, ameaças, falta de palavras na época, proteção da família, ou simplesmente não terem sido ouvidas quando tentaram. Muitas pessoas passam anos sem ligar seu sofrimento atual ao que viveram na infância.

O que a pesquisa mostra

Uma revisão guarda-chuva publicada no Lancet Psychiatry encontrou associação entre violência sexual na infância e 26 de 28 desfechos estudados, incluindo vários transtornos mentais, como depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, problemas psicossociais e de saúde física.1 O estudo ACE já tinha mostrado que experiências adversas na infância se acumulam e aumentam o risco de depressão, uso de substâncias e tentativas de suicídio.2

Como as marcas podem aparecer

• depressão, ansiedade, crises de pânico;

• lembranças intrusivas, pesadelos, sensação de desligamento;

• dificuldades na intimidade e na sexualidade;

• dificuldade de confiar e de estabelecer limites;

• dores crônicas e queixas físicas;

• uso de álcool e outras drogas, compulsões, autolesão.

Tratamento

Psicoterapias focadas no trauma, como as baseadas em terapia cognitivo-comportamental e o EMDR, têm as melhores evidências para estresse pós-traumático em adultos.3 Em traumas precoces e repetidos, o tratamento costuma começar por segurança, estabilização e regulação emocional.

Quando a pessoa tem filhos

Muitos sobreviventes temem repetir a violência ou não conseguir proteger os filhos. A pesquisa mostra que a transmissão entre gerações existe, mas é moderada, e a maioria não repete.4 Cuidar de si é também proteger quem vem depois.

Para quem viveu isso: não importa quanto tempo passou. Você tem o direito de ser ouvido e cuidado. A UBS e o CAPS podem ser o começo. Contar é decisão sua, no seu ritmo.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Hailes HP, Yu R, Danese A, et al. Long-term outcomes of childhood sexual abuse: an umbrella review. Lancet Psychiatry. 2019;6(10):830-839. doi:10.1016/S2215-0366(19)30286-X

• Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med. 1998;14(4):245-58. doi:10.1016/s0749-3797(98)00017-8

• Lewis C, Roberts NP, Andrew M, et al. Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. Eur J Psychotraumatol. 2020;11(1):1729633. doi:10.1080/20008198.2020.1729633

• Madigan S, Cyr C, Eirich R, et al. Testing the cycle of maltreatment hypothesis: Meta-analytic evidence of the intergenerational transmission of child maltreatment. Dev Psychopathol. 2019;31(1):23-51. doi:10.1017/S0954579418001700

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

36 · G2 · agendado 2026-12-16

Violência sexual na universidade: festas, consentimento e o que fazer depois

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) · ~3 min

A festa era da turma. Ela bebeu e acordou num quarto que não conhecia. Nos dias seguintes, não conseguiu ir à aula. Tinha vergonha, medo e não sabia se "aquilo" contava como violência. Contava.

Consentimento

Consentimento precisa ser livre, claro, informado e pode ser retirado a qualquer momento. Uma pessoa embriagada a ponto de não conseguir decidir, dormindo ou inconsciente não pode consentir. Silêncio não é sim.

Impacto na saúde mental

Uma metanálise mostrou que a violência sexual se associa a aumento do risco de praticamente todas as formas de sofrimento mental, com as associações mais fortes para estresse pós-traumático e suicidalidade.1 Nos inquéritos da OMS, estupro e outras agressões sexuais estiveram entre os eventos com maior peso no estresse pós-traumático.2

Prevenção em festas e eventos

A Lei nº 14.786/2023 criou o protocolo "Não é Não", que obriga casas noturnas, shows e eventos com venda de bebida alcoólica a adotar medidas para prevenir e responder ao constrangimento e à violência contra mulheres, como acolhimento, preservação de provas e acionamento das autoridades.3 Universidades, atléticas e

centros acadêmicos podem adotar regras semelhantes em seus eventos.

O que fazer depois

• buscar um lugar seguro e uma pessoa de confiança;

• procurar atendimento de saúde o quanto antes, idealmente nas primeiras 72 horas, para contracepção de emergência, profilaxias de infecções e cuidado das lesões;

• se possível, não tomar banho nem trocar de roupa antes do atendimento, para preservar provas, mas buscar atendimento mesmo que já tenha feito isso;

• decidir com calma, e com apoio, sobre o registro policial.

A Lei nº 12.845/2013 garante a toda pessoa em situação de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar no SUS, independentemente de boletim de ocorrência.4

Na universidade

• procure a ouvidoria, a comissão de enfrentamento à violência ou o serviço de apoio ao estudante;

• é possível pedir medidas como mudança de turma ou de orientador;

• o cuidado psicológico ajuda a retomar os estudos.

Não foi culpa sua: roupa, bebida, horário ou ter ido à festa não justificam violência. Ligue 180 para orientação, 190 em emergência, e procure o serviço de saúde mais próximo.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Dworkin ER, Menon SV, Bystrynski J, et al. Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2017;56:65-81. doi:10.1016/j.cpr.2017.06.002

• Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. Eur J Psychotraumatol. 2017;8(sup5):1353383. doi:10.1080/20008198.2017.1353383

• Brasil. Lei nº 14.786, de 28 de dezembro de 2023 — cria o protocolo "Não é Não" para prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher em ambientes de lazer e entretenimento. www.planalto.gov.br

• Brasil. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013 — dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. www.planalto.gov.br

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Primeiro episódio psicótico: orientações essenciais para a família

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~6 min

Perceber que alguém que amamos começou a enxergar ou a acreditar em coisas que não fazem sentido para mais ninguém é uma experiência assustadora. A família costuma ser a primeira a notar quando a realidade parece escapar das mãos de quem está sofrendo. Neste momento, o medo e a confusão são normais, mas o seu apoio calmo faz toda a diferença. Como médico de família e comunidade, acompanho de perto o impacto dessas situações nos lares. Vamos conversar sobre como identificar esses sinais iniciais e o que fazer para proteger e cuidar de quem você ama, sem julgamentos e com muita segurança.

Guia Prático

O que observar no dia a dia

• Mudanças bruscas de comportamento: A pessoa pode se mostrar desconfiada demais sem motivo aparente, achando que está sendo vigiada.

• Alterações na fala e no pensamento: Frases desconexas, ideias repetitivas que não mudam com argumentos lógicos ou a sensação de que os pensamentos estão sendo controlados.

• Alterações sensoriais: Relatos de escutar vozes ou ver coisas que outras pessoas não conseguem perceber.

• Isolamento e descuido: Afastamento repentino dos amigos, abandono de cuidados básicos de higiene e alterações marcantes no sono.

O que fazer no ambiente doméstico

• Mantenha a calma: O tom de voz deve ser sempre suave, pausado e acolhedor. Evite gritar ou demonstrar desespero.

• Não entre em confronto: Tentar convencer a pessoa de que ela está 'errada' ou 'louca' só aumenta a desconfiança e a agitação. Valide o sofrimento dela sem necessariamente concordar com o conteúdo da crença.

• Garanta um ambiente seguro: Remova objetos cortantes ou potencialmente perigosos de perto, mantendo o espaço silencioso e com pouca estimulação visual ou sonora.

• Busque ajuda profissional sem demora: O atendimento médico precoce muda o curso do cuidado. Procure uma unidade de saúde ou o pronto atendimento para uma avaliação presencial.

Fisiopatologia

O que acontece no cérebro durante um episódio psicótico

• Desregulação de neurotransmissores: A psicose não é fraqueza de caráter nem falta de vontade. Ela envolve alterações na forma como os neurônios se comunicam, especialmente através da dopamina em áreas específicas do cérebro.

• Processamento alterado da realidade: Circuitos cerebrais responsáveis por filtrar o que é real e o que é imaginação deixam de funcionar temporariamente de forma harmoniosa.

• Excesso de estímulos: O cérebro passa a interpretar estímulos cotidianos como ameaças ou mensagens direcionadas exclusivamente à pessoa, gerando um estado de alerta constante e exaustão mental.

Manejo Clínico

Condutas iniciais e segurança

• Avaliação médica obrigatória: Todo quadro de ruptura com a realidade exige avaliação presencial com equipe de saúde para descartar causas orgânicas, como uso de substâncias, infecções ou problemas metabólicos.

• Uso de medicamentos: Quando necessário, o tratamento de primeira linha inclui medicamentos antipsicóticos (típicos ou atípicos), cuja escolha e dose devem ser definidas exclusivamente pelo médico após exame físico e mental completo.

• Apoio familiar contínuo: A família atua como ponte fundamental para a adesão ao plano terapêutico e para a redução do estresse ambiental.

Sinais de gravidade e quando buscar urgência

• Risco imediato: Agitação psicomotora extrema, ameaças de agressão a si mesmo ou a terceiros.

• Recusa absoluta de hidratação ou alimentação: Sinais de exaustão física grave.

• Como agir nestes casos: Acione imediatamente os serviços de emergência médica ou dirija-se ao pronto atendimento mais próximo. Nunca hesite em pedir suporte especializado.

Pontos-chave

• A psicose é uma condição médica que altera a percepção da realidade e exige compreensão, não julgamento.

• Evite confrontar delírios ou alucinações; mantenha a calma e valide o sofrimento da pessoa.

• A busca precoce por avaliação médica presencial é essencial para o sucesso do cuidado.

• O tratamento envolve suporte familiar, ambiente seguro e, quando indicado pelo médico, o uso de medicamentos antipsicóticos.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Gleeson JFM, Ludwig K, Stiles BJ et al.. Systematic review and meta-analysis of family-based interventions for early psychosis: Carer and patient outcomes. Schizophr Res. 2025;276:57-78. PMID 39854977. doi:10.1016/j.schres.2025.01.006 — Revisão sistemática e metanálise

• Galletly C, Castle D, Dark F et al.. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice

guidelines for the management of schizophrenia and related disorders. Aust N Z J Psychiatry. 2016;50(5):410-72. PMID 27106681. doi:10.1177/0004867416641195 — Diretriz clínica (RANZCP)

• Breitborde NJ, Moreno FA, Mai-Dixon N et al.. Multifamily group psychoeducation and cognitive remediation for first-episode psychosis: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry. 2011;11:9. PMID 21226941. doi:10.1186/1471-244X-11-9 — Ensaio clínico randomizado

• Yesufu-Udechuku A, Harrison B, Mayo-Wilson E et al.. Interventions to improve the experience of caring for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 2015;206(4):268-74. PMID 25833867. doi:10.1192/bjp.bp.114.147561 — Revisão sistemática e metanálise

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

38 · G2 · agendado 2026-12-22

Delirium no pronto-atendimento: avaliação e manejo para residentes

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~6 min

Olá, colega médico em formação. No ritmo intenso do pronto-socorro, deparar-se com um paciente idoso agitado, confuso ou subitamente sonolento é um desafio frequente. O delirium é uma emergência médica que exige nosso olhar atento e rápido. Muitas vezes, ele é o único sinal de uma infecção grave, de um distúrbio metabólico ou do efeito colateral de uma medicação recente. Como médicos da linha de frente, precisamos agir com calma, buscar a causa de raiz e proteger o paciente, evitando o uso imediato e desnecessário de sedativos.

Guia Prático

A identificação rápida do delirium começa com a observação atenta da história trazida pelos acompanhantes. A característica principal é o início agudo e a flutuação dos sintomas ao longo do dia.

• Converse com quem cuida: Pergunte sempre como o paciente estava dias antes. A alteração cognitiva foi rápida ou gradual?

• Use ferramentas rápidas: O teste CAM (Confusion Assessment Method) é excelente para o pronto-socorro. Avalie a flutuação, a desatenção, o pensamento desorganizado e o nível de consciência.

• Diferencie da demência: Na demência, a perda de memória é crônica e o paciente costuma estar alerta até fases mais avançadas. No delirium, a atenção está profundamente prejudicada e há uma oscilação marcante.

• Exclua causas imediatas: Meça a glicemia capilar logo na chegada. Avalie a saturação de oxigênio e busque sinais de dor não expressa.

• Manejo ambiental: Reduza o excesso de estímulos do pronto-socorro. Mantenha o ambiente iluminado durante o dia, permita a presença de um familiar de confiança e ajude o paciente a usar seus óculos e aparelhos auditivos.

Fisiopatologia

O delirium reflete uma disfunção cerebral difusa, desencadeada por um estresse físico agudo em um cérebro vulnerável.

• Desequilíbrio de neurotransmissores: A deficiência relativa de acetilcolina e o excesso de dopamina desempenham um papel central na gênese dos sintomas agudos.

• Neuroinflamação: Processos infecciosos ou inflamatórios periféricos liberam citocinas que atravessam a barreira hematoencefálica, alterando a atividade neuronal.

• Hipóxia e estresse metabólico: Qualquer queda na oferta de oxigênio ou glicose compromete o metabolismo energético dos neurônios, gerando falhas na comunicação sináptica.

• Vulnerabilidade prévia: Idosos, portadores de demência prévia ou com atrofia cerebral têm menor reserva

funcional, o que reduz o limiar para o desenvolvimento do quadro diante de um gatilho sistêmico.

Manejo Clínico

No pronto-socorro, nossa prioridade absoluta é investigar e tratar o fator desencadeante, e não apenas sedar o paciente.

• Investigação inicial: Solicite exames básicos como hemograma, eletrólitos, função renal, uro análise e gasometria ou raio-x de tórax conforme a suspeita clínica.

• Revisão de drogas: Suspenda ou reduza medicamentos com ação anticolinérgica, opioides, benzodiazepínicos e sedativos que possam estar perpetuando o quadro.

• Sinais de gravidade: Quedas súbitas na saturação, instabilidade hemodinâmica, rigidez nucal ou déficits focais exigem investigação neurológica urgente e suporte intensivo.

• Manejo farmacológico de resgate: Reserve os antipsicóticos apenas para situações em que há risco iminente para o paciente ou para a equipe, ou quando o sofrimento psíquico é intenso e as medidas não farmacológicas falharam.

• Opções medicamentosas: Em casos selecionados de agitação grave, pode-se utilizar antipsicóticos em dose baixa, como a risperidona (atípico) ou o haloperidol (típico de alta potência), sempre por via oral ou conforme a via disponível, utilizando a menor dose possível, sobretudo em idosos, e reavaliando o paciente de perto. Segundo o Project BETA, antipsicóticos em dose baixa são a escolha na agitação com delirium quando os

sintomas persistem depois de tratar a causa e de tentar medidas não farmacológicas (Roppolo et al., 2020, PMID 33145538).

• Encaminhamento: Se houver necessidade de investigação complexa não disponível no local ou se a causa base exigir suporte de terapia intensiva, realize o encaminhamento adequado com a história clínica detalhada.

Pontos-chave

• O delirium é uma urgência médica caracterizada pelo início agudo e flutuante dos sintomas.

• A prioridade no atendimento de emergência é identificar e tratar o gatilho orgânico subjacente.

• Utilize ferramentas rápidas de triagem, como o CAM, e diferencie o quadro da demência crônica.

• Priorize medidas ambientais e suporte familiar antes de recorrer a intervenções farmacológicas.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Ormseth CH, LaHue SC, Oldham MA et al.. Predisposing and Precipitating Factors Associated With Delirium: A Systematic Review. JAMA Netw Open. 2023;6(1):e2249950. PMID 36607634. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.49950 — Revisão sistemática

• Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C et al.. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Crit Care Med. 2018;46(9):e825-e873. PMID 30113379. doi:10.1097/CCM.0000000000003299 — Diretriz clínica (UTI, PADIS)

• Tieges Z, Maclullich AMJ, Anand A et al.. Diagnostic accuracy of the 4AT for delirium detection in older adults: systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2021;50(3):733-743. PMID 33951145. doi:10.1093/ageing/afaa224 — Revisão sistemática e metanálise (acurácia do 4AT)

• Girard TD, Exline MC, Carson SS et al.. Haloperidol and Ziprasidone for Treatment of Delirium in Critical Illness. N Engl J Med. 2018;379(26):2506-2516. PMID 30346242. doi:10.1056/NEJMoa1808217 — Ensaio clínico randomizado (pacientes críticos)

• Roppolo LP, Morris DW, Khan F et al.. Improving the management of acutely agitated patients in the emergency department through implementation of Project BETA (Best Practices in the Evaluation and Treatment of Agitation). J Am Coll Emerg Physicians Open. 2020;1(5):898-907. PMID 33145538. doi:10.1002/emp2.12138 — Diretriz (Project BETA) e revisão

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade

médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

Catatonia na emergência médica: reconhecimento e manejo inicial

Motivo: Nível 1 (aguarda revisão médica) + medicamento · ~7 min

Olá, colega médico. Quando nos deparamos com um paciente imóvel, mudo ou que parece alheio ao mundo no pronto atendimento, nosso coração costuma acelerar. A catatonia é uma síndrome neuropsiquiátrica fascinante e desafiadora que exige nossa atenção imediata. Muitas vezes associada apenas à esquizofrenia, ela pode surgir em diversos contextos clínicos, como infecções, intoxicações, transtornos do humor e condições autoimunes. Reconhecer os sinais sutis e evidentes é o primeiro passo para evitar desfechos catastróficos, como a catatonia letal ou maligna. Vamos revisar juntos como identificar essa emergência e agir rapidamente.

Guia Prático

Guia Prático de Reconhecimento e Manejo

Identificar a catatonia exige um olhar atento e uma avaliação sistemática à beira do leito. Vamos focar nos passos essenciais para o plantão.

O que observar no paciente

• Imobilidade ou estupor: O paciente permanece sem se mover, muitas vezes com o olhar fixo, sem responder a estímulos verbais.

• Mutismo: Ausência total ou escassez extrema de fala, mesmo quando claramente consciente do ambiente.

• Negativismo: Resistência sem motivo aparente a qualquer comando ou tentativa de movimento, ou o oposto, fazendo exatamente o inverso do que foi pedido.

• Flexibilidade cérea: Os membros mantêm a posição em que são colocados pelo examinador, como se fossem feitos de cera.

• Posturamento: Manutenção espontânea de posturas inadequadas ou bizarras contra a gravidade por longos períodos.

• Eco-fenômenos: Repetição automática de palavras ditas por você (ecolalia) ou de movimentos realizados por você (ecopraxia).

Como conduzir a avaliação na emergência

• Aplique a Escala de Bush-Francis (BFCRS): Utilize os primeiros 14 itens para rastreamento rápido. A presença de dois ou mais critérios já sugere fortemente o quadro.

• Realize o teste do lorazepam: Esta é uma manobra diagnóstica e terapêutica de grande valor na emergência. Administre um benzodiazepínico (como o lorazepam), com dose e via definidas pelo médico conforme o protocolo do serviço, e reavalie o paciente após cerca de 5 minutos (via endovenosa), 15 minutos (intramuscular) ou 30 minutos (oral); a resposta por via oral costuma ser mais lenta. Considera-se resposta positiva uma redução de 50% em uma escala padronizada, como a BFCRS, o que torna o diagnóstico mais provável, embora não seja 100% específico (Rogers et al., 2023, PMID 37039129).

• Garanta a segurança clínica: Monitore sinais vitais rigorosamente. A catatonia pode evoluir para a forma letal,

marcada por febre alta, instabilidade autonômica e rigidez extrema, exigindo suporte intensivo imediato.

Fisiopatologia

Fisiopatologia da Catatonia

Compreender o que acontece no cérebro do paciente catatônico nos ajuda a direcionar o tratamento com mais segurança e tranquilidade.

O circuito cortico-estriado-talamo-cortical

Embora os mecanismos exatos ainda sejam objeto de estudo, a principal teoria aponta para uma disfunção nos circuitos que ligam o córtex frontal aos gânglios da base e ao tálamo. Esses circuitos são responsáveis pelo planejamento, iniciação e inibição dos movimentos e comportamentos.

O papel dos neurotransmissores

• Hipoatividade GABAérgica: Há uma redução na atividade dos receptores GABA-A em áreas específicas do córtex frontal e dos gânglios da base. Isso explica a excelente resposta clínica aos moduladores GABAérgicos, como os benzodiazepínicos.

• Disfunção Dopaminérgica: Observa-se frequentemente um estado de hipodopaminergia na via nigroestriatal e mesocortical, o que justifica a cautela extrema com o uso de antipsicóticos em pacientes com catatonia, pois eles podem agravar drasticamente o quadro e precipitar a síndrome neuroléptica maligna.

• Excitotoxicidade Glutamatérgica: O excesso de glutamato em certas fendas sinápticas pode contribuir para a rigidez e o dano neuronal associado às formas mais graves e prolongadas da síndrome.

Manejo Clínico

Manejo Clínico na Emergência

O manejo inicial na sala de emergência ou na unidade básica de saúde deve ser rápido, seguro e focado em reverter o quadro e afastar causas orgânicas.

Condutas de Primeira Linha

• Benzodiazepínicos: O tratamento de primeira linha costuma ser um benzodiazepínico (como o lorazepam), com dose e via definidas pelo médico conforme o protocolo do serviço; a diretriz britânica indica um teste com benzodiazepínicos e/ou eletroconvulsoterapia como primeira linha (Rogers et al., 2023, PMID 37039129). Se houver resposta parcial, reavalie e ajuste a conduta conforme a avaliação clínica.

• Suporte Clínico Geral: Hidratação venosa, prevenção de trombose venosa profunda, proteção de úlceras de pressão e sondagem vesical se houver retenção urinária. Mantenha o paciente em ambiente calmo.

Investigação Etiológica

Enquanto inicia o tratamento sintomático, pesquise causas secundárias:

• Solicite exames laboratoriais básicos: hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia, creatinofosfoquinase

(CPK) e toxicologia.

• Avalie neuroimagem (tomografia de crânio) e punção lombar se houver suspeita de infecção do sistema nervoso central.

• Considere causas autoimunes e encefalites límbicas, especialmente se houver sintomas psicóticos agudos associados.

Sinais de Gravidade e Complicações

Fique atento aos sinais de catatonia letal (ou maligna). Casos graves, como a catatonia maligna, com febre e instabilidade dos sinais vitais, ameaçam a vida (Rogers et al., 2023, PMID 37039129); por isso são tratados como emergência e podem exigir cuidados intensivos, conforme o protocolo do serviço (Apetauerova et al., 2021, PMID 33896535). Os sinais são:

• Febre alta sem foco infeccioso aparente.

• Instabilidade autonômica (taquicardia, flutuação severa da pressão arterial, sudorese intensa).

• Rigidez muscular extrema (em 'cano de chumbo').

• Elevação acentuada da CPK e mioglobinúria.

Quando e Como Encaminhar

• Encaminhe imediatamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI): Se houver sinais de instabilidade autonômica, febre alta, rigidez grave ou se o paciente não responder ao teste com benzodiazep ínicos.

• Eletroconvulsoterapia (ECT): É o padrão-ouro para casos refratários aos benzodiazepínicos ou na catatonia letal. Acione a equipe de psiquiatria e o hospital de referência para avaliação precoce da ECT se o quadro não ceder com os medicamentos.

Pontos-chave

• A catatonia é uma síndrome neuropsiquiátrica grave que vai muito além da esquizofrenia, exigindo reconhecimento rápido no pronto atendimento.

• A Escala de Bush-Francis auxilia no rastreamento sistemático dos sinais motores e comportamentais.

• O teste do lorazepam é uma conduta diagnóstica e terapêutica imediata na emergência.

• A febre e a instabilidade autonômica indicam catatonia letal, exigindo transferência urgente para a UTI.

• Evite o uso de antipsicóticos em altas doses na vigência de catatonia não esclarecida para não agravar o quadro.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Jaimes-Albornoz W, Serra-Mestres J. Catatonia in the emergency department. Emerg Med J. 2012;29(11):863-7. PMID 22389352. doi:10.1136/emermed-2011-200896 — Revisão

• Rogers JP, Oldham MA, Fricchione G et al.. Evidence-based consensus guidelines for the management of

catatonia: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2023;37(4):327-369. PMID 37039129. doi:10.1177/02698811231158232 — Diretriz clínica (consenso da BAP)

• Rogers JP, Zandi MS, David AS. The diagnosis and treatment of catatonia. Clin Med (Lond). 2023;23(3):242-245. PMID 37236789. doi:10.7861/clinmed.2023-0113 — Diretriz clínica

• Apetauerova D, Patel PA, Burns JD et al.. Movement Disorder Emergencies. Neurol Clin. 2021;39(2):615-630. PMID 33896535. doi:10.1016/j.ncl.2021.01.005 — Revisão (emergências, inclusive catatonia maligna)

• Redon M, Virolle J, Montastruc F et al.. The use of antipsychotics in the treatment of catatonia: a systematic review. Eur Psychiatry. 2025;68(1):e48. PMID 40123412. doi:10.1192/j.eurpsy.2025.9 — Revisão sistemática

• Wilson JE, Oldham MA, Francis A et al.. Catatonia: American Psychiatric Association Resource Document. J Acad Consult Liaison Psychiatry. 2025;66(4):277-299. PMID 40368005. doi:10.1016/j.jaclp.2025.05.001 — Documento de recursos da APA

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

40 · G3 · agendado 2026-11-16 08:00 (Bahia)

O domingo à tarde em que o telefone não chamou

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Esta é uma narrativa composta por personagens e situações fictícios inspirados em vivências comuns na Atenção Primária, sem paciente real identificável. O sol de domingo entrava pela janela da sala, mas eu não conseguia me concentrar no livro que estava aberto no meu colo. A xícara de café esfriava na mesinha de centro, esquecida enquanto minha mente teimava em voltar para o consultório que eu havia deixado na sexta-feira à tarde. Naquela última consulta, seu João sentou-se na cadeira com as mãos trêmulas e um olhar que parecia carregar o peso do mundo inteiro. Conversamos bastante. Ele me contou sobre a solidão que apertava o peito desde que perdeu a esposa, sobre os dias que pareciam não ter fim e sobre a vontade sumida de continuar tentando. Naquele momento, avaliei o risco, acolhi sua dor, combinamos estratégias de apoio e redobrei o cuidado para o final de semana, orientando os canais de urgência. Ainda assim, a sexta-feira foi embora deixando aquela pulsação incômoda no peito, o eco silencioso de quem carrega a responsabilidade pelo cuidado comunitário. O trabalho na saúde da família e no atendimento de urgência tem dessas coisas. A gente veste o jaleco, escuta histórias

que rasgam a alma, oferece o melhor ombro e o melhor plano terapêutico que a ciência e a humanidade nos permitem. Mas o jaleco fica no armário do posto quando o expediente acaba. O que não fica no armário é a nossa humanidade. Nós também sangramos, nos preocupamos e nos importamos genuinamente com cada vida que cruza nosso caminho. Olhei para o telefone pela milésima vez naquela tarde. A tela estava escura, sem chamadas perdidas, sem mensagens. No silêncio daquele domingo, aprendi de novo a lidar com a ambiguidade da nossa profissão. O silêncio do telefone podia ser uma boa notícia, o sinal de que a rede de apoio funcionou, de que o plano deu certo e de que ele encontrou um sopro de esperança em casa. Mas a angústia antecipatória insistia em sussurrar dúvidas. Sei que cuidar do outro exige que a gente também aprenda a cuidar de si, a reconhecer nossos limites e a respeitar o tempo das coisas. Se você que me lê agora sente que o peso está grande demais, saiba que você nunca está sozinho. A vida tem dias difíceis, mas sempre há caminhos possíveis para atravessar a tempestade. Se precisar conversar, se a dor apertar e parecer insuportável, lembre-se de que existem pessoas prontas para ouvir você a qualquer hora, com sigilo e respeito. Você pode ligar para o Centro de Valorização da Vida no número 188, ou buscar o atendimento de urgência pelo SAMU 192 e na unidade de saúde mais próxima. Vamos juntos, um passo de cada vez, porque a sua vida importa muito.

O que foi feito naquela sexta tem respaldo: um plano de segurança construído com o paciente, seguido de contatos nos dias seguintes, reduziu quase pela metade o comportamento suicida1, e mensagens breves de acompanhamento também protegem2. Muitas pessoas

que morrem por suicídio passaram pela atenção primária no mês anterior3. E quem cuida também sente: o estresse de lidar com o sofrimento dos outros é real e merece atenção4.

Referências

• Stanley B, Brown GK, Brenner LA, et al. Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency Department. JAMA Psychiatry. 2018;75(9):894-900. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.1776

• Motto JA, Bostrom AG. A randomized controlled trial of postcrisis suicide prevention. Psychiatr Serv. 2001;52(6):828-33. doi:10.1176/appi.ps.52.6.828

• Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-16. doi:10.1176/appi.ajp.159.6.909

• Henderson A, Jewell T, Huang X, et al. Personal trauma history and secondary traumatic stress in mental health professionals: A systematic review. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2024;32(1):13-30. doi:10.1111/jpm.13082

Aviso legal: esta crônica é uma narrativa composta. Personagens, falas e situações são fictícios, inspirados em vivências comuns do cuidado em saúde, e não retratam nenhum paciente real identificável (sigilo médico e Res. CFM).

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

41 · G3 · agendado 2026-11-19 08:00 (Bahia)

Transtorno obsessivo-compulsivo na APS: reconhecimento e manejo inicial

Motivo: medicamento · ~7 min

Olá, colega médico de família e comunidade, generalista ou residente. No nosso dia a dia na Atenção Primária à Saúde, frequentemente ouvimos queixas vagas de ansiedade, rituais repetitivos ou preocupações excessivas com organização e contaminação. Muitas vezes, esses sintomas ficam mascarados por anos até que o paciente receba o diagnóstico correto de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). A demora diagnóstica é uma realidade triste que prolonga o sofrimento das pessoas e impacta profundamente suas famílias. O consultório da APS é o local ideal para mudar essa história. Vamos conversar sobre como identificar os sinais mais sutis, diferenciar hábitos comuns de sintomas incapacitantes e iniciar o cuidado de forma segura, humanizada e resolutiva.

Guia Prático

Guia Prático para o Reconhecimento e Manejo na APS

Identificar o TOC na rotina exige um olhar atento e perguntas direcionadas, pois os pacientes costumam esconder os sintomas por vergonha ou medo de julgamento.

• Investigue com empatia: Pergunte diretamente sobre pensamentos repetitivos que incomodam ou rituais que consomem tempo do dia. Use frases simples como: "Você tem pensamentos que entram na sua cabeça sem convidar e que causam aflição?" ou "Você sente

necessidade de repetir certas ações para se sentir seguro?".

• Avalie o impacto funcional: Um hábito vira sintoma clínico quando consome mais de uma hora por dia, gera sofrimento significativo ou atrapalha o trabalho, os estudos e as relações sociais.

• Diferencie de traços de personalidade: O TOC causa sofrimento ego-distônico, ou seja, o paciente reconhece que os pensamentos e rituais são excessivos ou absurdos, mas não consegue parar sozinho.

• Exclua causas orgânicas e comorbidades: Lembre-se de investigar transtornos de humor, uso de substâncias e condições neurológicas que possam mimetizar ou acompanhar o quadro.

• Estabeleça metas realistas: Na APS, o objetivo inicial é reduzir a intensidade dos sintomas, melhorar a qualidade de vida e preparar o paciente para a abordagem psicoterapêutica estruturada.

Fisiopatologia

Fisiopatologia: O Circuito Cortico-Estriado-Talamo-Cortical

Compreender o mecanismo biológico do TOC nos ajuda a explicar o quadro ao paciente com clareza, tirando a culpa de cima dele e mostrando que se trata de uma condição médica real.

• Disfunção dos circuitos cerebrais: O TOC envolve principalmente a alteração no circuito cortico-estriado-tálamo-cortical (CETC). Esse sistema é responsável pela

filtragem de informações e pelo controle de impulsos e comportamentos motores.

• O papel dos neurotransmissores: A serotonina desempenha um papel central na regulação desse circuito. Baixa disponibilidade ou alteração na sinalização serotoninérgica na fenda sináptica perpetua o ciclo de dúvidas e rituais.

• O ciclo da obsessão e compulsão: O pensamento intrusivo gera ansiedade extrema. O ato compulsivo surge como uma tentativa desesperada de aliviar essa ansiedade. No entanto, o alívio é passageiro, reforçando o circuito e tornando o ciclo cada vez mais forte.

• Desmistificando o sofrimento: Explicar ao paciente que o cérebro dele está com um "filtro travado" ajuda a construir uma aliança terapêutica sólida e aumenta a adesão tanto ao tratamento medicamentoso quanto às orientações de estilo de vida.

Manejo Clínico

Manejo Clínico na APS: Farmacoterapia e Encaminhamento

O tratamento do TOC na atenção primária exige paciência, pois a resposta terapêutica costuma ser mais lenta do que em outros transtornos de ansiedade.

• Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS): São a base do tratamento medicamentoso. Utiliza-se medicações como Fluoxetina, Sertralina, Citalopram ou Paroxetina, com início em dose baixa e titulação gradual, segundo a bula e o protocolo local.

• Ajustes de dose específicos: No TOC, frequentemente precisamos de doses mais altas do que as usadas para depressão ou transtorno de pânico. Aumente a dose de forma gradual conforme a tolerabilidade do paciente. Uma metanálise de doses fixas mostrou maior eficácia com doses mais altas, ao custo de mais abandonos por efeitos adversos (Bloch et al., 2010, PMID 19468281), e uma revisão com meta-regressão estimou o ponto de maior eficácia em cerca de 40 mg de fluoxetina ou equivalente (Xu et al., 2021, PMID 34630180).

• Janela temporal: Oriente o paciente que a melhora clínica pode demorar de oito a doze semanas para se tornar evidente, sendo necessário manter o tratamento de forma contínua.

• Psicoterapia estruturada: A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), com foco específico na técnica de Prevenção de Resposta e Exposição (PER), é o padrão-ouro. O encaminhamento deve ser feito o mais cedo possível.

• Sinais de gravidade e quando encaminhar: Encaminhe para a psiquiatria e rede especializada se houver ideação suicida ativa, incapacidade total para o autocuidado, comorbidades graves resistentes, risco de autolesão ou refratariedade após uso adequado de pelo menos dois ISRS em doses plenas por tempo suficiente.

Pontos-chave

• A demora diagnóstica no TOC é comum e pode ser reduzida com perguntas direcionadas na consulta de APS.

• O TOC envolve o circuito cortico-estriado-tálamo-cortical e desbalanço na neurotransmissão serotoninérgica.

• O tratamento farmacológico de primeira linha utiliza ISRS, frequentemente em doses mais altas e com resposta mais lenta.

• A psicoterapia estruturada com foco em exposição e prevenção de resposta é essencial e deve ser associada precocemente.

• Sinais como ideação suicida ou refratariedade a dois ISRS indicam a necessidade de encaminhamento especializado.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Semenya AM, Bhatnagar P. Diagnosis and Management of Obsessive-Compulsive Disorder in the Primary Care Setting. Am Fam Physician. 2024;110(4):385-392. PMID 39418554 — Revisão

• Bandelow B, Sher L, Bunevicius R et al.. Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psychiatry Clin Pract. 2012;16(2):77-84. PMID 22540422. doi:10.3109/13651501.2012.667114 — Diretriz clínica (WFSBP, versão para atenção primária)

• Bloch MH, McGuire J, Landeros-Weisenberger A et al.. Meta-analysis of the dose-response relationship of SSRI

in obsessive-compulsive disorder. Mol Psychiatry. 2009;15(8):850-5. PMID 19468281. doi:10.1038/mp.2009.50 — Metanálise de ensaios clínicos randomizados (dose-resposta)

• Xu J, Hao Q, Qian R et al.. Optimal Dose of Serotonin Reuptake Inhibitors for Obsessive-Compulsive Disorder in Adults: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis. Front Psychiatry. 2021;12:717999. PMID 34630180. doi:10.3389/fpsyt.2021.717999 — Revisão sistemática com meta-regressão (dose-resposta)

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

42 · G3 · agendado 2026-11-19 14:00 (Bahia)

Transtorno de luto prolongado (CID-11): quando o luto deixa de seguir seu curso

Motivo: medicamento · ~4 min

A maioria das pessoas enlutadas encontra, com o tempo, uma forma de seguir vivendo com a perda. Uma parcela, porém, permanece presa a um sofrimento intenso que paralisa a vida. A CID-11 reconhece esse quadro como transtorno de luto prolongado, e saber identificá-lo evita dois erros: patologizar o luto normal e deixar sem cuidado quem precisa.

Critérios em resumo

• saudade persistente e intensa da pessoa falecida ou preocupação constante com ela;

• dor emocional intensa: tristeza, culpa, raiva, negação, dificuldade de aceitar a morte, sensação de ter perdido parte de si;

• duração de pelo menos 6 meses após a perda na CID-11 (12 meses no DSM-5-TR), acima do esperado para a cultura e o contexto da pessoa;

• prejuízo significativo na vida pessoal, familiar, social ou profissional.

Os critérios do DSM-5-TR e o instrumento PG-13-R foram validados em diferentes amostras e identificaram pessoas com mais ideação suicida e pior funcionamento.1

Quem tem mais risco

Uma meta-análise estimou prevalência de cerca de 10% de luto prolongado após mortes naturais.2 O risco é maior em mortes súbitas ou violentas, por suicídio, em perdas de filhos ou cônjuges, em quem tem transtorno mental prévio e em quem tem pouco apoio social.

Depois de mortes não naturais, como suicídio, homicídio e acidentes, o luto prolongado pode atingir quase metade dos enlutados.3

Abordagem

• perguntar pelo luto em toda consulta de seguimento após uma perda importante;

• diferenciar de depressão maior (anedonia global, autodesvalorização) e de estresse pós-traumático, que podem coexistir;

• avaliar sempre o risco de suicídio;

• a psicoterapia focada no luto tem as melhores evidências;4 antidepressivos ajudam quando há depressão associada;

• grupos de apoio ao luto e redes comunitárias complementam o cuidado.

Ponto de atenção: não existe prazo "certo" para o luto. O diagnóstico se apoia na intensidade, na duração e no prejuízo, não na saudade em si.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Prigerson HG, Boelen PA, Xu J, et al. Validation of the new DSM-5-TR criteria for prolonged grief disorder and the PG-13-Revised (PG-13-R) scale. World Psychiatry. 2021;20(1):96-106. doi:10.1002/wps.20823

• Lundorff M, Holmgren H, Zachariae R, et al. Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2017;212:138-149. doi:10.1016/j.jad.2017.01.030

• Djelantik AAAMJ, Smid GE, Mroz A, et al. The prevalence of prolonged grief disorder in bereaved individuals following unnatural losses: Systematic review and meta regression analysis. J Affect Disord. 2020;265:146-156. doi:10.1016/j.jad.2020.01.034

• Shear MK. Clinical practice. Complicated grief. N Engl J Med. 2015;372(2):153-60. doi:10.1056/NEJMcp1315618

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

43 · G3 · agendado 2026-11-21 14:00 (Bahia)

Transtornos somatoformes na UBS: investigação e manejo clínico

Motivo: medicamento · ~6 min

Olá, colega da Atenção Primária. É muito comum recebermos no consultório pessoas que trazem dores e desconfortos intensos, mas cujos exames complementares não mostram alterações orgânicas graves. Muitas vezes, esses pacientes peregrinam por diferentes serviços, acumulam prescrições e sentem que ninguém acredita no seu sofrimento. Como médicos de família e comunidade, sabemos que a dor é real, mesmo quando não encontramos um marcador laboratorial ou de imagem correspondente. O nosso maior instrumento de trabalho não é o aparelho de ausculta ou o bloco de pedidos de exames, mas sim a relação que construímos com cada pessoa que senta à nossa frente. Vamos conversar sobre como acolher esses quadros na rotina do posto de saúde e do pronto atendimento.

Guia Prático

Guia Prático para o Atendimento na APS

• Valide o sofrimento: Nunca diga que 'não é nada' ou que 'os exames deram normais, então você está bem'. Dizer isso rompe o vínculo. Prefira explicar que o exame afasta doenças graves, mas não anula o que a pessoa sente.

• Estabeleça consultas regulares: Agende retornos periódicos com hora marcada. Isso reduz a necessidade de idas frequentes à emergência por crises agudas de ansiedade somatizada.

• Evite a escalada diagnóstica: Pedir exames em cascata reforça na pessoa a ideia de que há uma doença grave oculta. Investigação prudente sim, exames excessivos não.

• Investigue estressores psíquicos: Explore com cuidado os contextos de perda, sobrecarga familiar, conflitos e vivências traumáticas que podem estar se manifestando através do corpo.

• Pratique a escuta ativa: Deixe que o paciente relate seus sintomas principais sem interrupções precoces. Muitas vezes, a chave do diagnóstico está nas entrelinhas da história de vida.

Fisiopatologia

Compreendendo a Fisiopatologia

Os sintomas somatoformes envolvem uma complexa intersecção entre o sistema nervoso central, o sistema autonômico e os eixos de resposta ao estresse crônico.

• Sensibilização central: O sistema nervoso passa a amplificar os sinais periféricos. Estímulos táteis ou viscerais normais são interpretados pelo cérebro como dor intensa.

• Desregulação autonômica: A hiperativação simpática crônica gera manifestações físicas reais, como taquicardia, sudorese, tensão muscular persistente e distúrbios gastrointestinais.

• Processamento emocional: Circuitos cerebrais responsáveis pela regulação das emoções e pela percepção da dor física se sobrepõem. O afeto que não

encontra palavras para ser expresso acaba encontrando vias somáticas.

• Fatores cognitivos: O hiperfoco nas sensações corporais gera um ciclo vicioso de ansiedade, que por sua vez intensifica ainda mais o sintoma físico percebido.

Manejo Clínico

Manejo Clínico na Atenção Primária

O manejo exige paciência, consistência e uma abordagem multiprofissional sempre que possível.

• Abordagem farmacológica de primeira linha: Quando há comorbidade ansiosa ou depressiva evidente, ou dor crônica refratária, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) ou antidepressivos duais (como a duloxetina) podem auxiliar. Utilize a menor dose efetiva e ajuste gradualmente, conforme a bula e o protocolo local. Evite o uso prolongado de benzodiazepínicos pelo alto risco de dependência e piora da somatização.

• Abordagem não farmacológica: Aconselhamento estruturado, técnicas de respiração e relaxamento, além de incentivo à atividade física regular.

• Sinais de gravidade e bandeiras vermelhas: Perda de peso inexplicada, febre persistente, sinais neurológicos focais, dor noturna progressiva ou alteração anatômica evidente ao exame físico exigem reavaliação e investigação direcionada.

• Quando e como encaminhar: Encaminhe para a psicologia ou psiquiatria da rede quando houver falha terapêutica após vínculo estabelecido, risco de

automutilação, ideação suicida ou sofrimento psíquico incapacitante. Lembre-se de manter o acompanhamento longitudinal na APS, mesmo após o encaminhamento.

Pontos-chave

• A dor relatada é sempre real e merece validação, independentemente dos resultados dos exames complementares.

• A relação médico-paciente fortalecida é a principal ferramenta terapêutica para reduzir a peregrinação médica.

• Consultas regulares agendadas evitam idas desnecessárias ao pronto atendimento e diminuem a iatrogenia.

• O uso de psicofármacos deve ser criterioso, reservado para comorbidades claras e sempre com dose definida pelo médico.

Referências

Referências localizadas no PubMed/MEDLINE (PMID e DOI conferidos nos registros da base). Leitura integral e escolha final das fontes ficam com o Dr. Antônio Felipe.

• Rosendal M, Blankenstein AH, Morriss R et al.. Enhanced care by generalists for functional somatic symptoms and disorders in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2013;2013(10):CD008142. PMID 24142886. doi:10.1002/14651858.CD008142.pub2 — Revisão sistemática Cochrane e metanálise

• Byrne AK, Scantlebury A, Jones K et al.. Communication interventions for medically unexplained symptom conditions in general practice: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. PLoS One. 2022;17(11):e0277538. PMID 36374916. doi:10.1371/journal.pone.0277538 — Revisão sistemática e metanálise

• Abbass A, Town J, Holmes H et al.. Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Functional Somatic Disorders: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Psychother Psychosom. 2020;89(6):363-370. PMID 32428905. doi:10.1159/000507738 — Metanálise de ensaios clínicos randomizados

• Gormley KJ. Medically unexplained symptoms: the need for effective communication and an integrated care strategy. Br J Community Nurs. 2014;19(2):86-90. PMID 24514109. doi:10.12968/bjcn.2014.19.2.86 — Revisão

Se precisar de apoio: CVV 188 (ligação gratuita, 24h) · SAMU 192

Conteúdo produzido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, com revisão e responsabilidade médica final do Dr. Antônio Felipe (Resolução CFM 2.454/2026).

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

44 · G3 · agendado 2026-11-22 14:00 (Bahia)

Autodiagnóstico pelas redes: quando o vídeo ajuda e quando atrapalha

Motivo: medicamento · ~4 min

"Será que tenho TDAH?", "isso é ansiedade ou trauma?", "acho que sou autista". Vídeos curtos sobre saúde mental viralizam todos os dias. Eles ajudam a falar de temas antes escondidos, mas também espalham informações erradas e estimulam o autodiagnóstico.

O lado bom

• reduz o estigma e incentiva conversas sobre saúde mental;

• ajuda algumas pessoas a reconhecerem sinais e a buscarem avaliação;

• cria comunidades de apoio.

Relatos em primeira pessoa podem reduzir preconceitos: o contato com quem vive a experiência é uma das estratégias com mais evidência contra o estigma.1

O lado arriscado

Uma análise dos vídeos mais populares sobre TDAH no TikTok mostrou que cerca de metade era enganosa, e que os conteúdos de profissionais de saúde eram mais confiáveis.2 Outros riscos:

• listas de sintomas muito gerais, em que quase todo mundo se reconhece;

• confundir traços de personalidade ou fases difíceis com transtornos;

• deixar de investigar outras causas, como problemas de tireoide, privação de sono e uso de substâncias;

• compra de cursos, suplementos e "testes" sem validade;

• uso de remédios sem prescrição, especialmente estimulantes.

Por que o diagnóstico precisa de avaliação

Diagnósticos em saúde mental dependem da história completa, de quando os sintomas começaram, de como afetam a vida e da exclusão de outras causas. No TDAH em adultos, por exemplo, os sintomas devem estar presentes desde a infância e em vários contextos.3 Questionários de internet podem ser um ponto de partida, nunca a conclusão.

Mesmo questionários validados, como a escala ASRS para TDAH, servem para rastreio e não substituem a avaliação clínica.4

Como usar as redes a seu favor

• prefira perfis de profissionais identificados, com registro no conselho;

• desconfie de quem vende soluções rápidas;

• anote o que reconheceu em si e leve para a consulta;

• lembre-se de que um vídeo não conhece a sua história.

Referências

• Thornicroft G, Sunkel C, Alikhon Aliev A, et al. The Lancet Commission on ending stigma and discrimination in mental health. Lancet. 2022;400(10361):1438-1480. doi:10.1016/S0140-6736(22)01470-2

• Yeung A, Ng E, Abi-Jaoude E. TikTok and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study of Social Media Content Quality. Can J Psychiatry. 2022;67(12):899-906. doi:10.1177/07067437221082854

• Song P, Zha M, Yang Q, et al. The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. J Glob Health. 2021;11:04009. doi:10.7189/jogh.11.04009

• Kessler RC, Adler L, Ames M, et al. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychol Med. 2005;35(2):245-56. doi:10.1017/s0033291704002892

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

45 · G3 · agendado 2026-11-23 14:00 (Bahia)

Enchentes, calor e desastres climáticos: primeiros cuidados psicológicos e seguimento em saúde mental

Motivo: medicamento · ~4 min

Enchentes, ondas de calor, secas e incêndios estão mais frequentes e já fazem parte da rotina da Atenção Primária e do pronto atendimento. As enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024, mostraram que o sofrimento psicológico após um desastre é amplo, duradouro e chega aos serviços muito depois da água baixar.

O que a evidência mostra

Uma revisão de escopo com 120 estudos associou calor, umidade, chuvas extremas, secas, incêndios e enchentes a sofrimento psicológico, piora de transtornos preexistentes, mais internações psiquiátricas e aumento de suicídios.1 Pessoas com transtorno mental grave, idosos, crianças e trabalhadores expostos ao calor são os mais vulneráveis.

Primeiros cuidados psicológicos (PCP)

Os PCP são uma abordagem humana de apoio imediato, que qualquer profissional treinado pode oferecer. Não são terapia nem "debriefing" forçado.2 Seus princípios:

• observar: segurança, necessidades básicas urgentes, pessoas com reações graves;

• escutar: aproximar-se, oferecer ajuda sem pressionar a pessoa a contar o que viveu, ajudá-la a se acalmar;

• conectar: água, abrigo, documentos, informação, reencontro com familiares e serviços.

Uma revisão sistemática mostrou que as evidências de efeito dos PCP sobre desfechos em saúde mental ainda são escassas e de baixa qualidade.3 Por isso, eles devem vir acompanhados de seguimento e encaminhamento, e não substituir o cuidado.

Depois da fase aguda

• garantir a continuidade de medicamentos psiquiátricos e anticonvulsivantes perdidos no desastre;

• rastrear, a partir de 4 semanas, estresse pós-traumático, depressão, luto e uso de álcool;

• em ondas de calor, revisar lítio, antipsicóticos e anticolinérgicos (risco de desidratação e hipertermia);

• cuidar das equipes: profissionais atingidos também adoecem.

Quando os sintomas de estresse pós-traumático persistem, as terapias focadas no trauma são as mais eficazes.4

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Charlson F, Ali S, Benmarhnia T, et al. Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(9). doi:10.3390/ijerph18094486

• World Health Organization, War Trauma Foundation, World Vision International. Psychological first aid: guide for field workers. Genebra: WHO; 2011. who.int

• Hermosilla S, Forthal S, Sadowska K, et al. We need to build the evidence: A systematic review of psychological first aid on mental health and well-being. J Trauma Stress. 2022;36(1):5-16. doi:10.1002/jts.22888

• Lewis C, Roberts NP, Andrew M, et al. Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. Eur J Psychotraumatol. 2020;11(1):1729633. doi:10.1080/20008198.2020.1729633

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

Quero engordar e não consigo: magreza, saúde e o preconceito que ninguém vê

Motivo: medicamento · ~5 min

"Come mais, menino." "Tá doente?" "Parece um palito." Quem é muito magro e quer ganhar peso também convive com comentários, frustração e, às vezes, com um sofrimento que ninguém leva a sério. Afinal, num país em que a maioria está acima do peso, reclamar da magreza parece privilégio. Mas não é.

Por que algumas pessoas não conseguem engordar

As causas são variadas:

• magreza constitucional: algumas pessoas são naturalmente muito magras, comem normalmente e têm dificuldade de ganhar peso. Estudos mostram que elas têm ingestão de energia normal e um perfil hormonal diferente do da anorexia;1

• doenças clínicas: hipertireoidismo, diabetes descompensado, doenças intestinais, infecções e outras condições;

• questões emocionais: ansiedade e depressão podem reduzir o apetite;

• uso de substâncias: cigarro, estimulantes e algumas drogas;

• transtornos alimentares: inclusive em pessoas que dizem querer engordar.

Por isso, perda de peso sem explicação ou dificuldade persistente de ganhar peso merece avaliação médica.

Quando a magreza traz riscos

O baixo peso pode trazer alterações hormonais, menstruais e ósseas, além de fraqueza e mais vulnerabilidade a doenças.2 Em pessoas idosas, o baixo peso se associa a mais dificuldade nas atividades básicas do dia a dia.3 Na gestação, o baixo peso antes da gravidez se associou a mais sintomas depressivos no pós-parto.4

Atenção: nem todo "quero engordar" é igual

Algumas pessoas com transtornos alimentares dizem querer ganhar peso, mas sentem pânico diante da comida ou de qualquer aumento na balança. Outras têm o transtorno alimentar restritivo/evitativo, em que a restrição não vem do medo de engordar, mas de medo de engasgar, vomitar, ou de aversão a texturas e cheiros. Esses quadros precisam de tratamento especializado.5

O sofrimento de quem é "magro demais"

• comentários constantes da família e de colegas;

• vergonha de usar roupas curtas, ir à praia ou à academia;

• no caso dos homens, a pressão para ser "grande" e "forte";

• frustração com tentativas de comer mais que terminam em mal-estar;

• gastos com suplementos que prometem ganho rápido.

O que ajuda

• avaliação médica para descartar doenças;

• refeições e lanches regulares, com alimentos nutritivos e calóricos de verdade, em vez de grandes quantidades de uma vez;

• exercícios de força, que ajudam a ganhar massa muscular;

• cuidado com suplementos: muitos prometem mais do que entregam, e anabolizantes trazem riscos sérios;

• cuidar do humor e da ansiedade, que interferem no apetite;

• aceitar o próprio biotipo: nem todo corpo foi feito para ficar grande.

Para quem convive

Comentários sobre o corpo magro também ferem. "Você precisa comer mais" pode soar como cuidado para quem fala, mas como cobrança para quem ouve. Assim como não se comenta o corpo de uma pessoa com obesidade, vale não comentar o de quem é muito magro.

Quando procurar ajuda

Procure a UBS se houver perda de peso sem explicação, dificuldade persistente de ganhar peso, medo de comer, vômitos ou sofrimento intenso com a aparência.

Referências

• Bailly M, Boscaro A, Pereira B, et al. Is constitutional thinness really different from anorexia nervosa? A systematic review and meta-analysis. Rev Endocr Metab Disord. 2021;22(4):913-971. doi:10.1007/s11154-021-09650-4

• Fricke C, Voderholzer U. Endocrinology of Underweight and Anorexia Nervosa. Nutrients. 2023;15(16):3509. doi:10.3390/nu15163509

• Lingying W, Hong Z, Hongxiu C, et al. Association of body mass index with disability in activities of daily living in older adults: a systematic review of the literature based on longitudinal data. BMC Public Health. 2025;25(1):6. doi:10.1186/s12889-024-21234-w

• Dachew BA, Ayano G, Betts K, Alati R. The impact of pre-pregnancy BMI on maternal depressive and anxiety symptoms during pregnancy and the postpartum period: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2021;281:321-330. doi:10.1016/j.jad.2020.12.010

• Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911. doi:10.1016/S0140-6736(20)30059-3

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

47 · G3 · agendado 2026-11-27 08:00 (Bahia)

Menopausa: peso, autoestima e humor

Motivo: medicamento · ~5 min

"Eu como a mesma coisa de sempre e engordo." "Não reconheço mais meu corpo." "Ando chorando à toa." Na transição para a menopausa, muitas mulheres sentem que o corpo e o humor mudaram de uma hora para outra. As duas coisas estão ligadas, e ambas merecem cuidado, e não deboche.

O que muda no corpo

Com a queda dos hormônios ovarianos, a gordura tende a se concentrar mais na barriga, a massa muscular diminui e o gasto de energia cai. Muitas mulheres ganham peso na meia-idade, mesmo sem mudar a alimentação. Uma revisão de 2026 sobre o ganho de peso na meia-idade defende uma abordagem com várias frentes: mudanças de estilo de vida, medicamentos e, quando indicado, cirurgia, com atenção especial à preservação da massa muscular.1

Somam-se a isso ondas de calor, suores noturnos, sono ruim, secura vaginal, queda de cabelo e mudanças na pele. Para muitas, é como habitar um corpo desconhecido.

O que muda no humor

A transição para a menopausa é um período de maior vulnerabilidade à depressão, mesmo em mulheres que nunca tiveram o quadro antes.2 Uma metanálise estimou que a depressão é frequente entre mulheres na menopausa no mundo todo.3 As diretrizes para avaliação

e tratamento da depressão perimenopáusica recomendam investigar ativamente o humor nessa fase e oferecer os tratamentos com eficácia comprovada, como psicoterapia e antidepressivos.4

Corpo, autoestima e cobrança

A insatisfação com o corpo não desaparece com a idade: estudos com mulheres mais velhas mostram que ela acompanha a vida inteira, alimentada por discursos "anti-idade" que promovem padrões irreais.5 Na menopausa, somam-se o ganho de peso, as mudanças na pele e no cabelo e a sensação de "ficar invisível".

Para algumas mulheres, a sexualidade também é afetada, por causa da secura vaginal, da queda do desejo e da insegurança com o próprio corpo.

O que ajuda

• conversar com o médico sobre os sintomas, inclusive os de humor e sexualidade;

• avaliar opções de tratamento hormonal ou não hormonal, conforme cada caso;

• exercícios de força, que ajudam a preservar músculos e ossos e melhoram o humor;

• sono: tratar as ondas de calor noturnas e a insônia faz diferença;

• alimentação equilibrada, sem dietas radicais;

• rede de apoio: conversar com outras mulheres na mesma fase alivia a solidão;

• trocar a cobrança pelo cuidado: o objetivo não é voltar ao corpo dos 30, e sim viver bem no corpo dos 50.

E as canetas?

Os medicamentos para obesidade podem ser uma opção para mulheres com obesidade na meia-idade, com indicação e acompanhamento médico. Eles não substituem o cuidado com músculos, ossos, sono e humor.

Quando procurar ajuda

Procure a UBS se a tristeza, a irritabilidade ou a ansiedade estiverem atrapalhando sua vida, ou se você perceber perda de interesse pelas coisas. Se surgirem pensamentos de morte, ligue para o CVV, 188.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Hung S, Adams KE. Midlife weight gain: challenges and solutions. Curr Opin Obstet Gynecol. 2026;38(2):94-102. doi:10.1097/GCO.0000000000001093

• Cohen LS, Soares CN, Vitonis AF, et al. Risk for new onset of depression during the menopausal transition: the Harvard study of moods and cycles. Arch Gen Psychiatry. 2006;63(4):385-90. doi:10.1001/archpsyc.63.4.385

• Jia Y, Zhou Z, Xiang F, et al. Global prevalence of depression in menopausal women: A systematic review

and meta-analysis. J Affect Disord. 2024;358:474-482. doi:10.1016/j.jad.2024.05.051

• Maki PM, Kornstein SG, Joffe H, et al. Guidelines for the evaluation and treatment of perimenopausal depression: summary and recommendations. Menopause. 2018;25(10):1069-1085. doi:10.1097/GME.0000000000001174

• Cameron E, Ward P, Mandville-Anstey SA, et al. The female aging body: A systematic review of female perspectives on aging, health, and body image. J Women Aging. 2018;31(1):3-17. doi:10.1080/08952841.2018.1449586

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

48 · G3 · agendado 2026-11-28 08:00 (Bahia)

Criança também tem depressão: sinais que vão além da tristeza

Motivo: medicamento · ~4 min

Muitos adultos acham que criança não tem depressão. Tem, e nem sempre ela aparece como tristeza. Irritação, queixas no corpo, queda na escola e perda do interesse pelas brincadeiras podem ser os primeiros sinais.

Como a depressão aparece na infância e na adolescência

• irritabilidade e "pavio curto" na maior parte dos dias;

• perda do prazer em brincar, encontrar amigos ou fazer o que gostava;

• choro fácil, tristeza ou sensação de vazio;

• dores de barriga e de cabeça frequentes;

• mudanças no sono e no apetite;

• cansaço, lentidão, dificuldade de concentração;

• queda no rendimento escolar;

• falas como "ninguém gosta de mim", "eu sou burro", "queria sumir".

Uma meta-análise mundial estimou que transtornos depressivos atingem cerca de 2,6% das crianças e adolescentes, com aumento a partir da puberdade.1

Fatores de risco

• histórico de depressão na família;

• perdas, separações e mudanças importantes;

• bullying e cyberbullying;

• violência, negligência ou conflitos intensos em casa;

• doenças crônicas, ansiedade e TDAH.

Vergonha, medo do estigma e pouca informação estão entre as barreiras que impedem crianças e adolescentes de pedir ajuda.2

Tratamento

• Psicoterapia é a base do tratamento, com participação da família;

• medicamentos são reservados para casos selecionados. Uma grande análise mostrou que, entre os antidepressivos estudados em crianças e adolescentes, a fluoxetina teve o melhor perfil quando o remédio é necessário;3

• rotina, sono, atividade física e convívio fazem parte da recuperação;

• escola informada e envolvida no cuidado.

Perguntar diretamente a jovens sobre pensamentos de morte, em rastreamentos, não aumentou o sofrimento nem o risco num ensaio clínico.4

Fale sobre o que vê: pergunte com calma como seu filho está se sentindo e se já pensou em se machucar ou em morrer. Perguntar não incentiva, e pode abrir a porta para o cuidado.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, et al. Annual research review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):345-65. doi:10.1111/jcpp.12381

• Radez J, Reardon T, Creswell C, et al. Why do children and adolescents (not) seek and access professional help for their mental health problems? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021;30(2):183-211. doi:10.1007/s00787-019-01469-4

• Cipriani A, Zhou X, Del Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Lancet. 2016;388(10047):881-90. doi:10.1016/S0140-6736(16)30385-3

• Gould MS, Marrocco FA, Kleinman M, et al. Evaluating iatrogenic risk of youth suicide screening programs: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;293(13):1635-43. doi:10.1001/jama.293.13.1635

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Por que os cuidados paliativos importam: o que a evidência mostra

Motivo: medicamento · ~4 min

Cuidado paliativo não é só uma questão de humanização. Há décadas de pesquisa mostrando que ele muda desfechos que importam para pacientes, famílias e sistemas de saúde.

Qualidade de vida e humor

No estudo de Temel e colaboradores, pessoas com câncer de pulmão metastático que receberam cuidado paliativo precoce tiveram melhor qualidade de vida e menos sintomas depressivos: 16% contra 38% no grupo de cuidado habitual. Receberam menos quimioterapia nos últimos dias de vida e tiveram sobrevida mediana maior.1

Uma metanálise de 2016, com 43 ensaios clínicos e mais de 12 mil pacientes, confirmou: o cuidado paliativo está associado a melhor qualidade de vida e menor carga de sintomas. Não houve associação com redução da sobrevida.2

Uso de serviços e custos

Um ensaio clínico multicêntrico com equipes paliativas consultoras em hospitais mostrou maior satisfação dos pacientes com a comunicação, menos internações em UTI nas reinternações e menor custo total nos seis meses após a alta.3 Uma metanálise de 2018 encontrou redução de custos quando a consultoria paliativa acontece nos

primeiros dias da internação, com efeito maior em pacientes com câncer e com mais comorbidades.4

Uma revisão Cochrane mostrou que o cuidado paliativo domiciliar mais que dobra a chance de a pessoa morrer em casa, quando esse é o desejo dela, e reduz a carga de sintomas, sem aumentar o luto dos cuidadores.5

Efeitos que não aparecem nas tabelas

• decisões mais alinhadas com os valores do paciente;

• menos procedimentos invasivos que não trazem benefício;

• famílias mais preparadas para a morte e para o luto;

• menos sensação de abandono, um dos maiores medos de quem adoece gravemente.

Atenção a um mito: cuidado paliativo não acelera a morte. Os grandes estudos não mostram redução da sobrevida, e alguns mostram aumento. O que muda é a qualidade do tempo vivido.

E a saúde mental?

A redução de sintomas depressivos no estudo de Temel não veio de antidepressivos. Veio de consultas regulares que tratavam sintomas, conversavam sobre prognóstico e ajudavam a pessoa a lidar com a doença.1 Isso mostra que boa comunicação e controle de sintomas são, também, intervenções de saúde mental.

O que ainda falta saber

Os estudos têm limitações: muitos foram feitos em países de alta renda, com câncer, e com modelos de equipe que nem sempre existem no Brasil. Há menos evidência para doenças não oncológicas e para populações vulneráveis. Isso reforça a necessidade de avaliar os serviços que estão sendo implantados no país.

Referências

• Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2010;363(8):733-42. doi:10.1056/NEJMoa1000678

• Kavalieratos D, Corbelli J, Zhang D, et al. Association Between Palliative Care and Patient and Caregiver Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2016;316(20):2104-2114. doi:10.1001/jama.2016.16840

• Gade G, Venohr I, Conner D, et al. Impact of an inpatient palliative care team: a randomized control trial. J Palliat Med. 2008;11(2):180-90. doi:10.1089/jpm.2007.0055

• May P, Normand C, Cassel JB, et al. Economics of Palliative Care for Hospitalized Adults With Serious Illness: A Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2018;178(6):820-829. doi:10.1001/jamainternmed.2018.0750

• Gomes B, Calanzani N, Curiale V, et al. Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness and their caregivers. Cochrane Database Syst Rev. 2013;2013(6):CD007760. doi:10.1002/14651858.CD007760.pub2

Conteúdo educativo sobre cuidados paliativos e saúde mental. Não substitui a avaliação individual nem a orientação da equipe que acompanha o paciente e a família. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Calor extremo no trabalho: riscos físicos e mentais e como proteger as equipes

Motivo: medicamento · ~3 min

As ondas de calor estão mais frequentes e intensas no Brasil. Para quem trabalha ao ar livre, em cozinhas, fábricas, armazéns ou veículos sem climatização, o calor é um risco físico e também mental: aumenta a irritabilidade, o cansaço, os erros e os conflitos.

O que a pesquisa mostra

• uma revisão associou calor extremo a mais sofrimento psicológico, piora de transtornos mentais, internações psiquiátricas e suicídios;1

• trabalhadores migrantes e de baixa renda estão entre os mais expostos e menos protegidos.2

Uma revisão de 35 estudos encontrou mais atendimentos de urgência por problemas de saúde mental e maior risco de suicídio em dias de calor extremo.3

Quem está mais vulnerável

• trabalhadores da construção civil, agricultura, entregas e limpeza urbana;

• pessoas com doenças crônicas;

• pessoas que usam medicamentos que dificultam a regulação da temperatura, como lítio, alguns antipsicóticos e diuréticos;

• trabalhadores mais velhos.

Medidas de proteção

• respeitar os limites de exposição ao calor previstos na NR-15;4

• incluir o calor no inventário de riscos do PGR;

• pausas em local fresco e acesso livre a água;

• reorganizar horários das tarefas mais pesadas;

• roupas e equipamentos adequados;

• período de aclimatação para novos trabalhadores;

• orientar lideranças sobre sinais de exaustão e de alteração de comportamento.

Emergência: confusão mental, desmaio, pele quente e seca ou temperatura muito alta podem indicar insolação. Leve a pessoa para a sombra, resfrie o corpo e ligue 192.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Charlson F, Ali S, Benmarhnia T, et al. Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(9). doi:10.3390/ijerph18094486

• Van der Horst L, Bouaddi O, Williams S, et al. International migrant workers, heat exposure, and climate change: a systematic review of health risks and protective

interventions. BMC Glob Public Health. 2025;3(1):107. doi:10.1186/s44263-025-00224-z

• Thompson R, Hornigold R, Page L, Waite T. Associations between high ambient temperatures and heat waves with mental health outcomes: a systematic review. Public Health. 2018;161:171-191. doi:10.1016/j.puhe.2018.06.008

• Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), Anexo 3 — limites de exposição ocupacional ao calor. gov.br/trabalho-e-emprego

Conteúdo educativo para gestores e RH. Não substitui avaliação médica, jurídica ou de segurança do trabalho. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Calor aos quarenta e oito

Motivo: medicamento · ~5 min

Ela abanava o rosto com um folheto da unidade enquanto falava.

— Doutor, eu acho que estou ficando louca.

Chamemos essa mulher de Sônia. Quarenta e oito anos, professora de história, casada, dois filhos adolescentes. Contou que, nos últimos meses, tinha virado outra pessoa: chorava por qualquer coisa, explodia com os filhos, esquecia o nome de alunos que conhecia havia anos. Acordava duas, três vezes por noite com o corpo encharcado de suor e o coração acelerado.

— Meu marido diz que é estresse. Minha mãe diz que é frescura. Eu já não sei mais quem eu sou.

Dar nome ao que se sente

Perguntei sobre a menstruação. Ela pensou. Estava irregular havia mais de um ano: às vezes vinha duas vezes no mês, às vezes sumia por dois meses. Ela não tinha ligado uma coisa à outra.

Expliquei o que poderia estar acontecendo: a perimenopausa, a fase de transição antes da última menstruação, quando os hormônios oscilam e afetam o sono, a temperatura do corpo, o humor e a memória. Que muitas mulheres passam por isso, e que essa fase traz também um risco maior de depressão, mesmo em quem nunca teve antes.

Sônia parou de abanar o rosto.

— Então não é coisa da minha cabeça?

— É coisa do seu corpo, que mexe com a sua cabeça — respondi. — E tem cuidado.

Ela riu, e o riso virou choro. Um choro diferente, disse depois: de alívio.

O cuidado, em casa e na unidade

Pedimos exames para descartar outras causas e conversamos sobre os caminhos de tratamento, com as vantagens e os cuidados de cada um, para que ela decidisse com calma. Falamos também do sono: quarto fresco, horários regulares, menos telas à noite. E da caminhada que ela tinha abandonado.

Na consulta seguinte, ela veio com o marido. Ele queria entender. Ouviu tudo com atenção e, no fim, disse uma frase que ela repetiu depois, rindo: "Eu achava que você estava brava comigo."

Alguns meses depois, Sônia contou que dormia melhor, que as explosões tinham diminuído e que tinha dado uma aula sobre a história das mulheres para as turmas do ensino médio.

— Falei de tudo — disse. — Inclusive disso.

O que esse encontro me ensinou

Muitas mulheres atravessam a perimenopausa sem saber o que está acontecendo, ouvindo que é estresse ou exagero. Nessa fase, o risco de sintomas depressivos chega a dobrar, mesmo em quem nunca teve depressão.1

Uma metanálise recente confirmou esse aumento de risco.2 A depressão é frequente entre mulheres na menopausa no mundo todo.3 E há tratamentos com evidência, que vão da psicoterapia aos antidepressivos e, em casos selecionados, à terapia hormonal, decididos em conjunto.4 Dar nome aos sintomas e incluir a família no cuidado transforma a sensação de estar "ficando louca" em algo compreensível e tratável.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Cohen LS, Soares CN, Vitonis AF, et al. Risk for new onset of depression during the menopausal transition: the Harvard study of moods and cycles. Arch Gen Psychiatry. 2006;63(4):385-90. doi:10.1001/archpsyc.63.4.385

• Badawy Y, Spector A, Li Z, et al. The risk of depression in the menopausal stages: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2024;357:126-133. doi:10.1016/j.jad.2024.04.041

• Jia Y, Zhou Z, Xiang F, et al. Global prevalence of depression in menopausal women: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2024;358:474-482. doi:10.1016/j.jad.2024.05.051

• Maki PM, Kornstein SG, Joffe H, et al. Guidelines for the evaluation and treatment of perimenopausal depression: summary and recommendations. Menopause.

2018;25(10):1069-1085.
doi:10.1097/GME.0000000000001174

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

52 · G3 · agendado 2026-12-15 14:00 (Bahia)

Sono na adolescência: por que dormem tarde e como proteger a saúde mental

Motivo: medicamento · ~4 min

"Ele não dorme à noite e não acorda de manhã." Na adolescência, o relógio biológico muda e o sono tende a ficar mais tarde. Somam-se a isso celular na cama, aulas cedo e muitas atividades. O resultado é um adolescente cronicamente cansado, com efeitos no humor, na atenção e na saúde mental.

Quanto um adolescente precisa dormir

Recomendações internacionais indicam de 8 a 10 horas de sono por noite para adolescentes de 13 a 18 anos.1 Muitos dormem bem menos do que isso nos dias de aula.

Por que o sono atrasa

• a melatonina, hormônio do sono, passa a ser liberada mais tarde na puberdade;

• o uso de telas à noite está associado a dormir mais tarde e menos;2

• notificações e conversas de madrugada fragmentam o sono;

• cafeína e energéticos à tarde e à noite;

• dormir até muito tarde nos fins de semana desregula o relógio.

Consequências da falta de sono

• irritabilidade, tristeza e ansiedade;

• dificuldade de concentração e de memória;

• queda no rendimento escolar;

• mais impulsividade e comportamentos de risco;

• sonolência ao dirigir, para os mais velhos.

Dormir bem, o suficiente e com regularidade se associou a melhor desempenho acadêmico em estudantes.3

O que ajuda

• celular fora do quarto à noite, carregando em outro cômodo;

• horário regular para acordar, inclusive nos fins de semana, com no máximo uma a duas horas de diferença;

• luz natural pela manhã e atividade física durante o dia;

• evitar café, chá preto, refrigerantes de cola e energéticos depois da tarde;

• combinar as regras com o adolescente, explicando o porquê;

• pais dando o exemplo no uso do celular à noite.

Escolas que atrasaram o horário de entrada observaram mais tempo de sono dos alunos e, em alguns estudos, menos sonolência e sintomas depressivos.4

Procure avaliação se houver insônia persistente, ronco alto, sonolência excessiva mesmo dormindo bem, ou se o

sono ruim vier com tristeza, ansiedade ou irritabilidade importantes.

Referências

• Paruthi S, Brooks LJ, D'Ambrosio C, et al. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6):785-786. doi:10.5664/jcsm.5866

• Hale L, Guan S. Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep Med Rev. 2015;21:50-58. doi:10.1016/j.smrv.2014.07.007

• Okano K, Kaczmarzyk JR, Dave N, et al. Sleep quality, duration, and consistency are associated with better academic performance in college students. NPJ Sci Learn. 2019;4:16. doi:10.1038/s41539-019-0055-z

• Minges KE, Redeker NS. Delayed school start times and adolescent sleep: A systematic review of the experimental evidence. Sleep Med Rev. 2016;28:86-95. doi:10.1016/j.smrv.2015.06.002

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

Ele só veio por causa da pressão

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Ele sentou na cadeira com os braços cruzados.

— Só vim porque a mulher encheu o saco. É a pressão. Mede aí e me libera, que eu tenho serviço.

Chamemos esse homem de Seu Valdir. Cinquenta e cinco anos, pedreiro, mãos calejadas e marcadas de cimento. Fazia mais de dez anos que não ia a uma consulta. A pressão estava alta. Não muito, mas alta.

Enquanto eu anotava os valores, perguntei como andava o sono. Ele deu de ombros. Dormia pouco. Acordava às três da manhã e não conseguia mais pegar no sono. Perguntei sobre a bebida. "Uma cervejinha no fim do dia. Às vezes umas a mais." Perguntei sobre a família. Ele ficou em silêncio.

— Ando sem paciência com todo mundo. A mulher diz que eu virei outra pessoa.

O luto que não teve espaço

Aos poucos, a história apareceu. Fazia um ano que Seu Valdir tinha perdido o filho mais velho num acidente de moto. Não chorou no velório. Voltou ao trabalho dois dias depois. Desde então, gritava com os outros filhos, brigava com a esposa, bebia mais. No canteiro de obras, tinha ficado conhecido como "o estourado".

— Homem não pode ficar chorando pelos cantos — disse. — Alguém tem que segurar a casa.

Perguntei, com cuidado, se em algum momento tinha pensado que seria melhor não estar vivo. Ele demorou muito. Depois disse que, às vezes, dirigindo de volta para casa, pensava que não faria diferença se não chegasse. Disse isso olhando para o chão, como quem confessa um crime.

Agradeci por ele ter contado. Disse que aquilo que ele vivia tinha nome: depressão, e um luto que nunca tinha tido espaço. Que a raiva, a insônia, a bebida e até a pressão alta podiam fazer parte do mesmo sofrimento. E que tinha tratamento.

Uma semana de cada vez

Seu Valdir não aceitou tudo de uma vez. Aceitou voltar para medir a pressão. Na semana seguinte, voltou. Na outra, também. Aos poucos, aceitou conversar com a psicóloga da equipe e depois começar o tratamento para a depressão. Combinamos que ele não ficaria sozinho nos momentos mais difíceis, e a esposa passou a acompanhá-lo nas consultas.

Meses depois, ele chegou mais cedo e esperou o fim do atendimento para falar comigo.

— Doutor, eu chorei pelo meu filho. Na frente dos outros dois. E eles choraram comigo.

A pressão daquele dia estava normal.

O que esse encontro me ensinou

Muitos homens só chegam ao serviço de saúde por uma queixa do corpo. Neles, a depressão aparece com frequência como raiva, bebida e comportamentos de

risco, e por isso passa despercebida.1 As normas de masculinidade afastam muitos homens do cuidado.2 Grande parte das pessoas que morrem por suicídio esteve com um profissional da Atenção Primária pouco antes.3 E perguntar diretamente sobre pensamentos de morte não aumenta o risco.4 Aproveitar a porta de entrada da pressão para perguntar sobre o sono, o humor, as perdas e a morte pode salvar uma vida que nunca pediria ajuda de outra forma.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Martin LA, Neighbors HW, Griffith DM. The experience of symptoms of depression in men vs women: analysis of the National Comorbidity Survey Replication. JAMA Psychiatry. 2013;70(10):1100-6. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.1985

• Seidler ZE, Dawes AJ, Rice SM, et al. The role of masculinity in men's help-seeking for depression: A systematic review. Clin Psychol Rev. 2016;49:106-118. doi:10.1016/j.cpr.2016.09.002

• Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-16. doi:10.1176/appi.ajp.159.6.909

• Dazzi T, Gribble R, Wessely S, et al. Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation?

What is the evidence?. Psychol Med. 2014;44(16):3361-3. doi:10.1017/S0033291714001299

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

54 · G3 · agendado 2026-12-18 08:00 (Bahia)

TPM ou transtorno disfórico pré-menstrual? Quando os sintomas do ciclo pedem tratamento

Motivo: medicamento · ~4 min

Inchaço, sensibilidade e alguma irritação antes da menstruação são comuns. Mas quando, todo mês, a tristeza, a raiva ou a ansiedade ficam tão intensas que prejudicam o trabalho e as relações, e somem poucos dias depois que a menstruação começa, pode ser transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM).

TPM ou TDPM?

• TPM (síndrome pré-menstrual): sintomas físicos e emocionais leves a moderados, que incomodam mas não paralisam a vida.

• TDPM: forma grave, com sintomas emocionais intensos, como tristeza profunda, desesperança, irritabilidade ou raiva marcantes, ansiedade, choro fácil e sensação de perda de controle, na semana anterior à menstruação, com melhora nos primeiros dias do ciclo.

As variações hormonais da vida reprodutiva estão entre os fatores que ajudam a explicar por que a depressão é mais comum em mulheres.1

Como confirmar

O melhor caminho é registrar os sintomas diariamente por pelo menos dois ciclos, em um diário ou aplicativo. Isso mostra se os sintomas acompanham o ciclo ou se estão

presentes o mês todo, o que sugere outro problema, como depressão ou ansiedade.

Uma meta-análise recente mostrou que TPM e TDPM frequentemente coexistem com transtornos do humor, como depressão e transtorno bipolar.2 Por isso, a avaliação deve ser completa.

Tratamento

• Antidepressivos: uma revisão Cochrane mostrou que eles provavelmente reduzem os sintomas pré-menstruais, com efeito possivelmente maior no uso contínuo do que apenas na segunda metade do ciclo. Os efeitos colaterais mais comuns são náusea, cansaço e sonolência.3

• Anticoncepcionais hormonais específicos podem ajudar algumas mulheres.4

• Psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental.

• Hábitos: atividade física, sono regular, menos álcool e cafeína.

Atenção: pensamentos de morte na fase pré-menstrual também devem ser levados a sério e comunicados à equipe de saúde.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Kuehner C. Why is depression more common among women than among men?. Lancet Psychiatry. 2017;4(2):146-158. doi:10.1016/S2215-0366(16)30263-2

• Bengi D, Strawbridge R, Drorian M, et al. A systematic review and meta-analysis on the comorbidity of premenstrual dysphoric disorder or premenstrual syndrome with mood disorders: prevalence, clinical and neurobiological correlates. Br J Psychiatry. 2025;229(3):314-327. doi:10.1192/bjp.2025.133

• Jespersen C, Lauritsen MP, Frokjaer VG, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2024;8(8):CD001396. doi:10.1002/14651858.CD001396.pub4

• Carlini SV, Lanza di Scalea T, McNally ST, et al. Management of Premenstrual Dysphoric Disorder: A Scoping Review. Int J Womens Health. 2022;14:1783-1801. doi:10.2147/IJWH.S297062

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

55 · G3 · agendado 2026-12-21 14:00 (Bahia)

A depressão pode voltar: como reconhecer os sinais e prevenir a recaída

Motivo: medicamento · ~4 min

Sair de uma depressão é um alívio enorme. Mas a depressão pode voltar, e o risco aumenta a cada novo episódio. A boa notícia é que existem estratégias comprovadas para reduzir as chances de recaída.

Por que a depressão volta

• suspensão do tratamento cedo demais, logo que a pessoa se sente melhor;

• sintomas residuais que não foram totalmente tratados;

• estresse intenso, perdas e conflitos;

• sono desregulado, álcool e isolamento;

• episódios anteriores: quanto mais episódios, maior o risco.

O que a ciência mostra

• Manter o antidepressivo: uma revisão de 31 ensaios clínicos mostrou que continuar o tratamento após a melhora reduziu em cerca de 70% as chances de recaída, em comparação com parar. A recaída foi de 41% com placebo e de 18% com o remédio.1

• Terapia cognitiva baseada em mindfulness: em pessoas com depressão recorrente, reduziu o risco de recaída em

comparação com o cuidado habitual e com outros tratamentos ativos.2

Sinais de alerta de recaída

• sono pior por mais de alguns dias;

• perda de interesse em coisas que voltou a fazer;

• isolamento e irritabilidade;

• pensamentos negativos repetitivos;

• cansaço sem explicação.

Seu plano de prevenção

• combine com o médico por quanto tempo manter o tratamento e como será a retirada, sempre gradual;

• anote seus sinais pessoais de alerta e compartilhe com alguém de confiança;

• mantenha sono regular, atividade física e contato com as pessoas;

• reduza ou evite o álcool;

• procure ajuda logo que perceber os primeiros sinais. Quanto antes, mais fácil.

Manter atividades prazerosas e significativas na agenda é o princípio da ativação comportamental, eficaz no tratamento da depressão.3

A atividade física regular é eficaz para reduzir sintomas depressivos e pode fazer parte do plano.4

Recaída não é fracasso. É uma característica da doença, que pode ser prevista, prevenida e tratada.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Geddes JR, Carney SM, Davies C, et al. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. Lancet. 2003;361(9358):653-61. doi:10.1016/S0140-6736(03)12599-8

• Kuyken W, Warren FC, Taylor RS, et al. Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse: An Individual Patient Data Meta-analysis From Randomized Trials. JAMA Psychiatry. 2016;73(6):565-74. doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.0076

• Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Behavioral activation treatments of depression: a meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2007;27(3):318-26. doi:10.1016/j.cpr.2006.11.001

• Noetel M, Sanders T, Gallardo-Gómez D, et al. Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2024;384:e075847. doi:10.1136/bmj-2023-075847

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

56 · G3 · agendado 2026-12-29 08:00 (Bahia)

A dor que nenhum exame mostrava

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

A pasta era grossa. Ressonâncias, ultrassons, exames de sangue, receitas de vários médicos. Ela colocou tudo sobre a mesa e disse, antes de qualquer pergunta:

— Está tudo normal, doutor. Mas eu sinto dor no corpo inteiro há três anos.

Chamemos essa mulher de Dona Rosângela. Quarenta e seis anos, cozinheira de restaurante, mãe de três filhos. A dor tinha começado nas costas, depois se espalhou para os ombros, para as pernas, para tudo. Doía para levantar, para trabalhar, para dormir.

— Já me disseram que é psicológico — contou. — Que é coisa da minha cabeça. Teve médico que nem me examinou.

Acreditar na dor

Examinei com calma. Fiz perguntas sobre a dor: onde, quando, o que melhorava, o que piorava. Depois perguntei sobre o sono. Ela dormia mal havia anos, acordava cansada. Perguntei sobre o humor. Ela ficou em silêncio e depois disse que andava sem paciência, chorando à toa, sem vontade de fazer nada.

— Mas não é depressão — disse rápido. — A dor é de verdade.

Respondi que eu acreditava na dor dela. Que dor crônica é real mesmo quando os exames estão normais. E que a

tristeza, o cansaço e o sono ruim não eram uma explicação para a dor ser "da cabeça", mas parte do mesmo ciclo: a dor tira o sono e o ânimo, e a falta de sono e de ânimo aumenta a dor.

Dona Rosângela ficou me olhando por um tempo.

— Ninguém tinha falado assim comigo — disse.

Um cuidado sem mágica

O tratamento não foi rápido, nem mágico. Começamos tratando o sono e o humor, com acompanhamento próximo. Ela entrou num grupo de atividade física da unidade, com exercícios leves e progressivos, junto com outras mulheres que também conviviam com dor. Aos poucos, aprendeu técnicas para lidar com as crises e voltou a fazer coisas que tinha abandonado.

Retiramos, com cuidado e aos poucos, alguns dos remédios acumulados das receitas antigas.

Meses depois, ela voltou à consulta. A dor não tinha sumido. Mas tinha voltado a cozinhar aos domingos para os filhos, coisa que não fazia havia dois anos.

— Ainda dói — disse. — Mas agora eu mando um pouco nela.

O que esse encontro me ensinou

Pessoas com dor crônica e exames normais muitas vezes ouvem que o problema "é da cabeça" e se sentem desacreditadas. Dor e depressão se alimentam em mão dupla e compartilham vias no sistema nervoso.1 Perguntas simples, como as do PHQ-9, ajudam a

reconhecer a depressão sem desqualificar a dor.2 A terapia cognitivo-comportamental reduz a dor, a incapacidade e o sofrimento.3 O exercício progressivo melhora a dor e a função.4 Acreditar na dor e propor um cuidado que envolva movimento, tratamento emocional e revisão dos remédios devolve a possibilidade de viver com menos sofrimento.

Referências

• Bair MJ, Robinson RL, Katon W, Kroenke K. Depression and pain comorbidity: a literature review. Arch Intern Med. 2003;163(20):2433-45. doi:10.1001/archinte.163.20.2433

• Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606-13. doi:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x

• Williams ACC, Fisher E, Hearn L, Eccleston C. Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2020;8(8):CD007407. doi:10.1002/14651858.CD007407.pub4

• Geneen LJ, Moore RA, Clarke C, et al. Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017;4(4):CD011279. doi:10.1002/14651858.CD011279.pub3

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo

educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Whey, creatina e suplementos: o que é ciência e o que é promessa

Motivo: medicamento · ~5 min

Pote de whey, creatina, pré-treino, termogênico, "hipercalórico", "secador". As prateleiras e os anúncios prometem músculos, energia e queima de gordura. Alguns suplementos têm boa evidência para certos objetivos. Outros têm pouca ou nenhuma. E alguns podem conter substâncias que não estão no rótulo.

Proteína em pó (whey)

O whey é proteína do soro do leite. Ele não tem nada de mágico: é uma forma prática de complementar a proteína da alimentação. Uma metanálise de ensaios clínicos mostrou que a suplementação de proteína aumentou um pouco os ganhos de massa e força em adultos que fazem treino de força. O efeito foi modesto e deixou de aumentar a partir de cerca de 1,6 g de proteína por quilo de peso por dia, considerando a alimentação total.1

Em outras palavras: para a maioria das pessoas, comida de verdade já resolve. O suplemento pode ajudar quem não consegue atingir a proteína necessária pela alimentação.

Creatina

É um dos suplementos mais estudados do mundo. A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva considera a creatina eficaz para melhorar o desempenho em exercícios de alta intensidade e o ganho de massa magra

com treino, e segura em doses usuais para pessoas saudáveis.2 Quem tem doença renal deve conversar com o médico antes de usar.

Termogênicos, "queimadores" e pré-treinos

Muitos contêm grandes quantidades de cafeína e outros estimulantes. Podem causar ansiedade, insônia, taquicardia, aumento da pressão e, em pessoas predispostas, crises de pânico. O efeito sobre o emagrecimento costuma ser pequeno.

O perigo do que não está no rótulo

Uma revisão de 50 estudos que analisaram mais de 3 mil suplementos encontrou substâncias não declaradas em quase 28% deles. As mais frequentes foram a sibutramina, um remédio para emagrecer, e anabolizantes.3 Isso significa que uma pessoa pode estar usando hormônios ou remédios sem saber.

Suplemento e saúde mental

O uso de suplementos, em si, não é problema. Ele pode virar sinal de alerta quando:

• a pessoa sente que não consegue treinar ou comer sem eles;

• gasta mais do que pode com produtos;

• vai aumentando doses e combinações em busca de resultados;

• passa a considerar anabolizantes como "o próximo passo".

Em homens, a busca intensa por músculos se associa a comportamentos alimentares problemáticos e ao uso de substâncias para modificar o corpo.4

Como escolher com segurança

• converse com nutricionista ou médico antes de começar;

• prefira marcas com registro e análises de qualidade;

• desconfie de promessas de resultados rápidos e de produtos "importados" sem registro;

• não combine vários estimulantes;

• lembre que sono, alimentação e treino bem feito pesam muito mais do que qualquer pote.

Quando procurar ajuda

Procure atendimento se surgirem palpitações, ansiedade intensa, insônia, alterações de humor ou mudanças no corpo depois de usar suplementos. E, se a busca por resultados estiver fugindo do controle, vale conversar sobre isso na UBS.

Referências

• Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med. 2017;52(6):376-384. doi:10.1136/bjsports-2017-097608

• Kreider RB, Kalman DS, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of

creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:18. doi:10.1186/s12970-017-0173-z

• Kozhuharov VR, Ivanov K, Ivanova S. Dietary Supplements as Source of Unintentional Doping. Biomed Res Int. 2022;2022:8387271. doi:10.1155/2022/8387271

• Lavender JM, Brown TA, Murray SB. Men, Muscles, and Eating Disorders: an Overview of Traditional and Muscularity-Oriented Disordered Eating. Curr Psychiatry Rep. 2017;19(6):32. doi:10.1007/s11920-017-0787-5

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

A porta conferida uma vez só

Motivo: medicamento · ~4 min

Ele chegou atrasado à consulta e pediu desculpas de um jeito que me chamou a atenção: "Eu precisei voltar em casa. Duas vezes."

Chamemos esse homem de Henrique. Trinta e três anos, contador, veio à unidade por causa de dores nas mãos. As mãos estavam vermelhas, rachadas, com feridas entre os dedos. Ele contou que lavava as mãos com frequência "por causa do trabalho". Quando perguntei quantas vezes por dia, ele ficou em silêncio.

Os rituais que ninguém via

Aos poucos, com o cuidado de quem fala de algo que guarda há muito tempo, ele contou. Lavava as mãos dezenas de vezes por dia, sempre de um jeito específico, até sentir que estavam "realmente limpas". Antes de sair de casa, conferia a porta, o gás e as janelas, repetidas vezes. Às vezes, já no carro, voltava para conferir de novo. Chegava atrasado ao trabalho quase todos os dias.

O mais difícil, ele disse, não eram os rituais. Eram os pensamentos. Imagens que surgiam sem convite, de algo ruim acontecendo à família por um descuido dele. Ele sabia que aquilo não fazia sentido. Mas, se não conferisse, a angústia ficava insuportável.

Ele nunca tinha contado aquilo para ninguém. Achava que estava "ficando louco".

Disse a ele que o que ele descrevia tinha nome, transtorno obsessivo-compulsivo, e que era mais comum do que se imagina. Expliquei que os pensamentos intrusivos não significavam que ele desejasse aquilo, que eles assustavam justamente porque iam contra o que ele valorizava. E que existia tratamento eficaz.

Cuidamos das mãos. Iniciamos tratamento e encaminhei para terapia cognitivo-comportamental com exposição e prevenção de resposta. Expliquei que o processo seria gradual: enfrentar aos poucos a angústia sem realizar os rituais, com apoio do terapeuta.

Meses depois, ele chegou à consulta na hora marcada. Mostrou as mãos, quase curadas. "Ainda confiro a porta uma vez. Uma vez só. E depois vou embora."

O que esse encontro me ensinou

O TOC costuma se esconder atrás de queixas pequenas: mãos machucadas, atrasos, cansaço. Muitas pessoas convivem com ele por anos em silêncio, por vergonha de pensamentos que acham inaceitáveis. Uma pergunta feita com curiosidade e sem julgamento pode ser o início de um tratamento que devolve tempo e liberdade.

O TOC costuma levar anos até ser reconhecido e tratado.1 Terapia cognitivo-comportamental com exposição e prevenção de resposta, e certos antidepressivos, são os tratamentos com mais evidência.2 Metanálises de ensaios controlados confirmam a eficácia da TCC no TOC.3 A vergonha dos próprios pensamentos e o estigma atrasam a busca de ajuda.4

Referências

• Stein DJ, Costa DLC, Lochner C, et al. Obsessive-compulsive disorder. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):52. doi:10.1038/s41572-019-0102-3

• Skapinakis P, Caldwell DM, Hollingworth W, et al. Pharmacological and psychotherapeutic interventions for management of obsessive-compulsive disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2016;3(8):730-739. doi:10.1016/S2215-0366(16)30069-4

• Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al. Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depress Anxiety. 2018;35(6):502-514. doi:10.1002/da.22728

• Clement S, Schauman O, Graham T, et al. What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychol Med. 2014;45(1):11-27. doi:10.1017/S0033291714000129

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____

[ ] Não publicar

A pílula da concentração e as três da manhã

Motivo: medicamento · ~5 min

Ele chegou ao pronto atendimento às três da manhã, com o coração disparado e a certeza de que ia morrer. Na mesa da sala, ao lado do celular, deixou um bloco de resumos para a prova do concurso, marcado com canetas de quatro cores.

Chamemos esse homem de Rafael. Vinte e nove anos, terceiro ano tentando o mesmo concurso público, estudando doze horas por dia. Os exames do coração estavam normais. A pressão estava alta, as mãos tremiam, e ele não dormia havia dois dias.

Perguntei sobre café, energéticos e remédios. Ele hesitou. Depois contou: tinha começado a usar comprimidos para concentração comprados de um colega do cursinho. No início, uma vez por semana. Agora, todo dia, às vezes dois.

O que o comprimido prometia

"Todo mundo usa, doutor. Sem isso eu não consigo competir." Ele falava rápido, com a mesma urgência com que devia estudar. Disse que, com o remédio, sentia que rendia o dobro. Mas também dormia cada vez menos, estava irritado com a namorada e, na semana anterior, tinha esquecido metade do que tinha lido.

Não fiz sermão. Expliquei o que a ciência mostra: em pessoas sem TDAH, esses medicamentos trazem pouco

ou nenhum ganho real de desempenho, embora deem a sensação de energia e confiança. E os riscos que ele estava sentindo no corpo naquela madrugada eram reais.

Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que, na verdade, tinha medo de ser reprovado de novo e de ter que voltar para a casa dos pais, no interior, como alguém que tinha fracassado.

Ali estava a conversa que importava. Falamos sobre sono, sobre estudar menos horas e com mais pausas, sobre a ansiedade que vinha crescendo a cada edital. Ele contou que, desde a escola, tinha dificuldade de concentração e que nunca ninguém tinha investigado isso.

Saiu com orientação para interromper o uso dos comprimidos, encaminhamento para a unidade de saúde do bairro, onde poderia ser avaliado com calma, inclusive para TDAH, e com uma sugestão que ele achou estranha: dormir oito horas antes da próxima prova.

O que esse encontro me ensinou

Por trás do uso de estimulantes sem prescrição, quase sempre existe uma pressão que não cabe no comprimido: medo de fracassar, comparação, exaustão. Tratar só o efeito da substância é pouco. A pergunta que muda o atendimento é "do que você está tentando dar conta?".

Em pessoas sem TDAH, os ganhos de desempenho com estimulantes são pequenos e inconsistentes.1 Dormir bem e com regularidade se associou a melhor desempenho acadêmico em universitários.2 Cerca de um terço dos estudantes no primeiro ano da faculdade

apresenta algum transtorno mental.3 Quando há suspeita de TDAH, o caminho é a avaliação cuidadosa, porque o transtorno persiste em parte dos adultos.4

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Roberts CA, Jones A, Sumnall H, et al. How effective are pharmaceuticals for cognitive enhancement in healthy adults? A series of meta-analyses of cognitive performance during acute administration of modafinil, methylphenidate and D-amphetamine. Eur Neuropsychopharmacol. 2020;38:40-62. doi:10.1016/j.euroneuro.2020.07.002

• Okano K, Kaczmarzyk JR, Dave N, et al. Sleep quality, duration, and consistency are associated with better academic performance in college students. NPJ Sci Learn. 2019;4:16. doi:10.1038/s41539-019-0055-z

• Auerbach RP, Mortier P, Bruffaerts R, et al. WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: Prevalence and distribution of mental disorders. J Abnorm Psychol. 2018;127(7):623-638. doi:10.1037/abn0000362

• Song P, Zha M, Yang Q, et al. The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. J Glob Health. 2021;11:04009. doi:10.7189/jogh.11.04009

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

60 · G3 · agendado 2027-01-30 08:00 (Bahia)

Depois de um ataque a uma escola: como cuidar de alunos, famílias e professores

Motivo: medicamento · ~4 min

Nos últimos anos, ataques violentos a escolas assustaram famílias brasileiras. Mesmo quem não estava no local sentiu medo de mandar os filhos para a aula. O cuidado depois de um evento assim precisa alcançar toda a comunidade.

O impacto vai além de quem estava lá

Um estudo nos Estados Unidos mostrou que, nos dois anos seguintes a ataques fatais com armas em escolas, o uso de antidepressivos entre jovens da região aumentou cerca de 21%.1 Uma revisão de 2026 sobre crianças, adolescentes e jovens afetados por ataques em massa reforçou a necessidade de cuidado baseado em evidências para os sobreviventes.2 Crianças expostas à violência na comunidade, mesmo como testemunhas ou ouvindo falar, podem desenvolver sintomas de estresse pós-traumático.3

Reações esperadas

• medo de voltar à escola, de barulhos, de pessoas desconhecidas;

• pesadelos, dificuldade para dormir;

• irritação, dificuldade de concentração;

• luto por colegas ou professores;

• culpa de quem sobreviveu.

O que ajuda nos primeiros dias

• garantir segurança e informação clara;

• retomar rotinas aos poucos, com acolhimento;

• espaços de conversa, sem obrigar ninguém a falar;

• atenção especial a quem estava presente, perdeu alguém ou já tinha sofrimento anterior;

• cuidar dos professores e funcionários, que também foram atingidos.

Como falar sem gerar contágio

• não divulgar nome, imagem ou mensagens de quem cometeu o ataque;

• não descrever detalhes de como o ataque foi feito;

• focar nas vítimas, na comunidade e nas formas de ajuda;

• não compartilhar vídeos e imagens do ocorrido;

• informar sobre serviços de apoio.

Prevenção

A Lei nº 14.811/2024 instituiu medidas de proteção contra a violência nos estabelecimentos educacionais.4 Prevenção eficaz combina clima escolar acolhedor, combate ao bullying, atenção à saúde mental dos estudantes, canais para relatar ameaças e trabalho conjunto entre escola, saúde, assistência e segurança.

Para pais: pergunte o que seu filho sabe e sente, corrija boatos com calma, limite a exposição a vídeos e notícias, e procure a UBS ou o CAPSi se o medo não diminuir depois de algumas semanas.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Rossin-Slater M, Schnell M, Schwandt H, et al. Local exposure to school shootings and youth antidepressant use. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(38):23484-23489. doi:10.1073/pnas.2000804117

• Böge J, Gabriel C, Sitarski E, et al. The mental health sequelae of mass shootings on affected children, adolescents and young adults - a scoping review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2026. doi:10.1007/s00787-026-03202-4

• Fowler PJ, Tompsett CJ, Braciszewski JM, et al. Community violence: a meta-analysis on the effect of exposure and mental health outcomes of children and adolescents. Dev Psychopathol. 2009;21(1):227-59. doi:10.1017/S0954579409000145

• Brasil. Lei nº 14.811, de 12 de janeiro de 2024 — institui medidas de proteção contra a violência nos estabelecimentos educacionais e inclui no Código Penal os crimes de bullying e cyberbullying (art. 146-A). planalto.gov.br

Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

61 · G3 · agendado 2027-01-30 14:00 (Bahia)

Transtorno dismórfico corporal: o defeito que só você vê

Motivo: medicamento · ~5 min

Ela não sai de casa sem maquiagem pesada por causa de uma "mancha" que ninguém mais enxerga. Ele já fez três rinoplastias e continua achando o nariz torto. Passam horas diante do espelho ou fogem dele. Não é vaidade. Pode ser transtorno dismórfico corporal.

O que é

O transtorno dismórfico corporal (TDC) é uma condição em que a pessoa fica intensamente preocupada com um ou mais "defeitos" na aparência que os outros não percebem ou consideram mínimos. A preocupação ocupa muito tempo, causa sofrimento importante e leva a comportamentos repetitivos.

Sinais comuns

• checar o espelho o tempo todo, ou evitar espelhos e fotos;

• comparar-se com outras pessoas constantemente;

• camuflar a parte do corpo com roupas, cabelo, maquiagem ou posturas;

• perguntar repetidamente aos outros se o "defeito" está aparente;

• mexer na pele, cutucar espinhas ou tentar "corrigir" com as próprias mãos;

• procurar procedimentos estéticos repetidos, sem alívio;

• evitar trabalho, escola, encontros e saídas por vergonha.

As preocupações mais frequentes envolvem pele, nariz, cabelo, dentes, barriga, seios e genitais. A dismorfia muscular, em que a pessoa se acha pequena demais, é uma forma de TDC.

É mais comum do que se imagina

As estimativas variam muito conforme o método usado, mas os estudos mostram que o TDC é frequente, mais nas mulheres, e com taxas altas na América Latina.1 Entre pacientes de cirurgia plástica, uma metanálise com mais de 17 mil pessoas estimou que quase um em cada cinco tinha o quadro, e o Brasil teve a maior proporção.2

Por que a cirurgia não resolve

O problema não está no nariz, na pele ou na barriga, e sim na forma como a pessoa percebe e sente essa parte do corpo. Por isso, procedimentos raramente trazem alívio duradouro: a insatisfação costuma continuar ou migrar para outra parte. O TDC está entre os fatores que se associam a resultados ruins em cirurgia estética.3

Um quadro que merece atenção

O TDC costuma vir acompanhado de depressão, ansiedade social e isolamento, e pode trazer pensamentos de morte. Por isso, perguntar sobre o humor e sobre esses pensamentos faz parte da avaliação.

Tem tratamento

• terapia cognitivo-comportamental: uma metanálise de ensaios clínicos mostrou que reduz os sintomas do TDC e da depressão associada;4

• medicamentos: antidepressivos do tipo inibidores seletivos da recaptação de serotonina também reduzem os sintomas, e uma metanálise recente encontrou melhora importante dos sintomas depressivos tanto com medicação quanto com a terapia;5

• a combinação dos dois pode trazer os melhores resultados.

Como ajudar alguém

• não discuta se o "defeito" existe ou não; isso raramente convence;

• reconheça o sofrimento: "vejo que isso te faz sofrer muito";

• evite reforçar as checagens, respondendo repetidamente às mesmas perguntas;

• incentive a busca de ajuda de saúde mental antes de novos procedimentos.

Quando procurar ajuda

Procure a UBS se a preocupação com a aparência estiver ocupando horas do dia, afastando você de compromissos ou levando a procedimentos repetidos. Se surgirem pensamentos de morte, ligue para o CVV, 188.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em

emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Pérez-Buenfil A, Morales-Sánchez A. Prevalence of Body Dysmorphic Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Cosmet Dermatol. 2025;24(4):e70121. doi:10.1111/jocd.70121

• Kaleeny JD, Janis JE. Body Dysmorphic Disorder in Aesthetic and Reconstructive Plastic Surgery-A Systematic Review and Meta-Analysis. Healthcare (Basel). 2024;12(13). doi:10.3390/healthcare12131333

• Honigman RJ, Phillips KA, Castle DJ. A review of psychosocial outcomes for patients seeking cosmetic surgery. Plast Reconstr Surg. 2004;113(4):1229-37. doi:10.1097/01.prs.0000110214.88868.ca

• Harrison A, Fernández de la Cruz L, Enander J, et al. Cognitive-behavioral therapy for body dysmorphic disorder: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Psychol Rev. 2016;48:43-51. doi:10.1016/j.cpr.2016.05.007

• Loewen A, Peñuelas-Calvo I, Alacreu-Crespo A, et al. Effects of Pharmacological and Psychological Treatments on Depressive Symptoms in Body Dysmorphic Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. Curr Psychiatry Rep. 2026;28(1). doi:10.1007/s11920-026-01688-y

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

62 · G3 · agendado 2027-02-14 08:00 (Bahia)

Estresse pós-traumático tem tratamento: o que a ciência recomenda hoje

Motivo: medicamento · ~4 min

Muita gente acredita que o trauma "é para sempre". Não é. O estresse pós-traumático tem tratamentos eficazes, e muitas pessoas melhoram de forma importante.

O que funciona melhor

Uma revisão sistemática com metanálise de 2020 sobre terapias psicológicas para adultos com estresse pós-traumático encontrou as evidências mais fortes para:1

• terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, incluindo terapia de processamento cognitivo, terapia cognitiva e exposição prolongada;

• EMDR (dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares).

A diretriz britânica NICE recomenda essas abordagens como primeira linha para adultos, com número adequado de sessões e profissionais treinados. Medicamentos podem ser considerados quando a pessoa prefere ou não pode fazer psicoterapia focada no trauma.2

Como funcionam

• entender o que aconteceu com o corpo e a mente: psicoeducação;

• rever pensamentos como "foi culpa minha" ou "o mundo é totalmente perigoso";

• aproximar-se das lembranças de forma gradual e segura, para que deixem de ser tão ameaçadoras;

• retomar a vida: lugares, pessoas e atividades que foram evitados.

Quando o trauma é repetido ou prolongado

Em violência doméstica de longa duração, abuso na infância ou violência comunitária contínua, pode ser necessário começar pela estabilização: segurança, sono, manejo de emoções intensas e apoio social.

Na Atenção Primária

O Guia de Intervenção mhGAP da OMS orienta profissionais não especialistas a reconhecer estresse agudo e pós-traumático, oferecer apoio, evitar benzodiazepínicos como tratamento principal e encaminhar para psicoterapia quando necessário.3

Quem precisa de tratamento

A maioria das pessoas expostas a um trauma se recupera sem tratamento específico. Nos inquéritos da OMS, violência sexual e violência por parceiro íntimo foram os eventos com maior peso no estresse pós-traumático, e merecem atenção especial.4

Onde buscar: UBS, CAPS, clínicas-escola de universidades e serviços especializados de atendimento a vítimas. Pergunte se o profissional trabalha com terapia focada no trauma.

Referências

• Lewis C, Roberts NP, Andrew M, et al. Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. Eur J Psychotraumatol. 2020;11(1):1729633. doi:10.1080/20008198.2020.1729633

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Post-traumatic stress disorder (NG116). Londres: NICE; 2018. www.nice.org.uk

• World Health Organization. mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings, version 2.0. Geneva: WHO; 2016. who.int

• Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. Eur J Psychotraumatol. 2017;8(sup5):1353383. doi:10.1080/20008198.2017.1353383

Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

63 · G3 · agendado 2027-03-15 08:00 (Bahia)

Depressão e ansiedade na doença grave: tristeza esperada ou transtorno que precisa de tratamento?

Motivo: medicamento · ~5 min

"É normal estar triste, ele está muito doente." A frase é verdadeira, mas pode esconder uma depressão que tira da pessoa o pouco tempo de qualidade que ela ainda tem.

Com que frequência acontece

Uma metanálise com dezenas de estudos em oncologia e cuidados paliativos encontrou depressão maior em cerca de uma em cada sete pessoas. Somando depressão menor, ansiedade e transtorno de adaptação, a proporção com algum quadro de humor chega a perto de um terço.1

Tristeza esperada x depressão

• Tristeza esperada: vem em ondas, convive com momentos de alegria, a pessoa ainda se conecta com quem ama e encontra sentido em algumas coisas.

• Depressão: tristeza ou vazio persistentes, perda de prazer em quase tudo, culpa excessiva, sensação de ser um peso, desesperança generalizada.

Na doença grave, sintomas físicos como cansaço, falta de apetite e insônia não ajudam a diferenciar, porque a própria doença os provoca. Os sintomas psicológicos, como desesperança, culpa, sentir-se um fardo e perda de interesse, são mais úteis.

Por que tratar faz diferença

Depressão e desesperança são os fatores mais fortemente associados ao desejo de antecipar a morte em pessoas com câncer terminal. No estudo de Breitbart, pacientes com depressão maior tiveram cerca de quatro vezes mais chance de expressar esse desejo.2 Tratar a depressão é, portanto, também uma forma de proteger a vida e a qualidade do tempo que resta.

Como rastrear

• duas perguntas simples: "Nas últimas semanas, você tem se sentido triste ou sem esperança?" e "Tem perdido o interesse pelas coisas?";

• escalas breves, como a HADS ou o PHQ-9, adaptando a interpretação dos sintomas físicos;

• perguntar diretamente sobre desejo de morrer e ideias de suicídio, com calma. Perguntar não induz.

Tratamento

• Cuidado paliativo bem feito: controlar dor e outros sintomas já melhora o humor. Em ensaios clínicos, o cuidado paliativo reduziu sintomas depressivos e ansiosos.3,4

• Psicoterapia: intervenções estruturadas como a terapia CALM reduziram sintomas depressivos em pessoas com câncer avançado.5

• Medicamentos: antidepressivos podem ser indicados, escolhendo opções com início de ação e interações

compatíveis com o tempo e os outros tratamentos da pessoa.

• Ansiedade: tratar a causa (dor, falta de ar, medo de sufocar), oferecer informação e plano para crises.

Para a família: se a pessoa diz que não aguenta mais, que é um peso ou que preferia morrer, não mude de assunto. Escute, diga que está ali e conte à equipe. Esse sofrimento pode ser aliviado.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Mitchell AJ, Chan M, Bhatti H, et al. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. Lancet Oncol. 2011;12(2):160-74. doi:10.1016/S1470-2045(11)70002-X

• Breitbart W, Rosenfeld B, Pessin H, et al. Depression, hopelessness, and desire for hastened death in terminally ill patients with cancer. JAMA. 2000;284(22):2907-11. doi:10.1001/jama.284.22.2907

• Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2010;363(8):733-42. doi:10.1056/NEJMoa1000678

• Rogers JG, Patel CB, Mentz RJ, et al. Palliative Care in Heart Failure: The PAL-HF Randomized, Controlled Clinical Trial. J Am Coll Cardiol. 2017;70(3):331-341. doi:10.1016/j.jacc.2017.05.030

• Rodin G, Lo C, Rydall A, et al. Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM): A Randomized Controlled Trial of a Psychological Intervention for Patients With Advanced Cancer. J Clin Oncol. 2018;36(23):2422-2432. doi:10.1200/JCO.2017.77.1097

Conteúdo educativo sobre cuidados paliativos e saúde mental. Não substitui a avaliação individual nem a orientação da equipe que acompanha o paciente e a família. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

64 · G4 · publicado em 2026-05-12

O resgate de um vínculo perdido

Motivo: medicamento · ~5 min

Fazia mais de um ano que ela não aparecia na unidade. O prontuário registrava apenas uma frase seca, de uma consulta antiga: "paciente relata melhora, decide suspender acompanhamento". Quando finalmente voltou, o motivo não foi nada bom.

Chamemos essa mulher de Dona Helena. Cinquenta e oito anos, diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, tinha sido acompanhada na Atenção Primária por uns dois anos, com melhora consistente. Em algum momento, sentindo-se bem, decidiu parar — tanto a medicação quanto as consultas — sem conversar isso com ninguém da equipe.

Voltou cerca de quatorze meses depois, trazida pela filha, em um quadro de recaída significativa: isolamento profundo, descuido com a própria aparência e higiene, recusa em sair de casa, e um discurso carregado de desesperança que preocupou bastante a família.

Na primeira consulta depois desse retorno, percebi algo além da recaída em si: havia vergonha. Dona Helena evitava meu olhar, falava baixo, como se estivesse pedindo desculpas por ter "decepcionado" o tratamento, por ter "estragado" o que tinha sido construído antes.

Reconstruindo, sem julgamento

Decidi não focar na "recaída" como falha dela. Em vez disso, conversamos sobre o que a tinha levado a interromper o tratamento — e descobri que, na cabeça

dela, sentir-se bem significava estar curada, e continuar tomando medicação ou indo às consultas parecia, de alguma forma, prova de que ela ainda estava "doente".

Era uma crença comum, que eu já tinha visto antes em outros pacientes, mas que raramente é discutida abertamente: a ideia de que tratamento contínuo é sinal de fraqueza, em vez de ser exatamente o que sustenta a estabilidade conquistada.

Expliquei, sem cobranças, que transtornos depressivos recorrentes frequentemente exigem acompanhamento contínuo, mesmo nos períodos de bem-estar — da mesma forma que outras condições crônicas de saúde. Validei sua experiência de ter se sentido bem o suficiente para acreditar que não precisava mais de cuidado, sem fazer dessa decisão um erro moral.

Reconstruir aquele vínculo levou tempo. Algumas consultas de pura escuta, sem pressa de "retomar de onde tínhamos parado". Pouco a pouco, Dona Helena voltou a confiar no processo — e, dessa vez, construímos juntos um plano que incluía conversar comigo antes de qualquer decisão futura de pausar o tratamento, em vez de simplesmente desaparecer.

O que esse encontro me ensinou

Pacientes que abandonam o tratamento raramente fazem isso por desinteresse ou descuido — muitas vezes, é uma crença equivocada sobre o que significa estar "curado", ou vergonha de precisar de cuidado contínuo. Quando esses pacientes retornam, eles não precisam de julgamento pelo tempo perdido. Precisam de um vínculo

que os receba de volta sem cobranças, para que o tratamento volte a ser sustentável de verdade.

Manter o antidepressivo depois da melhora reduz em mais da metade o risco de recaída da depressão.1 A terapia cognitiva baseada em mindfulness também reduz o risco de recaída na depressão recorrente.2 As crenças sobre o tratamento, como achar que não é mais necessário, pesam muito na decisão de parar.3 A vergonha e o estigma também afastam as pessoas do cuidado contínuo.4

Referências

• Geddes JR, Carney SM, Davies C, et al. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. Lancet. 2003;361(9358):653-61. doi:10.1016/S0140-6736(03)12599-8

• Kuyken W, Warren FC, Taylor RS, et al. Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse: An Individual Patient Data Meta-analysis From Randomized Trials. JAMA Psychiatry. 2016;73(6):565-74. doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.0076

• Horne R, Chapman SCE, Parham R, et al. Understanding patients' adherence-related beliefs about medicines prescribed for long-term conditions: a meta-analytic review of the Necessity-Concerns Framework. PLoS One. 2013;8(12):e80633. doi:10.1371/journal.pone.0080633

• Clement S, Schauman O, Graham T, et al. What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A

systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychol Med. 2014;45(1):11-27. doi:10.1017/S0033291714000129

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

65 · G4 · publicado em 2026-05-22

A receita que não veio sozinha

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Era só uma renovação de receita de pressão alta. Cinco minutos, no máximo, era o que eu esperava daquela consulta. Acabou se estendendo por quase meia hora — e revelando algo que ela mesma parecia não saber que precisava contar.

Chamemos essa mulher de Sandra. Quarenta e sete anos, hipertensa controlada havia anos, vinha à unidade basicamente só para renovar a receita a cada três meses, sempre rápida, sempre dizendo que "está tudo bem, doutor, só preciso da receita mesmo".

Naquele dia, antes de simplesmente assinar a renovação, decidi fazer as perguntas de rotina que costumo incluir nessas consultas — sobre sono, sobre humor, sobre como estavam as coisas em casa. Ela respondeu, no automático, que estava tudo bem. Mas notei que, enquanto falava, evitava meu olhar, e suas mãos não paravam de se mexer, alisando a barra da blusa repetidamente.

"Sandra, você parece tensa hoje. Está tudo bem mesmo?"

O que vinha sendo carregado em silêncio

Ela hesitou por um tempo que pareceu longo. Depois, em voz baixa, começou a contar que o marido tinha voltado a beber, depois de um período sóbrio, e que as coisas em casa tinham ficado tensas — discussões frequentes, alguns momentos em que ela tinha sentido medo, ainda que ele nunca tivesse sido fisicamente violento.

Contou também que vinha tendo crises de ansiedade havia meses, que escondia da família "para não preocupar todo mundo", e que, secretamente, tinha pensado em sair de casa algumas vezes, mas não sabia para onde ir, nem como sustentar os filhos sozinha.

Nada daquilo tinha relação direta com a hipertensão que motivou a consulta. Mas tudo aquilo, sem dúvida, contribuía para o quadro dela como um todo — inclusive, possivelmente, para a dificuldade que ela vinha tendo em manter a pressão arterial dentro dos níveis esperados nos últimos exames.

Conversamos sobre os recursos disponíveis — desde o acompanhamento psicológico que ela nunca tinha considerado buscar, até informações sobre rede de apoio para situações de violência doméstica, caso ela precisasse no futuro. Ela saiu daquela consulta, segundo me disse depois, sentindo-se "ouvida de um jeito que não acontecia há muito tempo".

O que esse encontro me ensinou

Muitas consultas que parecem simples e objetivas — uma renovação de receita, um exame de rotina — escondem, atrás de si, histórias inteiras de sofrimento que a pessoa nunca teve oportunidade, ou coragem, de contar. Reservar um espaço, mesmo pequeno, para perguntar genuinamente "como você está" pode abrir portas que o motivo declarado da consulta nunca revelaria por conta própria.

Pessoas que vivem violência doméstica têm risco bem maior de ansiedade, depressão e outros transtornos.1 Questionários breves, como o GAD-7, ajudam a medir a

ansiedade na própria consulta.2 A Lei Maria da Penha reconhece a violência psicológica e prevê medidas protetivas de urgência.3 Desde 2021, a violência psicológica contra a mulher é também crime no Código Penal.4

Referências

• Trevillion K, Oram S, Feder G, et al. Experiences of domestic violence and mental disorders: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2012;7(12):e51740. doi:10.1371/journal.pone.0051740

• Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, et al. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-7. doi:10.1001/archinte.166.10.1092

• Brasil. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) — cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. planalto.gov.br

• Brasil. Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021 — inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. planalto.gov.br

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

66 · G4 · publicado em 2026-05-24

Quando o corpo envelhece e a mente é esquecida

Motivo: medicamento · ~5 min

"Ele já está bem velhinho, doutor, é assim mesmo." Foi a explicação que recebi, de mais de um profissional ao longo dos anos, segundo o que constava no prontuário daquele paciente que eu conhecia havia pouco tempo. Quase dez anos de "é assim mesmo" tinham passado, sem que ninguém investigasse mais a fundo.

Chamemos esse homem de Seu Nilton. Setenta e oito anos, viúvo, vivia sozinho havia anos, e tinha um histórico extenso de consultas na unidade — quase sempre por queixas físicas variadas, e sempre com anotações de profissionais anteriores mencionando "tristeza relacionada à idade" ou "apatia esperada para a faixa etária".

Quando o atendi por primeira vez, ainda nas primeiras semanas naquela unidade, encontrei um homem visivelmente desanimado, com discurso lentificado, pouco contato visual, e um relato de que "não tem mais vontade de fazer nada, mas isso é normal quando se chega na minha idade, né doutor".

O que dez anos de "é normal" escondiam

Investigando com mais cuidado, descobri que Seu Nilton apresentava critérios consistentes para um quadro depressivo significativo — não um traço de personalidade, não uma fase esperada do envelhecimento, mas uma condição de saúde mental tratável que, ao que tudo

indicava, vinha sendo carregada, sem diagnóstico nem tratamento, havia quase uma década.

Perguntei sobre a vida social dele. Praticamente inexistente — desde a morte da esposa, tinha se afastado dos poucos amigos que tinha, e os filhos, moradores em outra cidade, ligavam esporadicamente. Perguntei sobre sono, apetite, prazer em atividades antigas: tudo apontava na mesma direção, um quadro depressivo moderado a grave, há muito tempo não identificado como tal.

Iniciamos tratamento, com acompanhamento psiquiátrico de apoio e reativação de algumas conexões sociais possíveis, incluindo um grupo de convivência para idosos que existia no território, mas que ele nunca tinha sido informado sobre. Meses depois, em uma consulta de retorno, Seu Nilton chegou com um sorriso que, segundo ele mesmo comentou, "fazia tempo que não aparecia".

Ele me disse algo que ficou comigo: "doutor, eu pensava que esse vazio que eu sentia era só parte de envelhecer. Ninguém nunca tinha me dito que talvez não precisasse ser assim".

O que esse encontro me ensinou

"É normal da idade" é, talvez, uma das frases mais perigosas da prática clínica — não porque seja dita com má intenção, mas porque fecha a porta para investigações que poderiam mudar completamente a qualidade de vida de uma pessoa. Sofrimento psíquico em idosos merece a mesma curiosidade clínica e o mesmo cuidado que em qualquer outra fase da vida — nunca menos, simplesmente porque a pessoa já viveu mais anos.

Em idosos, a depressão costuma aparecer como queixas físicas, cansaço e desinteresse, e por isso é confundida com o envelhecimento.1 Psicoterapia e antidepressivos são eficazes também nessa faixa etária.2 Solidão e isolamento social aumentam o risco de morte em magnitude comparável a fatores de risco bem conhecidos.3 Muitas pessoas idosas em sofrimento passam pela Atenção Primária pouco antes de uma crise, o que faz de cada consulta uma oportunidade.4

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Alexopoulos GS. Depression in the elderly. Lancet. 2005;365(9475):1961-70. doi:10.1016/S0140-6736(05)66665-2

• Kok RM, Reynolds CF. Management of Depression in Older Adults: A Review. JAMA. 2017;317(20):2114-2122. doi:10.1001/jama.2017.5706

• Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, et al. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspect Psychol Sci. 2015;10(2):227-37. doi:10.1177/1745691614568352

• Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-16. doi:10.1176/appi.ajp.159.6.909

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

67 · G4 · publicado em 2026-05-26

O medo do remédio

Motivo: medicamento · ~5 min

"Doutor, eu prefiro sofrer do meu jeito do que virar outra pessoa com esse remédio." Foi a frase que ouvi, com firmeza quase desafiadora, na segunda consulta com aquela paciente — e que me fez entender que ali não bastava insistir na prescrição.

Chamemos essa mulher de Cristina. Quarenta e um anos, professora, com um quadro depressivo moderado bem caracterizado: tristeza persistente, perda de interesse generalizada, dificuldade de concentração que já afetava o trabalho. Tecnicamente, o caso pedia avaliação para tratamento medicamentoso, combinado com psicoterapia.

Mas Cristina trazia, junto com os sintomas, um conjunto sólido de crenças sobre medicação psiquiátrica: tinha uma tia que, segundo a família contava, "nunca mais foi a mesma" depois de começar a tomar antidepressivo, décadas atrás. Tinha lido histórias na internet sobre "dependência para a vida toda". E carregava, como muitos pacientes, a ideia de que precisar de remédio significava ser fraca demais para lidar com a própria vida.

O que não adiantava fazer

Minha primeira tentativa, naquela segunda consulta, foi explicar tecnicamente por que os medos dela não correspondiam à realidade da maioria dos tratamentos modernos. Ela ouviu educadamente, mas saiu da consulta do mesmo jeito que entrou — decidida a não considerar medicação, disposta a "tentar resolver sozinha".

Nas semanas seguintes, sem tratamento, o quadro de Cristina não melhorou. Ela voltou, ainda resistente, mas visivelmente mais cansada da própria luta. Dessa vez, mudei de abordagem: em vez de argumentar tecnicamente contra os medos dela, perguntei mais sobre eles. Sobre a tia. Sobre o que especificamente a preocupava em "virar outra pessoa".

Foi conversando sobre isso, sem pressa de chegar logo numa prescrição, que ela foi, pouco a pouco, separando o medo genuíno da informação real. Expliquei que, se em algum momento ela sentisse qualquer coisa parecida com o que descrevia ter visto na tia, isso seria motivo imediato para reavaliarmos juntos — ela não precisaria "aguentar calada" um efeito que não fazia sentido para ela.

Cristina decidiu, por fim, tentar o tratamento — não porque eu a convenci com argumentos técnicos, mas porque construímos, juntos, espaço suficiente de confiança para que ela se sentisse segura de que não estaria entregando o controle da própria vida a um remédio, mas ganhando uma ferramenta a mais, sob sua própria supervisão e a minha, para lidar com o que estava sentindo.

O que esse encontro me ensinou

Medo de medicação psiquiátrica raramente se resolve com mais informação técnica isoladamente. Por trás da resistência, quase sempre existe uma história — de família, de cultura, de experiência vivida ou ouvida — que precisa ser escutada antes de qualquer argumento fazer sentido. Construir confiança, nesses casos, é tão parte do tratamento quanto a própria prescrição.

Crenças sobre remédios pesam na adesão: quanto mais preocupações com o tratamento, menor a chance de seguir a prescrição.1 Os antidepressivos são mais eficazes do que placebo na depressão do adulto, com diferenças de tolerabilidade entre eles.2 Sintomas ao parar são comuns e devem ser explicados com honestidade, junto com a orientação de retirada gradual.3 Combinar psicoterapia com antidepressivo tende a dar melhores resultados do que o remédio sozinho.4

Referências

• Horne R, Chapman SCE, Parham R, et al. Understanding patients' adherence-related beliefs about medicines prescribed for long-term conditions: a meta-analytic review of the Necessity-Concerns Framework. PLoS One. 2013;8(12):e80633. doi:10.1371/journal.pone.0080633

• Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366. doi:10.1016/S0140-6736(17)32802-7

• Davies J, Read J. A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based?. Addict Behav. 2018;97:111-121. doi:10.1016/j.addbeh.2018.08.027

• Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole SL, et al. Adding psychotherapy to antidepressant medication in depression and anxiety disorders: a meta-analysis. World Psychiatry. 2014;13(1):56-67. doi:10.1002/wps.20089

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

68 · G4 · publicado em 2026-06-01

O território que conhece seus segredos

Motivo: dúvida da checagem · ~4 min

Foi a agente comunitária de saúde quem primeiro percebeu. Não através de nenhuma queixa formal, mas pela soma de pequenos detalhes que só quem conhece o território de verdade consegue perceber.

Chamemos essa moradora de Dona Marlene. Cinquenta e três anos, hipertensa, acompanhada pela equipe da Estratégia Saúde da Família havia alguns anos. Vinha às consultas regularmente, sempre educada, sempre dizendo que tudo estava bem em casa.

Foi a Agente Comunitária de Saúde da área, que visitava a casa de Dona Marlene mensalmente, quem trouxe à equipe uma preocupação que vinha se acumulando havia tempo: visitas cada vez mais curtas, em que Dona Marlene parecia ansiosa para que a conversa terminasse rápido. Um vizinho que mencionou, en passant, gritos frequentes vindos da casa durante a noite. Marlene usando, numa visita recente, manga longa em pleno calor intenso de fevereiro.

O que o vínculo territorial permite ver

Esses sinais, isoladamente, talvez não significassem muita coisa. Mas a agente comunitária, que conhecia aquela família havia anos, que tinha visto a dinâmica da casa mudar gradualmente, trouxe essa preocupação para discussão em uma reunião de equipe — exatamente o tipo de informação que dificilmente chegaria através de uma consulta isolada e pontual.

Na consulta seguinte, abordei o assunto com Dona Marlene de forma cuidadosa, sem acusações diretas, criando espaço genuíno para que ela falasse, se quisesse. Ela inicialmente negou qualquer problema. Mas, ao final da consulta, já de pé, parou na porta e disse, em voz baixa: "doutor, as coisas em casa não estão fáceis".

Foi o suficiente para abrir uma conversa mais longa, com cuidado redobrado, sobre uma situação de violência doméstica que ela vinha vivendo havia meses, sem saber a quem recorrer, sem coragem de denunciar, com medo de represálias e também de julgamento.

Articulamos, com ela e com o consentimento dela em cada passo, acesso à rede de proteção disponível no território — desde orientação sobre seus direitos legais, até apoio psicológico e articulação, quando ela se sentiu pronta, com os serviços de proteção à mulher disponíveis na região.

O que esse encontro me ensinou

A Atenção Primária, especialmente através do vínculo territorial construído pelos agentes comunitários de saúde, tem uma capacidade única de identificar sofrimento que dificilmente se revelaria numa consulta isolada. Esse vínculo de confiança, construído ao longo de anos de presença constante no território, é uma das ferramentas mais poderosas — e mais subestimadas — que a Estratégia Saúde da Família oferece.

Pessoas que vivem violência doméstica têm risco bem maior de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais.1 Intervenções conduzidas por trabalhadores da atenção primária e da comunidade podem melhorar

desfechos de saúde mental, segundo revisão Cochrane.2 No Brasil, a violência contra a mulher atendida em serviços de saúde é de notificação compulsória.3 A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência para mulheres em situação de violência.4

Referências

• Trevillion K, Oram S, Feder G, et al. Experiences of domestic violence and mental disorders: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2012;7(12):e51740. doi:10.1371/journal.pone.0051740

• Purgato M, Prina E, Ceccarelli C, et al. Primary-level and community worker interventions for the prevention of mental disorders and the promotion of well-being in low- and middle-income countries. Cochrane Database Syst Rev. 2023;10(10):CD014722. doi:10.1002/14651858.CD014722.pub2

• Brasil. Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003 — estabelece a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher atendidos em serviços de saúde. www.planalto.gov.br

• Brasil. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) — cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. planalto.gov.br

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional

previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

69 · G4 · publicado em 2026-06-11

O dia em que aprendi a não saber tudo

Motivo: medicamento · ~5 min

Eu tinha uma hipótese diagnóstica bem construída, baseada em anos de formação e experiência clínica. Estava, tecnicamente, certo de que sabia o que estava acontecendo com aquela paciente. E, ainda assim, estava completamente errado sobre o que ela realmente precisava de mim.

Chamemos essa mulher de Dona Beatriz. Sessenta e poucos anos, vinha à consulta com um quadro que, clinicamente, eu já tinha visto repetidas vezes: sintomas depressivos claros, critérios bem preenchidos, tudo apontando para a indicação técnica de medicação antidepressiva e acompanhamento psicológico.

Expliquei a ela, com a clareza que considerava adequada, o diagnóstico e o plano de tratamento. Ela ouviu, educadamente, mas algo no silêncio dela depois da minha explicação me incomodou — não era o silêncio de quem concorda, era o silêncio de quem está esperando educadamente que a consulta termine.

O que eu não tinha perguntado

Numa pausa, decidi abandonar momentaneamente o roteiro técnico e perguntar, com genuína curiosidade, o que ela achava que estava acontecendo consigo mesma. A resposta me pegou de surpresa: "doutor, eu acho que isso é coisa espiritual, não é remédio que vai resolver".

Minha primeira reação interna foi de resistência — afinal, os critérios clínicos eram claros, a evidência científica

sobre tratamento de depressão é sólida. Mas, em vez de simplesmente reafirmar minha autoridade técnica, decidi perguntar mais: o que, especificamente, ela entendia como "coisa espiritual", e o que ela já tinha tentado fazer a respeito.

Dona Beatriz me contou sobre sua fé, profundamente importante para ela, e sobre uma crença de que aquele sofrimento tinha um significado espiritual que precisava ser trabalhado dentro da sua própria comunidade religiosa, não apenas com remédios. Ela não estava recusando ajuda — estava me dizendo, à sua maneira, que precisava que seu tratamento respeitasse também essa dimensão da sua vida.

Em vez de insistir apenas na via medicamentosa, construímos juntos um plano que incluía o tratamento clínico que eu considerava necessário, mas também espaço explícito para que ela buscasse apoio dentro da própria comunidade religiosa, sem que isso fosse tratado como contraditório ao tratamento médico. Ela aceitou seguir com a medicação, algo que provavelmente não teria acontecido se eu tivesse insistido apenas na minha versão técnica da história, sem ouvir a dela.

O que esse encontro me ensinou

O conhecimento técnico é essencial, mas não é suficiente sozinho. Cada paciente carrega uma visão de mundo, uma cultura, uma fé, que moldam como ele entende o próprio sofrimento — e ignorar essa dimensão, mesmo com a melhor intenção clínica, pode afastar exatamente a pessoa que mais precisamos alcançar. Saber muito sobre doenças não substitui saber escutar, com humildade genuína, o que cada pessoa entende sobre a própria vida.

A Associação Mundial de Psiquiatria recomenda considerar a religiosidade e a espiritualidade do paciente na avaliação e no cuidado.1 Revisões mostram que a religiosidade costuma se associar a melhores indicadores de saúde mental.2 Uma comunicação centrada no paciente se associa a melhor avaliação do cuidado e mais confiança.3 As crenças sobre o tratamento também influenciam a adesão, por isso precisam ser ouvidas.4

Referências

• Moreira-Almeida A, Sharma A, van Rensburg BJ, et al. WPA Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry. World Psychiatry. 2016;15(1):87-8. doi:10.1002/wps.20304

• Lucchetti G, Koenig HG, Lucchetti ALG. Spirituality, religiousness, and mental health: A review of the current scientific evidence. World J Clin Cases. 2021;9(26):7620-7631. doi:10.12998/wjcc.v9.i26.7620

• Cooper LA, Roter DL, Johnson RL, et al. Patient-centered communication, ratings of care, and concordance of patient and physician race. Ann Intern Med. 2003;139(11):907-15. doi:10.7326/0003-4819-139-11-200312020-00009

• Horne R, Chapman SCE, Parham R, et al. Understanding patients' adherence-related beliefs about medicines prescribed for long-term conditions: a meta-analytic review of the Necessity-Concerns Framework. PLoS One. 2013;8(12):e80633. doi:10.1371/journal.pone.0080633

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

70 · G4 · publicado em 2026-06-13

O tabaco que ninguém perguntava sobre

Motivo: medicamento · ~5 min

Trinta e dois anos fumando, e nenhuma consulta médica anterior, segundo ele mesmo contou, tinha realmente perguntado sobre isso com profundidade. Sempre uma pergunta de rotina, sempre uma resposta rápida, sempre seguindo para o próximo tópico.

Chamemos esse homem de Seu Edvaldo. Cinquenta e oito anos, fumante desde a adolescência, vinha à unidade para acompanhamento de hipertensão e, mais recentemente, por uma tosse persistente que o preocupava. O tabagismo constava em seu prontuário havia anos, sempre anotado, raramente discutido em profundidade.

Naquele dia, decidi não simplesmente anotar "tabagista" e seguir adiante. Perguntei a ele há quanto tempo fumava, quantos cigarros por dia, e — a pergunta que pareceu pegá-lo de surpresa — como ele se sentia em relação a esse hábito.

O que estava por trás de décadas de cigarro

Seu Edvaldo, inicialmente na defensiva, foi se abrindo aos poucos. Contou que já tinha tentado parar de fumar diversas vezes ao longo da vida, sempre sem sucesso duradouro. Que sentia vergonha disso, como se fosse uma falha pessoal de força de vontade. Que, mais recentemente, vinha fumando ainda mais, coincidindo com um período de estresse intenso no trabalho e dificuldades financeiras na família.

Expliquei a ele, com cuidado, que dependência de nicotina é reconhecida como uma das formas mais persistentes de dependência química — não por falta de força de vontade, mas por mecanismos neurobiológicos reais, que tornam a cessação genuinamente difícil sem apoio adequado. Essa simples informação pareceu aliviar, ainda que parcialmente, uma vergonha que ele carregava havia décadas.

Conversamos sobre as opções de apoio disponíveis — desde grupos de cessação tabágica oferecidos pela rede pública, até a possibilidade de suporte farmacológico, quando indicado, e acompanhamento psicológico para lidar com o estresse que parecia alimentar o hábito naquele momento específico da vida dele.

Seu Edvaldo não parou de fumar imediatamente — processos de cessação tabágica raramente são lineares. Mas, pela primeira vez em décadas, segundo ele mesmo relatou meses depois, sentiu que tinha alguém genuinamente interessado em ajudá-lo com aquilo, e não apenas anotando o hábito como mais um dado de rotina no prontuário.

O que esse encontro me ensinou

Por ser legal e socialmente normalizado, o tabagismo às vezes recebe menos atenção clínica profunda do que outras dependências — tratado como um dado de prontuário, não como um sofrimento real que merece escuta e apoio genuínos. Perguntar com profundidade, em vez de apenas registrar o hábito, pode abrir a porta para um processo de cessação que décadas de anotações superficiais nunca conseguiram iniciar.

Parar de fumar se associa a menos ansiedade, depressão e estresse, ao contrário do que muitos fumantes imaginam.1 Mesmo um aconselhamento breve do médico aumenta as chances de parar, segundo revisão Cochrane.2 Reposição de nicotina, bupropiona e vareniclina aumentam as taxas de cessação.3 Instrumentos como o ASSIST, da OMS, incluem o tabaco e ajudam a perguntar sobre o hábito de forma estruturada.4

Referências

• Taylor G, McNeill A, Girling A, et al. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2014;348:g1151. doi:10.1136/bmj.g1151

• Stead LF, Buitrago D, Preciado N, et al. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(5):CD000165. doi:10.1002/14651858.CD000165.pub4

• Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(5):CD009329. doi:10.1002/14651858.CD009329.pub2

• Humeniuk R, Ali R, Babor TF, et al. Validation of the Alcohol, Smoking And Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Addiction. 2008;103(6):1039-47. doi:10.1111/j.1360-0443.2007.02114.x

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e

circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

71 · G4 · publicado em 2026-06-25

Primeiros episódios psicóticos: reconhecimento precoce e conduta inicial

Motivo: medicamento · ~4 min

O tempo entre os primeiros sintomas de psicose e o início do tratamento adequado influencia o prognóstico. A Atenção Primária e o pronto atendimento são, muitas vezes, a porta de entrada, e podem encurtar esse caminho.

Por que o tempo importa

Uma revisão sistemática com meta-análise encontrou associação, pequena mas consistente, entre maior duração da psicose não tratada e pior evolução a longo prazo, incluindo mais sintomas, menor chance de remissão e pior funcionamento social.1

Serviços de intervenção precoce, com equipes dedicadas e cuidado integrado, mostraram resultados superiores ao tratamento habitual em todos os desfechos avaliados, como menos abandono e internações, melhor funcionamento e maior participação em trabalho e estudo.2

Antes da psicose franca: o período prodrômico

• isolamento social progressivo;

• queda no desempenho escolar ou no trabalho sem causa clara;

• alterações de sono, irritabilidade, ansiedade incomum;

• comportamentos ou ideias estranhos, diferentes do padrão anterior;

• desconfiança crescente, sensação de estar sendo observado.

Sintomas psicóticos

• Alucinações, especialmente auditivas;

• Delírios, como persecutórios, de referência, de grandeza ou de controle;

• Desorganização do pensamento e do comportamento;

• Sintomas negativos: embotamento, falta de iniciativa, pouca fala.

Antes de tudo, afastar causa clínica: delirium, encefalites (incluindo autoimunes), epilepsia, distúrbios metabólicos e endócrinos, efeitos de medicamentos e uso de substâncias. Alteração de consciência, início abrupto, sinais neurológicos e alucinações visuais predominantes reforçam essa suspeita. Pergunte sempre sobre maconha, estimulantes e outras drogas.

Também é preciso diferenciar

Experiências espirituais e religiosas culturalmente reconhecidas, sem sofrimento e sem prejuízo funcional, não são, por si, psicose.3 Na dúvida, converse com a família e com a comunidade de referência da pessoa.

Conduta inicial

• avaliar risco de suicídio, de agressão e de autonegligência;

• exames clínicos e laboratoriais básicos, e neuroimagem quando indicada;

• envolver a família, com consentimento, explicando o que está acontecendo;

• discutir o caso com a equipe de referência em saúde mental (matriciamento) e encaminhar com prioridade ao CAPS;

• se houver indicação de antipsicótico, preferir doses baixas, com titulação cuidadosa, atenção a efeitos metabólicos e motores e decisão compartilhada.

O uso de cannabis, sobretudo de alta potência e diário, se associa a maior risco de psicose, e deve ser investigado e abordado.4

A primeira experiência marca

A forma como a pessoa é recebida no primeiro contato com o sistema de saúde influencia a confiança e a adesão futuras. Acolhimento, explicação clara e participação nas decisões fazem parte do tratamento.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Penttilä M, Jääskeläinen E, Hirvonen N, et al. Duration of untreated psychosis as predictor of long-term outcome in schizophrenia: systematic review and meta-analysis. Br J

Psychiatry. 2014;205(2):88-94. doi:10.1192/bjp.bp.113.127753

• Correll CU, Galling B, Pawar A, et al. Comparison of Early Intervention Services vs Treatment as Usual for Early-Phase Psychosis: A Systematic Review, Meta-analysis, and Meta-regression. JAMA Psychiatry. 2018;75(6):555-565. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.0623

• Menezes A Jr, Moreira-Almeida A. Religion, spirituality, and psychosis. Curr Psychiatry Rep. 2010;12(3):174-179. doi:10.1007/s11920-010-0117-7

• Di Forti M, Quattrone D, Freeman TP, et al. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. Lancet Psychiatry. 2019;6(5):427-436. doi:10.1016/S2215-0366(19)30048-3

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

72 · G4 · publicado em 2026-07-01

Intoxicação exógena e agitação: diferenciando causas no PA

Motivo: medicamento · ~4 min

Nem toda agitação que chega ao pronto atendimento psiquiátrico é psiquiátrica. Intoxicação, abstinência e delirium podem se parecer com um surto, e confundir os quadros pode custar caro ao paciente.

A pergunta que vem primeiro

Diante de qualquer paciente agitado: isso é causa clínica, intoxicação ou abstinência, transtorno psiquiátrico primário, ou uma combinação? O consenso do Projeto BETA, da Associação Americana de Psiquiatria de Emergência, recomenda que a escolha do tratamento parta da causa mais provável da agitação, e que no delirium a prioridade seja tratar a causa de base.1

Sinais que apontam para causa clínica ou tóxica

• alteração ou flutuação do nível de consciência, desorientação;

• sinais vitais alterados: febre, taquicardia importante, hipotensão, dessaturação;

• sinais neurológicos focais, convulsão, trauma craniano;

• primeiro episódio após os 40 anos ou sem história psiquiátrica;

• alucinações visuais ou táteis predominantes;

• pupilas alteradas, sudorese, tremor, odor de álcool.

Diferenciação prática

• Intoxicação alcoólica: ataxia, disartria, labilidade. Atenção a hipoglicemia e trauma craniano oculto.

• Abstinência alcoólica: tremor, sudorese, taquicardia, hipertensão; risco de convulsões e delirium tremens.

• Estimulantes (cocaína, anfetaminas): midríase, taquicardia, hipertensão, hipertermia, dor torácica. Monitorização cardiovascular e controle térmico.

• Síndrome anticolinérgica: pele seca e quente, rubor, midríase, retenção urinária, delirium.

• Delirium de outra causa: início agudo, desatenção e flutuação. Não é diagnóstico final: sempre buscar a causa.

• Agitação psiquiátrica primária: consciência preservada, sinais vitais normais ou pouco alterados, história compatível. Diagnóstico após afastar as anteriores.

Princípio: agitação com alteração de consciência é causa clínica até prova em contrário.

Avaliação mínima

Glicemia capilar, sinais vitais completos, oximetria e exame físico dirigido são obrigatórios. Conforme o caso: eletrocardiograma, eletrólitos, função renal e hepática, exames toxicológicos disponíveis e neuroimagem.

Manejo enquanto se investiga

As diretrizes brasileiras recomendam começar por medidas não farmacológicas e, se a medicação for necessária, escolher o fármaco conforme a causa

provável, preferindo a via oral e evitando a via intravenosa fora de ambiente monitorizado.2,3 Em intoxicação por depressores do sistema nervoso central, cuidado redobrado com sedativos.

A desescalada verbal deve ser a primeira abordagem, antes de qualquer medida de contenção.4

Referências

• Wilson MP, Pepper D, Currier GW, et al. The psychopharmacology of agitation: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA Psychopharmacology Workgroup. West J Emerg Med. 2012;13(1):26-34. doi:10.5811/westjem.2011.9.6866

• Baldaçara L, Ismael F, Leite V, et al. Brazilian guidelines for the management of psychomotor agitation. Part 1. Non-pharmacological approach. Braz J Psychiatry. 2018;41(2):153-167. doi:10.1590/1516-4446-2018-0163

• Baldaçara L, Diaz AP, Leite V, et al. Brazilian guidelines for the management of psychomotor agitation. Part 2. Pharmacological approach. Braz J Psychiatry. 2019;41(4):324-335. doi:10.1590/1516-4446-2018-0177

• Richmond JS, Berlin JS, Fishkind AB, et al. Verbal De-escalation of the Agitated Patient: Consensus Statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup. West J Emerg Med. 2012;13(1):17-25. doi:10.5811/westjem.2011.9.6864

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

73 · G4 · publicado em 2026-07-25

Saúde mental do idoso: rastreio na consulta de rotina

Motivo: medicamento · ~4 min

Atribuir tristeza, desânimo ou isolamento ao "envelhecimento normal" é um viés que atravessa também a prática clínica. A depressão no idoso é frequente, tratável e muitas vezes não reconhecida.

Uma apresentação diferente

Pessoas idosas com depressão relatam menos tristeza e mais queixas físicas, cansaço, alterações de sono e apetite, irritabilidade, perda de interesse e queixas de memória. Uma revisão no JAMA sobre depressão em idosos ressalta que ela é comum, aumenta a morbidade e a mortalidade e pode ser tratada de forma eficaz.1

Rastreio

A Escala de Depressão Geriátrica (GDS) tem versões curtas. No Brasil, as versões com 10 e 15 itens mostraram confiabilidade adequada, enquanto as versões de 1 e 4 itens não foram confiáveis para a prática.2

O que investigar junto

• declínio cognitivo e delirium;

• medicamentos que podem causar ou piorar sintomas;

• dor crônica, perda auditiva e visual, limitações funcionais;

• luto, solidão, aposentadoria, mudança de casa;

• uso de álcool e de benzodiazepínicos;

• violência e negligência contra a pessoa idosa;

• risco de suicídio: elevado em idosos, especialmente homens, viúvos, com doenças graves e isolados.

Tratamento

• antidepressivos são eficazes; comece com doses baixas, ajuste devagar e monitore efeitos como hiponatremia, quedas e interações;1

• psicoterapia e atividade física são eficazes em quadros leves a moderados e para quem prefere tratamento não farmacológico;1

• grupos de convivência, atividades comunitárias e reconstrução da rede de apoio;

• eletroconvulsoterapia em casos graves, refratários ou com risco de vida.

Quase metade das pessoas que morreram por suicídio tinha procurado a Atenção Primária no mês anterior, proporção ainda maior entre idosos.3

Ponto de atenção: depressão com queixas cognitivas pode ser confundida com demência, e também pode ser um sinal precoce dela. A comissão da The Lancet sobre demência (2024) inclui depressão e isolamento social entre os fatores de risco modificáveis.4 Trate a depressão e reavalie a cognição depois.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em

emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Kok RM, Reynolds CF. Management of Depression in Older Adults: A Review. JAMA. 2017;317(20):2114-2122. doi:10.1001/jama.2017.5706

• Almeida OP, Almeida SA. [Reliability of the Brazilian version of the ++abbreviated form of Geriatric Depression Scale (GDS) short form]. Arq Neuropsiquiatr. 1999;57(2B):421-6. doi:10.1590/s0004-282x1999000300013

• Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-16. doi:10.1176/appi.ajp.159.6.909

• Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024;404(10452):572-628. doi:10.1016/S0140-6736(24)01296-0

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

74 · G4 · publicado em 2026-08-02

Psicofármacos na Atenção Primária: princípios de raciocínio clínico

Motivo: medicamento · ~4 min

Prescrever, ou não, um psicofármaco na Atenção Primária raramente é uma decisão só farmacológica. Envolve gravidade, preferências do paciente, comorbidades, acesso e acompanhamento ao longo de meses.

Antes de prescrever: cinco perguntas

• Qual a gravidade? Uma meta-análise com dados individuais mostrou que o benefício dos antidepressivos em relação ao placebo aumenta com a gravidade da depressão e pode ser pequeno, em média, em quadros leves.1 Em sintomas leves, intervenções psicossociais, atividade física e acompanhamento ativo são opções iniciais razoáveis.

• Há comorbidades e outros medicamentos? Interações, função renal e hepática, cardiopatias, gestação e lactação influenciam a escolha.

• O que o paciente espera e prefere? Decisão compartilhada aumenta a adesão.

• Há como acompanhar? As primeiras semanas concentram efeitos adversos e abandono. Programe retorno ou contato em duas a quatro semanas.

• É caso para discutir com a saúde mental? Suspeita de bipolaridade ou psicose, risco de suicídio importante, gestação, falha de tratamentos, uso de substâncias.

O que as evidências dizem sobre antidepressivos

Uma meta-análise em rede com 21 antidepressivos e mais de 500 ensaios concluiu que todos foram mais eficazes que placebo na depressão maior em adultos, com diferenças de eficácia e de tolerabilidade entre eles.2 Na prática da APS, a escolha costuma considerar perfil de efeitos adversos, interações, comorbidades, custo e disponibilidade na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e nas listas municipais.

Combinar é melhor que medicar sozinho

Associar psicoterapia à medicação foi mais eficaz do que a medicação isolada na depressão maior, no transtorno de pânico e no TOC, com efeito mantido por até dois anos.3 Grupos na própria unidade e o matriciamento ajudam a tornar isso possível.

Boas práticas

• começar com dose baixa e ajustar conforme resposta e tolerância;

• avisar sobre o tempo até o efeito (duas a seis semanas) e efeitos iniciais transitórios;

• avaliar resposta com instrumentos simples, como PHQ-9 e GAD-7;

• manter o tratamento por 6 a 12 meses após a remissão na depressão, e mais tempo em episódios recorrentes;

• planejar retirada gradual, nunca abrupta;

• monitorar risco de suicídio no início do tratamento, especialmente em jovens;

• em prescrições para pessoas em risco, limitar a quantidade dispensada.

Em idosos, os Critérios de Beers ajudam a evitar medicamentos com maior risco de efeitos adversos.4

Benzodiazep ínicos: evitar como tratamento de manutenção de ansiedade e insônia. Revisar prescrições antigas, sobretudo em idosos, e oferecer retirada gradual e acompanhada.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, et al. Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level meta-analysis. JAMA. 2010;303(1):47-53. doi:10.1001/jama.2009.1943

• Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366. doi:10.1016/S0140-6736(17)32802-7

• Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole SL, et al. Adding psychotherapy to antidepressant medication in depression and anxiety disorders: a meta-analysis. World Psychiatry. 2014;13(1):56-67. doi:10.1002/wps.20089

• 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

75 · G4 · publicado em 2026-08-04

Por que existe tanta desinformação sobre psicofármacos?

Motivo: medicamento · ~6 min

"Antidepressivo muda a personalidade." "Quem toma remédio para a cabeça fica dependente para sempre." "Isso é coisa de gente fraca." Frases assim afastam muita gente de um tratamento que poderia ajudar. Entender de onde vêm — e o que a ciência realmente diz — ajuda a decidir com mais liberdade.

Poucas áreas da medicina despertam tanta desconfiança quanto os medicamentos para saúde mental. Parte desse medo tem raízes compreensíveis. Parte é desinformação. Este texto ajuda a separar uma coisa da outra.

De onde vêm os mitos

Uma história que deixou marcas

Práticas do passado — sedação excessiva, internações longas, pouca escuta e pouco consentimento — deixaram uma desconfiança que ainda hoje é aplicada a um campo que mudou muito.

O que filmes e séries mostram

Personagens "dopados", sem emoção ou controlados pelo remédio moldam expectativas muito antes de qualquer consulta.

O estigma

Quando o sofrimento mental é visto como fraqueza ou falta de fé, o remédio passa a ser visto como "muleta", e não como cuidado. Curiosamente, explicar os transtornos apenas como "doença do cérebro" não resolve esse problema: um estudo que acompanhou a opinião pública ao longo de dez anos mostrou que essa explicação aumentou o apoio ao tratamento, mas não reduziu o preconceito contra quem sofre1. O estigma diminui mais quando se enfatizam a capacidade e a inclusão das pessoas.

As redes sociais

Relatos negativos — reais e importantes para quem os viveu — circulam mais do que explicações cuidadosas e acabam parecendo a regra, e não a exceção.

Uma comissão da revista Lancet mostrou que o estigma e a discriminação em saúde mental continuam afastando as pessoas do cuidado, e uma revisão sistemática confirmou que ele reduz a busca por ajuda2,3.

Mito ou fato? Guarde esta lista

• "Antidepressivo não funciona, é placebo." Mito. Uma grande análise, com 522 estudos e mais de 116 mil pessoas, mostrou que os 21 antidepressivos avaliados foram mais eficazes que o placebo no tratamento da depressão em adultos4. O efeito varia de pessoa para pessoa, e nenhum remédio funciona para todos.

• "Muda quem você é." Mito. O objetivo é retirar o peso da doença. Se a pessoa se sente "apagada" ou diferente, isso é um efeito a ser conversado e ajustado com o médico — não algo que se deva aceitar calado.

• "Vicia." Depende. Antidepressivos não causam dependência no sentido de vício, mas parar de repente pode causar sintomas de retirada, como tontura, irritação e insônia. Por isso, a retirada deve ser gradual e planejada, às vezes ao longo de meses5. Já alguns calmantes, como os benzodiazepínicos, podem causar dependência quando usados por tempo prolongado.

• "É para sempre." Mito, na maioria dos casos. Muitas pessoas usam por um período e depois param com segurança, com acompanhamento.

• "Remédio é para quem é fraco." Mito. Tratar depressão ou ansiedade é tão legítimo quanto tratar pressão alta ou diabetes.

• "Tem efeitos colaterais." Fato. Todo medicamento pode ter. A maioria é leve ou passageira, e quase sempre há alternativas quando incomodam.

Um ponto de equilíbrio: desmistificar psicofármacos não é dizer que não existem desafios. Efeitos colaterais existem, ajustes às vezes são necessários e cada pessoa responde de um jeito. É separar esses desafios reais dos medos sem fundamento.

Perguntas para levar à consulta

Se você está com receio de começar um tratamento, leve estas perguntas ao médico:

• Por que este medicamento, para o meu caso?

• Em quanto tempo devo perceber melhora?

• Quais efeitos são comuns e o que faço se aparecerem?

• Por quanto tempo devo usar, e como será a retirada?

• Existem outras opções, como psicoterapia, junto ou no lugar do remédio?

Para profissionais de saúde

Corrigir o mito com dados raramente basta. Reconhecer o medo por trás da resistência — "você tem receio de perder o controle sobre quem você é, e isso é compreensível" — costuma abrir mais espaço para a conversa. Informar sobre a retirada desde o início também aumenta a confiança e a adesão.

Nunca interrompa ou mude a dose de um medicamento por conta própria. Converse antes com o médico que acompanha você. Se você precisar de apoio agora: CVV — 188 (gratuito, 24h) · SAMU — 192 em emergências.

Orientação geral: respeitam-se sempre os protocolos hospitalares, do Pronto Atendimento (PA) e da rede de saúde locais.

Referências

• Pescosolido BA, Martin JK, Long JS, et al. "A disease like any other"? A decade of change in public reactions to schizophrenia, depression, and alcohol dependence. American Journal of Psychiatry. 2010;167(11):1321-1330. doi:10.1176/appi.ajp.2010.09121743

• Thornicroft G, Sunkel C, Alikhon Aliev A, et al. The Lancet Commission on ending stigma and discrimination in mental health. Lancet. 2022;400(10361):1438-1480. doi:10.1016/S0140-6736(22)01470-2

• Clement S, Schauman O, Graham T, et al. What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychol Med. 2014;45(1):11-27. doi:10.1017/S0033291714000129

• Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366. doi:10.1016/S0140-6736(17)32802-7

• Horowitz MA, Taylor D. Tapering of SSRI treatment to mitigate withdrawal symptoms. Lancet Psychiatry. 2019;6(6):538-546. doi:10.1016/S2215-0366(19)30032-X

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

76 · G4 · publicado em 2026-08-12

Saúde mental na residência: como sobreviver (e se desenvolver) nos anos de formação

Motivo: medicamento · ~6 min

Ninguém avisa, antes da residência começar, que o maior desafio não vai ser o conhecimento técnico — vai ser continuar inteiro emocionalmente enquanto se forma como médico.

A residência médica é, ao mesmo tempo, um dos períodos de maior crescimento profissional e um dos de maior risco para a saúde mental na carreira médica. Plantões extensos, privação crônica de sono, exposição precoce ao sofrimento e à morte, hierarquias rígidas e a pressão por desempenho constante criam um ambiente que, sem cuidado ativo, adoece com facilidade.

Por que esse período é particularmente vulnerável

Diferente da graduação, na residência a exigência deixa de ser só intelectual e passa a ser também física e emocional, em tempo integral. O residente precisa, ao mesmo tempo, aprender, performar, lidar com a responsabilidade real sobre vidas e ainda construir identidade profissional — tudo isso com sono insuficiente e suporte emocional muitas vezes escasso.

Um dado que merece ser dito sem rodeios: médicos residentes apresentam taxas de depressão, ansiedade e burnout consistentemente mais altas que a população geral da mesma faixa etária — e a cultura médica,

historicamente, tratou isso como "parte do processo" em vez de como um problema a ser enfrentado.

Uma meta-análise estimou que cerca de 29% dos médicos residentes apresentam depressão ou sintomas depressivos, e entre estudantes de medicina a proporção é parecida1,2.

Sinais de que algo precisa de atenção

• Exaustão que não melhora com o descanso disponível

• Cinismo crescente em relação aos pacientes ou à profissão

• Sensação persistente de incompetência, mesmo com desempenho adequado

• Isolamento de amigos e família "porque não tenho tempo nem energia"

• Uso de substâncias (incluindo cafeína em excesso, álcool, ansiolíticos sem orientação) como forma de lidar com o estresse

• Pensamentos recorrentes de desistir da carreira ou de que "não vale a pena continuar"

O que de fato ajuda

No nível individual

Buscar apoio psicológico ou psiquiátrico não é admissão de fracasso — é uma decisão estratégica de qualquer profissional que entende os próprios limites. Pequenos hábitos protetores também importam: preservar o sono sempre que a escala permitir, manter ao menos um

vínculo social fora da medicina, e processar casos difíceis em vez de simplesmente acumulá-los emocionalmente.

No nível dos pares

Conversas entre residentes sobre as dificuldades reais — não só sobre conteúdo técnico — quebram o isolamento e normalizam buscar ajuda. Programas de mentoria entre residentes mais experientes e iniciantes também fazem diferença real na adaptação aos primeiros meses, historicamente os mais difíceis.

No nível institucional

Programas de residência que oferecem suporte psicológico estruturado, supervisão clínica com espaço genuíno para dúvidas e fragilidades, e jornadas de trabalho dentro dos limites legais têm impacto direto na saúde mental e na qualidade da formação. Cobrar isso das instituições não é "fragilidade" — é parte legítima da construção de uma formação médica sustentável.

"A residência forma médicos competentes tecnicamente, mas só forma médicos íntegros e sustentáveis quando também cuida da saúde mental de quem está se formando. Pedir ajuda durante esse processo não te torna um residente pior — pode ser exatamente o que vai te permitir terminar essa formação inteiro."

Levar a própria saúde mental em conta durante a residência não é desviar o foco da formação técnica — é parte dela. Médicos que aprendem, desde cedo, a reconhecer seus próprios limites e buscar apoio quando necessário tendem a sustentar carreiras mais longas,

mais saudáveis e, no fim, mais úteis para quem vão cuidar.

Este conteúdo tem finalidade educativa e reflexiva, baseado em evidências sobre saúde mental de médicos em formação e na experiência prática do autor em mentoria de residentes e estudantes de medicina.

Estratégias individuais e mudanças na organização do trabalho reduzem o burnout em médicos, e as mudanças organizacionais tendem a ter efeito maior3,4.

Ferramenta interativa

Indexador de Foco e Procrastinação Acadêmica

Seis afirmações sobre hábitos de estudo, escala de 1 (nunca) a 5 (quase sempre).

Adio o início de tarefas de estudo mesmo tendo tempo disponível

1 2 3 4 5

Me distraio com celular ou redes sociais enquanto deveria estar estudando

1 2 3 4 5

Sinto que só consigo produzir de verdade perto do prazo final

1 2 3 4 5

Tenho dificuldade de retomar o foco depois de qualquer interrupção

1 2 3 4 5

Sinto culpa ou ansiedade nos momentos em que não estou "produzindo"

1 2 3 4 5

Estudo por horas seguidas sem pausas reais, até esgotar

1 2 3 4 5

Calcular meu índice de dispersão

Ferramenta educativa de autoavaliação. Não substitui consulta, diagnóstico ou acompanhamento por profissional habilitado.

Falar sobre mentoria individual

(function () { var fatores = ['adiar', 'distracao', 'prazo', 'retomar', 'culpa', 'maratona']; var botao = document.getElementById('fa-calcular'); if (!botao) return; botao.addEventListener('click', function () { var erro = document.getElementById('fa-erro'); var soma = 0, faltando = false; for (var i = 0; i

Se você precisar de apoio agora: CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências.

Referências

• Mata DA, Ramos MA, Bansal N, et al. Prevalence of Depression and Depressive Symptoms Among Resident Physicians: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2015;314(22):2373-83. doi:10.1001/jama.2015.15845

• Rotenstein LS, Ramos MA, Torre M, et al. Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA. 2016;316(21):2214-2236. doi:10.1001/jama.2016.17324

• West CP, Dyrbye LN, Erwin PJ, et al. Interventions to prevent and reduce physician burnout: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016;388(10057):2272-2281. doi:10.1016/S0140-6736(16)31279-X

• Panagioti M, Panagopoulou E, Bower P, et al. Controlled Interventions to Reduce Burnout in Physicians: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2017;177(2):195-205. doi:10.1001/jamainternmed.2016.7674

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

77 · G4 · publicado em 2026-08-24

Saúde mental do idoso: o que toda família precisa saber

Motivo: medicamento · ~5 min

"É normal ficar assim na idade dele" é uma das frases mais comuns — e mais perigosas — quando se trata da saúde mental de idosos. Sofrimento psíquico não é parte inevitável do envelhecimento, e tratá-lo como tal frequentemente significa deixar de oferecer um cuidado que poderia genuinamente ajudar.

Depressão, ansiedade e outros sofrimentos psíquicos em idosos são subdiagnosticados com frequência, justamente porque sintomas são atribuídos precipitadamente à idade, a doenças físicas concomitantes, ou simplesmente normalizados como parte de "ficar mais velho".

Por que a depressão no idoso costuma passar despercebida

Diferente do que se imagina, depressão em idosos frequentemente não se apresenta como tristeza evidente. Pode se manifestar como queixas físicas persistentes sem causa orgânica clara, irritabilidade, perda de interesse em atividades antes valorizadas, isolamento social progressivo, ou até como declínio cognitivo que pode ser confundido com demência inicial.

Um ponto clinicamente relevante: a chamada "pseudodemência depressiva" — quadro de depressão que se apresenta com sintomas cognitivos significativos, como esquecimento e lentificação do pensamento — pode ser confundida com demência, mas responde bem

ao tratamento adequado da depressão, diferente de quadros neurodegenerativos verdadeiros.

Na pessoa idosa, a depressão costuma aparecer mais como queixas físicas, perda de interesse e dificuldades de memória do que como tristeza declarada1.

Fatores que aumentam a vulnerabilidade na terceira idade

• Perdas acumuladas — luto de cônjuge, amigos, perda de papéis sociais (aposentadoria), perda de autonomia física

• Isolamento social, especialmente quando a mobilidade reduzida limita a participação em atividades

• Doenças crônicas e dor persistente, que têm relação bidirecional com sofrimento psíquico

• Sensação de perda de propósito ou de "ser um peso" para a família

• Polifarmácia (uso de múltiplas medicações), que pode contribuir para sintomas de humor ou cognitivos

Isolamento social e solidão aumentam em cerca de 26% a 32% o risco de morte, um efeito comparável ao de outros fatores de risco conhecidos2.

Sinais de alerta para a família observar

• Isolamento social crescente, recusa em participar de atividades antes apreciadas

• Mudança significativa de apetite ou padrão de sono

• Comentários sobre se sentir um peso para a família, ou sobre não ter mais motivo para continuar

• Negligência progressiva do autocuidado ou de medicações necessárias

• Irritabilidade persistente ou mudança significativa de personalidade

Sobre risco de suicídio em idosos: embora menos discutido socialmente, o risco de suicídio em idosos, especialmente homens, está entre os mais altos de todas as faixas etárias. Comentários sobre desesperança ou sobre "não fazer mais sentido continuar" devem ser levados a sério e nunca minimizados como "coisa da idade".

Diferenciando sofrimento psíquico de declínio cognitivo

Tanto depressão quanto quadros neurocognitivos (como demências) podem se apresentar com sintomas que se sobrepõem — apatia, lentificação, dificuldade de concentração. A diferenciação exige avaliação cuidadosa, e muitas vezes os dois quadros coexistem. Por isso, queixas cognitivas em idosos merecem investigação cuidadosa, sem assumir automaticamente nenhuma das duas possibilidades.

A versão brasileira da Escala de Depressão Geriátrica é uma ferramenta simples para ajudar nessa avaliação3.

O que ajuda, na prática

• Buscar avaliação médica diante de qualquer mudança significativa de humor, comportamento ou cognição — sem assumir que "é da idade"

• Manter vínculos sociais ativos, mesmo com limitações de mobilidade — visitas regulares, chamadas de vídeo, participação em grupos quando possível

• Valorizar a autonomia possível, evitando infantilizar ou assumir decisões pelo idoso sem necessidade real

• Tratar o sofrimento psíquico com a mesma seriedade que qualquer outra condição de saúde, sem naturalizá-lo como parte inevitável do envelhecimento

"Envelhecer traz, sim, perdas reais — mas sofrimento psíquico intenso não é uma dessas perdas inevitáveis. É uma condição de saúde, como tantas outras, que merece reconhecimento e tratamento adequado, em qualquer idade."

O tratamento funciona também na velhice: há evidência de benefício dos antidepressivos em idosos com depressão maior; a psicoterapia também pode ajudar, sobretudo nos quadros leves e moderados4.

Referências

• Alexopoulos GS. Depression in the elderly. Lancet. 2005;365(9475):1961-70. doi:10.1016/S0140-6736(05)66665-2

• Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, et al. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspect Psychol Sci. 2015;10(2):227-37. doi:10.1177/1745691614568352

• Almeida OP, Almeida SA. [Reliability of the Brazilian version of the ++abbreviated form of Geriatric Depression Scale (GDS) short form]. Arq Neuropsiquiatr.

1999;57(2B):421-6. doi:10.1590/s0004-282x1999000300013

• Kok RM, Reynolds CF. Management of Depression in Older Adults: A Review. JAMA. 2017;317(20):2114-2122. doi:10.1001/jama.2017.5706

Este conteúdo tem finalidade educativa, baseado em literatura sobre saúde mental do idoso e na experiência prática do autor. Não substitui avaliação médica individualizada.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

78 · G4 · publicado em 2026-08-30

Psicofármacos: mitos e verdades sobre o tratamento medicamentoso em saúde mental

Motivo: medicamento · ~6 min

Poucas áreas da medicina carregam tanto receio e desinformação quanto o uso de medicações para a mente. Boa parte desse medo vem de ideias que circulam socialmente, não de informação médica real.

É comum que a indicação de um psicofármaco gere reações intensas: medo de "ficar dependente", de "virar outra pessoa", de "nunca mais conseguir parar". Esses receios são compreensíveis — afinal, estamos falando de algo que atua sobre como pensamos e sentimos. Mas muitos deles vêm de mitos amplamente disseminados, não da realidade clínica. Vamos revisar os mais comuns.

Mito: "Psicofármaco vicia, igual droga"

O que de fato acontece: a grande maioria das medicações usadas em saúde mental — incluindo as mais prescritas para depressão e ansiedade — não causa dependência no sentido de vício, com busca compulsiva e perda de controle. Existe um grupo específico de medicações (usadas, por exemplo, para insônia ou crises agudas de ansiedade) que exige cuidado maior de uso e tempo, justamente por esse motivo — e é por isso que o acompanhamento médico orienta o tempo de uso adequado para cada situação.

Mito: "Vou ficar 'zonado' ou virar outra pessoa"

O que de fato acontece: o objetivo do tratamento adequado não é apagar emoções ou "robotizar" a pessoa — é aliviar sintomas que estão causando sofrimento e prejudicando a vida (sono, concentração, humor, relações), preservando quem a pessoa é. Quando há sensação de embotamento intenso ou de "não ser mais você mesmo", isso é informação importante para levar ao médico — pode indicar necessidade de ajuste, não que toda medicação cause esse efeito.

Mito: "Se eu precisar de remédio, é porque sou fraco(a)"

O que de fato acontece: transtornos mentais têm bases biológicas, psicológicas e sociais — assim como hipertensão ou diabetes. Precisar de tratamento medicamentoso não é uma questão de força de vontade ou caráter, é uma resposta a um processo de saúde real, que merece cuidado como qualquer outro.

Mito: "Uma vez que eu melhorar, posso parar por conta própria"

O que de fato acontece: interromper medicação sem orientação médica é uma das causas mais comuns de recaída. Muitas medicações precisam de retirada gradual, planejada com o médico, justamente para evitar sintomas de reajuste e proteger a estabilidade conquistada. A decisão de reduzir ou parar deve ser sempre conversada e construída junto ao profissional que acompanha o caso.

Mito: "O efeito é imediato — se não melhorar logo, não funciona"

O que de fato acontece: muitas classes de medicação em saúde mental levam semanas para atingir o efeito pleno, e

alguns efeitos colaterais iniciais tendem a diminuir com o tempo. Desistir nas primeiras semanas, sem conversar com o médico sobre o que está sentindo, é uma das razões mais comuns de tratamentos malsucedidos.

Um princípio central: toda decisão sobre iniciar, ajustar ou interromper uma medicação psiquiátrica deve ser feita em conjunto com o médico responsável, considerando o histórico individual, outras condições de saúde e a resposta específica de cada pessoa ao tratamento. Não existe "receita padrão" que sirva igualmente para todos.

Os antidepressivos não causam dependência como as drogas de abuso, mas a suspensão brusca pode provocar sintomas de retirada, que são mais frequentes do que se pensava1.

Manter o antidepressivo pelo tempo indicado após a melhora reduz em cerca de 70% a chance de recaída2.

Uma grande meta-análise com 21 antidepressivos confirmou que todos foram mais eficazes que o placebo na depressão do adulto3, e o benefício tende a ser maior nos quadros mais graves4.

O que vale perguntar ao seu médico

• Como essa medicação pode ajudar no meu caso específico, e em quanto tempo posso esperar efeito?

• Quais efeitos colaterais são esperados, e quais merecem contato imediato com o consultório?

• Existe interação relevante com outras medicações ou substâncias que eu uso?

• Por quanto tempo, em geral, esse tipo de tratamento costuma ser necessário?

• O que fazer se eu esquecer uma dose, ou sentir vontade de parar?

O papel da medicação dentro de um cuidado mais amplo

Na maior parte dos casos, o tratamento medicamentoso funciona melhor combinado a outras formas de cuidado: psicoterapia, mudanças de hábito, suporte social e, quando aplicável, ajustes nas condições de vida e trabalho que contribuem para o sofrimento. A medicação é uma ferramenta importante — não a única, e não substituto de um cuidado integral.

Importante: este conteúdo tem finalidade educativa geral e não constitui orientação para iniciar, ajustar, substituir ou interromper qualquer medicação. Decisões sobre tratamento medicamentoso devem ser sempre feitas com acompanhamento médico individualizado.

Orientação geral: respeitam-se sempre os protocolos hospitalares, do Pronto Atendimento (PA) e da rede de saúde locais.

Referências

• Davies J, Read J. A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based?. Addict Behav. 2018;97:111-121. doi:10.1016/j.addbeh.2018.08.027

• Geddes JR, Carney SM, Davies C, et al. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. Lancet.

2003;361(9358):653-61. doi:10.1016/S0140-6736(03)12599-8

• Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366. doi:10.1016/S0140-6736(17)32802-7

• Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, et al. Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level meta-analysis. JAMA. 2010;303(1):47-53. doi:10.1001/jama.2009.1943

Este conteúdo tem finalidade educativa, baseado em diretrizes clínicas gerais de uso de psicofármacos e na experiência prática do autor. Não substitui consulta médica.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

79 · G4 · publicado em 2026-09-22

O idoso que escondia os comprimidos debaixo do travesseiro

Motivo: medicamento · ~4 min

A filha jurava que ele estava tomando tudo certinho. Foi só numa visita domiciliar de rotina que a agente comunitária encontrou, por acaso, uma pilha de comprimidos escondidos, intactos, havia semanas.

Chamemos esse homem de Seu Otávio. Setenta e cinco anos, diagnóstico recente de depressão, prescrição de antidepressivo iniciada havia um mês. A filha, que morava com ele, garantia que administrava a medicação diariamente, sem falhas.

Quando a agente comunitária encontrou os comprimidos escondidos, a situação exigiu uma conversa cuidadosa, sem acusação, tanto com Seu Otávio quanto com a filha. Ele, envergonhado, admitiu que vinha escondendo os comprimidos havia semanas — tinha medo de "virar dependente de remédio para a cabeça", e não queria desapontar a filha dizendo isso diretamente.

O medo silencioso que sabotava o tratamento

Seu Otávio carregava crenças antigas e profundamente arraigadas sobre medicação psiquiátrica, formadas décadas atrás, numa época em que o tratamento psiquiátrico era, de fato, muito diferente e mais estigmatizado. Ele nunca tinha verbalizado esse medo por vergonha, preferindo esconder fisicamente os comprimidos a admitir a resistência.

Conversamos longamente sobre suas dúvidas específicas, desmistificando crenças antigas com informação atualizada, e ele, aos poucos, aceitou retomar o tratamento — dessa vez com compreensão real do que estava tomando e por quê.

O que esse encontro me ensinou

Não adesão a tratamento nem sempre é comunicada abertamente — às vezes se manifesta em silêncio, através de comprimidos escondidos ou descartados. Visitas domiciliares e observação atenta da rotina real do paciente, além do que é relatado verbalmente, revelam informações essenciais que a consulta isolada nem sempre captura.

A adesão a remédios de uso contínuo depende muito das crenças da pessoa: quanto maiores as preocupações com o tratamento, menor a adesão.1 O estigma ligado à saúde mental afasta as pessoas do cuidado e pode levar a esconder a recusa.2 Em idosos, a depressão tem tratamento eficaz, com psicoterapia e antidepressivos escolhidos com atenção a interações e efeitos colaterais.3 E ela costuma ser subdiagnosticada, porque se manifesta de forma diferente nessa idade.4

Referências

• Horne R, Chapman SCE, Parham R, et al. Understanding patients' adherence-related beliefs about medicines prescribed for long-term conditions: a meta-analytic review of the Necessity-Concerns Framework. PLoS One. 2013;8(12):e80633. doi:10.1371/journal.pone.0080633

• Clement S, Schauman O, Graham T, et al. What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychol Med. 2014;45(1):11-27. doi:10.1017/S0033291714000129

• Kok RM, Reynolds CF. Management of Depression in Older Adults: A Review. JAMA. 2017;317(20):2114-2122. doi:10.1001/jama.2017.5706

• Alexopoulos GS. Depression in the elderly. Lancet. 2005;365(9475):1961-70. doi:10.1016/S0140-6736(05)66665-2

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

80 · G4 · publicado em 2026-09-22

A mãe que carregava a culpa pelo diagnóstico do filho

Motivo: medicamento · ~4 min

Ela chorava mais do que o próprio filho, na consulta em que confirmamos o diagnóstico. Repetia baixinho: 'eu devia ter percebido antes, eu falhei com ele'.

Chamemos essa mãe de Dona Iracema. O filho, Enzo, dezesseis anos, havia sido diagnosticado com transtorno depressivo há poucas semanas. Dona Iracema carregava uma culpa visível, quase física, como se cada sintoma do filho fosse prova de algum erro seu como mãe.

Perguntei o que a fazia pensar assim. Ela contou sobre o divórcio recente, sobre as horas extras que precisou fazer para sustentar a casa sozinha, sobre a sensação de ter "abandonado" o filho emocionalmente nesse período difícil.

Separando causa de coincidência temporal

Expliquei a Dona Iracema, com cuidado, que depressão tem múltiplas causas — biológicas, genéticas, ambientais — e que a coincidência temporal entre o divórcio e o início dos sintomas não significava, necessariamente, relação causal direta e exclusiva. A culpa que ela sentia, embora compreensível, não correspondia à complexidade real do que havia acontecido.

Trabalhamos juntos um plano de tratamento para Enzo, e também orientei Dona Iracema a considerar apoio psicológico para si mesma — a culpa que carregava

merecia cuidado próprio, não apenas ser posta de lado em nome do cuidado com o filho.

O que esse encontro me ensinou

Pais frequentemente assumem culpa integral por transtornos mentais dos filhos, mesmo quando a causa é multifatorial e não reduzível a nenhuma decisão específica. Aliviar essa culpa, com informação clara e cuidado, é parte importante do apoio à família como um todo.

Filhos de pais separados têm, em média, só um pouco mais de dificuldades, e as diferenças dependem muito do clima entre os adultos.1 O conflito entre os pais, mais do que a separação em si, se associa aos problemas emocionais dos filhos.2 Na depressão de adolescentes, a psicoterapia é a base, e quando há indicação de remédio a fluoxetina tem o melhor perfil de evidência.3 Vergonha e medo do estigma também afastam adolescentes da ajuda, e o apoio sem culpa da família faz diferença.4

Referências

• Amato PR. Children of divorce in the 1990s: an update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. J Fam Psychol. 2001;15(3):355-70. doi:10.1037//0893-3200.15.3.355

• van Eldik WM, de Haan AD, Parry LQ, et al. The interparental relationship: Meta-analytic associations with children's maladjustment and responses to interparental conflict. Psychol Bull. 2020;146(7):553-594. doi:10.1037/bul0000233

• Cipriani A, Zhou X, Del Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Lancet. 2016;388(10047):881-90. doi:10.1016/S0140-6736(16)30385-3

• Radez J, Reardon T, Creswell C, et al. Why do children and adolescents (not) seek and access professional help for their mental health problems? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021;30(2):183-211. doi:10.1007/s00787-019-01469-4

Narrativa composta, construída a partir de padrões observados na prática clínica. Nomes, idades e circunstâncias foram criados ou alterados, e nenhum personagem corresponde a uma pessoa real. Conteúdo educativo, elaborado em respeito ao sigilo profissional previsto no Código de Ética Médica. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

81 · G4 · publicado em 2026-09-22

Síndrome de abstinência alcoólica: reconhecimento e manejo inicial

Motivo: medicamento · ~4 min

A abstinência alcoólica pode ir de um tremor leve a convulsões e delirium tremens em poucas horas. Reconhecer cedo, medir a gravidade com uma escala e tratar com segurança muda o desfecho.

Pessoas com uso importante de álcool chegam à urgência por muitos motivos: trauma, infecção, dor abdominal, crise de ansiedade. A abstinência pode começar ali, durante a observação, sem que ninguém tenha perguntado sobre o último gole. Por isso, a primeira regra é perguntar ativamente sobre quantidade, frequência e horário da última dose em todo paciente com suspeita de uso nocivo.

Linha do tempo típica

• 6 a 24 horas após a última dose: tremor, ansiedade, insônia, sudorese, náuseas, taquicardia e hipertensão.

• 12 a 48 horas: risco de convulsões, geralmente tônico-clônicas generalizadas; alucinações com sensório preservado podem surgir.

• 48 a 96 horas: risco de delirium tremens, com confusão flutuante, alucinações e instabilidade autonômica importante.

Medir a gravidade

A escala CIWA-Ar, de dez itens, quantifica a gravidade e orienta a dose de medicação em tratamento guiado por

sintomas, desde que o paciente consiga se comunicar.1 A diretriz da Sociedade Americana de Medicina das Adições (ASAM, 2020) recomenda usar escalas validadas para decidir o local de tratamento, reavaliar com frequência e considerar o risco de complicações, e não só os sintomas do momento.2

Fatores de risco para evolução grave

• convulsões ou delirium tremens em abstinências anteriores;

• uso diário intenso e prolongado;

• doença clínica aguda associada (infecção, trauma, hepatopatia);

• sintomas importantes já com álcool no sangue;

• uso concomitante de benzodiazepínicos ou outros sedativos.

Conduta inicial

• Benzodiazepínicos são o tratamento de primeira linha para controlar sintomas e prevenir convulsões e delirium. Em hepatopatia grave e idosos, preferir agentes de meia-vida curta e sem metabólitos ativos, com doses menores e reavaliação próxima.2

• Tiamina parenteral antes de glicose em pacientes com uso nocivo e risco nutricional, para prevenir a encefalopatia de Wernicke, que muitas vezes passa despercebida quando o paciente está intoxicado.3

• Hidratação, correção de eletrólitos (potássio, magnésio, fósforo) e glicemia capilar.

• Investigar causas associadas: trauma craniano, infecção, hepatopatia descompensada, sangramento.

Ponto de atenção: antipsicóticos isolados não tratam a abstinência e reduzem o limiar convulsivo. Se forem necessários para agitação ou alucinações, devem ser usados apenas como adjuvantes, junto do benzodiazepínico.

Onde tratar

Abstinência leve, sem fatores de risco e com suporte em casa, pode ser manejada ambulatorialmente com retorno próximo. Convulsões, delirium, instabilidade clínica, CIWA-Ar elevado ou falta de suporte exigem observação hospitalar.

Depois da crise

A abstinência é uma janela de oportunidade. Antes da alta, ofereça intervenção breve, discuta tratamento do uso de álcool e articule a continuidade com a Unidade Básica de Saúde ou o CAPS AD.

A alta é uma oportunidade de cuidado: intervenções breves na Atenção Primária reduzem o consumo de álcool, e o seguimento no CAPS AD deve ser combinado antes da saída.4

Referências

• Sullivan JT, Sykora K, Schneiderman J, et al. Assessment of alcohol withdrawal: the revised clinical institute withdrawal assessment for alcohol scale (CIWA-Ar). Br J Addict. 1989;84(11):1353-1357. doi:10.1111/j.1360-0443.1989.tb00737.x

• American Society of Addiction Medicine. The ASAM Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management. J Addict Med. 2020;14(3S Suppl 1):1-72. doi:10.1097/ADM.0000000000000668

• Thomson AD, Cook CCH, Touquet R, et al. The Royal College of Physicians report on alcohol: guidelines for managing Wernicke's encephalopathy in the accident and Emergency Department. Alcohol Alcohol. 2002;37(6):513-521. doi:10.1093/alcalc/37.6.513

• Kaner EF, Beyer FR, Muirhead C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2018;2(2):CD004148. doi:10.1002/14651858.CD004148.pub4

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

82 · G4 · publicado em 2026-09-22

Transtorno de ansiedade generalizada: diagnóstico e manejo na APS

Motivo: medicamento · ~4 min

O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) chega à Atenção Primária, na maioria das vezes, como dor, cansaço, insônia ou desconforto gastrintestinal. Reconhecê-lo evita exames desnecessários e abre caminho para tratamentos que funcionam.

Como reconhecer

• preocupação excessiva e difícil de controlar, sobre vários temas, na maioria dos dias, por pelo menos seis meses;

• tensão muscular, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração e alterações de sono;

• sofrimento ou prejuízo no trabalho, nos estudos ou nas relações.

O GAD-7, com sete perguntas, é um instrumento breve e validado para rastreio e acompanhamento. Pontuações de 5, 10 e 15 indicam ansiedade leve, moderada e grave; 10 ou mais costuma ser o ponto de corte para investigação.1

Antes de fechar o diagnóstico

• afastar causas clínicas: hipertireoidismo, arritmias, efeito de medicamentos, cafeína em excesso;

• perguntar sobre álcool, sedativos e outras substâncias, inclusive retirada;

• rastrear depressão, frequentemente associada;

• avaliar risco de suicídio quando houver sintomas depressivos.

Tratamento na APS

• Psicoeducação: explicar o que é a ansiedade e o ciclo preocupação–sintoma–preocupação.

• Terapia cognitivo-comportamental tem eficácia moderada nos transtornos de ansiedade, em meta-análise de ensaios controlados com placebo.2 Grupos na própria unidade ampliam o acesso.

• Atividade física, sono e redução de cafeína e álcool como parte do plano.

• Medicação: uma meta-análise em rede encontrou várias opções eficazes; inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina são as escolhas mais usadas como primeira linha.3 O efeito costuma aparecer em 2 a 6 semanas; avise sobre a possível piora transitória da ansiedade no início.

Ponto de atenção: evite benzodiazepínicos como tratamento de manutenção. Se usados, que seja por curto período, com plano de retirada combinado desde o início.

Quando discutir com a equipe de saúde mental

Falha de dois tratamentos adequados, comorbidades importantes, uso problemático de substâncias ou risco de suicídio.

O cuidado colaborativo entre Atenção Primária e saúde mental melhora a depressão e a ansiedade.4

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, et al. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-7. doi:10.1001/archinte.166.10.1092

• Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al. Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depress Anxiety. 2018;35(6):502-514. doi:10.1002/da.22728

• Slee A, Nazareth I, Bondaronek P, et al. Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2019;393(10173):768-777. doi:10.1016/S0140-6736(18)31793-8

• Archer J, Bower P, Gilbody S, et al. Collaborative care for depression and anxiety problems. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10(10):CD006525. doi:10.1002/14651858.CD006525.pub2

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____

[ ] Não publicar

83 · G4 · publicado em 2026-09-22

Uso de benzodiazepínicos na urgência psiquiátrica

Motivo: medicamento · ~3 min

Benzodiazepínicos são ferramenta central no manejo agudo da agitação e ansiedade intensa no PA — mas seu uso exige critério, já que carregam risco de depressão respiratória, especialmente combinados a álcool ou opioides.

Indicações principais na urgência

• Agitação psicomotora aguda, isolada ou associada a outros sintomas

• Crises de ansiedade intensa, incluindo ataques de pânico

• Síndrome de abstinência alcoólica, onde têm papel central e específico

• Sedação pré-procedimento em contextos selecionados

Diretrizes brasileiras e o consenso norte-americano (projeto BETA) colocam os benzodiazepínicos entre as opções para a agitação, sempre depois da abordagem verbal1,2.

Cuidados essenciais

Avaliar uso concomitante de álcool ou outros depressores do SNC antes da administração. Monitorar função respiratória após uso, especialmente em idosos e pacientes com comorbidades pulmonares. Evitar uso

prolongado sem reavaliação — dependência e tolerância se desenvolvem rapidamente com uso continuado.

Uma revisão da Cochrane concluiu que a evidência para o uso de benzodiazepínicos isolados na agitação por psicose é de baixa qualidade, e que associá-los a outros medicamentos não trouxe vantagem clara; por isso a escolha deve ser individualizada e cuidadosa3.

Quando evitar

Quadros de intoxicação por depressores do SNC não identificada, insuficiência respiratória não compensada, e uso isolado em quadros psicóticos sem componente de agitação associado — onde antipsicóticos costumam ser mais indicados como primeira linha.

Ponto de atenção clínica: Documentar sempre dose, via e horário de administração, e reavaliar a resposta em intervalo curto antes de repetir a dose — evita tanto subtratamento quanto sedação excessiva.

Conteúdo educativo de apoio à prática clínica em urgência psiquiátrica. Não substitui protocolos institucionais ou bula do medicamento.

Na abstinência alcoólica, ao contrário, os benzodiazepínicos são o tratamento de escolha4.

Referências

• Baldaçara L, Diaz AP, Leite V, et al. Brazilian guidelines for the management of psychomotor agitation. Part 2. Pharmacological approach. Braz J Psychiatry. 2019;41(4):324-335. doi:10.1590/1516-4446-2018-0177

• Wilson MP, Pepper D, Currier GW, et al. The psychopharmacology of agitation: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA Psychopharmacology Workgroup. West J Emerg Med. 2012;13(1):26-34. doi:10.5811/westjem.2011.9.6866

• Zaman H, Sampson SJ, Beck AL, et al. Benzodiazepines for psychosis-induced aggression or agitation. Cochrane Database Syst Rev. 2017;12(12):CD003079. doi:10.1002/14651858.CD003079.pub4

• American Society of Addiction Medicine. The ASAM Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management. J Addict Med. 2020;14(3S Suppl 1):1-72. doi:10.1097/ADM.0000000000000668

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

84 · G4 · publicado em 2026-09-22

Transtorno bipolar: diferenciando de depressão unipolar

Motivo: medicamento · ~4 min

Muitas pessoas com transtorno bipolar passam anos tratadas como se tivessem depressão unipolar. Algumas perguntas simples, feitas antes da primeira prescrição de antidepressivo, ajudam a evitar esse atraso.

Por que o erro acontece

As pessoas procuram ajuda, sobretudo, durante a depressão. Os períodos de hipomania costumam ser vividos como fases boas, de energia e produtividade, e não são relatados se ninguém perguntar. Um seminário da revista The Lancet, escrito para médicos da Atenção Primária, ressalta que a depressão é a apresentação mais comum e que o rastreio de episódios de elevação do humor deve fazer parte da avaliação de toda depressão.1

Perguntas que ajudam

• "Já teve dias seguidos em que se sentiu com energia muito acima do normal, precisando dormir bem menos sem sentir cansaço?"

• "Nesses períodos, os pensamentos ficavam acelerados, você falava mais, fazia muitos planos?"

• "Fez coisas fora do seu jeito habitual: gastos, decisões impulsivas, brigas, comportamentos de risco?"

• "Alguém da família já comentou sobre essas mudanças? Alguém na família tem diagnóstico de transtorno bipolar?"

O Questionário de Transtornos do Humor (MDQ) pode apoiar o rastreio: no estudo original, sete ou mais respostas positivas tiveram sensibilidade de 73% e especificidade de 90%.2 Ele não substitui a entrevista clínica.

Sinais de alerta numa depressão

• início na adolescência ou no início da vida adulta;

• episódios depressivos recorrentes;

• história familiar de transtorno bipolar;

• sintomas psicóticos ou depressão pós-parto;

• ativação, irritabilidade ou "virada" com antidepressivos anteriores.

Ponto de atenção: antidepressivo isolado em pessoa com transtorno bipolar pode precipitar mania ou piorar o curso da doença. As diretrizes CANMAT e ISBD recomendam estabilizadores do humor ou antipsicóticos com evidência para depressão bipolar, e cautela com antidepressivos.3

O que fazer na APS

• diante de suspeita, discutir o caso no matriciamento antes de iniciar antidepressivo;

• avaliar sempre o risco de suicídio, que é elevado no transtorno bipolar;

• após estabilização, a APS tem papel central no acompanhamento: adesão, exames de monitorização, saúde física e prevenção de recaídas.

O guia mhGAP da OMS orienta a abordagem do transtorno bipolar e da depressão em serviços não especializados.4

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• McIntyre RS, Berk M, Brietzke E, et al. Bipolar disorders. Lancet. 2020;396(10265):1841-1856. doi:10.1016/S0140-6736(20)31544-0

• Hirschfeld RM, Williams JB, Spitzer RL, et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry. 2000;157(11):1873-5. doi:10.1176/appi.ajp.157.11.1873

• Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord. 2018;20(2):97-170. doi:10.1111/bdi.12609

• World Health Organization. mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings, version 2.0. Geneva: WHO; 2016. who.int

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

85 · G4 · publicado em 2026-09-22

Catatonia: um quadro frequentemente não reconhecido no PA

Motivo: medicamento · ~4 min

A catatonia é mais frequente do que se imagina e muitas vezes passa despercebida no pronto atendimento. Reconhecê-la importa porque costuma responder bem ao tratamento e porque algumas formas são emergências clínicas.

Como reconhecer

A escala de Bush-Francis oferece uma lista de sinais e um exame padronizado. Em seu estudo original, cerca de 7% dos pacientes internados numa unidade psiquiátrica preenchiam critérios para catatonia.1 Sinais frequentes:

• estupor e imobilidade;

• mutismo;

• olhar fixo;

• negativismo (resistência sem motivo aparente);

• postura mantida e flexibilidade cérea;

• ecolalia e ecopraxia;

• recusa alimentar;

• excitação sem propósito, em algumas apresentações.

Não é só esquizofrenia

A catatonia ocorre em transtornos do humor (especialmente na mania e na depressão grave), em transtornos psicóticos, no autismo e em diversas condições clínicas e neurológicas: encefalites (incluindo autoimunes), distúrbios metabólicos, epilepsia, efeitos de medicamentos e abstinência de benzodiazepínicos. A diretriz de consenso da Associação Britânica de Psicofarmacologia (2023) recomenda investigar causas clínicas em todos os casos.2

Conduta inicial

• Benzodiazepínico como teste e tratamento: o lorazepam é o mais estudado; a resposta costuma ser rápida. A ausência de resposta não exclui o diagnóstico.2

• Suporte clínico: hidratação, nutrição, prevenção de tromboembolismo, úlceras de pressão e aspiração.

• Eletroconvulsoterapia para casos que não respondem, graves ou com risco de vida.2

A síndrome neuroléptica maligna, que pode lembrar ou complicar a catatonia, tem critérios de consenso internacional para o diagnóstico.3

Ponto de atenção: antipsicóticos, especialmente de alta potência, podem piorar a catatonia e aumentar o risco de síndrome neuroléptica maligna. Em quadro catatônico com febre, instabilidade autonômica e rigidez (catatonia maligna), a situação é de emergência clínica.2,4

Na prática do PA

Diante de um paciente "parado", mudo ou que "não colabora", pergunte-se: pode ser catatonia? Aplique a lista

de sinais, investigue causas clínicas e discuta o caso cedo com a equipe de referência.

Referências

• Bush G, Fink M, Petrides G, et al. Catatonia. I. Rating scale and standardized examination. Acta Psychiatr Scand. 1996;93(2):129-136. doi:10.1111/j.1600-0447.1996.tb09814.x

• Rogers JP, Oldham MA, Fricchione G, et al. Evidence-based consensus guidelines for the management of catatonia: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2023;37(4):327-369. doi:10.1177/02698811231158232

• Gurrera RJ, Caroff SN, Cohen A, et al. An international consensus study of neuroleptic malignant syndrome diagnostic criteria using the Delphi method. J Clin Psychiatry. 2011;72(9):1222-8. doi:10.4088/JCP.10m06438

• Strawn JR, Keck PE, Caroff SN. Neuroleptic malignant syndrome. Am J Psychiatry. 2007;164(6):870-876. doi:10.1176/ajp.2007.164.6.870

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

86 · G4 · publicado em 2026-09-22

Comprometimento cognitivo leve: quando encaminhar

Motivo: medicamento · ~4 min

Comprometimento cognitivo leve não é sinônimo de demência. É uma zona intermediária entre o envelhecimento normal e a demência, que pede investigação, acompanhamento e ações de prevenção, e não alarme.

Como caracterizar

• queixa cognitiva, de preferência confirmada por alguém próximo;

• testes breves como a MoCA, mais sensível que o Mini-Exame para esses casos;1

• desempenho abaixo do esperado para idade e escolaridade em testes;

• independência preservada nas atividades do dia a dia, o que o diferencia da demência.

A diretriz da Academia Americana de Neurologia orienta a avaliação e o seguimento do comprometimento cognitivo leve.2

Nem todo caso progride

Uma revisão sistemática com meta-análise mostrou que a reversão para cognição normal é um desfecho comum no comprometimento cognitivo leve, o que reforça a

importância de reavaliar ao longo do tempo antes de rotular.3 Causas tratáveis contribuem para isso.

Investigação na APS

• medicamentos com efeito cognitivo (benzodiazepínicos, anticolinérgicos, opioides);

• depressão e ansiedade;

• sono: insônia e apneia;

• exames: hemograma, função tireoidiana, vitamina B12, glicemia, função renal e hepática, e outros conforme o caso;

• audição e visão;

• uso de álcool.

O que recomendar

A comissão da revista The Lancet sobre demência (2024) identificou 14 fatores de risco modificáveis, entre eles hipertensão, diabetes, colesterol LDL elevado, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, perda auditiva e visual não tratadas, depressão e isolamento social.4 Na prática:

• atividade física regular;

• controle dos fatores de risco cardiovasculares;

• tratamento da perda auditiva e visual;

• atividades cognitivas e sociais;

• sono adequado;

• revisão de medicamentos.

Quando encaminhar

Progressão nas reavaliações, impacto funcional, dúvida diagnóstica, início precoce (antes dos 65 anos) ou sinais neurológicos atípicos justificam avaliação neuropsicológica completa e com neurologia ou geriatria.

Comunicação: explique o diagnóstico com honestidade e esperança, discuta prognóstico e planejamento, e evite promessas de suplementos ou tratamentos sem evidência.

Referências

• Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005;53(4):695-9. doi:10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x

• Petersen RC, Lopez O, Armstrong MJ, et al. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment [RETIRED]: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2017;90(3):126-135. doi:10.1212/WNL.0000000000004826

• Canevelli M, Grande G, Lacorte E, et al. Spontaneous Reversion of Mild Cognitive Impairment to Normal Cognition: A Systematic Review of Literature and Meta-Analysis. J Am Med Dir Assoc. 2016;17(10):943-8. doi:10.1016/j.jamda.2016.06.020

• Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024;404(10452):572-628. doi:10.1016/S0140-6736(24)01296-0

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

87 · G4 · publicado em 2026-09-22

Delirium, demência e depressão: diagnóstico diferencial na prática

Motivo: medicamento · ~4 min

Delirium, demência e depressão podem se parecer, especialmente em pessoas idosas, mas exigem condutas muito diferentes. Errar a diferenciação tem consequências sérias, e os três podem coexistir.

O que mais ajuda a diferenciar: início, curso e atenção

• Delirium: início agudo (horas a dias), curso flutuante, prejuízo marcante da atenção e alteração do nível de consciência. É uma emergência clínica com causa a ser buscada.1

• Demência: início insidioso, progressão ao longo de meses ou anos, atenção relativamente preservada nas fases iniciais.

• Depressão com queixas cognitivas: início mais delimitado, frequentemente com humor deprimido, perda de interesse e queixas cognitivas desproporcionais ao desempenho nos testes.

Rastrear delirium

O delirium é frequente em idosos hospitalizados e no pronto atendimento, e muitas vezes não é reconhecido, sobretudo na forma hipoativa, em que o paciente fica quieto e sonolento.1 O 4AT é um teste breve, que leva cerca de dois minutos e não exige treinamento especial. Uma meta-análise encontrou sensibilidade de 86% e especificidade de 89% para detectar delirium em idosos.2

Diante de piora cognitiva aguda

Investigue ativamente:

• infecções (urinária, respiratória, de pele);

• medicamentos novos ou ajustes recentes, sobretudo anticolinérgicos, sedativos e opioides;

• desidratação, distúrbios eletrolíticos, hipoglicemia;

• retenção urinária, constipação intestinal, dor não tratada;

• hipóxia, eventos cardiovasculares e neurológicos.

Demência: não é destino inevitável do envelhecimento

A comissão da revista The Lancet sobre demência (2024) estimou que cerca de 45% dos casos poderiam ser prevenidos ou adiados atuando sobre 14 fatores de risco modificáveis ao longo da vida, como baixa escolaridade, perda auditiva, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, depressão, isolamento social, perda visual não tratada e LDL elevado.3 Em quem já tem demência, o delirium acelera o declínio, e a prevenção do delirium protege a cognição.

Depressão em idosos

A depressão pode se apresentar com lentificação, queixas de memória e desinteresse, e também pode ser um sinal precoce de demência. Tratar a depressão e reavaliar a cognição depois é uma conduta prudente antes de fechar um diagnóstico de demência.

Psicoterapia e antidepressivos são eficazes na depressão do idoso, com atenção às interações e efeitos

colaterais.4

Ponto de atenção: os três quadros podem coexistir. Um idoso com demência pode desenvolver delirium por infecção e ter depressão ao mesmo tempo. Ouça a família: ela é quem melhor descreve a mudança em relação ao "normal" da pessoa.

Referências

• Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet. 2013;383(9920):911-22. doi:10.1016/S0140-6736(13)60688-1

• Tieges Z, Maclullich AMJ, Anand A, et al. Diagnostic accuracy of the 4AT for delirium detection in older adults: systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2021;50(3):733-743. doi:10.1093/ageing/afaa224

• Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024;404(10452):572-628. doi:10.1016/S0140-6736(24)01296-0

• Kok RM, Reynolds CF. Management of Depression in Older Adults: A Review. JAMA. 2017;317(20):2114-2122. doi:10.1001/jama.2017.5706

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____

[ ] Não publicar

88 · G4 · publicado em 2026-09-22

Delirium tremens: reconhecimento e conduta de urgência

Motivo: medicamento · ~4 min

O delirium tremens é a forma mais grave da abstinência alcoólica. Quando reconhecido tarde, a mortalidade é real. Quando reconhecido cedo e tratado em ambiente adequado, a maioria dos pacientes se recupera.

Quando suspeitar

O quadro costuma surgir entre 48 e 96 horas após a última dose, em pessoas com uso intenso e prolongado. Muitas vezes aparece em pacientes internados por outra causa, como trauma, cirurgia ou infecção, quando a abstinência não foi prevista.1

Quadro clínico

• Delirium: início agudo, desatenção, desorientação e flutuação ao longo do dia.

• Alucinações vívidas, sobretudo visuais e táteis.

• Agitação psicomotora intensa.

• Hiperatividade autonômica: taquicardia, hipertensão, febre, sudorese profusa, tremor.

Fatores de risco

• delirium tremens ou convulsões em abstinências anteriores;

• doença clínica aguda concomitante;

• sintomas de abstinência intensos já no início;

• idade mais avançada, hepatopatia, distúrbios eletrolíticos.

Diagnóstico diferencial que não pode faltar

Delirium em pessoa que usa álcool não é sempre delirium tremens. Antes de fechar o diagnóstico, considere hipoglicemia, encefalopatia de Wernicke, encefalopatia hepática, trauma craniano com hematoma, infecção do sistema nervoso central, sepse e intoxicação por outras substâncias.1,2

Em idosos e pessoas com doença clínica, outras causas de delirium devem ser investigadas em paralelo, porque frequentemente coexistem.3

Conduta

• Ambiente hospitalar com monitorização contínua; casos graves podem precisar de terapia intensiva.

• Benzodiazepínicos em doses suficientes, ajustadas à resposta, com reavaliações frequentes. O objetivo é um paciente calmo e despertável.1,2

• Tiamina parenteral antes da glicose e em doses adequadas ao risco de Wernicke.4

• Hidratação, correção de potássio, magnésio e fósforo, controle térmico.

• Tratamento das condições clínicas associadas.

• Em casos refratários, a conduta deve ser discutida com a equipe de terapia intensiva, conforme protocolo

institucional.

Ponto de atenção: o diagnóstico é clínico. Não espere exames completos para iniciar o tratamento quando o quadro é sugestivo; investigue em paralelo.

Prevenção

A melhor forma de tratar o delirium tremens é preveni-lo: perguntar sobre álcool em toda admissão, aplicar escalas de abstinência, iniciar o tratamento cedo em quem tem fatores de risco e reavaliar com frequência.2

Referências

• Schuckit MA. Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). N Engl J Med. 2014;371(22):2109-13. doi:10.1056/NEJMra1407298

• American Society of Addiction Medicine. The ASAM Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management. J Addict Med. 2020;14(3S Suppl 1):1-72. doi:10.1097/ADM.0000000000000668

• Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet. 2013;383(9920):911-22. doi:10.1016/S0140-6736(13)60688-1

• Thomson AD, Cook CCH, Touquet R, et al. The Royal College of Physicians report on alcohol: guidelines for managing Wernicke's encephalopathy in the accident and Emergency Department. Alcohol Alcohol. 2002;37(6):513-521. doi:10.1093/alcalc/37.6.513

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação

individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

89 · G4 · publicado em 2026-09-22

Insônia na consulta de rotina: além da prescrição automática

Motivo: medicamento · ~4 min

A insônia é uma das queixas mais frequentes na Atenção Primária, e uma das que mais terminam em prescrição automática. As diretrizes atuais apontam outro caminho como primeira escolha.

Investigar antes de prescrever

• Padrão: dificuldade para iniciar o sono, despertares, despertar precoce.

• Duração: insônia crônica ocorre três ou mais noites por semana, por três meses ou mais, com prejuízo diurno.

• Causas e fatores associados: depressão, ansiedade, dor, noctúria, refluxo, apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, medicamentos, cafeína, álcool e trabalho em turnos.

• Hábitos: horários irregulares, telas e trabalho na cama, cochilos longos.

Primeira linha: terapia cognitivo-comportamental para insônia

As diretrizes europeia e do Colégio Americano de Médicos recomendam a terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) como tratamento inicial da insônia crônica em adultos.1,2 Seus componentes cabem, em versão simplificada, na consulta e em grupos da APS:

• controle de estímulos: cama só para dormir; sair da cama se não dormir em cerca de 20 minutos;

• restrição do tempo na cama ao tempo real de sono, ampliando aos poucos;

• horário fixo para acordar, inclusive nos fins de semana;

• reestruturação de pensamentos catastróficos sobre o sono;

• técnicas de relaxamento;

• higiene do sono, que isoladamente tem efeito limitado, mas complementa.

Medicação: com critério

A diretriz europeia considera que alguns hipnóticos podem ser usados por curto prazo, até cerca de quatro semanas, e não recomenda anti-histamínicos, antipsicóticos, melatonina e fitoterápicos para insônia.1 O Colégio Americano de Médicos recomenda decisão compartilhada, discutindo benefícios, riscos e custos.2

Idosos: uma meta-análise mostrou que, em pessoas acima de 60 anos, os benefícios dos hipnóticos são pequenos e o risco de eventos adversos, como quedas e prejuízo cognitivo, é significativo, podendo não justificar o uso.3 Revise periodicamente prescrições antigas e planeje a retirada gradual.

Quando investigar mais

Ronco alto com pausas respiratórias, sonolência diurna excessiva, movimentos anormais durante o sono ou

insônia refratária justificam investigação de distúrbios específicos do sono.

O álcool usado para dormir fragmenta a segunda metade da noite e piora a insônia.4

Referências

• Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6):675-700. doi:10.1111/jsr.12594

• Qaseem A, Kansagara D, Forciea MA, et al. Management of Chronic Insomnia Disorder in Adults: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2016;165(2):125-33. doi:10.7326/M15-2175

• Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005;331(7526):1169. doi:10.1136/bmj.38623.768588.47

• Ebrahim IO, Shapiro CM, Williams AJ, Fenwick PB. Alcohol and sleep I: effects on normal sleep. Alcohol Clin Exp Res. 2013;37(4):539-49. doi:10.1111/acer.12006

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

90 · G4 · publicado em 2026-09-22

Intoxicação por psicofármacos: conduta inicial no PA

Motivo: medicamento · ~4 min

A intoxicação intencional por medicamentos exige dois cuidados ao mesmo tempo: estabilizar o corpo e cuidar da saúde mental. Separar as duas frentes, ou deixar a segunda para depois, aumenta o risco de uma nova tentativa.

Por que levar a sério cada atendimento

Uma revisão sistemática com meta-análise de pessoas atendidas em hospitais após autolesão encontrou que cerca de 1 em cada 6 repete o comportamento no ano seguinte e que o risco de morte por suicídio permanece aumentado por anos.1 Cada atendimento é uma oportunidade de prevenção.

Prioridades clínicas

• via aérea, respiração, circulação e nível de consciência;

• identificar substâncias, quantidade estimada e horário, com ajuda de acompanhantes e embalagens;

• considerar sempre ingestão de mais de uma substância, inclusive paracetamol e álcool;

• eletrocardiograma e exames conforme o caso;

• contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) da região para orientação específica;

• internação em unidade de maior complexidade quando indicado.

Avaliação de saúde mental: desde cedo

Assim que o paciente estiver em condições de conversar, a avaliação deve começar, sem esperar a "alta clínica". Inclui:

• intenção, planejamento e expectativa de morte;

• desencadeantes, sofrimento atual e problemas de vida;

• transtornos mentais e uso de substâncias;

• tentativas anteriores;

• fatores de proteção e rede de apoio;

• acesso a meios em casa.

Perguntar diretamente sobre a intenção e sobre pensamentos de morte não aumenta o risco e é parte essencial da avaliação.2

Linguagem e atitude da equipe

Comentários como "foi só para chamar atenção" ou "tomou pouco" são ouvidos e lembrados. Eles aumentam a vergonha e afastam a pessoa de pedir ajuda no futuro. Toda tentativa merece acolhimento e avaliação cuidadosa.

Antes da alta

• Plano de segurança construído com o paciente, incluindo redução do acesso a medicamentos em casa. Em serviços de emergência, o plano de segurança com

seguimento telefônico reduziu o comportamento suicida nos meses seguintes.3

• Prescrições em quantidades limitadas.

• Encaminhamento com data marcada para CAPS, UBS ou ambulatório, idealmente em até sete dias.

• Família ou pessoa de referência orientada, com consentimento.

Os dias e semanas após a alta são o período de maior risco: a taxa de suicídio é muito elevada logo depois de internações psiquiátricas, o que reforça a necessidade de seguimento precoce.4

Notificação: a violência autoprovocada, incluindo tentativa de suicídio, é de notificação compulsória no Brasil e deve ser registrada no SINAN, com notificação imediata (em até 24 horas) à vigilância municipal.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Carroll R, Metcalfe C, Gunnell D. Hospital presenting self-harm and risk of fatal and non-fatal repetition: systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014;9(2):e89944. doi:10.1371/journal.pone.0089944

• Dazzi T, Gribble R, Wessely S, et al. Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation?

What is the evidence?. Psychol Med. 2014;44(16):3361-3. doi:10.1017/S0033291714001299

• Stanley B, Brown GK, Brenner LA, et al. Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency Department. JAMA Psychiatry. 2018;75(9):894-900. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.1776

• Chung DT, Ryan CJ, Hadzi-Pavlovic D, et al. Suicide Rates After Discharge From Psychiatric Facilities: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2017;74(7):694-702. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.1044

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

Reconciliação medicamentosa em pacientes psiquiátricos idosos

Motivo: medicamento · ~4 min

Idosos em acompanhamento de saúde mental costumam acumular prescrições de vários profissionais ao longo dos anos. Revisar tudo o que está em uso, com olhar crítico, previne quedas, confusão, interações e internações.

Por que é crítico

• mudanças no metabolismo e na eliminação dos fármacos com a idade;

• mais doenças e mais medicamentos ao mesmo tempo;

• maior sensibilidade a efeitos sedativos e anticolinérgicos;

• prescrições mantidas "por inércia", sem reavaliação.

Passos da reconciliação

• "Saco de remédios": peça que tragam todos os medicamentos, inclusive os de farmácia popular, fitoterápicos, vitaminas e os usados "de vez em quando".

• Confirme indicação, dose e duração de cada um.

• Procure interações e duplicidades (por exemplo, dois sedativos ou dois anticolinérgicos).

• Use os Critérios de Beers (atualização 2023) para identificar medicamentos potencialmente inapropriados em idosos, como benzodiazepínicos, hipnóticos "Z",

anticolinérgicos fortes e alguns antipsicóticos em pessoas com demência.1

• Planeje a desprescrição gradual, um medicamento por vez, com monitorização.

• Registre e comunique a lista atualizada para o paciente, a família e os outros serviços.

Benzodiazepínicos e hipnóticos

Em pessoas acima de 60 anos, os hipnóticos têm benefício pequeno e aumentam o risco de quedas e de prejuízo cognitivo.2 Num ensaio clínico, uma simples cartilha educativa entregue diretamente aos idosos levou cerca de um quarto deles a interromper o benzodiazepínico em seis meses, em decisão compartilhada com o médico.3

Na retirada: reduza gradualmente, ao longo de semanas ou meses, explique os sintomas de retirada esperados e ofereça alternativas não farmacológicas para o sono e a ansiedade. Nunca suspenda de forma abrupta após uso prolongado.

Também merece atenção

• antidepressivos e risco de hiponatremia e sangramentos;

• antipsicóticos em pessoas com demência: riscos aumentados de AVC e mortalidade, uso apenas quando indispensável e pelo menor tempo;

• lítio: função renal, tireoide e interações com diuréticos, anti-inflamatórios e inibidores da ECA.

O uso prolongado de medicamentos com efeito anticolinérgico se associou a maior risco de demência.4

Referências

• 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372

• Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005;331(7526):1169. doi:10.1136/bmj.38623.768588.47

• Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, et al. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014;174(6):890-8. doi:10.1001/jamainternmed.2014.949

• Coupland CAC, Hill T, Dening T, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1084-1093. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0677

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Síndrome neuroléptica maligna: reconhecimento precoce

Motivo: medicamento · ~4 min

A síndrome neuroléptica maligna é rara, mas potencialmente fatal. Reconhecê-la cedo, sobretudo após início ou aumento de antipsicótico, permite suspender o fármaco e iniciar suporte antes das complicações.

Quadro clínico

Um consenso internacional de especialistas propôs critérios diagnósticos com pesos diferentes para cada elemento.1 Os principais:

• exposição a antagonista dopaminérgico (ou retirada de agonista dopaminérgico) nas 72 horas anteriores;

• hipertermia, em geral acima de 38 °C em mais de uma medida;

• rigidez muscular generalizada, em "cano de chumbo";

• alteração do estado mental, de confusão a coma;

• elevação de creatinoquinase (CK), frequentemente importante;

• instabilidade autonômica: taquicardia, pressão lábil, sudorese, incontinência;

• ausência de outra causa infecciosa, tóxica, metabólica ou neurológica que explique o quadro.

Fatores de risco

• início recente ou aumento rápido de dose;

• antipsicóticos de alta potência e formulações injetáveis;

• desidratação, agitação intensa, contenção prolongada;

• episódio anterior de síndrome neuroléptica maligna;

• catatonia prévia.2

Conduta

• Suspender imediatamente o antipsicótico e outros fármacos que possam contribuir.

• Suporte clínico intensivo: hidratação, resfriamento, monitorização cardiorrespiratória, prevenção de tromboembolismo e aspiração.

• Acompanhar CK, função renal (risco de rabdomiólise e insuficiência renal), eletrólitos e coagulação.

• Em casos moderados a graves, benzodiazepínicos, agonistas dopaminérgicos e dantroleno podem ser considerados, conforme protocolo e equipe de terapia intensiva; eletroconvulsoterapia em casos refratários.2

Diagnósticos diferenciais

• Síndrome serotoninérgica: início mais rápido, clônus, hiper-reflexia, diarreia, após medicamentos serotoninérgicos.

• Catatonia maligna: quadro sobreposto; a distinção pode ser difícil.3

• Hipertermia maligna, intoxicação anticolinérgica, infecção do sistema nervoso central, insolação.

O delirium por outras causas clínicas também entra no diagnóstico diferencial e deve ser rastreado ativamente.4

Depois do episódio: reintroduzir antipsicótico só após a resolução completa, aguardando um intervalo de pelo menos duas semanas, com fármaco de menor potência, dose baixa, titulação lenta e monitorização próxima.2 Registre o evento de forma clara no prontuário e na carta de alta.

Referências

• Gurrera RJ, Caroff SN, Cohen A, et al. An international consensus study of neuroleptic malignant syndrome diagnostic criteria using the Delphi method. J Clin Psychiatry. 2011;72(9):1222-8. doi:10.4088/JCP.10m06438

• Strawn JR, Keck PE, Caroff SN. Neuroleptic malignant syndrome. Am J Psychiatry. 2007;164(6):870-876. doi:10.1176/ajp.2007.164.6.870

• Rogers JP, Oldham MA, Fricchione G, et al. Evidence-based consensus guidelines for the management of catatonia: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2023;37(4):327-369. doi:10.1177/02698811231158232

• Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet. 2013;383(9920):911-22. doi:10.1016/S0140-6736(13)60688-1

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

93 · G4 · publicado em 2026-09-22

Estresse pós-traumático na Atenção Primária: rastreio com o PC-PTSD-5, tratamento e rede de proteção

Motivo: medicamento · ~4 min

O estresse pós-traumático raramente chega à consulta com esse nome. Chega como insônia, irritabilidade, dores, uso de álcool ou evitação que a pessoa não sabe explicar.

Quem tem mais risco

Nos inquéritos mundiais da OMS, cerca de 70% das pessoas relataram ao menos um evento traumático na vida. Estupro, outras agressões sexuais, perseguição e violência sexual por parceiro íntimo estiveram entre os eventos com maior peso no estresse pós-traumático.1 No Brasil, a violência urbana e a doméstica tornam o trauma um tema cotidiano na Atenção Primária.

Sinais

• revivência: lembranças intrusivas, pesadelos, flashbacks;

• evitação de lugares, pessoas e conversas ligadas ao evento;

• alterações de pensamento e humor: culpa, vergonha, distanciamento;

• hiperativação: sobressalto, hipervigilância, irritabilidade, insônia.

Rastreio breve

O PC-PTSD-5, com uma pergunta de entrada sobre exposição a evento traumático e cinco perguntas de sim ou não, foi desenvolvido para a Atenção Primária e bem aceito pelos pacientes. Três ou mais respostas positivas indicam necessidade de avaliação mais detalhada.2

Como perguntar sem retraumatizar: "Você já passou por algo muito assustador, violento ou que ameaçou sua vida ou a de alguém próximo? Isso ainda afeta você hoje?" Não é preciso pedir detalhes do evento na consulta de rastreio.

Tratamento

• psicoterapias focadas no trauma (terapia de processamento cognitivo, terapia cognitiva, exposição prolongada e EMDR) são a primeira linha, segundo revisão sistemática com metanálise;3

• medicação: alguns antidepressivos têm efeito positivo pequeno, com evidência para fluoxetina, paroxetina e venlafaxina; podem ser considerados quando a psicoterapia não está disponível ou como complemento;4

• evite benzodiazepínicos como tratamento do estresse pós-traumático, como orientam as diretrizes.5

Na APS

• acolher, nomear e explicar que as reações são compreensíveis;

• avaliar segurança atual: a violência ainda está acontecendo?

• avaliar risco de suicídio, uso de álcool e drogas e depressão;

• acionar a rede de proteção quando houver violência: notificação, CRAS, CREAS, Ligue 180, Disque 100;

• encaminhar para psicoterapia focada no trauma, com apoio matricial.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. Eur J Psychotraumatol. 2017;8(sup5):1353383. doi:10.1080/20008198.2017.1353383

• Prins A, Bovin MJ, Smolenski DJ, et al. The Primary Care PTSD Screen for DSM-5 (PC-PTSD-5): Development and Evaluation Within a Veteran Primary Care Sample. J Gen Intern Med. 2016;31(10):1206-11. doi:10.1007/s11606-016-3703-5

• Lewis C, Roberts NP, Andrew M, et al. Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. Eur J Psychotraumatol. 2020;11(1):1729633. doi:10.1080/20008198.2020.1729633

• Hoskins M, Pearce J, Bethell A, et al. Pharmacotherapy for post-traumatic stress disorder: systematic review and

meta-analysis. Br J Psychiatry. 2015;206(2):93-100. doi:10.1192/bjp.bp.114.148551

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Post-traumatic stress disorder (NG116). Londres: NICE; 2018. www.nice.org.uk

Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

94 · G4 · publicado em 2026-09-22

TOC: sinais que merecem atenção na consulta de rotina

Motivo: medicamento · ~4 min

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) costuma ser vivido com vergonha e escondido por anos. Algumas perguntas na consulta de rotina podem abrir a porta para um tratamento que funciona.

O que é

• Obsessões: pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos e indesejados, que causam ansiedade ou angústia.

• Compulsões: comportamentos repetitivos ou atos mentais feitos para aliviar essa angústia ou "evitar que algo ruim aconteça".

Uma revisão abrangente na revista Nature Reviews Disease Primers descreve o TOC como um transtorno comum, frequentemente de início na infância ou na adolescência, com atraso importante até o diagnóstico.1

Muito além da "mania de limpeza"

• contaminação e limpeza;

• verificação (portas, gás, fogão, documentos);

• simetria, ordem e "sensação de incompletude";

• pensamentos intrusivos de conteúdo agressivo, sexual ou religioso, que causam horror justamente por contrariarem os valores da pessoa;

• rituais mentais, como contar ou rezar repetidamente.

Como perguntar

• "Você tem pensamentos que voltam o tempo todo, mesmo sabendo que não fazem sentido, e que são difíceis de tirar da cabeça?"

• "Você sente que precisa fazer algo repetidamente para aliviar esses pensamentos?"

• "Quanto tempo isso ocupa por dia? Atrapalha sua vida?"

Ponto de atenção: pensamentos intrusivos de conteúdo violento ou sexual no TOC são egodistônicos, ou seja, causam angústia porque a pessoa não quer agir. Explicar isso reduz a vergonha. Ao mesmo tempo, avalie se há risco real ou outro diagnóstico quando o conteúdo não gera angústia.

Tratamento

As opções com melhor evidência são a terapia cognitivo-comportamental com exposição e prevenção de resposta e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, em geral em doses mais altas e por mais tempo do que na depressão.1 Uma meta-análise em rede sugere que a combinação de psicoterapia e medicação tende a ser mais eficaz do que a psicoterapia isolada em casos mais graves.2 Outra meta-análise mostrou que associar psicoterapia à medicação é mais eficaz do que a medicação isolada no TOC, com efeito mantido por até dois anos.3

Papel da APS

• reconhecer, nomear e acolher;

• iniciar tratamento farmacológico, quando indicado, com apoio matricial;

• encaminhar para psicoterapia com exposição e prevenção de resposta;

• rastrear depressão e risco de suicídio, frequentemente associados.

O cuidado colaborativo entre Atenção Primária e saúde mental melhora os desfechos de transtornos de ansiedade e depressão.4

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Stein DJ, Costa DLC, Lochner C, et al. Obsessive-compulsive disorder. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):52. doi:10.1038/s41572-019-0102-3

• Skapinakis P, Caldwell DM, Hollingworth W, et al. Pharmacological and psychotherapeutic interventions for management of obsessive-compulsive disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2016;3(8):730-739. doi:10.1016/S2215-0366(16)30069-4

• Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole SL, et al. Adding psychotherapy to antidepressant medication in depression

and anxiety disorders: a meta-analysis. World Psychiatry. 2014;13(1):56-67. doi:10.1002/wps.20089

• Archer J, Bower P, Gilbody S, et al. Collaborative care for depression and anxiety problems. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10(10):CD006525. doi:10.1002/14651858.CD006525.pub2

Conteúdo educativo para profissionais de saúde. Não substitui protocolos institucionais, bulas e avaliação individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

95 · G4 · publicado em 2026-09-22

Saúde mental em startups: a pressão do crescimento acelerado

Motivo: medicamento · ~4 min

Crescimento acelerado, rodadas de investimento, prazos curtos, papéis pouco definidos e a ideia de que todos devem "vestir a camisa" sem limite. Startups podem ser ambientes estimulantes e também muito adoecedores, para fundadores e equipes.

Riscos comuns

• jornadas longas e disponibilidade permanente;

• insegurança financeira e risco de demissões em massa;

• mudanças constantes de prioridade;

• papéis acumulados e pouco claros;

• lideranças jovens, sem preparo em gestão de pessoas;

• cultura de celebração do excesso de trabalho.

Uma meta-análise mostrou associação entre jornadas longas e o surgimento de sintomas depressivos.1 A insegurança no emprego também pode trazer riscos à saúde comparáveis aos do desemprego.2

Alta exigência, pouco controle e desequilíbrio entre esforço e recompensa estão entre os fatores do trabalho mais associados a depressão e ansiedade.3

Fundadores também adoecem

Fundadores carregam a responsabilidade pelo negócio, pelos investidores e pelos empregos. A solidão nas decisões, o medo do fracasso e a falta de limites favorecem ansiedade, depressão e esgotamento. Mentoria, pares e apoio profissional são parte da estratégia de sobrevivência da empresa.

Práticas que cabem no orçamento

• combinar horários de disponibilidade e respeitar a desconexão;

• definir papéis e prioridades com clareza, revistos com frequência;

• capacitar as primeiras lideranças em gestão de pessoas;

• comunicação transparente sobre a situação da empresa, inclusive em momentos difíceis;

• processos de desligamento respeitosos;

• benefício de saúde com cobertura para saúde mental, mesmo que básico;

• incluir riscos psicossociais no PGR desde o início.

Revisões mostram que mudanças simples na organização do trabalho tendem a ter efeitos mais duradouros do que ações isoladas de bem-estar.4

Cultura se forma cedo: os hábitos criados com dez pessoas tendem a se repetir com cem. Construir uma cultura saudável desde o início custa menos do que consertá-la depois.

Referências

• Virtanen M, Jokela M, Madsen IE, et al. Long working hours and depressive symptoms: systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data. Scand J Work Environ Health. 2018;44(3):239-250. doi:10.5271/sjweh.3712

• Kim TJ, von dem Knesebeck O. Is an insecure job better for health than having no job at all? A systematic review of studies investigating the health-related risks of both job insecurity and unemployment. BMC Public Health. 2015;15:985. doi:10.1186/s12889-015-2313-1

• Harvey SB, Modini M, Joyce S, et al. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occup Environ Med. 2017;74(4):301-310. doi:10.1136/oemed-2016-104015

• Aust B, Leduc C, Cresswell-Smith J, et al. The effects of different types of organisational workplace mental health interventions on mental health and wellbeing in healthcare workers: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health. 2024;97(5):485-522. doi:10.1007/s00420-024-02065-z

Conteúdo educativo para gestores e RH. Não substitui avaliação médica, jurídica ou de segurança do trabalho. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

96 · G4 · publicado em 2026-09-22

Ansiedade: quando deixa de ser nervosismo comum

Motivo: medicamento · ~4 min

Sentir ansiedade antes de uma prova, de uma entrevista ou de uma conversa difícil é normal e até útil: o corpo se prepara para agir. O problema começa quando a preocupação aparece sem motivo claro, dura semanas e passa a comandar o dia a dia.

Nervosismo comum ou transtorno de ansiedade?

• Nervosismo comum: tem um motivo identificável, é proporcional à situação e passa quando ela termina.

• Transtorno de ansiedade: a preocupação é excessiva, difícil de controlar, está presente na maioria dos dias e atrapalha o trabalho, o sono, os estudos ou as relações.

Os transtornos de ansiedade estão entre os problemas de saúde mental mais comuns ao longo da vida e costumam começar ainda na infância ou na adolescência.1

Sinais que merecem atenção

• preocupação constante com várias coisas ao mesmo tempo;

• inquietação, sensação de estar "no limite";

• cansaço fácil, dificuldade de concentração, "mente em branco";

• irritabilidade e tensão muscular (pescoço, ombros, mandíbula);

• sono difícil ou que não descansa;

• sintomas no corpo: aperto no peito, falta de ar, coração acelerado, estômago "embrulhado".

Na consulta, os profissionais costumam usar questionários curtos, como o GAD-7, que ajudam a medir a intensidade dos sintomas e a acompanhar a melhora.2 Eles não substituem a conversa, mas ajudam a transformar a sensação em algo que pode ser acompanhado.

Tem tratamento, e ele funciona

• Psicoterapia: a terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem eficácia comprovada em muitos estudos para transtornos de ansiedade.3

• Medicamentos: quando indicados, alguns antidepressivos são a primeira escolha no transtorno de ansiedade generalizada, com bom equilíbrio entre benefício e efeitos colaterais.4 Calmantes do tipo benzodiazepínico devem ser usados por pouco tempo, pelo risco de dependência.

• Hábitos: atividade física regular, sono em horários estáveis, menos cafeína e álcool e pausas de verdade ao longo do dia ajudam, mas não substituem o tratamento quando os sintomas são intensos.

Quando procurar ajuda: se a ansiedade dura mais de algumas semanas, se você deixou de fazer coisas por causa dela ou se precisa de álcool ou calmantes para "dar conta", procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um profissional de saúde mental.

Referências

• Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602. doi:10.1001/archpsyc.62.6.593

• Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, et al. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-7. doi:10.1001/archinte.166.10.1092

• Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al. Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depress Anxiety. 2018;35(6):502-514. doi:10.1002/da.22728

• Slee A, Nazareth I, Bondaronek P, et al. Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2019;393(10173):768-777. doi:10.1016/S0140-6736(18)31793-8

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

97 · G4 · publicado em 2026-09-22

Ansiedade em filhos: o que os pais podem fazer

Motivo: medicamento · ~4 min

Quando um filho tem medo, o impulso natural dos pais é protegê-lo: acompanhar em tudo, evitar as situações difíceis, responder sempre que pergunta "vai dar certo?". Esse cuidado alivia na hora, mas, sem querer, pode manter a ansiedade viva.

Medo comum ou ansiedade que precisa de ajuda?

• medos passageiros (do escuro, de monstros, de ficar longe dos pais) fazem parte do desenvolvimento;

• preocupa quando o medo é intenso, dura meses e impede a criança de ir à escola, dormir sozinha, brincar com colegas ou participar de atividades;

• dores de barriga e de cabeça frequentes antes da escola também podem ser ansiedade.

Os transtornos de ansiedade estão entre os problemas de saúde mental mais frequentes na infância e na adolescência em todo o mundo.1

Muitos transtornos de ansiedade começam cedo, por volta do início da adolescência, por isso reconhecer os sinais na infância faz diferença.2

A acomodação familiar

Pesquisadores chamam de "acomodação" as mudanças que a família faz para evitar o sofrimento da criança:

deixar faltar à aula, dormir sempre junto, falar por ela, repetir garantias o tempo todo. A curto prazo, isso acalma. A longo prazo, ensina que o medo era mesmo perigoso.

Um ensaio clínico mostrou que um programa voltado apenas para os pais, ensinando a reduzir a acomodação e a apoiar a criança, foi tão eficaz quanto a terapia cognitivo-comportamental feita diretamente com a criança.3

O que os pais podem fazer

• Acolher e confiar: "Eu sei que você está com medo, e sei que você consegue enfrentar isso".

• Reduzir a acomodação aos poucos, com combinados claros e sem castigos.

• Incentivar pequenos passos de enfrentamento e elogiar o esforço, não só o resultado.

• Cuidar da própria ansiedade: crianças aprendem observando como os adultos lidam com o medo.

• Manter a rotina: sono, escola e atividades físicas ajudam a regular as emoções.

Tratamento

A terapia cognitivo-comportamental, com a criança e com a participação dos pais, é o tratamento psicológico mais estudado para a ansiedade infantil.3 Em alguns casos, o médico pode indicar medicamentos. Procure a UBS ou o pediatra para a avaliação inicial.

Em crianças e adolescentes com ansiedade, a terapia cognitivo-comportamental e a sertralina foram eficazes, e

a combinação das duas teve o melhor resultado num grande ensaio clínico.4

Referências

• Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, et al. Annual research review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):345-65. doi:10.1111/jcpp.12381

• Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602. doi:10.1001/archpsyc.62.6.593

• Lebowitz ER, Marin C, Martino A, et al. Parent-Based Treatment as Efficacious as Cognitive-Behavioral Therapy for Childhood Anxiety: A Randomized Noninferiority Study of Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2019;59(3):362-372. doi:10.1016/j.jaac.2019.02.014

• Walkup JT, Albano AM, Piacentini J, et al. Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med. 2008;359(26):2753-66. doi:10.1056/NEJMoa0804633

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

98 · G4 · publicado em 2026-09-22

Ansiedade social: quando a timidez vira algo mais

Motivo: medicamento · ~3 min

Ser tímido não é doença. Muitas pessoas reservadas vivem bem, trabalham, têm amigos e relacionamentos. A ansiedade social é diferente: o medo de ser julgado é tão intenso que a pessoa passa a evitar situações importantes e sofre muito com isso.

Timidez ou ansiedade social?

• Timidez: desconforto inicial em situações novas, que diminui com a convivência e não impede a pessoa de fazer o que precisa.

• Ansiedade social: medo intenso e persistente de passar vergonha ou ser avaliado negativamente, com evitação de situações como falar em reunião, comer em público, fazer ligações ou ir a festas.

A ansiedade social costuma começar cedo, muitas vezes na adolescência, e quando não é tratada aumenta o risco de depressão e de uso de álcool e outras substâncias.1

Sinais comuns

• rosto vermelho, tremor, suor e voz falhando diante de outras pessoas;

• ensaiar mentalmente cada frase e passar dias revendo o que disse;

• recusar promoções, cursos ou oportunidades para não se expor;

• usar álcool para conseguir se socializar.

Três perguntas simples ajudam a levantar a suspeita: medo de constrangimento, evitação de situações sociais e medo de ser o centro das atenções. É essa a lógica do questionário Mini-SPIN, usado em serviços de saúde.2

Tratamento

• a terapia cognitivo-comportamental individual teve os melhores resultados entre as psicoterapias em uma grande análise de estudos;3

• alguns antidepressivos também são eficazes, especialmente em quadros mais graves;3

• a exposição gradual às situações temidas, planejada com o terapeuta, é parte central da melhora.

Metanálises de ensaios controlados confirmam a eficácia da terapia cognitivo-comportamental na ansiedade social.4

Para quem convive: evite rótulos como "antissocial" ou "fresco" e não force exposições bruscas. Incentive a busca por ajuda e reconheça cada pequeno passo.

Referências

• Stein MB, Stein DJ. Social anxiety disorder. Lancet. 2008;371(9618):1115-25. doi:10.1016/S0140-6736(08)60488-2

• Connor KM, Kobak KA, Churchill LE, et al. Mini-SPIN: A brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depress Anxiety. 2001;14(2):137-40. doi:10.1002/da.1055

• Mayo-Wilson E, Dias S, Mavranezouli I, et al. Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2014;1(5):368-76. doi:10.1016/S2215-0366(14)70329-3

• Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al. Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depress Anxiety. 2018;35(6):502-514. doi:10.1002/da.22728

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

99 · G4 · publicado em 2026-09-22

Depressão: sinais além da tristeza que muita gente não reconhece

Motivo: medicamento · ~4 min

Muita gente imagina a depressão como tristeza constante e choro. Mas ela pode aparecer como cansaço que não passa, irritação, falta de prazer, dores pelo corpo ou dificuldade de pensar. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para procurar tratamento.

Sinais que vão além da tristeza

• perda de interesse ou prazer em coisas de que gostava;

• cansaço e falta de energia mesmo depois de descansar;

• sono alterado: insônia, despertar muito cedo ou dormir demais;

• mudança de apetite e de peso;

• irritabilidade, impaciência, "pavio curto";

• dificuldade de concentração e de tomar decisões;

• sentimento de culpa ou de inutilidade;

• dores no corpo, dor de cabeça e problemas digestivos sem causa clara;

• pensamentos de que a vida não vale a pena.

Quando vários desses sinais aparecem na maior parte dos dias, por pelo menos duas semanas, e atrapalham a vida, é hora de procurar avaliação. O questionário PHQ-9,

usado em muitos serviços, ajuda a identificar a depressão e medir sua gravidade.1

Nos homens, a depressão aparece com frequência como irritabilidade, explosões de raiva, uso de álcool ou comportamentos de risco, o que ajuda a explicar por que passa despercebida.2

Depressão tem tratamento

• Psicoterapia: a terapia cognitivo-comportamental é eficaz, sozinha ou associada a medicamentos.3

• Antidepressivos: uma análise de mais de 500 estudos mostrou que todos os 21 antidepressivos avaliados foram mais eficazes que placebo em adultos com depressão.4 A escolha depende de cada pessoa.

• Estilo de vida: atividade física, rotina de sono e contato com outras pessoas ajudam na recuperação.

Importante: depressão não é preguiça, falta de fé ou fraqueza. É uma condição de saúde, e quanto antes for tratada, melhor tende a ser a recuperação.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606-13. doi:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x

• Martin LA, Neighbors HW, Griffith DM. The experience of symptoms of depression in men vs women: analysis of the National Comorbidity Survey Replication. JAMA Psychiatry. 2013;70(10):1100-6. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.1985

• Cuijpers P, Berking M, Andersson G, et al. A meta-analysis of cognitive-behavioural therapy for adult depression, alone and in comparison with other treatments. Can J Psychiatry. 2013;58(7):376-85. doi:10.1177/070674371305800702

• Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366. doi:10.1016/S0140-6736(17)32802-7

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

100 · G4 · publicado em 2026-09-22

Medicação psiquiátrica: perguntas que você pode fazer ao médico

Motivo: medicamento · ~4 min

Começar um medicamento para a saúde mental traz dúvidas e, às vezes, medo. Fazer perguntas é seu direito e ajuda o tratamento a dar certo. Pacientes bem informados costumam seguir melhor o tratamento e identificar mais cedo efeitos indesejados.

Perguntas para fazer ao médico

• Para que serve este remédio no meu caso?

• Em quanto tempo devo perceber melhora?

• Quais efeitos colaterais são mais comuns e quais são sinal de alerta?

• Posso beber álcool? Interage com outros remédios que uso?

• Posso dirigir e trabalhar normalmente?

• Por quanto tempo vou precisar tomar?

• O que faço se esquecer uma dose?

• Como e quando poderemos reduzir ou parar?

• Existe opção mais barata ou disponível no SUS?

• E se eu engravidar ou estiver amamentando?

O que é bom saber sobre antidepressivos

• eles são mais eficazes que placebo na depressão, e há várias opções;1

• o benefício tende a ser maior quanto mais grave é a depressão;2

• a melhora costuma começar em duas a quatro semanas, e o efeito completo pode levar mais tempo;

• combinar com psicoterapia aumenta as chances de resposta.3

Cuidados importantes

• não interrompa por conta própria, mesmo se melhorar;

• avise o médico sobre qualquer piora, agitação ou pensamentos de morte nas primeiras semanas, principalmente em jovens;

• informe todos os remédios, chás e suplementos que usa;

• guarde os medicamentos longe do alcance de crianças.

Sintomas de descontinuação ao parar antidepressivos são comuns e às vezes duram mais do que se pensava, por isso a retirada deve ser gradual e combinada com o médico.4

Dica: anote suas perguntas antes da consulta e as respostas durante. Se algo não ficou claro, peça para o profissional explicar de outra forma.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366. doi:10.1016/S0140-6736(17)32802-7

• Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, et al. Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level meta-analysis. JAMA. 2010;303(1):47-53. doi:10.1001/jama.2009.1943

• Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole SL, et al. Adding psychotherapy to antidepressant medication in depression and anxiety disorders: a meta-analysis. World Psychiatry. 2014;13(1):56-67. doi:10.1002/wps.20089

• Davies J, Read J. A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based?. Addict Behav. 2018;97:111-121. doi:10.1016/j.addbeh.2018.08.027

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

101 · G4 · publicado em 2026-09-22

Síndrome do pânico: entendendo o que acontece no corpo

Motivo: medicamento · ~4 min

Coração disparado, falta de ar, tremor, suor, sensação de que vai desmaiar, enlouquecer ou morrer. Quem já teve uma crise de pânico sabe como ela assusta. A boa notícia é que o transtorno de pânico é comum, bem conhecido e tem tratamento eficaz.

O que acontece no corpo

Na crise de pânico, o sistema de alarme do corpo dispara sem que exista um perigo real. A adrenalina acelera o coração e a respiração e tensiona os músculos, como se fosse preciso fugir. Os sintomas atingem o pico em poucos minutos e depois diminuem. Por mais assustadora que seja, a crise em si não causa infarto nem loucura.

Crise isolada ou transtorno de pânico?

• muitas pessoas têm uma crise isolada em algum momento da vida;

• fala-se em transtorno de pânico quando as crises se repetem de forma inesperada e surgem o medo constante de ter outra crise e mudanças de comportamento para evitá-la;

• o transtorno de pânico atinge de 1% a 4% das pessoas ao longo da vida.1

Cerca de uma em cada vinte pessoas terá transtorno de pânico em algum momento da vida, o que mostra que não

se trata de algo raro.2

Quando o medo encolhe a vida

Com o tempo, a pessoa pode evitar ônibus, metrô, filas, shoppings ou sair sozinha, com medo de passar mal longe de ajuda. Isso se chama agorafobia e tende a piorar quando o evitamento aumenta.

Tratamento

• Terapia cognitivo-comportamental: é a abordagem psicológica com mais evidência como primeira escolha. Ensina a entender as sensações e a enfrentar, aos poucos, as situações evitadas.1

• Medicamentos: alguns antidepressivos ajudam a prevenir novas crises. Terapia e medicamento podem ser combinados.3

• Avaliação clínica: na primeira crise, é importante descartar outras causas, como problemas de tireoide, arritmias e uso de estimulantes.

A terapia cognitivo-comportamental tem eficácia confirmada em metanálises de ensaios controlados para o transtorno de pânico e outros transtornos de ansiedade.4

Durante uma crise

• lembre-se de que a crise passa, geralmente em minutos;

• respire devagar, soltando o ar por mais tempo do que puxa;

• descreva para si o que está vendo ao redor, para ancorar a atenção no presente;

• evite fugir imediatamente do lugar, se for seguro ficar.

Atenção: dor no peito forte, falta de ar intensa ou desmaio, principalmente em quem tem fatores de risco cardíaco, devem ser avaliados com urgência. Na dúvida, procure atendimento ou ligue 192.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Pompoli A, Furukawa TA, Imai H, et al. Psychological therapies for panic disorder with or without agoraphobia in adults: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4(4):CD011004. doi:10.1002/14651858.CD011004.pub2

• Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602. doi:10.1001/archpsyc.62.6.593

• Imai H, Tajika A, Chen P, et al. Psychological therapies versus pharmacological interventions for panic disorder with or without agoraphobia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2016;10(10):CD011170. doi:10.1002/14651858.CD011170.pub2

• Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al. Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.

Depress Anxiety. 2018;35(6):502-514.
doi:10.1002/da.22728

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

102 · G4 · publicado em 2026-09-22

TDAH em adultos: sinais que muitas pessoas não reconhecem

Motivo: medicamento · ~4 min

O TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) não acaba necessariamente na infância. Muitos adultos convivem com ele sem diagnóstico e passam a vida ouvindo que são desorganizados, desligados ou irresponsáveis. Ao mesmo tempo, o tema virou moda nas redes, e nem toda distração é TDAH.

Sinais em adultos

• dificuldade de manter a atenção em tarefas longas ou pouco interessantes;

• esquecimentos frequentes: compromissos, contas, objetos;

• desorganização com tempo, prazos e papéis;

• começar muitas coisas e terminar poucas;

• inquietação interna, dificuldade de esperar e de relaxar;

• impulsividade: interromper os outros, decisões ou compras por impulso.

Em mulheres, o TDAH costuma ser reconhecido mais tarde, porque predominam a desatenção e sintomas menos visíveis do que a hiperatividade.1

O que diferencia o TDAH

• os sintomas começam na infância, mesmo que só sejam percebidos depois;

• aparecem em vários ambientes: casa, trabalho, estudos, relações;

• causam prejuízo real e persistente.

Uma revisão global estimou que cerca de 2,6% dos adultos têm TDAH que persiste desde a infância e que perto de 6,8% apresentam sintomas importantes.2 Questionários como o ASRS, da Organização Mundial da Saúde, ajudam na triagem, mas o diagnóstico depende de avaliação clínica cuidadosa.3 Ansiedade, depressão, privação de sono, uso de substâncias e problemas de tireoide também causam desatenção e precisam ser considerados.

Tratamento

• psicoeducação e estratégias de organização: agendas, alarmes, listas, rotinas;

• terapia cognitivo-comportamental adaptada ao TDAH;

• medicamentos, quando indicados, são eficazes a curto prazo em adultos e exigem acompanhamento médico.4

Cuidado com o autodiagnóstico pelas redes: vídeos curtos podem ajudar a reconhecer sinais, mas muitos trazem informações imprecisas. Leve suas dúvidas a um profissional e nunca use medicamentos estimulantes sem prescrição.

Referências

• Young S, Adamo N, Ásgeirsdóttir BB, et al. Females with ADHD: An expert consensus statement taking a lifespan approach providing guidance for the identification and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in girls and women. BMC Psychiatry. 2020;20(1):404. doi:10.1186/s12888-020-02707-9

• Song P, Zha M, Yang Q, et al. The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. J Glob Health. 2021;11:04009. doi:10.7189/jogh.11.04009

• Kessler RC, Adler L, Ames M, et al. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychol Med. 2005;35(2):245-56. doi:10.1017/s0033291704002892

• Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2018;5(9):727-738. doi:10.1016/S2215-0366(18)30269-4

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

Depressão pós-parto e ansiedade perinatal: reconhecendo os sinais além do "baby blues"

Motivo: medicamento · ~5 min

O período após o parto é cercado de expectativa de felicidade — o que torna ainda mais difícil para muitas mães reconhecer, ou admitir, que o que sentem é tristeza persistente, ansiedade intensa ou exaustão que vai além do esperado. O "baby blues" (oscilação de humor nos primeiros dias, que passa sozinha) é comum e diferente de depressão pós-parto ou ansiedade perinatal, que exigem atenção e cuidado específicos.

Diferenciando baby blues de algo que precisa de cuidado

O baby blues costuma aparecer nos primeiros dias, é leve, e melhora sozinho em até duas semanas. Quando a tristeza, ansiedade ou desconexão emocional persistem além desse período, se intensificam, ou vêm acompanhadas de pensamentos assustadores, o quadro pode ser depressão pós-parto ou ansiedade perinatal — condições clínicas reconhecidas, comuns, e tratáveis.

A depressão pós-parto é comum e tratável1, e a Escala de Edimburgo, validada no Brasil, ajuda a identificá-la2,3.

A sobrecarga invisível da amamentação

A pressão — própria e externa — para amamentar "do jeito certo" costuma adicionar uma camada extra de exaustão e culpa em um momento já fisicamente exigente. Dificuldade na amamentação não é falha da

mãe, e o desgaste físico e emocional que ela pode causar merece ser levado a sério, não minimizado como "faz parte".

Ponto de atenção: Pensamentos intrusivos assustadores (sobre machucar o bebê, por exemplo) são mais comuns do que se fala abertamente e, na maioria das vezes, geram angústia exatamente porque a mãe não quer que aconteçam — mas merecem avaliação profissional, não silêncio por vergonha.

Ansiedade também é frequente: atinge cerca de uma em cada cinco gestantes e muitas mulheres no pós-parto4. Vários antidepressivos são compatíveis com a amamentação5.

Rede de apoio como parte do tratamento

Dividir tarefas com o parceiro ou família, conversar abertamente com outras mães, e não carregar sozinha a expectativa de dar conta de tudo são parte concreta do cuidado — ao lado, quando necessário, de acompanhamento profissional. Pedir ajuda cedo tende a encurtar o sofrimento, não a prolongá-lo.

Conteúdo educativo baseado em literatura sobre depressão pós-parto e ansiedade perinatal. Não substitui avaliação individual.

Ferramenta interativa

Termômetro de Bem-Estar no Puerpério

Seis afirmações sobre o período pós-parto, escala de 1 (nunca) a 5 (quase sempre). Pensada para mães nas primeiras semanas ou meses após o parto.

Sinto tristeza persistente que não passa em poucos dias

1 2 3 4 5

Tenho ansiedade intensa ou medo constante em relação à saúde do bebê

1 2 3 4 5

A amamentação (ou tentativa dela) está me deixando fisicamente exausta

1 2 3 4 5

Sinto culpa ou que não estou sendo "boa mãe o suficiente"

1 2 3 4 5

Sinto uma desconexão emocional em relação ao bebê que me incomoda

1 2 3 4 5

Tenho pensamentos assustadores ou intrusivos que me preocupam

1 2 3 4 5

Ver meu resultado

Ferramenta educativa de autoavaliação. Não substitui consulta, diagnóstico ou acompanhamento por profissional habilitado.

Agendar uma avaliação

(function () { var fatores = ['tristeza', 'ansiedade-bebe', 'exaustao-amamentacao', 'culpa', 'desconexao', 'pensamentos']; var botao = document.getElementById('mp-calcular'); if (!botao) return; botao.addEventListener('click', function () { var erro = document.getElementById('mp-erro'); var soma = 0, faltando = false; for (var i = 0; i

Referências

• Stewart DE, Vigod S. Postpartum Depression. N Engl J Med. 2016;375(22):2177-2186. doi:10.1056/NEJMcp1607649

• Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry. 1987;150:782-6. doi:10.1192/bjp.150.6.782

• Santos IS, Matijasevich A, Tavares BF, et al. Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) in a sample of mothers from the 2004 Pelotas Birth Cohort Study. Cad Saude Publica. 2007;23(11):2577-88. doi:10.1590/s0102-311x2007001100005

• Dennis CL, Falah-Hassani K, Shiri R. Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 2017;210(5):315-323. doi:10.1192/bjp.bp.116.187179

• Sriraman NK, Melvin K, Meltzer-Brody S. ABM Clinical Protocol #18: Use of Antidepressants in Breastfeeding Mothers. Breastfeed Med. 2015;10(6):290-9. doi:10.1089/bfm.2015.29002

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

104 · G4 · publicado em 2026-09-23

Ansiedade social: quando o medo do julgamento limita a vida

Motivo: medicamento · ~5 min

Timidez é um traço de personalidade comum e não necessariamente problemático. Ansiedade social é diferente: envolve medo intenso e persistente de julgamento ou humilhação em situações sociais, com evitação que chega a limitar decisões importantes — de não aceitar uma promoção que exigiria apresentações, a evitar relacionamentos por medo de rejeição.

O ciclo que mantém a ansiedade social

Evitar uma situação social alivia a ansiedade no curto prazo, mas reforça a crença de que a situação era, de fato, perigosa — alimentando o ciclo. Some a isso a ruminação pós-evento, revisando cada detalhe da interação em busca de erros, e o resultado é um padrão que se autoperpetua, mesmo sem eventos sociais realmente negativos acontecendo.

A ansiedade social é um dos transtornos de ansiedade mais comuns e costuma começar na adolescência1.

Metade dos transtornos mentais começa até os 14 anos, e a ansiedade social está entre os que surgem mais cedo2.

O medo de falar em público como caso extremo

Fobia de falar em público é uma das manifestações mais comuns de ansiedade social — e uma das mais limitantes profissionalmente. Os sintomas físicos intensos

(taquicardia, tremor, sudorese) que a acompanham costumam gerar medo adicional de que os outros percebam a ansiedade, criando uma camada extra de autoconsciência que piora a experiência.

Ponto de atenção: Ansiedade social não é falta de habilidade social — muitas pessoas com ansiedade social têm boas habilidades sociais, mas o medo do julgamento impede que essas habilidades sejam exercidas com naturalidade.

Perguntas simples, como as três do Mini-SPIN, ajudam a identificar quando o medo merece avaliação3.

Ansiedade social tem tratamento eficaz

Entre as condições de saúde mental, ansiedade social é uma das que respondem melhor a acompanhamento estruturado — a exposição gradual a situações temidas, com apoio adequado, tende a quebrar o ciclo de evitação de forma consistente. Buscar ajuda não é admitir fraqueza; é acessar um tratamento que genuinamente funciona.

Conteúdo educativo baseado em literatura sobre transtorno de ansiedade social. Não substitui avaliação individual.

Uma grande meta-análise mostrou que a terapia cognitivo-comportamental individual é o tratamento psicológico mais eficaz, e alguns antidepressivos também ajudam4.

Ferramenta interativa

Termômetro de Ansiedade Social

Seis afirmações sobre situações sociais, escala de 1 (nunca) a 5 (quase sempre).

Evito situações sociais por medo de ser julgado(a) ou passar vergonha

1 2 3 4 5

Sinto sintomas físicos intensos (coração acelerado, suor, tremor) antes de falar em público ou interagir

1 2 3 4 5

Ensaio excessivamente o que vou dizer antes de situações sociais simples

1 2 3 4 5

Evito iniciar conversas ou contato, mesmo quando gostaria de me aproximar de alguém

1 2 3 4 5

Fico repassando mentalmente interações sociais depois, procurando erros que cometi

1 2 3 4 5

Tenho me isolado socialmente mais do que gostaria

1 2 3 4 5

Calcular meu nível de ansiedade social

Ferramenta educativa de autoavaliação. Não substitui consulta, diagnóstico ou acompanhamento por profissional habilitado.

Falar sobre mentoria individual

(function () { var fatores = ['evitacao', 'sintomas-fisicos', 'ensaio', 'iniciar', 'ruminacao', 'isolamento']; var botao = document.getElementById('as-calcular'); if (!botao) return; botao.addEventListener('click', function () { var erro = document.getElementById('as-erro'); var soma = 0, faltando = false; for (var i = 0; i

Referências

• Stein MB, Stein DJ. Social anxiety disorder. Lancet. 2008;371(9618):1115-25. doi:10.1016/S0140-6736(08)60488-2

• Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602. doi:10.1001/archpsyc.62.6.593

• Connor KM, Kobak KA, Churchill LE, et al. Mini-SPIN: A brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depress Anxiety. 2001;14(2):137-40. doi:10.1002/da.1055

• Mayo-Wilson E, Dias S, Mavranezouli I, et al. Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2014;1(5):368-76. doi:10.1016/S2215-0366(14)70329-3

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

105 · G4 · publicado em 2026-10-21

Perimenopausa e saúde mental: por que o risco de depressão aumenta, os sinais e os tratamentos disponíveis

Motivo: medicamento · ~4 min

Ondas de calor, noites mal dormidas, irritação sem motivo aparente, esquecimentos, choro fácil. Muitas mulheres entre os 40 e os 50 anos sentem que algo mudou, mas não sabem dar nome ao que estão vivendo. Muitas vezes, é a perimenopausa.

O que é a perimenopausa

É a fase de transição que antecede a última menstruação. Pode durar alguns anos, com variações hormonais que afetam o ciclo menstrual, o sono, a temperatura do corpo e o humor.

Um período de maior risco para depressão

Um estudo que acompanhou mulheres sem história de depressão encontrou que aquelas que entraram na perimenopausa tiveram cerca do dobro de risco de desenvolver sintomas depressivos importantes, com risco um pouco maior entre as que tinham ondas de calor.1 Uma metanálise recente confirmou que o risco de depressão é maior na perimenopausa do que antes dela.2 E a depressão é frequente entre mulheres na menopausa em diferentes regiões do mundo.3

Sinais comuns

• ondas de calor e suores noturnos;

• insônia e sono fragmentado;

• irritabilidade, tristeza, ansiedade;

• dificuldade de concentração e esquecimentos;

• diminuição do desejo sexual.

O que ajuda

• Dar nome ao que está acontecendo: muitas mulheres se sentem aliviadas ao entender a causa.

• Cuidar do sono: quarto fresco, horários regulares, menos telas à noite.

• Atividade física regular, que melhora humor e sono.

• Conversar com a família e o parceiro sobre essa fase.

Tratamentos com evidência

Diretrizes específicas para a depressão da perimenopausa recomendam antidepressivos e psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental, como tratamentos de primeira linha. A terapia hormonal pode ajudar nos sintomas físicos e, em algumas mulheres na perimenopausa, também no humor, mas a decisão deve ser individual, pesando benefícios e riscos com o médico.4

Quando procurar ajuda

Se a tristeza durar semanas, tirar o prazer das coisas, atrapalhar o trabalho ou vier com pensamentos de morte, procure a UBS. Depressão nessa fase é comum e tratável.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Cohen LS, Soares CN, Vitonis AF, et al. Risk for new onset of depression during the menopausal transition: the Harvard study of moods and cycles. Arch Gen Psychiatry. 2006;63(4):385-90. doi:10.1001/archpsyc.63.4.385

• Badawy Y, Spector A, Li Z, et al. The risk of depression in the menopausal stages: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2024;357:126-133. doi:10.1016/j.jad.2024.04.041

• Jia Y, Zhou Z, Xiang F, et al. Global prevalence of depression in menopausal women: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2024;358:474-482. doi:10.1016/j.jad.2024.05.051

• Maki PM, Kornstein SG, Joffe H, et al. Guidelines for the evaluation and treatment of perimenopausal depression: summary and recommendations. Menopause. 2018;25(10):1069-1085. doi:10.1097/GME.0000000000001174

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

106 · G4 · publicado em 2026-10-21

Depressão no idoso não é "coisa da idade": como ela aparece, por que passa despercebida e o tratamento que funciona

Motivo: medicamento · ~4 min

"É a idade." Essa frase costuma encerrar a conversa quando um idoso fica mais quieto, perde o interesse pelas coisas ou passa a reclamar de dores. Mas a depressão não é parte natural do envelhecimento, e tem tratamento.

O que a ciência mostra

Uma revisão publicada na The Lancet mostrou que, nos idosos, a depressão afeta principalmente quem tem doenças crônicas e alterações de memória, causa sofrimento e incapacidade, piora a evolução de outras doenças e aumenta a mortalidade. Perdas, isolamento, mudanças de casa, dificuldades financeiras e o cuidado de outras pessoas contribuem para o quadro.1 Revisões mais recentes confirmam que psicoterapia e antidepressivos são eficazes nessa fase, com atenção especial a interações e efeitos colaterais.2

Como a depressão aparece no idoso

• desânimo e perda de interesse, mais do que tristeza declarada;

• queixas físicas frequentes: dores, cansaço, falta de apetite;

• esquecimentos e dificuldade de concentração;

• isolamento e abandono de atividades;

• irritação e sensação de ser um peso para a família.

Na UBS, a Escala de Depressão Geriátrica, validada no Brasil, ajuda a rastrear o quadro em poucos minutos.3

Por que ela é ignorada

• os sintomas são confundidos com o envelhecimento ou com outras doenças;

• muitos idosos cresceram ouvindo que falar de tristeza é fraqueza;

• familiares e profissionais nem sempre perguntam.

Uma consulta pode fazer diferença

Uma revisão encontrou que quase metade das pessoas que morreram por suicídio tinha procurado a Atenção Primária no mês anterior, proporção ainda maior entre os idosos.4 Perguntar sobre humor e pensamentos de morte faz parte do cuidado.

O que ajuda

• Perguntar diretamente como a pessoa está se sentindo.

• Manter vínculos e rotina: visitas, telefonemas, atividades em grupo.

• Atividade física adaptada e exposição à luz do dia.

• Revisar os medicamentos, porque alguns podem piorar o humor.

• Buscar tratamento: psicoterapia e medicação são eficazes nessa fase.

Quando procurar ajuda

Procure a UBS se o desânimo durar semanas ou se o idoso disser que a vida não tem mais sentido. Na terceira idade, falas sobre morrer devem ser sempre levadas a sério.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Alexopoulos GS. Depression in the elderly. Lancet. 2005;365(9475):1961-70. doi:10.1016/S0140-6736(05)66665-2

• Kok RM, Reynolds CF. Management of Depression in Older Adults: A Review. JAMA. 2017;317(20):2114-2122. doi:10.1001/jama.2017.5706

• Almeida OP, Almeida SA. [Reliability of the Brazilian version of the ++abbreviated form of Geriatric Depression Scale (GDS) short form]. Arq Neuropsiquiatr. 1999;57(2B):421-6. doi:10.1590/s0004-282x1999000300013

• Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-16. doi:10.1176/appi.ajp.159.6.909

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Depressão pós-parto e amamentação: por que tratar é cuidar do bebê e quais opções são compatíveis

Motivo: medicamento · ~4 min

"Se eu tomar remédio, vou ter que parar de amamentar." Esse medo faz muitas mães com depressão pós-parto sofrerem em silêncio por meses. Mas tratar e amamentar, em muitos casos, é possível.

Uma condição frequente

A depressão pós-parto atinge entre 13% e 19% das mulheres depois do nascimento do bebê.1 Ela vai além do baby blues: dura mais de duas semanas e traz tristeza persistente, perda de prazer, culpa, ansiedade e dificuldade de cuidar de si e do bebê.

Tratar é cuidar da mãe e do bebê

A depressão não tratada afeta a mãe, o vínculo com o bebê e a família. Por isso, tratar não é um luxo: é parte do cuidado com a criança.2

As opções de tratamento

• Psicoterapia: é a primeira opção para quadros leves e moderados, com evidência de eficácia no tratamento e na prevenção.2

• Medicação: nos quadros moderados a graves, os antidepressivos são eficazes.3 O protocolo da Academia de Medicina da Amamentação indica que vários antidepressivos, como a sertralina, passam em

quantidades muito pequenas para o leite e são considerados compatíveis com a amamentação, com acompanhamento do bebê.4

• Rede de apoio: dividir os cuidados, garantir sono e alimentação.

Como decidir com segurança

Ainda há poucos estudos de alta qualidade sobre medicamentos na gestação e na amamentação; por isso, a decisão deve ser individual, pesando riscos e benefícios.2 Na consulta, pergunte:

• Qual é o risco de não tratar a minha depressão?

• Quais opções são compatíveis com a amamentação?

• Que sinais devo observar no bebê?

• Posso começar pela psicoterapia?

Sinais de emergência

Confusão mental, ouvir vozes, ideias estranhas sobre o bebê ou pensamentos de fazer mal a si mesma ou ao bebê exigem atendimento imediato: SAMU (192), UPA ou pronto-socorro.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• O'Hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions. Annu Rev Clin Psychol. 2013;9:379-407. doi:10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612

• Howard LM, Molyneaux E, Dennis CL, et al. Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. Lancet. 2014;384(9956):1775-88. doi:10.1016/S0140-6736(14)61276-9

• Stewart DE, Vigod S. Postpartum Depression. N Engl J Med. 2016;375(22):2177-2186. doi:10.1056/NEJMcp1607649

• Sriraman NK, Melvin K, Meltzer-Brody S. ABM Clinical Protocol #18: Use of Antidepressants in Breastfeeding Mothers. Breastfeed Med. 2015;10(6):290-9. doi:10.1089/bfm.2015.29002

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

108 · G4 · publicado em 2026-10-23

O peso emocional de uma doença crônica: depressão, adesão ao tratamento e o cuidado que integra corpo e mente

Motivo: medicamento · ~4 min

Diabetes, hipertensão, artrite, asma, doença do coração, câncer, HIV. Receber um diagnóstico crônico muda a rotina, os planos e a forma como a pessoa se vê. Medo, raiva, negação e tristeza são reações comuns nos primeiros tempos.

Corpo e mente andam juntos

Um levantamento da Organização Mundial da Saúde com mais de 245 mil pessoas em 60 países encontrou depressão em 9% a 23% das pessoas com doenças crônicas como angina, artrite, asma e diabetes, frequência bem maior que a de quem não tinha essas doenças. Quem tinha depressão junto com uma doença crônica apresentou os piores índices de saúde entre todos os grupos.1

A relação é de mão dupla: a depressão aumenta o risco de doenças crônicas, e as doenças crônicas aumentam o risco de depressão. A depressão também dificulta seguir o tratamento e piora a evolução da doença.2

Sinais de que o sofrimento passou do esperado

• tristeza ou desânimo na maior parte dos dias, por semanas;

• perda de interesse por tudo;

• abandono do tratamento: parar remédios, faltar a consultas;

• isolamento, sensação de ser um peso;

• pensamentos de que a vida não vale mais a pena.

O que ajuda

• Entender a doença: informação reduz o medo.

• Fazer perguntas na consulta e participar das decisões.

• Buscar grupos de pessoas com a mesma condição.

• Incluir a família no cuidado.

• Pedir avaliação do humor. Instrumentos simples, como a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, ajudam a identificar sofrimento em pessoas com doenças físicas.3

O tratamento funciona

Psicoterapia e antidepressivos são eficazes também em pessoas com doenças crônicas.2 Num ensaio na Atenção Primária, um cuidado colaborativo coordenado por enfermeiros melhorou ao mesmo tempo a depressão e o controle do diabetes, da pressão e do colesterol.4 Procure a UBS.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Moussavi S, Chatterji S, Verdes E, et al. Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health Surveys. Lancet. 2007;370(9590):851-8. doi:10.1016/S0140-6736(07)61415-9

• Katon WJ. Epidemiology and treatment of depression in patients with chronic medical illness. Dialogues Clin Neurosci. 2011;13(1):7-23. doi:10.31887/DCNS.2011.13.1/wkaton

• Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983;67(6):361-70. doi:10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x

• Katon WJ, Lin EH, Von Korff M, et al. Collaborative care for patients with depression and chronic illnesses. N Engl J Med. 2010;363(27):2611-20. doi:10.1056/NEJMoa1003955

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

109 · G4 · publicado em 2026-10-26

Timidez ou ansiedade social na adolescência? Como diferenciar, sinais de alerta e os tratamentos que funcionam

Motivo: medicamento · ~4 min

Ficar vermelho ao falar em público, preferir poucos amigos, demorar para se soltar. A timidez é comum e não precisa de tratamento. Mas, para alguns adolescentes, o medo de ser julgado é tão intenso que eles deixam de ir à escola, de falar em sala, de fazer amigos.

Timidez ou ansiedade social?

• Timidez: desconforto em situações sociais que diminui com o tempo e não impede a pessoa de viver.

• Ansiedade social: medo intenso e persistente de ser observado, julgado ou humilhado, que leva a evitar situações e causa sofrimento importante.

Começa cedo

A ansiedade social está entre os transtornos de ansiedade mais comuns. Costuma começar na infância ou na adolescência e aumenta o risco de depressão e de uso de substâncias depois.1 Um grande levantamento nos Estados Unidos mostrou que a idade mediana de início dos transtornos de ansiedade é 11 anos, e que metade de todos os transtornos mentais começa até os 14 anos.2

Sinais de alerta

• evitar falar em sala, apresentar trabalhos, comer em público;

• faltar à escola em dias de apresentação;

• sintomas físicos intensos: tremor, suor, rubor, coração acelerado;

• isolamento e poucos amigos, apesar do desejo de ter mais;

• uso de álcool para "se soltar".

Na consulta, três perguntas rápidas do questionário Mini-SPIN ajudam a identificar quem precisa de avaliação mais detalhada.3

O que ajuda em casa e na escola

• Não forçar nem proteger demais. Incentive pequenos passos.

• Elogie o esforço, não só o resultado.

• Combine com a escola formas graduais de participação.

• Evite rótulos como "você é muito tímido".

Tratamentos que funcionam

Uma metanálise em rede com 101 estudos e mais de 13 mil adultos encontrou que a terapia cognitivo-comportamental individual teve os maiores efeitos e deve ser o tratamento inicial de escolha. Para quem não quer ou não pode fazer psicoterapia, alguns antidepressivos mostraram a evidência mais consistente.4 Em crianças e adolescentes, a terapia também é o primeiro passo.

Procure a UBS ou o CAPSi se a ansiedade estiver atrapalhando a vida do adolescente.

Referências

• Stein MB, Stein DJ. Social anxiety disorder. Lancet. 2008;371(9618):1115-25. doi:10.1016/S0140-6736(08)60488-2

• Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602. doi:10.1001/archpsyc.62.6.593

• Connor KM, Kobak KA, Churchill LE, et al. Mini-SPIN: A brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depress Anxiety. 2001;14(2):137-40. doi:10.1002/da.1055

• Mayo-Wilson E, Dias S, Mavranezouli I, et al. Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2014;1(5):368-76. doi:10.1016/S2215-0366(14)70329-3

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

110 · G4 · publicado em 2026-10-27

Beber água ajuda a saúde mental? O que a ciência realmente mostra e como se hidratar no calor

Motivo: medicamento · ~4 min

Água é tão básica que quase esquecemos dela. Em Salvador, com calor quase o ano inteiro, isso é ainda mais importante. Mas qual é, de fato, a relação entre hidratação e saúde mental? Existe alguma relação, mas a evidência é mais limitada do que as redes sociais fazem parecer.

O que a ciência mostra

A desidratação afeta humor e cognição. Revisões mostram que a desidratação, mesmo leve, pode prejudicar a atenção, a memória e o humor, com mais fadiga e tensão, embora os estudos tenham limitações, como medidas diferentes de cognição e de hidratação.1 A água tem papel em quase todas as funções do corpo, inclusive no funcionamento do cérebro.2

Mudar a quantidade de água muda o humor. Num estudo experimental, pessoas que bebiam pouca água e passaram a beber mais relataram menos fadiga, confusão e sonolência; as que bebiam bastante e reduziram relataram menos calma e menos emoções positivas.3

Associação com depressão, sem prova de causa. Um grande estudo transversal encontrou que quem bebia pouca água tinha mais chance de apresentar depressão. Como os dados foram coletados num único momento, não dá para saber o que vem primeiro: a pessoa deprimida pode beber menos água justamente por estar deprimida.4

O que dá para concluir

• manter-se hidratado ajuda o corpo e a mente a funcionar melhor;

• a desidratação pode piorar cansaço, irritação e dificuldade de concentração;

• água não é tratamento para depressão ou ansiedade.

Como se hidratar

• beba água ao longo do dia, sem esperar sentir muita sede;

• aumente nos dias quentes, durante atividade física e em caso de febre, vômitos ou diarreia;

• urina clara costuma ser um bom sinal; urina escura e pouca indica necessidade de mais água;

• deixe uma garrafa por perto no trabalho e na escola;

• prefira água a refrigerantes, sucos adoçados e energéticos.

Atenção especial

• idosos sentem menos sede e precisam de lembretes;

• pessoas com doenças nos rins ou no coração devem seguir a orientação da equipe sobre a quantidade;

• beber água em excesso também faz mal; em algumas pessoas com transtornos mentais pode surgir uma vontade incontrolável de beber muita água, o que exige avaliação médica;

• lítio e outros medicamentos exigem cuidado redobrado com a hidratação: siga a orientação de quem prescreveu.

Quando buscar ajuda

Se cansaço, tristeza ou ansiedade persistem, procure a UBS: provavelmente há mais coisas a cuidar. Se pensar em morrer, ligue para o CVV, 188.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Masento NA, Golightly M, Field DT, et al. Effects of hydration status on cognitive performance and mood. Br J Nutr. 2014;111(10):1841-52. doi:10.1017/S0007114513004455

• Popkin BM, D'Anci KE, Rosenberg IH. Water, hydration, and health. Nutr Rev. 2010;68(8):439-58. doi:10.1111/j.1753-4887.2010.00304.x

• Pross N, Demazières A, Girard N, et al. Effects of changes in water intake on mood of high and low drinkers. PLoS One. 2014;9(4):e94754. doi:10.1371/journal.pone.0094754

• Haghighatdoost F, Feizi A, Esmaillzadeh A, et al. Drinking plain water is associated with decreased risk of depression and anxiety in adults: Results from a large cross-sectional study. World J Psychiatry. 2018;8(3):88-96. doi:10.5498/wjp.v8.i3.88

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

111 · G4 · publicado em 2026-10-28

Transtorno bipolar: muito além da mudança de humor

Motivo: medicamento · ~4 min

"Hoje ele está bipolar" virou expressão comum para falar de mau humor. Mas o transtorno bipolar é outra coisa: uma condição de saúde em que a pessoa alterna períodos de depressão com períodos de euforia ou irritação intensa, que duram dias ou semanas. Reconhecer os sinais evita anos de diagnóstico errado.

Os dois polos

• Depressão: tristeza, desânimo, falta de prazer, cansaço, alterações de sono e apetite.

• Mania ou hipomania: energia excessiva, pouca necessidade de sono sem cansaço, fala acelerada, ideias que correm, sensação de grandeza, irritabilidade, gastos e comportamentos de risco fora do habitual.

Na hipomania, os sintomas são mais leves e às vezes passam despercebidos ou até parecem "fase boa". Muitas pessoas procuram ajuda apenas na fase depressiva, e o transtorno bipolar acaba sendo tratado como depressão comum.1

Por que o diagnóstico correto importa

• o tratamento é diferente do da depressão: o uso de antidepressivo sozinho pode não ajudar e, em algumas pessoas, desencadear euforia;

• estabilizadores do humor, como o lítio, e alguns antipsicóticos são a base do tratamento, junto com psicoeducação e psicoterapia;2

• o transtorno bipolar tem risco aumentado de suicídio, e o tratamento adequado protege.

Questionários de triagem, como o Questionário de Transtornos do Humor (MDQ), ajudam a levantar a suspeita, mas a confirmação é sempre clínica.3

Sinais para contar ao médico

• períodos em que dormia muito pouco e não sentia falta do sono;

• fases de gastos, projetos ou relacionamentos impulsivos;

• pessoas próximas que comentaram "você não parecia você";

• casos de transtorno bipolar na família;

• depressões que começaram cedo, se repetem ou não melhoraram com antidepressivos.

Vivendo bem com o transtorno bipolar

• manter horários regulares de sono: noites mal dormidas podem desencadear crises;

• evitar álcool e drogas;

• tomar a medicação de forma contínua, mesmo nos períodos bons;

• combinar com a família um plano para reconhecer sinais de crise.

O guia mhGAP da Organização Mundial da Saúde orienta o acompanhamento contínuo do transtorno bipolar também na Atenção Primária.4

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• McIntyre RS, Berk M, Brietzke E, et al. Bipolar disorders. Lancet. 2020;396(10265):1841-1856. doi:10.1016/S0140-6736(20)31544-0

• Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord. 2018;20(2):97-170. doi:10.1111/bdi.12609

• Hirschfeld RM, Williams JB, Spitzer RL, et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry. 2000;157(11):1873-5. doi:10.1176/appi.ajp.157.11.1873

• World Health Organization. mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings, version 2.0. Geneva: WHO; 2016. who.int

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

112 · G4 · publicado em 2026-10-29

TOC não é mania de organização: sinais e tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo

Motivo: medicamento · ~4 min

Gostar de organização não é TOC. O transtorno obsessivo-compulsivo é marcado por pensamentos intrusivos que causam muita angústia e por rituais repetidos para aliviar essa angústia, ocupando horas do dia e trazendo grande sofrimento.

Obsessões e compulsões

• Obsessões: pensamentos, imagens ou impulsos indesejados que se repetem, como medo de contaminação, dúvidas ("tranquei a porta?"), medo de causar mal a alguém, pensamentos de conteúdo religioso ou sexual que a pessoa rejeita, necessidade de simetria.

• Compulsões: comportamentos ou atos mentais repetidos para neutralizar a angústia, como lavar as mãos muitas vezes, conferir, contar, rezar de forma ritualizada, pedir garantias.

A pessoa geralmente percebe que os pensamentos são exagerados, mas não consegue evitá-los. O TOC costuma começar na infância, na adolescência ou no início da vida adulta e pode passar anos sem diagnóstico, muitas vezes por vergonha.1

Sinais de que é hora de procurar ajuda

• rituais que tomam mais de uma hora por dia;

• evitar lugares, objetos ou pessoas por causa dos pensamentos;

• atrasos e prejuízos no trabalho, nos estudos ou em casa;

• família envolvida nos rituais, respondendo perguntas repetidas ou limpando de determinada forma.

A vergonha dos próprios pensamentos faz muita gente esconder os sintomas por anos, e o estigma em saúde mental atrasa a busca de ajuda.2

O TOC tem tratamento

• Terapia cognitivo-comportamental com exposição e prevenção de resposta: a pessoa enfrenta aos poucos as situações temidas sem realizar os rituais, com apoio do terapeuta. É a psicoterapia com melhores resultados;3

• Medicamentos: alguns antidepressivos, em doses muitas vezes mais altas e por mais tempo do que na depressão, são eficazes;3

• Família: aprender a não participar dos rituais, com acolhimento, ajuda no tratamento.

Metanálises de ensaios controlados confirmam a eficácia da terapia cognitivo-comportamental no TOC.4

Importante: ter pensamentos intrusivos não significa desejar o que eles dizem. No TOC, eles assustam justamente porque vão contra os valores da pessoa.

Referências

• Stein DJ, Costa DLC, Lochner C, et al. Obsessive-compulsive disorder. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):52. doi:10.1038/s41572-019-0102-3

• Clement S, Schauman O, Graham T, et al. What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychol Med. 2014;45(1):11-27. doi:10.1017/S0033291714000129

• Skapinakis P, Caldwell DM, Hollingworth W, et al. Pharmacological and psychotherapeutic interventions for management of obsessive-compulsive disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2016;3(8):730-739. doi:10.1016/S2215-0366(16)30069-4

• Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al. Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depress Anxiety. 2018;35(6):502-514. doi:10.1002/da.22728

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

113 · G4 · publicado em 2026-10-29

Clonazepam, diazepam e outros calmantes: riscos do uso prolongado e como reduzir com segurança

Motivo: medicamento · ~4 min

Clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam e lorazepam estão entre os remédios mais usados no Brasil. Os chamados benzodiazepínicos aliviam a ansiedade e a insônia rapidamente, mas, quando usados por meses ou anos, trazem riscos que muitas pessoas desconhecem.

Para que servem

São úteis em situações específicas e por pouco tempo: crises agudas de ansiedade, abstinência de álcool, algumas emergências e convulsões. O problema é quando o uso, que deveria ser de dias ou semanas, se estende por anos.

Riscos do uso prolongado

• Tolerância: com o tempo, o efeito diminui e a dose tende a subir.

• Dependência: ao parar de repente, podem surgir ansiedade intensa, insônia, tremores e, em casos graves, convulsões.

• Memória e atenção: esquecimentos, lentidão e sonolência durante o dia.

• Acidentes: risco aumentado no trânsito e no trabalho.

• Idosos: mais quedas, fraturas e confusão. Em pessoas idosas, os riscos dos sedativos costumam superar os benefícios,1 e eles estão na lista de medicamentos potencialmente inapropriados para essa faixa etária.2

• Mistura com álcool ou opioides: pode deprimir a respiração e ser fatal.

É possível reduzir com segurança

Em um ensaio clínico com idosos que usavam benzodiazepínicos há muito tempo, um simples material educativo sobre os riscos e sobre como reduzir levou cerca de um em cada quatro participantes a parar o uso em seis meses, contra 5% no grupo de comparação.3

• converse com o médico antes de qualquer mudança;

• a redução deve ser gradual, ao longo de semanas ou meses;

• trate o que está por trás: ansiedade, depressão e insônia têm tratamentos mais adequados a longo prazo, como psicoterapia e antidepressivos;

• sintomas leves de retirada costumam ser temporários.

Quando o calmante é usado para dormir, a terapia cognitivo-comportamental para insônia é o tratamento de primeira escolha recomendado pela diretriz europeia.4

Nunca pare um calmante de uma vez após uso prolongado, não aumente a dose por conta própria e não use o remédio de outra pessoa.

Referências

• Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005;331(7526):1169. doi:10.1136/bmj.38623.768588.47

• 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372

• Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, et al. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014;174(6):890-8. doi:10.1001/jamainternmed.2014.949

• Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6):675-700. doi:10.1111/jsr.12594

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

114 · G4 · publicado em 2026-10-29

Remédio para estudar? Os riscos do uso de estimulantes sem prescrição

Motivo: medicamento · ~4 min

Concurso, vestibular, residência, prova da faculdade, prazo no trabalho. Cresce o número de pessoas que usam metilfenidato, lisdexanfetamina ou modafinila sem indicação médica para "turbinar" o estudo e a produtividade. A promessa é tentadora, mas a ciência não confirma o ganho, e os riscos são reais.

Funcionam para quem não tem TDAH?

Uma série de meta-análises com adultos saudáveis mostrou efeitos pequenos e restritos a algumas tarefas, em experimentos que não reproduzem o uso real. Os autores concluíram que a percepção de que esses remédios melhoram o desempenho não é sustentada pelas evidências.1 Muitas vezes, o que aumenta é a sensação de energia e de confiança, não o aprendizado.

Riscos do uso sem prescrição

• insônia, perda de apetite, dor de cabeça, palpitações e aumento da pressão;

• ansiedade, irritabilidade e crises de pânico;

• em pessoas predispostas, episódios de euforia ou psicose;

• uso em doses cada vez maiores e risco de dependência;

• misturas perigosas com álcool, energéticos e outras substâncias;

• origem incerta de comprimidos obtidos de forma irregular.

Esses medicamentos são controlados e exigem receita especial justamente por causa do risco de abuso.

O que ajuda de verdade no estudo

• sono regular: dormir bem consolida a memória;

• estudo distribuído ao longo do tempo, com revisões espaçadas;

• testar-se com questões, em vez de apenas reler;

• blocos de foco com pausas, celular longe;

• atividade física e alimentação adequada;

• cuidar da ansiedade de desempenho com apoio profissional.

Em universitários, dormir bem, o suficiente e em horários regulares se associou a melhor desempenho acadêmico.2

Usar telas antes de dormir atrasa e encurta o sono de adolescentes, o que prejudica a atenção no dia seguinte.3

Se você sempre teve dificuldade de atenção, desde a infância e em vários contextos, procure avaliação. O TDAH, quando presente, deve ser diagnosticado e tratado com acompanhamento.4

Referências

• Roberts CA, Jones A, Sumnall H, et al. How effective are pharmaceuticals for cognitive enhancement in healthy adults? A series of meta-analyses of cognitive performance during acute administration of modafinil, methylphenidate and D-amphetamine. Eur Neuropsychopharmacol. 2020;38:40-62. doi:10.1016/j.euroneuro.2020.07.002

• Okano K, Kaczmarzyk JR, Dave N, et al. Sleep quality, duration, and consistency are associated with better academic performance in college students. NPJ Sci Learn. 2019;4:16. doi:10.1038/s41539-019-0055-z

• Hale L, Guan S. Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep Med Rev. 2015;21:50-58. doi:10.1016/j.smrv.2014.07.007

• Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2018;5(9):727-738. doi:10.1016/S2215-0366(18)30269-4

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

115 · G4 · publicado em 2026-10-29

Ansiedade de saúde e “Dr. Google”: quando pesquisar sintomas vira sofrimento

Motivo: medicamento · ~4 min

Uma dor de cabeça vira suspeita de tumor depois de meia hora de buscas na internet. Exames normais trazem alívio por poucos dias, até surgir a próxima preocupação. A ansiedade de saúde, antes chamada de hipocondria, causa muito sofrimento, e a internet pode alimentá-la.

Preocupação normal ou ansiedade de saúde?

• é natural ficar preocupado com um sintoma novo e procurar informação;

• na ansiedade de saúde, a preocupação com ter ou vir a ter uma doença grave é intensa, persiste mesmo com avaliações e exames normais e toma boa parte do dia.

A "cibercondria"

Revisões de estudos mostram que quanto maior a ansiedade de saúde, mais as pessoas buscam informações médicas na internet, e mais angustiadas ficam depois das buscas.1 A busca funciona como um comportamento de segurança: traz alívio por um momento, mas mantém o ciclo de preocupação.

Sinais de alerta

• checar o corpo várias vezes ao dia, como apalpar, medir a pressão ou olhar a pele;

• pesquisar sintomas por horas;

• pedir garantias repetidas a familiares e médicos;

• ir a vários médicos e fazer muitos exames sem se tranquilizar;

• ou, ao contrário, evitar consultas e exames por medo do resultado.

Tratamento

• a terapia cognitivo-comportamental é muito eficaz para a ansiedade de saúde, inclusive em formato online;2

• alguns antidepressivos também podem ajudar;

• um acompanhamento regular com o mesmo médico de família, com consultas programadas, evita peregrinações e exames desnecessários.

A terapia cognitivo-comportamental tem ampla base de evidência em ansiedade e problemas relacionados, incluindo a preocupação excessiva com a saúde.3

O que você pode fazer

• combinar consigo um limite para buscas sobre saúde;

• anotar a preocupação e esperar alguns dias antes de agir, quando não houver sinal de urgência;

• levar suas dúvidas para a consulta, em vez de buscar respostas na madrugada.

Exercícios de respiração lenta se associam a mais relaxamento e menos ansiedade, e ajudam a atravessar o pico de preocupação sem correr para a busca.4

Referências

• McMullan RD, Berle D, Arnáez S, et al. The relationships between health anxiety, online health information seeking, and cyberchondria: Systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2018;245:270-278. doi:10.1016/j.jad.2018.11.037

• Axelsson E, Hedman-Lagerlöf E. Cognitive behavior therapy for health anxiety: systematic review and meta-analysis of clinical efficacy and health economic outcomes. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019;19(6):663-676. doi:10.1080/14737167.2019.1703182

• Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJ, et al. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognit Ther Res. 2012;36(5):427-440. doi:10.1007/s10608-012-9476-1

• Zaccaro A, Piarulli A, Laurino M, et al. How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing. Front Hum Neurosci. 2018;12:353. doi:10.3389/fnhum.2018.00353

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: _____
[ ] Não publicar

116 · G4 · publicado em 2026-10-30

Ansiedade na infância: quando o medo passa do normal, como aparece no corpo e o tratamento que funciona

Motivo: medicamento · ~4 min

Medo do escuro, de ficar longe dos pais, de prova, de cachorro. Medos fazem parte da infância. A ansiedade passa a ser um problema quando é intensa, dura muito e começa a impedir a criança de viver: ir à escola, dormir sozinha, brincar com outras crianças.

Um problema comum

Os transtornos de ansiedade estão entre os problemas de saúde mental mais frequentes na infância e na adolescência no mundo.1 E não ficam só na infância: crianças com dor abdominal funcional, aquela sem causa orgânica encontrada, tiveram mais transtornos de ansiedade quando acompanhadas até a vida adulta.2

Como a ansiedade aparece na criança

• no corpo: dor de barriga, dor de cabeça, enjoo, especialmente antes da escola;

• no comportamento: choro, birra, evitar situações, pedir para ir embora;

• no sono: dificuldade de dormir sozinha, pesadelos;

• nas perguntas: "E se acontecer alguma coisa?", repetidas muitas vezes;

• na escola: recusa em ir, idas frequentes à enfermaria.

O que os pais podem fazer

• Acolher sem reforçar o medo: "Eu entendo que é difícil, e eu sei que você consegue."

• Evitar proteger demais. Deixar de ir à escola alivia hoje e aumenta o medo amanhã.

• Enfrentar aos poucos: pequenos passos em direção ao que dá medo, com elogio pelo esforço.

• Manter a rotina: sono, alimentação e horários previsíveis acalmam.

• Cuidar da própria ansiedade. Crianças aprendem observando os adultos.

Os pais podem ser parte central do tratamento: em um ensaio clínico, um programa dirigido só aos pais, que os ensina a apoiar a criança sem acomodar o medo, foi tão eficaz quanto a terapia feita diretamente com a criança.3

O tratamento funciona

Num grande estudo com 488 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, a terapia cognitivo-comportamental e o antidepressivo sertralina foram eficazes isoladamente, e a combinação dos dois teve a melhor resposta: cerca de 81% melhoraram muito.4 Uma metanálise posterior confirmou o benefício da terapia cognitivo-comportamental e dos antidepressivos da classe dos ISRS.5 A terapia é, em geral, o primeiro passo; a medicação é considerada nos casos mais intensos, sempre com acompanhamento médico.

Quando procurar ajuda

Se os sintomas duram semanas, fazem a criança faltar à escola ou atrapalham a vida da família, procure o pediatra ou a UBS. Queixas físicas frequentes também merecem avaliação, para descartar outras causas.

Referências

• Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, et al. Annual research review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):345-65. doi:10.1111/jcpp.12381

• Shelby GD, Shirkey KC, Sherman AL, et al. Functional abdominal pain in childhood and long-term vulnerability to anxiety disorders. Pediatrics. 2013;132(3):475-82. doi:10.1542/peds.2012-2191

• Lebowitz ER, Marin C, Martino A, et al. Parent-Based Treatment as Efficacious as Cognitive-Behavioral Therapy for Childhood Anxiety: A Randomized Noninferiority Study of Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2019;59(3):362-372. doi:10.1016/j.jaac.2019.02.014

• Walkup JT, Albano AM, Piacentini J, et al. Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med. 2008;359(26):2753-66. doi:10.1056/NEJMoa0804633

• Wang Z, Whiteside SPH, Sim L, et al. Comparative Effectiveness and Safety of Cognitive Behavioral Therapy and Pharmacotherapy for Childhood Anxiety Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr.

2017;171(11):1049-1056.
doi:10.1001/jamapediatrics.2017.3036

Conteúdo educativo. Não substitui avaliação individual. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

117 · G4 · publicado em 2026-10-30

Assalto, tiroteio, bala perdida: quando o medo não passa depois da violência urbana e o que ajuda a se recuperar

Motivo: medicamento · ~4 min

Assaltos, sequestros-relâmpago, tiroteios, acidentes de trânsito, violência sexual. No Brasil, muitas pessoas vivem ou presenciam situações de violência. Depois de um trauma, é esperado ficar abalado. Quando o medo não passa e a vida encolhe, pode ser estresse pós-traumático.

Um risco comum no Brasil

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública registra, ano a ano, números elevados de roubos e mortes violentas no país.1 Nos inquéritos da OMS, a violência interpessoal está entre os eventos mais associados ao estresse pós-traumático.2

Reações esperadas nas primeiras semanas

• lembranças que voltam sem querer, pesadelos;

• sobressalto com barulhos, medo de sair;

• dificuldade para dormir e se concentrar;

• choro, irritação ou sensação de anestesia emocional.

Para a maioria das pessoas, essas reações diminuem nas semanas seguintes, com apoio e retomada da rotina.

Sinais de estresse pós-traumático

• reviver o trauma como se estivesse acontecendo de novo;

• evitar lugares, pessoas, conversas ou pensamentos que lembrem o ocorrido;

• estado de alerta constante, sensação de perigo o tempo todo;

• culpa, vergonha, raiva ou desconfiança persistentes;

• sintomas que duram mais de um mês e atrapalham a vida.

Cinco perguntas simples, usadas na Atenção Primária, ajudam a identificar quem precisa de avaliação mais detalhada.3

Tratamento

• psicoterapias focadas no trauma, como a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma e o EMDR, são as mais eficazes;4

• alguns antidepressivos também ajudam, com efeito menor, especialmente quando há depressão associada;5

• tratar insônia e uso de álcool e outras substâncias, que costumam piorar o quadro.

O que ajuda depois de uma situação de violência

• buscar segurança e pessoas de confiança;

• não se forçar a contar detalhes se não quiser, mas também não se isolar;

• retomar aos poucos rotina, sono e atividades;

• evitar álcool como forma de "esquecer";

• em caso de violência sexual, procurar atendimento de saúde o quanto antes, idealmente em até 72 horas.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Anuário Brasileiro de Segurança Pública — edição mais recente. São Paulo: FBSP. forumseguranca.org.br

• Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. Eur J Psychotraumatol. 2017;8(sup5):1353383. doi:10.1080/20008198.2017.1353383

• Prins A, Bovin MJ, Smolenski DJ, et al. The Primary Care PTSD Screen for DSM-5 (PC-PTSD-5): Development and Evaluation Within a Veteran Primary Care Sample. J Gen Intern Med. 2016;31(10):1206-11. doi:10.1007/s11606-016-3703-5

• Lewis C, Roberts NP, Andrew M, et al. Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. Eur J Psychotraumatol. 2020;11(1):1729633. doi:10.1080/20008198.2020.1729633

• Hoskins M, Pearce J, Bethell A, et al. Pharmacotherapy for post-traumatic stress disorder: systematic review and

meta-analysis. Br J Psychiatry. 2015;206(2):93-100. doi:10.1192/bjp.bp.114.148551

Conteúdo educativo sobre violência e saúde mental. Não substitui avaliação individual nem orientação jurídica. Leis, serviços e números citados podem mudar; confirme nos canais oficiais. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

Parar de fumar melhora a saúde mental: o que a ciência mostra

Motivo: medicamento · ~4 min

Muitos fumantes dizem que o cigarro acalma e que têm medo de ficar mais ansiosos ou deprimidos se pararem. A ciência mostra o contrário: depois do período inicial de abstinência, parar de fumar melhora a saúde mental.

O que a pesquisa mostra

Uma meta-análise de estudos que acompanharam pessoas ao longo do tempo mostrou que quem parou de fumar teve menos depressão, ansiedade e estresse e melhor humor e qualidade de vida do que quem continuou fumando. O efeito foi semelhante em pessoas com e sem transtornos mentais e de tamanho comparável ao de tratamentos com antidepressivos.1

Por que o cigarro parece acalmar

A nicotina causa dependência. Entre um cigarro e outro, surgem sintomas de abstinência: irritação, ansiedade, inquietação. O cigarro seguinte alivia esses sintomas, o que dá a impressão de que ele acalma. Na verdade, ele alivia um desconforto que ele mesmo criou.

E o cigarro eletrônico?

No Brasil, a fabricação, a venda, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos, os "vapes" e "pods", são proibidas pela Anvisa.2 Muitos têm altas concentrações de nicotina, o que aumenta a dependência. Não são uma forma segura de parar de fumar.

Entre jovens, usar cigarro eletrônico se associa a maior chance de começar a fumar o cigarro comum depois.3

Como parar

• Procure a UBS: o SUS oferece tratamento gratuito para parar de fumar, com grupos e medicamentos.

• Marque uma data e prepare-se: retire cigarros, isqueiros e cinzeiros de casa.

• Identifique gatilhos: café, álcool, estresse, pausas no trabalho. Planeje o que fazer no lugar.

• Use apoio: adesivos, gomas e medicamentos aumentam as chances de sucesso.

• A fissura passa em poucos minutos: beba água, respire fundo, caminhe.

• Recaiu? Faz parte do processo. Cada tentativa aproxima do objetivo.

Reposição de nicotina, bupropiona e vareniclina aumentam as chances de parar de fumar, segundo uma revisão Cochrane com mais de 100 mil participantes.4

Para quem tem depressão, ansiedade ou outro transtorno mental: parar de fumar é possível e traz benefícios. Avise seu médico, porque algumas doses de medicamentos podem precisar de ajuste depois que você parar.

Referências

• Taylor G, McNeill A, Girling A, et al. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and

meta-analysis. BMJ. 2014;348:g1151. doi:10.1136/bmj.g1151

• Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 855, de 23 de abril de 2024 — mantém a proibição de fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. gov.br/anvisa

• Soneji S, Barrington-Trimis JL, Wills TA, et al. Association Between Initial Use of e-Cigarettes and Subsequent Cigarette Smoking Among Adolescents and Young Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2017;171(8):788-797. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.1488

• Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(5):CD009329. doi:10.1002/14651858.CD009329.pub2

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

119 · G4 · publicado em 2026-10-30

TDAH na infância: sinais, diagnóstico cuidadoso e tratamento

Motivo: medicamento · ~4 min

"Não para quieto", "vive no mundo da lua", "esquece tudo". Toda criança é agitada ou distraída às vezes. No TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade), essas dificuldades são intensas, começam cedo, aparecem em casa e na escola e atrapalham o desenvolvimento.

Sinais de desatenção

• dificuldade de manter a atenção em tarefas e brincadeiras;

• parece não escutar quando falam com ela;

• não termina tarefas, perde materiais, esquece compromissos;

• evita atividades que exigem esforço mental prolongado.

Sinais de hiperatividade e impulsividade

• mexe-se o tempo todo, levanta da cadeira, corre e escala em momentos inadequados;

• fala demais, interrompe, responde antes de a pergunta terminar;

• dificuldade de esperar a vez;

• age sem pensar nas consequências.

Uma meta-análise mundial estimou que cerca de 3,4% das crianças e adolescentes têm TDAH.1 O diagnóstico exige que os sintomas estejam presentes há pelo menos seis meses, em mais de um ambiente, e que causem prejuízo real.

Antes de concluir que é TDAH

Problemas de visão e audição, sono insuficiente, ansiedade, depressão, dificuldades de aprendizagem, violência em casa e excesso de telas também causam desatenção e agitação. A avaliação cuidadosa inclui informações da família e da escola.

Tratamento

• Orientação aos pais sobre rotinas, comandos claros e elogios ao comportamento adequado;

• adaptações na escola, como sentar perto do professor, instruções curtas e tempo extra;

• psicoterapia para habilidades de organização e regulação emocional;

• medicamentos, quando indicados: o metilfenidato é a primeira escolha em crianças e adolescentes, com eficácia comprovada a curto prazo e acompanhamento médico.2

Programas de orientação para pais em grupo reduzem problemas de comportamento e melhoram o bem-estar da família.3

Direitos na escola

A Lei 14.254/2021 garante acompanhamento integral, na escola e na rede de saúde, para estudantes com TDAH, dislexia ou outros transtornos de aprendizagem.4

Referências

• Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, et al. Annual research review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):345-65. doi:10.1111/jcpp.12381

• Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2018;5(9):727-738. doi:10.1016/S2215-0366(18)30269-4

• Furlong M, McGilloway S, Bywater T, et al. Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2012(2):CD008225. doi:10.1002/14651858.CD008225.pub2

• Brasil. Lei nº 14.254, de 30 de novembro de 2021 — dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. planalto.gov.br

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar

120 · G4 · publicado em 2026-10-30

Harmonização, plástica e espelho: quando a preocupação com a aparência é transtorno dismórfico corporal

Motivo: medicamento · ~4 min

Harmonização facial, preenchimentos, cirurgias plásticas e filtros nas redes sociais fazem parte do dia a dia no Brasil. Querer cuidar da aparência é legítimo. Mas, para algumas pessoas, a preocupação com um "defeito" que os outros mal percebem vira sofrimento intenso, e nenhum procedimento resolve: é o transtorno dismórfico corporal.

Sinais do transtorno dismórfico corporal

• preocupação com um ou mais "defeitos" na aparência que os outros não veem ou acham pequenos;

• passar horas se olhando no espelho, ou evitar espelhos e fotos;

• comparar-se constantemente e pedir opinião sobre a aparência;

• tentar esconder a parte do corpo com maquiagem, roupas ou posturas;

• evitar sair, trabalhar ou se relacionar por vergonha;

• buscar procedimentos repetidos sem ficar satisfeito.

Procedimentos estéticos não curam

Revisões de estudos mostram que o transtorno dismórfico corporal é bem mais frequente entre pessoas que procuram cirurgias e procedimentos estéticos do que na população em geral, com taxas especialmente altas na América Latina.1,2 Nessas pessoas, o procedimento costuma não trazer alívio duradouro: a insatisfação se desloca para outra parte do corpo ou para o resultado.

Por que acontece

• predisposição pessoal e familiar;

• experiências de provocação e bullying sobre a aparência;

• padrões de beleza irreais, reforçados por filtros e edições;

• associação com ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo.

O uso de redes sociais centradas em imagem se associa a mais insatisfação com o corpo.3

Tratamento

A terapia cognitivo-comportamental adaptada para o transtorno e alguns antidepressivos são os tratamentos com melhores resultados. O primeiro passo é reconhecer que o sofrimento está na forma de enxergar o próprio corpo.

A terapia cognitivo-comportamental reduziu os sintomas do transtorno dismórfico corporal e da depressão associada numa metanálise de ensaios clínicos.4

Antes de um procedimento estético, pergunte-se: "Estou fazendo isso por mim, com expectativas realistas, ou para acabar com um sofrimento que não me deixa em paz?". Se a resposta for a segunda, converse antes com um profissional de saúde mental.

Precisa de apoio agora? CVV — 188 (ligação gratuita, 24h, também por chat em cvv.org.br) · SAMU — 192 em emergências · A UBS e o CAPS da sua cidade acolhem e encaminham.

Referências

• Kaleeny JD, Janis JE. Body Dysmorphic Disorder in Aesthetic and Reconstructive Plastic Surgery-A Systematic Review and Meta-Analysis. Healthcare (Basel). 2024;12(13). doi:10.3390/healthcare12131333

• Pérez-Buenfil A, Morales-Sánchez A. Prevalence of Body Dysmorphic Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Cosmet Dermatol. 2025;24(4):e70121. doi:10.1111/jocd.70121

• Holland G, Tiggemann M. A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. Body Image. 2016;17:100-10. doi:10.1016/j.bodyim.2016.02.008

• Harrison A, Fernández de la Cruz L, Enander J, et al. Cognitive-behavioral therapy for body dysmorphic disorder: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Psychol Rev. 2016;48:43-51. doi:10.1016/j.cpr.2016.05.007

Conteúdo educativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento individual. Atualizado em outubro de 2026.

[ ] Aprovo
[ ] Aprovo com ajuste: ____
[ ] Não publicar